



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

박사학위 논문

아동 · 청소년기 대인외상경험이 있는
폭식장애경향 성인 여성을 위한
이미지 재구성 인지행동치료 프로그램의
개발 및 효과

명지대학교 대학원

아동학과

홍 채 영

지도교수 김 정 민

2022년 2월

아동·청소년기 대인외상경험이 있는
폭식장애경향 성인 여성을 위한
이미지 재구성 인지행동치료 프로그램의
개발 및 효과

이 논문을 박사학위 논문으로 제출함.

2022년 2월

명지대학교 대학원

아동학과

홍 채 영

아동·청소년기 대인외상경험이 있는
폭식장애경향 성인 여성을 위한
이미지 재구성 인지행동치료 프로그램의
개발 및 효과

명지대학교 대학원
아동학과
홍 채 영

상기자의 아동학박사 학위논문을 인준함.

심사위원장 _____ 홍 혜 영 (인)
심 사 위 원 _____ 김 수 정 (인)
심 사 위 원 _____ 신 혜 원 (인)
심 사 위 원 _____ 정 은 정 (인)
심 사 위 원 _____ 김 정 민 (인)

2022년 2월

목 차

표 목차	iv
그림목차	vii
국문초록	viii
 I. 문제제기	 1
 II. 이론적 배경	 11
1. 섭식장애 및 폭식의 정의 및 특징	11
2. 폭식장애의 정의 및 특징	12
3. 아동·청소년기 대인외상경험의 정의 및 특징	13
4. 아동·청소년기 대인외상경험과 폭식장애의 관련 특성	14
1) 인지적 특성	15
2) 정서적 특성	21
3) 행동적 특성	30
5. 이미지 재구성	36
1) 이미지 재구성 I	36
2) 이미지 재구성 II	40
6. 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 위한 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램	42
1) 외상초점 인지행동치료	42
2) 폭식장애 인지행동치료	43
3) 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램 치료구성요인	46
 III. 연구문제 및 용어정의	 54
1. 연구문제	54
2. 용어정의	55

IV. 연구방법	60
1. 연구설계	60
2. 연구대상	61
1) 연구 대상 선정	61
2) 연구 대상의 일반적 특성	62
3. 측정도구	63
1) 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성 선별 도구	63
2) 프로그램 효과 측정 도구	65
4. 자료분석	74
V. 프로그램 개발	75
1. 프로그램의 개발 및 절차	75
1) 예비 프로그램의 구성 및 실시	77
2) 예비 프로그램의 수정 및 보완	78
2. 프로그램의 구성	81
1) 프로그램의 목표 및 치료구성요인	81
2) 프로그램의 회기별 구조	90
3. 프로그램의 실시	92
1) 실험집단 대상 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램 실시	92
2) 비교집단 대상 전통적인 인지행동치료 프로그램 실시	103
3) 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램과 전통적인 인지행동치료 프로그램 비교	105
VI. 프로그램 효과 검증	108
1. 집단 간 사전검사 비교	108
1) 집단 간 섭식 변인 사전검사 비교	109
2) 집단 간 인지 변인 사전검사 비교	109
3) 집단 간 정서 변인 사전검사 비교	110
4) 집단 간 행동 변인 사전검사 비교	110

2. 집단 간 사후검사 비교	110
1) 집단 간 섭식 변인 사후검사 비교	110
2) 집단 간 인지 변인 사후검사 비교	111
3) 집단 간 정서 변인 사후검사 비교	114
4) 집단 간 행동 변인 사후검사 비교	117
3. 집단 내 사전-사후검사 비교	117
1) 집단 내 섭식 변인 사전-사후검사 비교	117
2) 집단 내 인지 변인 사전-사후검사 비교	118
3) 집단 내 정서 변인 사전-사후검사 비교	121
4) 집단 내 행동 변인 사전-사후검사 비교	123
4. 실험집단과 비교집단 간 추후검사 비교	124
1) 집단 간 섭식 변인 추후검사 비교	124
2) 집단 간 인지 변인 추후검사 비교	125
3) 집단 간 정서 변인 추후검사 비교	127
4) 집단 간 행동 변인 추후검사 비교	130
5. 실험집단과 비교집단 내 사전-사후-추후검사 비교	130
1) 집단 내 섭식 변인 사전-사후-추후검사 비교	130
2) 집단 내 인지 변인 사전-사후-추후검사 비교	132
3) 집단 내 정서 변인 사전-사후-추후검사 비교	136
4) 집단 내 행동 변인 사전-사후-추후검사 비교	141
6. 실험집단의 인지 내용의 변화 분석	144
1) 대인외상경험(자기 지각, 대인 지각) 관련 인지 내용의 변화 분석	146
2) 폭식(자기 지각, 대인 지각) 관련 인지 내용의 변화 분석	164
 VII. 논의 및 결론	 180
 참고문헌	 201
부록	245
Abstract	288

표 목 차

<표 IV-1> 연구 설계	60
<표 IV-2> 연구 대상 제외기준	61
<표 IV-3> 연구 대상의 일반적 특성	62
<표 IV-4> 본 연구의 대인외상경험 및 폭식장애경향 대상자 선별 도구	63
<표 IV-5> 본 연구의 사전·사후·추후 효과 측정 도구	65
<표 IV-6> 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동 척도	66
<표 IV-7> 역기능적 신념 척도	67
<표 IV-8> 부정적 자동적 사고 척도	68
<표 IV-9> 자아존중감 척도	69
<표 IV-10> 정서조절곤란 척도	70
<표 IV-11> 우울 척도	71
<표 IV-12> 상태-특성 불안 척도	71
<표 IV-13> 상태-특성 분노 척도	72
<표 IV-14> 스트레스 대처방식 척도	73
<표 V-1> 프로그램 개발과정	76
<표 V-2> 예비 프로그램 구성 내용	78
<표 V-3> 예비 프로그램 실시 후 수정 및 보완 사항	80
<표 V-4> 실험집단 프로그램 구성 내용	93
<표 V-5> 이미지 재구성 I 절차	98
<표 V-6> 이미지 재구성 II 절차	101
<표 V-7> 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램, 인지행동치료 프로그램의 치료구성요인 비교	107
<표 VI-1> 집단 간 변인별 사전검사 비교	108
<표 VI-2> 집단 간 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동 사후검사 비교	111
<표 VI-3> 집단 간 역기능적 신념 사후검사 비교	112
<표 VI-4> 집단 간 부정적 자동적 사고 사후검사 비교	113
<표 VI-5> 집단 간 자아존중감 사후검사 비교	114

<표 VI-6> 집단 간 정서조절곤란 사후검사 비교	115
<표 VI-7> 집단 간 우울 사후검사 비교	116
<표 VI-8> 집단 간 상태-특성 불안 사후검사 비교	116
<표 VI-9> 집단 간 상태-특성 분노 사후검사 비교	116
<표 VI-10> 집단 간 스트레스 대처방식 사후검사 비교	117
<표 VI-11> 집단 내 부정적 정서로 유발된 섭식동기 · 행동 사전-사후검사 비교 ·	118
<표 VI-12> 집단 내 역기능적 신념 사전-사후검사 비교	119
<표 VI-13> 집단 내 부정적 자동적 사고 사전-사후검사 비교	120
<표 VI-14> 집단 내 자아존중감 사전-사후검사 비교	121
<표 VI-15> 집단 내 정서조절곤란 사전-사후검사 비교	122
<표 VI-16> 집단 내 우울 사전-사후검사 비교	122
<표 VI-17> 집단 내 상태-특성 불안 사전-사후검사 비교	123
<표 VI-18> 집단 내 상태-특성 분노 사전-사후검사 비교	123
<표 VI-19> 집단 내 스트레스 대처방식 사전-사후검사 비교	124
<표 VI-20> 실험집단과 비교집단 간 부정적 정서로 유발된 섭식동기 · 행동 추후검사 비교	125
<표 VI-21> 실험집단과 비교집단 간 역기능적 신념 추후검사 비교	126
<표 VI-22> 실험집단과 비교집단 간 부정적 자동적 사고 추후검사 비교	127
<표 VI-23> 실험집단과 비교집단 간 자아존중감 추후검사 비교	127
<표 VI-24> 실험집단과 비교집단 간 정서조절곤란 추후검사 비교	128
<표 VI-25> 실험집단과 비교집단 간 우울 추후검사 비교	128
<표 VI-26> 실험집단과 비교집단 간 상태-특성 불안 추후검사 비교	129
<표 VI-27> 실험집단과 비교집단 간 상태-특성 분노 추후검사 비교	129
<표 VI-28> 실험집단과 비교집단 간 스트레스 대처방식 추후검사 비교	130
<표 VI-29> 실험집단과 비교집단 내 부정적 정서로 유발된 섭식동기 · 행동 사전-사후-추후검사 비교	131
<표 VI-30> 실험집단과 비교집단 내 역기능적 신념 사전-사후-추후검사 비교 ·	133
<표 VI-31> 실험집단과 비교집단 내 부정적 자동적 사고 사전-사후-추후검사 비교	134

<표 VI-32> 실험집단과 비교집단 내 자아존중감 사전-사후-추후검사 비교	135
<표 VI-33> 실험집단과 비교집단 내 정서조절곤란 사전-사후-추후검사 비교	137
<표 VI-34> 실험집단과 비교집단 내 우울 사전-사후-추후검사 비교	138
<표 VI-35> 실험집단과 비교집단 내 상태-특성 불안 사전-사후-추후검사 비교 ·	139
<표 VI-36> 실험집단과 비교집단 내 상태-특성 분노 사전-사후-추후검사 비교	140
<표 VI-37> 실험집단과 비교집단 내 스트레스 대처방식 사전-사후-추후검사 비교	142
<표 VI-38> 실험집단의 개인별 특성	145
<표 VI-39> 실험집단의 대인외상경험 관련 인지적 오류 범주 분류	147
<표 VI-40> 대인외상경험의 자기 지각과 관련된 자기비난 사고의 변화 내용 ..	148
<표 VI-41> 대인외상경험의 자기 지각과 관련된 흑백논리 사고의 변화 내용 ..	152
<표 VI-42> 대인외상경험의 대인 지각과 관련된 과잉일반화 사고의 변화 내용	157
<표 VI-43> 실험집단의 폭식 관련 인지적 오류 범주 분류	165
<표 VI-44> 폭식과 관련된 자기비난 사고의 변화 내용	165
<표 VI-45> 폭식과 관련된 흑백논리 사고의 변화 내용	170
<표 VI-46> 폭식과 관련된 독심술 사고의 변화 내용	175

그 립 목 차

<그림 V-1> 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램 치료구성요인	82
<그림 V-2> 전통적인 인지행동치료 프로그램 치료구성요인	104
<그림 VI-1> 실험집단과 비교집단 내 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동 사전- 사후-추후검사 비교	132
<그림 VI-2> 실험집단과 비교집단 내 역기능적 신념 사전-사후-추후검사 비교	134
<그림 VI-3> 실험집단과 비교집단 내 부정적 자동적 사고 사전-사후-추후검사 비교	135
<그림 VI-4> 실험집단과 비교집단 내 자아존중감 사전-사후-추후검사 비교	136
<그림 VI-5> 실험집단과 비교집단 내 정서조절곤란 사전-사후-추후검사 비교 ..	138
<그림 VI-6> 실험집단과 비교집단 내 우울 사전-사후-추후검사 비교	139
<그림 VI-7> 실험집단과 비교집단 내 상태-특성 불안 사전-사후-추후검사 비교	140
<그림 VI-8> 실험집단과 비교집단 내 상태-특성 분노 사전-사후-추후검사 비교	141
<그림 VI-9> 실험집단과 비교집단 내 스트레스 대처방식의 문제중심적 대처 사전-사후-추후검사 비교	142
<그림 VI-10> 실험집단과 비교집단 내 스트레스 대처방식의 사회적지지 추구 대처 사전-사후-추후검사 비교	143
<그림 VI-11> 실험집단과 비교집단 내 스트레스 대처방식의 정서완화적 대처 사전-사후-추후검사 비교	143

아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 위한 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램의 개발 및 효과

홍 채 영

명지대학교 대학원 아동학과

아동가족심리치료전공

지도교수 김 정 민

본 연구의 목적은 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 위한 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램을 개발, 실시한 후 전통적인 인지행동치료 프로그램과 그 효과를 비교하는 것이다. 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램의 구성요인은 자기관리, 인지적 재구성, 이미지 재구성, 이완훈련 및 스트레스 대처훈련이며, 전통적인 인지행동치료 프로그램의 구성요인은 자기관리, 자기감찰, 인지적 재구성, 이완훈련, 스트레스 대처훈련이다. 연구대상은 두 단계로 선별하였다. 1차는 대인외상경험 체크리스트 5점 이상, BULIT-R 88점 이상의 중복 기준에 해당되는 20~30대 여성을 선별하였다. 2차는 면접 및 심상 면접을 실시하여 최종 선별된 성인 여성 21명을 이미지 재구성 인지행동치료를 실시한 실험집단, 전통적인 인지행동치료를 실시한 비교집단 및 무처치 통제집단에 각각 7명씩 임의 배정하였다. 회기진행은 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 주 2회, 120분씩 총 10회기(10회기 중 개별 3회기는 개인당 약 50분 내외 소요)를 실시하였고, 전통적인 인지행동치료 프로그램은 주 2회, 120분씩 총 10회기를 실시하였다.

프로그램의 효과 검증은 사전, 사후 및 3개월 추후 검사와 내용분석을 통해 이루어졌으며 대인외상경험과 폭식장애경향 관련 변인을 섭식, 인지(내용, 과정), 정서 및 행동의 네 가지 영역으로 분류하여 부정적 정서로 유발된 섭식 동기 척도와 섭식 행동 척도, 역기능적 신념(SDBT), 부정적 자동적 사고(ATQ-N), 자아존중감(RSS), 정서조절곤란(DERS), 우울(BDI), 상태-특성 불안(STAI), 상태-특성 분노(STAXI-K), 스트레스 대처방식(SCSC)의 척도들을 사용하여 측정하였다. 수집된 자료의 분석은 SPSS 21.0 통계 프

로그그램을 사용하였다.

본 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 프로그램 실시 후 섭식 변인인 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동과 하위요인인 섭식동기, 섭식행동에서 실험집단인 이미지 재구성 인지행동치료는 전체 척도와 하위요인 모두 점수가 유의하게 감소하였다. 반면, 비교집단인 전통적인 인지행동치료는 하위요인인 섭식행동에서만 점수가 유의하게 감소하였다. 둘째, 프로그램 실시 후 인지 변인 중 인지 내용인 역기능적 신념, 부정적 자동적 사고에서 실험집단은 역기능적 신념과 부정적 자동적 사고 모두 점수가 유의하게 감소하였다. 반면, 비교집단은 부정적 자동적 사고에서만 점수가 유의하게 감소하였다. 또 다른 인지 변인 중 인지 과정인 자아존중감에서 실험집단만이 점수가 유의하게 증가하였다. 셋째, 프로그램 실시 후 정서 변인인 정서조절곤란, 우울, 상태-특성 분노에서 실험집단과 비교집단 모두 점수가 유의하게 감소하였다. 특히 우울의 경우 집단 간 유의한 차이를 보였는데, 실험집단이 비교집단보다 더 효과적인 것으로 나타났다. 한편, 또 다른 정서변인인 상태-특성 불안은 실험집단만이 점수가 유의하게 감소하였다. 넷째, 프로그램 실시 후 행동 변인인 스트레스 대처방식의 문제중심적 대처, 사회적지지 추구, 정서완화적 대처 중 문제중심적 대처와 사회적지지 추구는 실험집단과 비교집단 모두 점수가 유의하게 증가하였고, 정서완화적 대처는 실험집단만이 점수가 유의하게 감소하였다. 다섯째, 프로그램 종결 3개월 후 실시한 추후검사에서 전체 변인 모두 실험집단과 비교집단 간 유의한 차이를 보였으며, 사전-사후-추후검사에서 실험집단만이 전체 변인 모두에서 유의한 효과를 유지 혹은 지속적으로 변화시키는 것으로 나타났다.

본 연구의 의의는 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 대상으로 폭식 증상의 감소를 위한 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램을 구성, 개발하였다는 것이며, 특히 폭식 증상의 감소를 위하여 폭식에만 초점을 맞춘 선행연구들과는 차별적으로 대인외상경험과 폭식 모두를 이미지 재구성으로 다루어주며 대상자의 폭식 증상 감소뿐만 아니라, 관련 변인들까지도 효과적으로 변화시켜 그 효과를 유지시켰다는 점이다. 이는 곧 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램이 폭식장애경향자들의 심리적 건강을 되찾는 데 유망한 치료가 될 수 있음을 시사한다.

주요어: 대인외상경험, 폭식장애경향, 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램, 소크라테스 기법, 인지적 재구성, 이미지 재구성, 성인 여성

I. 문제제기

폭식(Binge Eating)은 ‘유사한 상황에서 보통 2시간 이내의 제한된 시간 동안 대부분의 사람들이 먹는 것보다 분명하게 많은 양의 음식을 섭취하는 것’으로 정의된다(American Psychiatric Association; 이하 APA, 2013). 먹는 동안 조절 능력을 상실하여 음식의 종류와 양을 조절할 수 없는 것이 특징이다. 이러한 폭식은 일반인에게 만연하게 나타나는 식습관이지만, 반복적으로 나타날 경우 정신장애의 명백한 발현양상으로 볼 수 있다(Ackard, et al., 2003; Croll, et al., 2002). 폭식과 관련된 섭식장애 중 가장 밀접한 연관성이 있는 것은 폭식장애(Binge-Eating Disorder)이며, 폭식 이후 보상 행동(의도적인 구토, 하제 및 기타 약물 오용)을 하지 않는 것이 특징이다. 이러한 폭식장애는 2013년부터 DSM-5에 공식 진단명으로 명시되었으며, 이는 폭식장애에 대한 문제성이 중점적으로 다뤄져야 함을 시사한다.

폭식장애를 가진 사람들은 신체적인 배고픔이 느껴지지 않을 때도 많은 양의 음식을 먹으며, 불편한 포만감이 느껴짐에도 계속적으로 음식을 섭취한다. 이러한 음식에 대한 조절능력의 어려움으로 이들은 자신이 얼마나 많이 먹고 있는지를 타인에게 들키는 것을 두려워하고, 혼자 먹는 것을 선호하여(Garner & Garfinkel, 1997) 다른 사람들의 눈을 피해 몰래 음식을 먹는 특성상 음식이 있는 행사나 사적인 모임은 피하게 된다(Heatherton & Baumeister, 1991). 따라서 이들은 대인관계 문제, 부정적인 자기평가 및 자기비난 등을 경험하게 될 가능성이 높고, 특히 정서조절에 어려움을 겪는다(Craighead, et al., 2013; Cooper, 2011). 이처럼, 폭식장애는 개인에게 만성적인 심리·사회적 문제를 초래할 뿐만 아니라 치료가 어렵고 쉽게 재발하며(Agras, et al., 1997), 지속적으로 나타나기도 한다(Polivy, et al., 1994).

일반적으로, 폭식장애의 평생 유병률은 1-3%이며(Dingemans, et al., 2002), 폭식장애의 남녀 성비는 2:3.5%로(Hudson, et al., 2007), 남성보다 여성에게서 더 높은 유병률을 보인다(Hudson, et al., 2012; Kessler, et al., 2013; Smink, et al., 2012). 또한, 폭식장애의 평균적인 발병 연령은 22.4세로, 주로 성인기에 발병하는 것으로 알려져 있다(Hudson, et al., 2007; Yanovski, et al., 1993). 폭식장애를 포함하는 폭식 관련 통계 자료에 따르면, 2016년 진료 현황 기준으로 남성 진료환자는 449명(12.6%), 여성 진료환자는 3,110명(87.4%)으로 여성 환자의 수가 약 7배 많았으며, 전체 여성 환자 중 20

~30대가 57.8%로 가장 큰 비중을 차지하였다(건강보험심사평가원, 2018). 이처럼 많은 20, 30대 여성들이 폭식을 경험하고 개인적·사회적으로 많은 어려움을 겪고 있지만 사회적 낙인, 치료의 접근성, 비용 및 병식의 부재와 같은 다양한 이유로 적절한 시기에 치료를 받지 않고 있다(Darcy & Dooley, 2007). 폭식은 초기에 발견하여 중재하면 폭식장애로 진단 받을 가능성이 적어지고, 치료하지 않으면 뚜렷한 폭식장애로 진전될 가능성이 높다는 연구들을 살펴볼 때(Tanofsky-Kraff, et al., 2011), 폭식장애경향에 대한 조기 발견 및 적절한 초기 개입은 매우 중요하다고 볼 수 있다(Stice, et al., 1998). 따라서 본 연구에서는 폭식장애의 임상적 진단 기준에는 충족하지 못하더라도, 폭식장애의 전조 증상들을 나타내는 취약 집단인 20, 30대 성인 여성을 대상으로 하고자 한다.

이러한 폭식을 설명하는 가장 대표적인 모델 가운데 정서 조절 및 도피 모델(Emotional Regulation and Escape Model)이 있다. 이 모델은 부정 정서(불안, 우울 및 분노)로부터 도피하기 위해 폭식을 주의분산의 구체적인 한 가지 방법으로 사용하는 것이다(Agras & Telch, 1998; Danner, et al., 2014; Heatherton & Baumeister, 1991). 따라서 폭식자는 폭식이 고통스러운 정서를 빠르게 둔화시켜준다는 것을 학습하며, 부정 정서를 다루기 위한 방법으로 폭식을 사용한다(오자영, 2006; Arnow, et al., 1992). 이때, 이러한 부정 정서 요인에 의해 섭식 행동이 촉발된 경우를 정서적 섭식(Emotional Eating)이라고 일컫는다(Arnow, et al., 1995; Lindeman, et al., 2001; Ricca, et al., 2012; Strien, et al., 1986). 정서적 섭식을 하는 사람들은 배고픔이나 포만감과 같은 내적 신호가 아닌 부정적인 정서에 반응해 섭식행동을 하기 때문에 정상적인 섭식 행동 집단과 달리 정서조절에 어려움이 생기는 정서적 각성(Emotional Arousal)이나 스트레스 상황에서 폭식을 하게 된다(Greeno & Wing, 1994; Kaplan & Kaplan 1957; Snoek, et al., 2007).

본 연구에서는 정서 조절 및 도피 모델에 근거하여 정서적 섭식으로 인한 폭식의 기원이 초기 대인외상경험에 있다는 점에 주목하였다. 대인외상경험(Interpersonal Traumatic Experience)은 타인의 고의적인 신체·언어·정신적 폭력으로 인한 외상사건의 경험을 의미하며(Allen, 2008; D'Andrea, et al., 2012), 대표적인 대인외상 사건에는 학대, 성폭력, 이별, 파도림 및 관계 단절 등이 포함된다(Clancy, et al., 2006). 선행 연구에 의하면 어린 시절의 대인외상경험은 성인기의 폭식장애를 유발하는 근원적인 변인이라고 하였으며(Monteleone, et al., 2021), 대인외상경험이 폭식을 즉각적으로 발

현한다기보다는 이들의 관계를 매개하는 변인들에 의해 이후에 폭식장애로 발전됨을 보고하였다(Monica, et al., 2010; Monteleone, et al., 2021). 대표적인 매개 변인에는 역기능적 사고(Feinson & Hornik-Lurie, 2016), 낮은 자아존중감(Groleau, et al., 2012), 정서조절곤란(Racine & Wildes, 2015) 등이 있다. 초기 대인외상경험은 개인의 부정적인 자기개념과 타인에 대한 불신이라는 역기능적 신념을 형성하며 낮은 자아존중감에 영향을 미치게 되어 지속적인 대인관계의 어려움(Interpersonal Difficulties)을 야기한다(한기백, 2021). 이때, 대인관계적 스트레스는 정서조절의 어려움을 일으켜(Fowler, et al., 2013), 폭식이 부정 정서에 대한 대처방안으로 사용되어지는데(Fairburn, et al., 2003) 이러한 경로가 반복되면 폭식이 습관적으로 고착화가 되어 이후에 폭식장애로 발전되는 것이다.

폭식과 관련하여 대인외상경험자의 심리적 특성을 구체적으로 인지, 정서, 행동적 요인에서 살펴보면 다음과 같다. 우선, 인지적 측면에서는 크게 인지적 내용과 과정에 대한 두 가지 오류가 발견된다. 먼저, 인지적 내용의 오류는 다시 자기(Self)지각과 대인지각에 대한 오류로 나누어지며 다음과 같이 살펴볼 수 있다. 첫째, 자기개념에 대한 인지적 왜곡이 있다. 어린 시절 타인으로 인한 외상경험은 스스로를 무가치하고 결함이 있는 사람으로 여겨 사랑받지 못하는 사람으로 인식하게 됨으로써(Van der Kolk, 2001), 자신을 향한 무가치하고 열등한 느낌의 부정적인 자기감을 형성하게 된다. 이러한 자기 스스로의 가치절하 및 평가는 낮은 자존감과 같은 심리·정서적인 문제를 유발하게 된다(이태영, 심혜숙, 2011; Pearlman & Saakvitne, 1998). 따라서 외상경험 이후에도 대인관계와 관련된 사건 및 상황에서 자신을 부정적으로 평가하거나 비난하고, 자기위안을 하지 못할 가능성이 크며 이러한 경험들은 더 큰 가치 절하, 낮은 자존감을 불러일으킨다(조현주, 현명호, 2011). 이러한 대인외상경험자의 왜곡된 신념과 같이 폭식장애 환자를 대상으로 한 연구에서도 자기비난적 사고, 무가치감, 실패감과 같은 역기능적 사고 및 신념이 두드러졌으며(Cooper, 2011; Striegel-Moore, et al., 1993), 이로 인한 이들의 낮은 자아존중감은 폭식의 심각성에 대한 강한 예언요인으로 밝혀졌다(Sanftner & Crowther, 1998; Wolf & Crowther, 1992).

둘째, 대인지각에 대한 인지적 왜곡이 있다. 아동·청소년기의 외상경험은 이후의 대인관계에서 상처 받을 것 같은 느낌을 지속적으로 느끼게 하며, 이유 없이 타인이 자신을 가혹하게 대한다는 느낌을 경험하게 한다(Drapeau & Perry, 2004). 따라서 대

인관계에 있어서 타인을 신뢰하는 것이 어렵고, 반복적으로 피해자가 되어 해를 입기도 하고, 때로는 타인에게 해를 가하기도 한다(Fleming, et al., 1999). 이와 같이 타인에 대한 부적응적인 사고 및 비합리적인 신념은 우울, 불안 및 분노와 같은 부정적인 정서를 일으키고, 이러한 부정적인 정서를 해결하기 위한 방안으로 폭식과 같은 부적절한 식이행동이 나타난다고 보고되고 있다(Confalonieri, et al., 2013). 또한, 폭식을 보이는 여성들도 일반 여성에 비해 타인으로부터 인정받고자 하는 욕구가 더 높고, 타인의 거부나 비난에 매우 민감하게 반응한다고 밝혀졌다(Short, et al., 2013). 따라서 대인외상경험자들과 같이 폭식자들은 대인관계와 관련된 문제에서 공통적인 심각한 어려움을 경험하는 것으로 보이며(Fairburn, et al., 1991; Lacey, et al., 1986; Steiger, et al., 1999), 이는 어린 시절 대인외상경험에서 형성된 타인에 대한 왜곡된 사고 및 신념이 해결되지 않으면 성인기에도 지속적으로 대인관계적 문제에 영향을 미친다는 것을 시사한다. 이에 본 연구에서는 인지 내용인 자기지각과 대인지각에 대한 부적응적인 사고 및 신념을 측정하기 위하여 부정적 자동적 사고 척도, 역기능적 신념 척도를 사용하고자 한다.

다음으로, 인지적 과정에서의 오류가 있다. 인지적 과정에서의 오류란 대인외상경험자가 외상 사건이 더 이상의 실질적인 위협이 되지 않음에도 불구하고(Ehlers & Clark, 2000), 당시 자신의 무능감, 무력감 등의 부정적인 이미지에 초점을 맞춰 현실에서 아무런 대처를 하지 못하는 것이다(최윤경, 2010; Kleim, et al., 2012). 이러한 인지적 과정의 오류 속에서 대인외상경험자들은 고통스러운 외상 기억에 압도되는 것으로부터 자신을 보호하기 위해 외상과 관련된 부정적인 이미지를 생각하지 않으려고 노력한다(박경희, 2006). 그러나, 역설적이게도 이때 사용하는 사고억제, 연상 자극에 대한 억압 및 회피와 같은 부적응적인 기제가 외상경험 당시 스스로의 무능했던 이미지를 재경험하게 하여(Ehlers & Clark, 2000) 불쾌한 정서적 및 심리적 고통을 반복적으로 느끼게 한다(안현의 외, 2013). 이때, 불쾌한 외상 기억을 통해 발생하는 부정 정서는 정서조절곤란으로 이어져 결국 폭식을 유발한다(Craighead, et al., 2013). 이러한 인지적 과정에서의 오류를 해결하기 위해서는 자아존중감(Self-Esteem)의 역할이 중요한데, 자아존중감이란 자신의 능력을 평가하는 인지적 요소로서(Rosenberg, 1979), 외상으로 인한 어려움을 극복 가능하게 하는 긍정적인 심리 변수이다(Agabi & Wilson, 2005; Ventegodt et al., 2007). Hater(1990)에 의하면, 개인의 자아존중감이 향상되려면

낮은 자아존중감을 형성시킨 초기의 원인 수준에서 개입이 발생해야 한다고 하였다. 따라서, 초기 대인외상경험으로 인한 인지처리 과정의 회복을 위해서는 낮은 자아존중감을 향상시키는 방안이 중요할 것으로 보이며 이에 따라, 본 연구에서는 자아존중감 척도를 사용하여 이를 살펴보고자 한다.

다음으로 정서적 측면을 살펴보면, 대인외상경험자의 경우 우울, 불안 및 분노 등의 정서조절에 있어서의 곤란으로 심각한 정서적 어려움을 호소하는 것으로 나타났다(김평화, 윤혜미, 2014; 이수연, 이동훈, 2017; Gratz, et al., 2009; Shorey, et al., 2011; Shorey, et al., 2011). 이러한 부정 정서는 폭식을 유발하는 주된 요인으로 드러났으며(Fairburn, et al., 2003; Stein, et al., 2007), 실제로 폭식장애를 가진 사람들 중 90% 이상이 우울, 불안, 및 분노와 같은 기분장애를 겪고 있음이 밝혀졌다(Grilo, et al., 2009; Telch, et al., 2001). 앞서 기술한 바와 같이 정서조절의 어려움을 겪는 폭식장애 환자들은 부정 정서를 경험하는 상황에서 이를 적응적으로 처리하지 못하여, 회피 기제로 음식을 계속적으로 사용한다(이미현, 2009; 이미현, 채규만, 2012; Hawkins & Clement, 1984; Thompson, et al., 1987). 따라서 이러한 경향성을 제어하기 위해서는 폭식장애를 유발하는 대표적인 부정 정서인 우울, 불안 및 분노에 초점을 맞춰, 보다 근본적으로 정서조절곤란을 다룰 수 있는 완화방법이 필요하다.

마지막으로 행동적 측면을 살펴보면, 대인외상경험자의 경우 대인관계 문제에 노출될 위험성이 크며, 관계적인 문제가 발생하였을 때 이를 적절하게 대처하는 것에 어려움이 있다(고나래, 2008; 이유경, 2006; 조은정, 이기학, 2004). 이는 대인외상경험자의 적응적인 대처능력이 손실되었기 때문이며, 부적절한 대처는 높은 관계적 스트레스를 유발하여 결국 폭식과 같은 이상섭식 행동을 야기할 가능성이 크다(Evers, et al., 2010; Michopoulos, et al., 2015). 폭식장애 환자의 경우에도 대인관계에서 어려움을 경험하고, 대인관계 문제와 관련된 부정 정서를 적응적으로 처리하는 것에 어려움이 있다(손은정, 2013). 특히, 이들은 관계적 갈등에 노출되는 경험이 많을수록 스트레스 수준이 높아졌고, 이에 따라 실제 폭식까지 이어지는 빈도가 늘어났다(오경자, 정현강, 2008). 폭식자는 스트레스 발생 시 문제해결중심의 대처방식보다는 정서 중심적이고, 회피적인 스트레스 대처방식으로(김혜은, 박경, 2003; Grau, et al., 2002) 폭식을 한다. 이렇듯, 대인외상경험 및 폭식 문제를 겪는 사람들은 대인관계 문제의 높은 스트레스 상황에서 회피기제로 폭식을 사용하므로 폭식을 유발하는 관계적 스트레스 요인에 대

한 대처능력을 증진시키는 적절한 개입이 필요할 것으로 보인다.

현재까지 폭식장애의 치료에는 인지행동치료(Cognitive Behavior Therapy; 이하 CBT)가 가장 대표적으로 사용되어 왔다. 폭식을 다룬 CBT는 부정적인 신체상, 폭식 전후의 비합리적인 사고 및 신념을 수정함으로써, 부적절한 폭식 증상을 감소시키는 것을 목표로 하여 치료적 효용성을 나타냈다(이삼연, 2000; Cooper & Fairburn, 1993). 그러나, 폭식장애에 대한 CBT의 효과가 나타나기까지는 수개월 이상 치료자와 내담자가 상호작용을 해야 한다는 문제점이 있으며(Kotler, et al., 2003; Pull, 2004; Wilson & Fairburn, 2002), 폭식 문제와 같은 섭식장애가 있는 대상은 정서 문제나 대인관계 문제 등 다른 정신 병리를 가지고 있을 확률이 높고, 대안 사고를 찾는 인지적 유연성이 현저히 부족하여(Monica, et al., 2010), 전통적인 CBT가 이들의 인지 변수를 다루는데 충분히 효과적이지 못하다는 한계점이 제기되었다(백지은, 박경애, 2016; Fairburn, et al., 2003; Lundgren, et al., 2004). 이에 따라 참여자들의 20~60%는 폭식이 회복된 이후에도 음식과 관련된 강박적 사고, 부적응적 사고 및 부정 정서를 경험하는 등 높은 재발률을 보였다(Brown & Keel, 2012; Cooper, et al., 2003; Vocks, et al., 2010). Gilbert와 Procter(2006)에 의하면 폭식장애 환자와 같이 수치심을 쉽게 경험하고, 심하게 자기비판적인 사람들은 스스로를 위로하거나 달래는 능력이 부족하여 대안적 사고를 찾기 어렵고, 찾아낸 이후에도 자신이 만들어낸 대안적인 사고를 실제로 믿기는 매우 어렵다고 하였다. 따라서 폭식에서 회복한 이후에도 부적응적인 생각이나 정서를 경험하고, 어려움을 지속적으로 호소하는 등의 재발 위험성이 높아 이를 보완할 수 있는 대안적인 치료방법에 대한 필요성이 제기되었다(Bosch, et al., 2008; Cooper, 2005; Cooper, et al., 2003; Kotler, et al., 2003; Wilson & Fairburn, 2002).

뿐만 아니라, 앞서 기술된 것처럼 폭식장애는 대인외상 경험과 결부된 것들이 굉장히 많음에도 불구하고, 폭식에 대한 CBT를 진행하며 대인외상에는 초점을 맞추지 않아 근본적인 문제를 해결하지 못하였다. 따라서 폭식에 대한 연구에서는 폭식과 더불어서 대인외상을 추가적으로 고려하여 함께 다루주는 접근이 필요하다. 기존의 대인외상만 다룬 CBT에서는 치료효과가 좋은 구성요인으로 노출훈련을 제시하였기에, 본 연구에서는 기존에 폭식을 다룬 CBT에서는 포함되지 않았던 노출을 구성요인에 포함시키고자 한다. 또한, 이전의 대인외상자를 대상으로 한 CBT의 노출은 매뉴얼에 따라 부정 정서를 일으키는 외상장면에 직면하도록 하는 것에 초점을 맞추다보니 노출치료

시 대상자의 노출 참여에 대한 낮은 동기, 비수용적 태도 및 회기 이후의 중도 탈락과 같은 문제가 있었다(조용래, 2001). 이에 따라, 치료에 참여했다 하더라도 불쾌한 감정을 소화하기 어렵고, 치료효과가 나타나지 않은 경우도 있어 이를 보완할 수 있는 대안적인 치료방법의 필요성이 제기되었다(윤혜영, 권정혜, 2010).

따라서 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성들을 위한 프로그램을 개발할 때는 앞의 두 가지 문제점을 보완하는 대안책이 필요하다. 첫째, 앞서 설명한 폭식을 대상으로 한 CBT의 단점을 보완하여 인지적 재구성을 잘 활용시켜 줄 수 있는 방안이 필요하다. 둘째, 기존에 폭식을 대상으로 한 CBT에서는 간과하였던 대인외상을 다루는 노출을 구성요인에 추가하고, 노출훈련의 제한점인 참여 동기, 중도 탈락률 등을 보완시켜줄 수 있는 방법이 필요하다. 이러한 두 가지 대안 방법을 고려해보았을 때, 이를 모두 만족시키는 치료기법으로 이미지 재구성(Imagery Rescripting)이 있다. 이 기법은 심상을 활용하기 때문에 언어적 치료보다 왜곡된 핵심신념을 보다 기능적으로 변화시킬 수 있다(Cooper, 2011). 구체적으로, 이미지 재구성은 성인인 자기가 심상에 등장하여 과거 외상 사건을 재경험 및 재구성하며 어린 시절보다 개선된 성인 수준의 인지기능으로 대안적인 사고를 원활하게 찾아낼 수 있도록 도와 왜곡된 인지 과정을 적응적으로 재구성한다(Lee & Kwon, 2013; Wild, et al., 2008). 동시에 외상경험에 대한 노출을 가능하게 하며 성인인 자신이 외상 당시의 어린 자신에게 위안이 되는 역할을 하기 때문에 참여자의 탈락률을 낮추는 특성도 있다(Stopa, 2009). 실제로 이미 국외에서는 폭식장애를 유발하는 더 근본적인 원인을 외상경험에 초점을 두고, 이에 대한 이미지 재구성의 치료적 효과를 입증하였으며(Cooper, 2011; Cooper, et al., 2007), 최근까지도 효과성을 증명하기 위한 연구들이 활발하게 진행되고 있다(Dugué, et al., 2019; Kadriu, et al., 2021).

이미지 재구성은 부정적인 자기 심상 및 관련 초기 기억을 수정하기 위한 심리적인 개입법으로(Arntz, et al., 2014), 현재 경험하는 정서적 어려움의 기원이 되는 초기 기억을 심상 속에서 재경험하는 동시에 개인의 적응적인 욕구를 반영하는 방식으로 해당 기억을 재구성해보는 3단계 개입법이다(Arntz, et al., 2014). 1단계에서는 자서전적 기억에 직접 개입하기 위해 사건 당시의 과거 자신의 관점으로 기억을 회상하여 노출을 경험하고, 2단계에서는 현재 자신의 관점으로 과거 사건을 관찰하면서 현재의 성인인 자신이 개입하여 과거 어린 시절의 자신이 만족스러울 만큼 위안과 도움을 준

다. 마지막 3단계에서는 다시 어린 시절 자신의 관점으로 돌아가 2단계에서 성인인 자신에게 도움 받은 내용들을 통합한 뒤 새롭게 배운 것을 응고화하도록 돕는 과정으로 이루어진다. 이러한 3단계의 과정을 거쳐 이미지 재구성은 부정적 자기심상과 고통스러운 자서전적 기억 모두에 수반되는 핵심 믿음을 보다 기능적으로 변화시킨다 (Cooper, 2011; Stopa, 2009). 따라서, 이러한 이미지 재구성의 특성을 기반으로 폭식자들이 심상 속에서 초기 아동·청소년기의 대인외상에 노출되었을 때 성인인 자신이 직접 개입하여 위안과 도움을 주며 사건을 재경험하는 것은 왜곡된 인지를 재구성하는 데 큰 유효유가 될 것으로 보인다.

또한, 이미지 재구성은 미래의 긍정적 시나리오에 대한 심상을 통해 치료적인 효과도 얻을 수 있다. 이는 미래사건을 긍정적으로 상상하는 것은 같은 사건이 미래에 발생하는 것으로 지각할 가능성을 높이고(Carroll, 1978), 이에 따라 행동의 동기 수준과 적응적인 인지 기능의 수준을 높일 수 있으므로 개인의 목표지향적인 행동을 향상시킬 수 있다는 것이다(Libby, et al., 2007; Pictet, et al., 2011). 따라서, 이와 같은 연구를 바탕으로 미래 심상을 통해 폭식을 유발했던 가장 최근의 대인관계적 스트레스 사건을 개인이 원하는 긍정적인 결말로 재구성하는 것은 유사한 미래 상황에 당면했을 때 보다 적응적으로 사고하고, 적절하게 대처할 가능성을 높여주므로 폭식 증상의 감소에 도움이 될 것으로 기대된다.

따라서, 본 연구의 목적은 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 폭식 증상의 감소를 위해 자기관리, 언어적 접근의 인지적 재구성, 심상적 접근의 이미지 재구성을 활용한 인지적 재구성 및 노출, 이완훈련, 스트레스 대처 훈련으로 구성된 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램(Cognitive Behavioral Therapy Using Imagery Rescripting)을 개발하는 것이며, 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램의 각 구성요인은 다음과 같다.

첫째, 자기관리(Self-Management)는 인지행동치료 기법 중 하나로 자신이 원하는 방향으로 행동을 변화시키기 위해 기술이나 전략들을 사용하여 변화를 주도하는 과정이다(Rehm & Rokke, 1988). 본 연구에서는 식단계획, 식단일지 쓰기가 이상섭식 행동을 줄이는 것에 효과적인 방법이라는(김미리혜, 2008) 점에 착안하여 자기관리에 규칙적인 식단계획, 폭식 피드백 일지 및 섭식DTR일지를 포함하였다. 따라서, 이것들을 매일의 과제로 제시하고, 회기에서 다루며 폭식에 대한 자기관리가 체계적으로 습관화

될 수 있도록 하였다.

둘째, 인지적 재구성(Cognitive Restructuring)은 정서 장애의 원인과 심리적 고통이 되는 부적응적인 사고를 탐색하여 이를 적응적인 사고로 수정하고, 변화할 수 있도록 돕는 작업이다(Hope, et al., 2010; Wright, et al., 2009). 이러한 인지적 재구성은 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성에게 세 가지 측면에서 도움을 줄 수 있다. 첫째는 대인외상경험으로 인해 생겨난 자신 및 타인에 대한 부적응적인 사고 및 신념에 대한 왜곡을 수정시킬 수 있다. 둘째는 폭식으로 인한 부적응적인 사고를 수정시킬 수 있다. 셋째는 대인외상과 폭식에 대한 사고 및 신념의 변화가 불안, 우울 및 분노와 같은 부정 정서의 유발을 낮출 수 있으므로, 폭식으로 연결된 회피패턴을 감소시키는 기회를 제공해준다.

셋째, 이미지 재구성(Imagery Rescripting)은 과거 대인외상에 대한 노출을 경험하게 하고, 이에 대한 왜곡된 사고 및 핵심 신념을 수정하게 하여 심상을 통한 인지적 재구성을 효과적으로 도모한다. 즉, 이미지 재구성은 대인외상경험으로 인해 파생된 기존의 부정적인 자기개념과 대립하는 긍정적인 자기개념의 수정을 도움으로써, 초기 기억의 일화적 정보와 연결되는 자기개념을 보다 적응적으로 변화시킬 수 있다(Brewin, 2006; Brewin, et al., 2010). 또한, 1차적으로 변화된 긍정적 자기개념을 토대로 최근 폭식을 유발한 대인관계적 스트레스 상황을 심상을 통해 인지를 수정하고, 적절하게 대처하도록 함으로써 미래에 유사한 상황에 당면했을 때 보다 적응적으로 상황을 해결할 수 있게 한다. 이러한 2차적인 이미지 재구성의 미래 심상은 1차적으로 변화된 긍정적인 자기개념에 대한 사고를 더 공고히 할 수 있는 기회와 대인관계의 스트레스 대처능력 증진에 도움을 준다.

넷째, 이완(Relaxation)이란 신체가 긴장되어 있거나 불필요한 걱정 및 두려움으로부터 자유로운 편안한 상태를 말한다(Payne & Donaghy, 2010). 즉, 이완훈련은 심리적 측면과 생리적 측면의 상호작용이 이루어져 편안한 기분을 유지할 수 있도록 돕는 훈련으로 대표적인 이완훈련에는 호흡, 점진적 근육 이완, 심상이 있다(Smith, 1999). 대인외상경험이 있는 폭식자들은 대인관계적 스트레스와 정서조절에 매우 취약하여 우울, 불안 및 분노와 같은 부정 정서에 의해 폭식이 유발되므로(Fairburn, 1995), 이완훈련을 통해 스트레스 감소와 정서적인 조절감에 도움이 될 것이다.

다섯째, 스트레스 대처훈련은 스트레스 상황을 줄이거나 없애기 위해 개인에게 적

응적인 인지·행동적 방법을 알려주고, 훈련하는 과정이다(Lazarus & Folkman, 1984). 초기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향자들의 경우 일상생활의 대인관계적 문제 상황이 발생하였을 때 이러한 스트레스 상황을 객관적으로 평가하는데 어려움이 있고, 취약한 대처전략을 갖고 있으므로, 이로 인한 스트레스 증가가 폭식의 빈도를 증가시킨다(오지원, 2000). 따라서 스트레스를 유발한 상황에 대한 객관적인 평가와 문제해결 기술의 스트레스 대처전략을 통해 이들의 회피적이고 정서중심적인 대처방식을 문제해결중심의 대처방식으로 수정시키는 것이 중요하다.

종합하면, 본 연구에서는 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 대상으로 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램을 개발 및 실시하여 그 효과를 검증하고자 하였다. 이를 위해 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램을 실시한 실험집단, 전통적인 인지행동치료 프로그램을 실시한 비교집단 및 통제집단과의 차이를 사전, 사후, 추후에 걸쳐 확인하고자 하였으며 섭식 변인(부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동), 인지 변인(역기능적 신념, 부정적 자동적 사고, 자아존중감), 정서 변인(정서조절곤란, 우울, 상태-특성 불안, 상태-특성 분노) 및 행동 변인(스트레스 대처방식)의 네 가지 측면의 변화를 통해 프로그램의 효과성을 살펴보고자 하였다.

II. 이론적 배경

1. 섭식장애 및 폭식의 정의 및 특징

정신장애의 진단 및 통계편람 제 5판(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5thEd; 이하 DSM-5)에 따르면 섭식장애(Eating Disorder: ED)는 심각하게 혼란된 섭식행동을 핵심적인 특징으로 하는 심리장애이다. 섭식장애는 개인의 신체적 손상 및 심리적 어려움을 동반하고, 섭식행동이 계속적으로 불규칙해질수록 정신적 부작용도 더욱 심해져 가족, 직장 및 학교 등의 모든 생활과 대인관계에 악영향을 미치며, 심할 경우 생명의 위협까지 줄 수 있는 심각한 정신적 질병이다(박찬섭, 2000).

섭식장애의 하위유형은 이식증, 되새김장애, 신경성 식욕부진증, 회피적/제한적 음식섭취장애, 신경성 폭식증 및 폭식장애가 있으며 이 중 유병률이 비교적 높은 편에 속하는 신경성 식욕부진증, 신경성 폭식증 및 폭식장애는 모두 폭식과 관련이 있다.

폭식이 진단기준 자체에 명시되어 있는 장애는 신경성 폭식증과 폭식장애로, DSM-5에서 두 장애의 폭식삽화는 모두 ‘유사한 상황에서 보통 2시간 이내의 제한된 시간 동안 대부분의 사람들이 먹는 것보다 분명하게 많은 양의 음식을 섭취하는 것’과 ‘삽화 중에 먹는 것에 대한 조절 능력의 상실감을 경험하는 것’으로 정의된다(APA, 2013).

폭식은 섭식장애를 진단하는 중요한 요인이기도 하지만 다른 부정 정서와 같은 심리적 문제들의 원인이자 촉발요인 및 유지요인으로 작용하기도 한다(Fairburn, et al., 1993). 폭식은 불안, 긴장, 지루함, 외로움, 분노 등의 심리적 문제들의 상태에 의해 일어날 수 있는데 이러한 부정적인 정서는 폭식을 유발한다(김준기, 1997). 이때, 부정적인 기분 상태에서의 폭식은 개인에게 일시적인 위안을 주기도 하지만 곧이어 죄의식, 수치감, 분노 등을 경험시킨다(이진희 외, 1999). 그럼에도 불구하고, 폭식이 반복되는 이유는 폭식이 혐오적인 자기지각, 부정 정서 상태로부터 일시적으로 주의를 거두어주는 기능을 하는 것으로 보이며, 더 나아가 폭식 후 죄책감이나 수치감 등 부정 정서를 경험하더라도 혐오적 자기지각이나 실패지각 탓이 아니라 폭식 탓으로 돌리게 되며 폭식이 부정 정서에 대한 대안적 귀인을 제공하는 것으로 여겨진다(Heatherton & Baumeister, 1991).

2. 폭식장애의 정의 및 특징

폭식장애는 1959년 Stunkard에 의해 비만인 사람 중에 폭식 문제로 고통 받고 있는 사람들이 있다는 보고 후에 거의 주목을 받지 못했다. 그러나 1979년 Russell이 신경성 폭식 증상을 소개하면서 알려지게 되었고, 신경성 폭식증이 DSM-III에 ‘폭식증’이라는 진단명으로 처음 수록되었다. 이후 DSM-IV에서 폭식증이 ‘신경성 폭식증’으로 ‘폭식장애’는 공식적인 명칭 없이 ‘달리 분류 되지 않는 섭식 장애’로 추가적인 진단에 포함되었다. 그리고 현재 DSM-5에서는 폭식장애(Binge Eating Disorder)가 새로운 진단명으로 추가되며, 폭식 직후의 보상유무에 따라 ‘신경성 폭식증’과 ‘폭식장애’로 진단명이 수록되었다.

폭식장애는 신경성 폭식증과 달리 폭식 후에 체중의 증가를 막기 위한 부적절한 보상행동이 나타나지 않는 것이 특징이다. 부적절한 보상행동이란 폭식 후에 스스로 유도한 구토, 이뇨제, 관장약이나 다른 치료 약물의 남용, 금식 혹은 과도한 운동 등을 말한다. 폭식장애의 경우 폭식삽화가 ‘평소보다 많은 양을 급하게 먹음’, ‘불편하게 배가 부를 때까지 먹음’, ‘신체적으로 배고프지 않은데도 많은 양의 음식을 먹음’, ‘얼마나 많이 먹는지에 대한 부끄러운 느낌 때문에 혼자서 먹음’, ‘폭식 후 스스로에 대한 역겨운 느낌, 우울감 혹은 큰 죄책감을 느낌’ 중 세 가지 이상의 특징을 보여야 한다고 명시되어있다(APA, 2013).

폭식장애의 유병률은 3%이고(Hudson, et al., 2007), 주로 젊은 성인 여성들에게서 나타난다(Pyle, et al., 1981). 폭식장애는 다양한 부적응적인 특성과 관계가 있다. 폭식자는 충동성이 높을 경우 섭식장애의 증상심각도가 높게 나타나고, 섭식행동을 조절하지 못한다고 하였다(Craighead, et al., 2013). 이들이 폭식하는 동안의 특징은 어떤 특정 영양소에 대한 갈망이 아닌 섭취한 음식의 비정상적인 양에 있다. 폭식자는 일단 한 번 음식을 먹기 시작하면 스스로 멈출 수 없고, 조절능력이 떨어지기 때문에 폭식은 대부분 밤에, 아무도 보지 않을 때, 혼자 집에 있을 때 자주 일어난다. 이처럼 폭식은 혼자만의 공간에서 비밀스럽게 이루어지는 경우가 많아, 가족 및 친구 등과 같은 주변 사람들이 이러한 사실을 모르는 경우가 많다(권석만, 2013).

3. 아동·청소년기 대인외상경험의 정의 및 특징

대인외상경험(Interpersonal Traumatic Experience)은 보통 외상의 원인이 타인일 경우를 말하며, 타인과의 관계로 인하여 발생한 외상 사건의 경험을 의미한다(Afifi, et al., 2010; Allen, 2008; D'Andrea, et al., 2012; Romito & Grassi, 2007). 즉, 관계 안에서 학대, 폭력, 소외, 이별, 배신 등 주관적으로 지각한 삶의 위기나 감정을 뒤흔드는 사건으로, 부정적인 심리적 결과를 유발하여 극심한 수준의 스트레스를 만들어내는 사건들을 직접적으로 경험하는 것이다. 특히, 사랑하는 사람의 질병이나 죽음과 같은 상실은 극심한 심리적 고통을 야기할 수 있으며(이수진, 장혜인, 2017), 죽음이나 이별과 같은 상실이 급작스럽게 일어났을 경우에는 더욱 혼란을 보일 수 있다(Gillies & Neimeyer, 2006). 따라서, 대인외상경험은 개인의 인지·정서·행동을 포괄하여 전 영역을 황폐화시키는 대인 간 폭력 경험을 의미하며(Courtois & Ford, 2009), 본 연구에서는 관계적 상실을 포함한 모든 대인관계에서 나타나는 외상사건을 대인외상경험이라고 정의하였다.

Herman(1992)은 반복적이고 지속적인 관계외상(Relational Trauma)에 주목하였는데, 이러한 반복적인 대인외상경험은 감정조절의 어려움과 수치심, 죄책감 등의 정서적 증상이 나타나고, 기억 상실 혹은 해리장애, 타인과의 관계 변화 등이 핵심특징으로 확인되었다(Pelcovitz, et al., 1997). 대인외상경험의 경우, 심층적인 심리구조에서의 변화가 나타난다는 점에서 단순 외상과 다르며, 그 증상도 정서적 문제와 자기혐오, 자기파괴적 행동, 물질남용, 이상섭식태도 등과 같이 다양하다(Courtois & Ford, 2009; Herman, 1992).

특히, 아동·청소년기는 신체적, 정신적, 사회적인 측면의 모든 발달영역에 급격한 변화를 경험하는 시기로, 이 시기의 대인외상경험은 신경전달물질, 신경내분비계의 변화로 인한 해마와 같은 두뇌기능의 손상을 유발하여 인지와 정서를 조직해나가는 능력에 부정적인 영향을 미친다(채정호, 2004). 또한, 이러한 영향으로 인해 추후 성인이 되어서도 알코올 문제, 폭식, 자해 등과 같은 심리·행동적으로 다양한 어려움이 발생한다(Stovall-McClough & Cloitre, 2006). 구체적으로는 아동·청소년기 타인으로 인한 학대, 가정폭력, 성폭력, 따돌림 등과 같은 대인외상을 경험한 이들은 대인관계에서 문제해결능력이 떨어진다고 하였고(McLaughlin & Nolen-Hoeksema, 2012), 낮은 자아존

중감의 형성으로 인한 대인관계의 어려움, 대처능력의 문제, 자기 희생화와 같이 지속적으로 부정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었다(김희경, 2012; 윤명숙, 김서현, 2012; 최승미, 2008; Briere & Runtz, 1988, Haskett & Kistner, 1991; Wind & Silvern, 1992). 무엇보다 아동·청소년기의 대인외상은 정서조절능력의 어려움을 야기하는 것으로 밝혀졌으며(김은정, 김진숙, 2010), 사소한 스트레스에도 과도하게 반응하고 쉽게 압도당하며, 스스로를 진정시키는 데 문제가 있다. 정서적으로는 우울, 불안 및 분노와 같은 정서를 경험하게 되며(이태영, 심혜숙, 2011; 조한익, 최종환, 2013; Briere & Runtz, 1988; Wind & Silvern, 1992), 이러한 부정 정서에 대한 정서조절이 제대로 이루어지지 못하여 고통스러운 정서로부터 도망치기 위해 자기 파괴적인 행동을 일으킨다(김보미, 유성은, 2012).

4. 아동·청소년기 대인외상경험과 폭식장애의 관련 특성

아동·청소년기 대인외상경험은 전형적으로 외상후 스트레스 장애를 유발하는 것으로 알려져 있으나 폭식장애, 성격장애, 우울장애 등의 질환과도 밀접한 관련이 있는 것으로 보고되었다(Courtois & Ford, 2009). 초기 대인외상경험과 폭식장애와의 관련성을 살펴본 연구결과에 따르면, 연구에 참여한 성인 폭식장애 환자 중 59%가 정서적 학대, 30%가 성적 학대, 69%가 정서적 무시, 그리고 49%는 신체적 무시를 당했다고 보고하였다(Grilo & Masheb, 2001). 전체적으로 살펴보면 폭식장애 환자 집단의 약 83%가 높은 비율로 가족 및 타인에 의한 어린 시절의 대인외상을 경험한 것이다. 또한, 같은 맥락에서 Brewerton(2007)은 중복 외상을 경험한 사람들은 폭식과 같은 위험 행동을 자주 하였다고 보고하였고, Gerke, Mazzeo와 Kliewer(2006)의 연구에서도 초기 대인외상경험은 폭식을 야기하는 데 큰 관련성이 있는 것으로 드러나 대인외상경험과 폭식장애와의 상관성을 시사한다.

몇몇의 연구들은 어린 시절의 대인외상경험이 이후의 폭식장애를 유발하는지에 대한 관련성을 밝히기 위해 노력하였다. Fairburn 등(1999)의 연구에 의하면, 성인기의 폭식장애는 이전의 정신적 위협에 대한 노출과 관련이 있다고 하였으며, 특히, 폭식장애를 가진 성인의 경우 과거 대인외상경험으로 인한 부정적인 자기 평가가 두드러지게

나타난다고 보고하였다. 다른 선행연구에서도 과거 대인외상경험은 성인기의 폭식장애를 유발하는 근원적인 변인임을 보고하였으며(Grilo & Masheb, 2001; Monteleone, et al., 2021), 어린 시절의 대인외상경험은 개인의 심리적인 문제에 대한 장기적인 영향을 미쳐 성인기의 폭식장애를 나타낸다고 하였다(Feinson & Hornik-Lurie, 2016). 이때 일련의 연구들에서는 어린 시절의 대인외상경험과 성인기 폭식장애를 연결하는 메커니즘에 주목하였다. 예를 들어, 앞서 연구에서 밝힌 자기 비난을 포함하는 부정적인 자기평가(Fairburn, et al., 1999; Feinson & Hornik-Lurie, 2016), 낮은 자존감(Groleau, et al., 2012), 정서조절곤란(Racine & Wildes, 2015) 등이 대표적이다. 최근 선행연구에서도 초기 대인외상경험과 성인기 여성의 폭식 증상을 예측하는 인지적, 정서적 경로를 다양한 매개변인들의 순차적인 경로로 검증하였다(한기백, 2021). 관련 변인들에는 어린 시절의 대인외상 사건으로 형성된 부정적인 자기개념 및 타인에 대한 불신과 같은 역기능적 신념, 무능감과 관련된 낮은 자아존중감 등이 있었으며 이러한 요소들이 지속적인 대인관계적 어려움(Interpersonal Difficulties)에 영향을 미쳐 정서조절 문제를 일으키고, 이에 대한 대처방안으로 폭식이 작용한다고 하였다. 이와 같이 다수의 선행연구들에서 아동·청소년기 대인외상경험이 폭식장애를 유발하는 강력한 위험요인임을 보고하며, 초기 대인외상경험과 폭식장애와의 높은 상관성을 시사하였다.

1) 인지적 특성

(1) 아동·청소년기 대인외상경험의 인지적 특성

① 인지적 내용(자기 지각, 대인 지각)의 오류

대인외상경험자는 외상경험 이후에 다양한 부적응적인 증상을 보이며, 외상사건과 관련된 인지에 있어서도 부정적인 변화가 발생한다. 외상을 경험한 개인은 외상경험 이후에 자신과 세상에 대한 기본적인 사고와 신념의 변화가 나타나는데(Ehlers & Clark, 2000; Foa & Rothbaum, 1998), 이는 외상 사건이 대체로 갑작스럽게 일어나기 때문에 개인은 통제력 상실 및 무력감을 경험하면서 외상사건 이전에 가지고 있던 자신 및 세상에 대해 혼란을 겪기 때문이다.

Janoff-Bulman(1989, 1992)은 인간의 보편적 신념인 세상이 우호적이라는 신념, 세상은 의미 있는 곳이라는 신념, 그리고 자신이 가치 있는 존재라는 신념이 외상 사건을 경험 한 후에 큰 변화를 겪게 된다고 하였다. 외상 사건은 세상은 안전한 곳이라는 개인의 인식을 파괴하며, 외상 경험자의 외부세상은 악의적이며 위협적이고 내부세상은 붕괴되고 쓸모없어 보이게 만든다(Janoff-Bulman, 2006). Bolton과 Hill(1996) 또한, 외상경험은 기존에 자신이 가지고 있던 자기 스스로가 유능한 존재이고 세상은 충분히 예측가능하며 자신에게 필요한 것을 충분히 제공해 줄 수 있다는 신념이 붕괴된다고 하였다. 특히, 외상사건의 영향으로 개인은 자신이 무능하다는 자기비난적인 신념을 가지게 되면 무기력감과 죄책감이 증가하고, 세상이 위험하다는 비현실적인 신념을 가지게 될 경우 현재 상황에 대한 위협과 불안, 공포감이 심해질 수 있다고 하였다. 즉, 대인외상경험자들은 스스로에 대해 ‘무력한, 무능한, 상처 입은, 타인에게 거부 받은’ 등의 부정적인 사고를 발달시키는 것이다(Luxenberg, et al., 2001).

아동·청소년기는 논리적이고 합리적인 사고가 충분히 발달해 있지 않은 상태이기 때문에 이 시기의 대인외상경험은 자신 및 타인에 대한 지각 혹은 귀인 방식을 더 왜곡시킬 가능성을 증가시킨다(Briere, 1996; Browne & Winkelman, 2007; Mannarino & Cohen, 1996). 특히, 발달이 완료되지 못한 아동·청소년기의 경우, 세상의 중심을 자신으로 보는 등의 전조작기 사고 및 자기중심적(Egocentrism) 사고로 인해 자신을 대인외상경험의 원인으로 인식하는 경향성이 있다. 더불어 어린 시절 대인외상을 경험한 경우에는 외상을 겪지 않은 사람들은 외상을 당한 자신을 이해할 수 없다는 혼자만의 생각으로 인해 외부 현실과의 접촉이 감소하기 때문에 결국 현재의 어려움이 어린 시절에 경험한 대인외상과 관련되었다고 설명 받을 기회를 놓치게 된다. 이들은 자신에게 상처를 주었던 가해자가 말했던 결점을 본인에게서 찾고, 대인외상의 원인을 자신으로 받아들여 ‘그 일이 일어난 것은 내 탓이다(자기 비난)’와 같은 사고를 한다. 즉, 대인외상에 대한 책임이 행위를 가한 가해자가 아닌 자기 자신에게 돌려 스스로 과도한 자기비난에 빠지고, 이로 인해 낮은 자아존중감, 수치심과 죄책감 등의 고통감을 경험한다고 하였다(안현의, 장진이, 조하나, 2009).

이들은 또한 대인외상경험으로 인한 타인에 대한 불신으로 외상 이후에 타인들과 관계를 맺고 친밀해지는 능력에 어려움을 겪는다. 이로 인해 타인에 대해서도 학대와 착취를 예상하는 사고가 발달되기 때문에 누군가가 자신을 존중하거나 친절하게 대할

때 놀라거나 불안하게 되며, 타인을 신뢰하기 어렵게 된다(이정민, 2019). 그로 인해 개인의 대인 지각 및 대인관계에 대한 표상은 영향을 받게 된다(Cole & Putnam, 1992; Salo, et al., 2004).

따라서, 아동·청소년기의 대인외상경험은 개인의 자기지각, 대인지각을 왜곡시켜 ‘내가 결함이 많아서 사랑받을 수 없는 것’, ‘나는 완전히 무능하다’, ‘나는 별로다’, ‘타인에게 지지받거나 수용되지 못할 것’, ‘세상 사람들은 믿을 수 없다’ 등의 사고 및 신념을 발달시킨다(이아람, 김남재, 2012; Foa, et al., 1993; Foa & Rothbaum, 1998; Herman, 1992). 이처럼 대인외상경험은 부정적인 자기 지각 및 대인 지각을 형성하여 외상경험자들이 자신에 대한 일관된 믿음을 유지하는 것에 문제를 일으킬 수 있으며(최은영, 안현의, 2011), 관계의 기초가 되는 신뢰감 구축에 영향을 미쳐 타인과의 관계 형성 및 유지에 지속적인 어려움을 일으킬 수 있다(Williams & Galliher, 2006). 또한, 타인에 대한 불신감으로 인하여 주위 사람들에게 도움을 구하지 못하는 악순환을 형성하여 PTSD나 우울, 불안 증상이 심화될 가능성을 높일 수 있다(Ehlers & Clark, 2000; Foa & Rothbaum, 1998).

② 인지적 과정(대인외상경험)의 오류

대인외상경험자는 외상경험 이후에 인지적 내용에서의 오류뿐만 아니라 외상경험을 처리하는 인지적 과정에서도 오류가 발생한다. 이는 대인외상경험자의 경우 외상 사건 당시의 무력했던 자신에 대한 부정적 자기상(Negative Self-Image)이 기억으로 남아있기 때문에(Hackmann, et al., 2000) 일상생활에서 외상 사건이 침습적으로 떠오르거나 그 사건과 관련된 단서만 봐도 강한 정서에 압도되는 인지적 과정에서의 문제가 발생하는 것이다(Ehlers & Clark, 2000). 즉, 과거 모습이 현재 자신의 모습을 반영한다고 생각하여 초기 외상사건이 현재에는 실질적인 영향을 미치지 않음에도 불구하고, 적응적인 대처를 하지 못하는 상태가 되는 것이다(최윤경, 2010).

대인외상경험자의 외상경험 후의 외상 기억은 일반 기억과 다른 특징이 있다. 외상 사건이 예상치 못한 상태에서 노출되었기 때문에 일반적인 기억과는 다른 형태로 정보가 저장될 수 있는 것이다. 이를 두고, 기존 외상의 인지모델에서는 외상 기억이 ‘조각난 상태’로 입력되며 다른 기억에 비해 정교성과 맥락성의 질이 떨어진다는 점을 주

요한 특징으로 설명하였다(Ehlers & Clark, 2000; Foa, et al., 1989; Foa, et al., 1993; Foa & Rothbaum, 1998). 따라서, 외상경험자들의 외상에 대한 기억은 비조직화된 조각된 상태의 특성을 보인다. 즉, 과거 외상적 사건이 파편화된 기억으로 회상되어 외상경험 당시의 전체적인 상황 및 맥락에 대한 이해가 없기 때문에 자신의 부정적인 자아상에 초점을 두고 편향된 부정적 인지처리 과정이 반복되는 것이다.

이러한 외상경험에 대한 기억 처리 과정에는 외상 기억에 대한 ‘침습적인 재경험’과 ‘관련 자극의 회피’를 반복하는 특징이 있다. 먼저, 침습적인 재경험은 대인외상경험에 대한 기억으로 사건과 관련된 심상이나 생각, 혹은 지각의 형태로 나타나며 불수의적으로 떠오른다는 점에서 ‘침습적’이라는 표현을 사용한다. 외상이라는 부정적인 심리적 경험이 기억 및 이미지의 형태로 표상되기 때문에 대인외상 직후 형성된 외상 기억 및 이미지는 비조직화되고 침습적인 형태로, 외상 사건 자체의 특성보다는 개인의 기억을 통해 유지되고 과장된다(Rubin, et al., 2008). 이때, 침습적 기억의 특성은 신체 감각적인 느낌이 매우 생생하여(Hackmann, et al., 2004; Rubin, et al., 2004; Speckens, et al., 2007) 외상 기억의 침습적 회상의 전과 후의 환경적인 맥락을 연결 짓지 못하는(Michael, et al., 2005) 특성들을 보이기 때문에 외상 기억이 침습적으로 회상되었을 때 과거의 외상 기억이 회상된 것이라는 감각을 상실하게 된다. 또한, 마치 과거 외상경험의 피해자로 돌아가서 현재에도 외상 사건을 마치 경험하고 있는 것과 같은 착각을 불러일으키는 해리 상태를 보이는데 이를 플래시백이라고 한다. 다음으로, 관련 자극의 회피는 대인외상과 관련된 생각, 느낌, 대화, 외상 기억을 불러일으킬 수 있는 장소나 사람 및 활동 등을 의도적으로 회피하는 것이다. 이로 인해 외상경험의 중요한 측면을 회상하지 못하게 되며, 전반적으로 정서 경험의 범위가 제한되거나 정서적 마비(Numbing)가 나타날 수 있다.

이처럼 대인외상경험자들의 초점화된 부정적인 자아상은 외상경험을 더욱 위협적으로 인식하게하며 인지·행동적인 차원에서 이를 회피하고자 사고억제, 연상자극에 대한 억압 및 회피, 생각하지 않기(Not to Think), 반추 등과 같은 부적절한 대처 기제들을 사용하게 된다(Ehlers & Clark, 2000). 그러나 역설적이게도 사고를 억제 및 회피하고자 하는 시도를 하면 할수록 그 사고는 더욱 증가하는 양상을 보이므로(Wegner, et al., 1987), 외상 기억은 오히려 더욱 강렬하고 빈번하게 회상되면서 인지적인 문제를 비롯한 다양한 정서와 행동상의 문제들을 유발 및 지속시키게 된다. 즉,

자신이 겪은 외상 경험에 대해 부적응적인 대처전략들을 사용함으로써 과편화된 외상 기억이 왜곡되고 지속적으로 부정적인 자아상과 외상 사건에 대한 부정적인 인지적 평가(Negative Cognitive Appraisal)를 하게 되는 것이다. 이러한 인지적 처리 과정에서 오류는 외상 기억이 기존의 자서전적 기억들과 통합되지 못하게하여 적응적으로 변화해 나갈 수 있는 경로 혹은 자연적으로 회복할 수 있는 경로를 방해하므로 삼화적 기억이나 플래시백을 포함하여 다양한 침투적 반추가 계속적으로 동반될 수 있다(Ehlers & Steil, 1995; Reynolds & Brewin, 1998; Steil & Ehlers, 2000).

한편, 외상경험의 극복에 중요한 영향을 미치는 요인으로 자아존중감이 있다(Agabi & Wilson, 2005). 자아존중감(Self-esteem)은 자기 자신에 대한 긍정적 또는 부정적 평가와 관련되는 것으로(Rosenberg, 1965) 자신을 얼마나 유능하고 중요한 존재로 인식하는지에 대한 심리적·인지적 판단을 의미한다(Coopersmith, 1967). 또한, 자아존중감은 자신의 자아상에 대한 일반화된 긍정적인 평가를 의미하는데, 이는 삶의 전반에서 직면하게 되는 여러 가지 역경을 극복 및 해결하게 하는 핵심적인 역할을 한다.

이에 따라, 낮은 자아존중감은 삶을 지속하면서 정신 및 신체적 어려움을 극복하는 장애물로 지속적으로 작용하는 반면, 높은 자아존중감은 긍정적인 자아상을 강화시켜 부정적인 사건들을 안정화시키는데 기여하는 광범위한 내적인 속성을 지니고 상황을 역전시킬 수 있다(Campbell, et al., 1991; Link, et al., 2001). 즉, 자아존중감은 과거의 외상경험과 현재의 심리적 상태를 연결하는 여러 심리학적 변인들 사이의 주요한 매개 변인으로 기능할 수 있는 것이다(허정윤, 유영달, 2012). 선행연구에 의하면, 개인의 자아존중감을 향상시키는 데 있어서 낮은 자아존중감을 형성시킨 초기의 원인수준에서 개입하는 것이 중요하다고 하였다(Harter, 1990). 따라서, 자아존중감은 과거의 대인 외상경험과 현재의 심리적 상태를 극복하게 하는데 있어서 중요한 변수로 작용하므로 초기에 형성된 낮은 자아존중감의 향상을 위한 적합한 치료적 개입은 매우 중요할 것으로 보인다.

(2) 성인 폭식장애의 인지적 특성

폭식과 관련된 부적응적인 인지 및 사고의 요인들은 부정 정서에 선행해서 나타나는 것으로 보고되고 있다(Masuda, et al., 2012). Heatherton과 Baumeister(1991)의 정서조

절 및 회피모델(Escape Model)에 따르면, 폭식자들은 자기 스스로에게 높은 기대와 기준을 부과하고 있으며 타인들도 자신에게 높은 기대를 가지고 있을 것이라 사고한다. 따라서, 타인의 요구에 민감한 경향이 있기 때문에 타인의 기대를 충족시켜주기 위해 노력한다. 이러한 특성으로 만약 타인의 기대를 조금이라도 충족시켜주지 못했을 때 이들은 자기비난적 사고를 하며, 스스로에 대한 혐오와 부적절감으로 인해 불안 및 우울과 같은 정서적인 고통을 겪게 된다고 하였다. 폭식자들은 자기가 직접적으로 당면한 문제와 환경에만 관심을 둬으로써 정서적 고통을 피하려고 한다. 이러한 좁은 시각은 더 의미 있는 다른 문제에 관심을 두지 못하도록 방해하고, 부정적인 자기인식(Self-Awareness)으로부터 회피하게 해준다. 또한, 섭식장애 환자들은 흑백논리 사고방식의 영향으로 작은 실수도 용납하기 어려워하며(김정옥, 2000), 그들에게 있어서 모든 행위는 성공 아니면 실패로 귀결된다(김중술 외, 2003). 이와 같은 인지적인 편협함(Cognitive Narrowing)은 결국 폭식자들의 역기능적인 사고를 활성화시킨다. 실제로 선행연구에 의하면, 섭식장애 환자들의 경우 작업 기억 용량 및 집행 기능, 인지적 유연성 등이 비임상군보다 유의하게 저하되어 있다는 연구결과들이 이를 간접적으로 뒷받침 하고 있다(임지수, 박경, 2018; Hirst, et al., 2017; Hofmann, et al., 2008; Schmeichel, et al., 2008; Tchanturia, et al., 2004).

폭식장애 환자는 자기 비난적 사고와 타인이 자신을 부정적으로 생각할 것이라는 생각으로 인하여 심리적 부적응을 나타낸다(Jacobson & Robins, 1989; Striegel-Moore, et al., 1993). 이러한 폭식자의 자기비난적 사고와 타인에 대한 지각 모두에는 자아존중감과 높은 관련성이 있다. 자아존중감은 자신 스스로가 가치가 있고 자기수용이 가능한 존재라고 느끼는 정도를 의미하며, 자아에 대한 긍정적이거나 부정적인 태도 및 평가이다(Rosenberg, 1979). 폭식장애 환자들은 자기 자신을 부정적으로 평가하는데(김정옥, 2000), 이들은 다른 영역에서 자기가 이룬 것에 대해 자신이 없기 때문에 폭식의 여부에 따라 자기를 평가하려 한다(Fairburn & Harrison, 2003). 이처럼 낮은 자아존중감은 많은 선행연구들을 통해 폭식과 유의미한 상관이 있음이 밝혀졌다(Button, et al., 1996; Fryer, et al., 1997; Gan, et al., 2018; Herbozo, et al., 2015; Pasold, et al., 2014; Tomori & Rus-Makovec, 2000). 특히, 낮은 자아존중감은 남성보다 여성의 폭식행동에 더욱 강한 유발하는 예측요인으로 보고되었다(Dorairaj, et al., 2013). 폭식장애를 보이는 사람들은 어린 시절부터 자신에 대해 근본적인 불신감, 무력

감, 열등감, 자기비하 경향성을 가지고 있으며 자신이 가진 능력 및 판단에 의한 삶을 살기보다는 주위 사람들의 높은 기대에 부응하는 삶을 살아가기 위해 많은 노력을 하게 된다(Fairburn, et al., 1993). 또한, 자신만의 독립적인 판단이 요구될 때는 스스로를 아무것도 할 수 없는 하찮은 인간으로 생각하기 때문에 다른 사람으로부터 사랑받을 수 없을 것 같은 두려움을 느끼게 된다고 하였다. 이때, 음식은 단순히 불쾌한 기분을 해소하기 위한 방법뿐만 아니라, 자신 스스로 조절할 수 있는 자신감을 얻고자 하는 심리적 기제가 내포되어 있다는 설명이 있다(박정희, 2012).

이처럼 낮은 자아존중감은 폭식의 위험요인으로 명백하게 밝혀졌으나 높은 자아존중감은 폭식에 대한 보호적 기능을 한다는 주장도 있다. Twamley와 Davis(1999)는 자아존중감 수준이 높을 때에는 폭식과 같은 병리적인 섭식을 할 가능성이 감소한다고 주장하였다. 따라서, 자아존중감과 폭식의 관계에 대한 연구결과들을 종합해보면, 낮은 자아존중감은 폭식의 위험성을 증가시키는 한편, 높은 자아존중감은 이에 대한 완충제로 작용할 수 있음을 알 수 있다.

2) 정서적 특성

(1) 정서조절곤란

① 아동·청소년기 대인외상경험과 정서조절곤란

초기 대인외상경험자들은 관계 속에서 자신의 감정이나 정서, 부적절한 행동 등을 정확하게 알아차리는 데 어려움이 있다(최나운, 이영호, 2018). 이는 과거 어린 시절의 대인외상경험이 개인으로 하여금 스스로를 무능하고, 상처받은 존재로 인지하게 함으로써 세상에 대한 부정적인 시각을 가지게 하기 때문이다(Luxenberg, et al., 2001). 이들은 다른 사람들이 자신을 이해하지 못한다는 사고가 내재되어 있으며 타인과의 관계를 객관적으로 바라보지 못하고, 이에 따라 자신의 정서를 적응적으로 파악, 조절 및 통제하는 것에 어려움을 겪는다.

많은 선행연구들에 따르면, 아동·청소년기의 대인외상경험은 정서조절곤란의 강력한 선행요인이며, 정서조절곤란은 초기 대인외상경험자들의 주된 기능장애라고 하였다

(안현의, 2007; Courtois & Ford, 2009; Luxenberg, et al., 2001). 대인외상경험자들은 아주 작은 스트레스에도 과도하게 반응하고 쉽게 부정 정서에 압도되며, 중립적이거나 보통의 자극에도 극도의 반응을 보여 스스로를 진정시키는 데 어려움을 겪는다. 또한, 정서를 통제하려는 시도로 자해, 약물사용 및 섭식장애와 같은 자기파괴적이고 충동적인 행동 문제를 보이기도 한다(이수연, 이동훈, 2017; Lieb, et al., 2004; Luxenberg, et al., 2001).

Allen(1995)은 발달 단계인 아동·청소년기에 외상을 겪게 되면 자신의 심리적 증상과 반응을 구체적인 사건과 연관시킬 수 있는 능력의 결함을 갖게 되고, 정서조절곤란과 자아기능의 혼란이 전반적으로 나타날 수 있다고 설명하였다. 이러한 내용을 뒷받침하는 연구로써, 최지영과 오경자(2015)는 초기 대인외상경험으로 인한 정서조절곤란이 여러 부정적인 결과를 낳게 하는 중요한 매개체가 됨을 발견하였다. 실제로 선행연구들에 의하면 초기 대인외상은 우울, 불안 및 PTSD 등과 관련이 있을 뿐만 아니라, 정서조절곤란과도 높은 관련성을 나타냈다(고나래, 2008; Cloitre, et al., 2005; Lamoureux, et al., 2012). 또한, 초기 대인외상경험과 성인기 대인관계 문제 및 우울간의 관계에서 정서조절곤란이 부분매개 하였으며(고나래, 2008; 김은정, 김진숙; 2008; 최나운, 이영호, 2018), 초기 대인외상경험과 폭식과의 관계를 살펴본 연구에서 어린 시절의 대인외상경험이 많을수록 정서조절의 곤란이 초래되고 이에 따라 폭식이 증가하는 것으로 나타났다(조혜나, 2016).

따라서, 아동·청소년기에 대인외상을 경험한 경우, 정서조절곤란이 초래될 위험성이 높은 것으로 보이며, 정서조절곤란은 외상사건의 경험으로 손상된 정서적인 적응 및 이후의 증상에 대해 파악할 수 있는 매개 변인인 것으로 시사된다(Ehring & Quack, 2010; Tull, et al., 2007).

② 폭식장애와 정서조절곤란

최근에는 폭식과 관련하여 정서조절곤란에 초점을 맞춘 연구가 급증하고 있으며, 정서조절곤란을 폭식의 선행요인으로 보고 있다(Chua, et al., 2004; Craighead, et al., 2013; Hilbert & Tuschen-Caffier, 2007). 정서조절곤란은 폭식과 같은 병리적 섭식행동에서 주요한 역할을 하는 개인의 특성 요인으로(Gianini, et al., 2013), 정서적 섭식

및 병리적 섭식 행동 집단에서 유의하게 높은 수준의 정서조절곤란이 있음이 밝혀졌으며(Lavender & Anderson, 2010; Whiteside, et al., 2007), 정서조절곤란이 심할수록 폭식의 위험성이 더 커진다고 하였다(Luxenberg, et al., 2001).

폭식자들은 부정 정서에 대한 역기능적인 대처, 혹은 부적응적인 정서조절전략이나 기술을 많이 사용하기 때문에 정서조절곤란을 폭식의 원인으로 보는 것이다(Mayhew & Edelmann, 1989; Troop, et al., 1994). 이렇듯 폭식자는 폭식이 고통스러운 정서를 빠르게 경감시켜준다는 것을 학습하며, 정서를 조절하기 위한 방법으로 폭식을 계속적으로 사용하게 된다(Arnou, et al., 1992). 즉, 폭식자는 부정 정서를 강하게 경험하고 정서가 불안정하기 때문에 폭식을 일종의 부적응적인 정서조절 전략으로 사용하는 것이다(Craighead, et al., 2013). 따라서, 폭식은 부정 정서와 연관성이 높고, 정서조절의 곤란을 느낄 때 그 위험성이 더 커지므로(이미현, 2009), 폭식에 대한 치료 개입 시 정서조절곤란의 측면을 다루는 것이 중요함을 시사한다.

(2) 우울

DSM-5에 의하면, 우울이란 주요 정서 장애로 지속적으로 우울한 기분을 보고하거나 흥미 저하, 무가치감, 수면 문제 등을 보고하는 증상으로 정의하였다. Beck(1967)은 우울을 구체적 기분 변화로서 고독, 무관심, 슬픔에 빠지게 되고 부정적인 자기 개념을 갖게 되며, 활동 수준에서 변화로 인해 초조감이나 정신운동이 지연되는 것이라고 설명하였다.

① 아동·청소년기 대인외상경험과 우울

우울은 외상경험자들에게 발견되는 대표적인 심리적 반응으로, 아동·청소년기 대인외상으로 인한 자기 손상이나 낮은 자아존중감은 일생을 통해 우울 증상들을 야기한다(Cicchetti & Toth, 1992). Beck(1967)에 의하면, 우울한 사람은 개인이 경험한 사건 그 자체 보다는 사건에 대한 인지적 왜곡이 더 문제가 되며, 이러한 인지적 왜곡이 우울을 야기한다고 하였다. 비슷한 맥락에서 초기 대인외상경험자는 외상경험으로 인한 자기비난 및 타인의 비판과 거절에 대한 두려움으로 부적응적인 인지 도식을 형성하게 되는데, 이는 우울을 유발시키는 요인이 될 수 있다는 것이다(Maciejewski & Mazure, 2006).

국외 연구들을 살펴보면, 성인 792명을 대상으로 한 연구에서 어린 시절의 학대 및 기타 외상에 노출될수록 우울의 심각성이 증가하는 것으로 나타났다(Wingo, et al., 2010). 이 밖에 다른 연구에서도 초기 대인외상과 우울 간에 강한 상관성이 있으며 아동기 외상 수준이 높을수록 심각한 우울 증상을 호소하였다는 일관된 결과가 보고되었다(Hopfenger, et al., 2016; Humphreys, et al., 2020; Mandelli, et al., 2015; Negele, et al., 2015; Rezaei & Ghazanfari, 2016).

국내 연구에서도, 대학생 467명을 대상으로 한 연구에서 아동·청소년기의 외상 경험이 우울에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났으며(박시현, 김명식, 2014), 444명의 대학생을 대상으로 한 연구에서도 어린 시절에 경험한 대인외상 사건이 많을수록 우울 수준이 높아진다는 결과가 보고되었다(고유나, 2016). 또한, 초기 대인외상경험자는 정서를 인식 및 표현하는 방법을 적절하게 습득하지 못하여 이후 성인기에 부정 정서를 유발하는 상황에서 정서 인식의 어려움을 호소하여 정서 표현을 억제하거나 회피적으로 정서조절을 할 수 있다고 하였으며, 이는 우울과 같은 심리적 부적응을 유발한다고 보았다(김혜인 외, 2012; 양유진, 정경미, 2008).

대인외상 사건은 한 개인에게 감당하기 힘든 극심한 강도의 스트레스로 작용하여 압도적인 무력감을 느끼게 하고(Ehlers & Clark, 2000), 이는 우울을 야기한다. 어린 시절의 대인외상경험은 성인기까지도 개인의 정서인식을 방해하며, 이에 따라 부정 정서 표현을 지속적으로 억제하고 회피함으로써 우울과 같은 부정 정서가 나타난다(김혜인 외, 2012).

따라서, 이러한 연구결과들을 통해 우울은 외상 사건 이후의 정신적 회복과 여러 적응적 기능 활동에 부정적 영향을 주는 심리적 증상임을 보여주기에, 대인외상경험자들의 우울을 이해하고 적절한 심리치료적 개입이 이루어져야 할 것으로 보인다.

② 폭식장애와 우울

우울을 포함하는 부정 정서는 폭식장애 집단에서 폭식의 주요한 촉발 요인으로 밝혀졌으며(Leehr, et al., 2015), 폭식장애 발병(Onset)에 있어서 우울은 다른 부정 정서에 비해 폭식 경로에서 큰 영향력을 보이는 것으로 나타났다(Beck, et al., 1988; Stice, 2001; Stice, et al., 2002). 다른 연구들에서도 우울은 폭식과 정적인 상관성을 보이며, 폭

식에 선행하는 요인임이 입증되었다(공성숙, 2001; Ganley, 1989; Laessle, et al., 1989; Pasold, et al., 2014; Polivy & Herman, 2002; Stice, et al., 2002).

폭식자들은 일상생활 전반에서 일반인보다 더 많은 스트레스를 경험하고, 이러한 스트레스는 우울을 매개로하여 폭식을 야기한다는 결과가 있다(Wolff, et al., 2000). 우울을 많이 느끼는 사람들은 그렇지 않은 사람들보다 폭식이나 다른 정신 장애를 더 많이 겪는 것으로 나타났다(Goldschmidt, et al., 2016). 그 밖의 연구에서도 폭식장애는 우울 증상과 관련되며, 체중상태와는 무관하게 심리적 고통의 증가와 관련된다고 하였다(Didie & Fitzgibbon, 2005). 비슷한 맥락에서 폭식을 하는 비만인(Marcus, et al., 1988) 및 정상 체중의 사람들(Webber, 1994) 모두 폭식을 하지 않는 일반인들에 비해 더 우울해하는 경향이 나타났고, 이와 함께 정신과적 문제 및 의학적 문제도 더 많은 것으로 확인되었다(Bulik, et al., 2002). 국내연구에서도 폭식 집단이 비폭식 집단에 비해 더 많은 우울을 경험하였으며, 우울과 정서중심 대처가 상호작용하여 폭식에 영향을 미치는 것으로 보고되었다(김혜은, 박경, 2003).

이처럼 우울과 폭식은 높은 상관성을 보이며 서로에게 영향을 끼치기 때문에 한쪽을 치료하기 위해서는 다른 한쪽도 치료해야 하는 것으로 보인다(Skinner, et al., 2012).

(3) 불안

불안이란 어떤 특정한 상황에 대해 개인으로 하여금 위험하다고 받아들임으로써 야기되는 두려움, 긴장감 또는 불쾌한 감정반응이라고 정의할 수 있다. 이는 친숙하지 않은 환경에 적응하고자 할 때 나타나는 가장 기본적인 반응양상이며, 정상인도 위험이나 고통이 예견될 때 혹은 예기치 않은 상황에 직면하였을 때 불안을 경험하게 된다. 즉, 불안은 일상생활에서 누구나 흔하게 경험할 수 있는 불쾌하고 고통스러운 감정으로 위험한 상황에서 긴장하고 경계하는 태도를 취함으로써 그러한 상황을 피할 수 있는 적응적인 반응이기도 하지만, 과도한 긴장태도를 취하게 되면 이는 부적응적임을 나타낸다(권석만, 2013).

① 아동·청소년기 대인외상경험과 불안

불안은 외상경험에 따르는 심리적 문제로 빈번하게 나타나는 증상 중 하나로(심현진, 권해수, 2013; Browne, 2002), 우울과 더불어 외상사건 경험으로 인해 초래될 수 있는 심리적 증상이다. 일반적으로 불안은 인간의 주요한 정서 요인으로 어느 누구나 경험할 수 있는 보편적인 정서장애로, 위험한 상황이나 위협에 노출되었을 때 수반될 수 있는 부정 정서이다(정세봄, 2012). 이러한 불안은 의욕을 저하시켜 지연행동을 유발하기도 하고, 자신의 불편감에 집중하도록 하여 외부의 문제보다는 자신 스스로의 불안을 통제하려는 데 집착하게 만든다. 또한, 개인의 성격형성이나 발달에도 큰 영향을 미치는데, 불안이 심한 사람일수록 자아존중감이나 자기평가가 낮아 건강한 대인관계를 유지하기가 힘들게 되고, 사회적 상황에서 많은 어려움을 겪게 되는 것으로 나타났다(백희진, 2010).

외상경험으로 인한 심리적 증상이나 정신적 장애를 겪는 사람들의 주요한 문제는 바로 과거의 외상경험이 현재의 삶으로 빈번하게 침습하는 것이다(Allen, 2008). 외상 경험자들은 고통스러운 기억, 플래시백(Flash Back) 및 외상 당시 경험했던 강렬한 감정들에 끊임없이 시달리게 된다. 예를 들어, 외상 사건과 관련된 자극이 떠오르는 침습증상은 다시 외상 사건을 경험하는 것처럼 느끼게 하여 불안을 유발 할 수 있고, 외상과 관련된 자극에 노출되었을 때 보이는 과도한 놀람 반응도 불안과 연관되어 있는 것이다. 외상경험 당시에 개인은 스스로가 아무것도 할 수 있는 것이 없다는 무력감을 느끼게 되었고, 그러한 무력감은 삶의 주체자로서의 자기(Self)의 존재감에 큰 위협을 주게 된다. 이러한 외상경험에 대한 인지적·정서적 처리가 원활하게 되지 않으면 개인으로 하여금 외상과 관련된 주변 자극에 더욱 민감하게 반응하게 되고, 외상의 경험이 침습적으로 떠올랐을 때 자기(Self)에 대한 위협을 느끼게 되며 통제 불가능한 불안을 크게 느끼게 되는 것이다(이유미, 2013).

외상 사건은 신체적 증상을 야기 시킬 수 있는데, 대표적으로 땀 흘림, 위장장애, 설사, 근육긴장, 뺨 붉힘 등의 신체적인 증상이 동반되어 나타날 수 있다(APA, 2013). 위와 같은 증상들은 회피행동을 유발하고, 회피행동은 다음에 유사한 상황에 처하게 되면, 미리 그 상황을 염려하고 두려워하는 부정적 자동적 사고를 거쳐 이전에는 느꼈던 불안을 또 느끼게 될 것이라고 생각하는 예기불안을 발생시킨다. 이러한 예기불안은 부정적인 자기평가와 평가에 대한 비현실적 위협지각이라는 인지요소들을 강화시키고, 과거의 외상 사건을 더욱 부정적으로 기억하게 되어 결국 불안의 악순환이 발생

한다(이정윤, 최정훈, 1996; 임선영 외, 2007).

외상경험자를 대상으로 정서적 각성을 유발하는 동영상을 시청하게 하여 위협관련 자극에 대해 보이는 주의편향의 경향을 확인하는 연구를 진행하였을 때, 외상경험자의 경우 외상 사건과 관련된 위협 자극을 더 빠르게 탐지하고, 경계하였다고 보고되었다(함진선, 이장한, 2012).

② 폭식장애와 불안

불안은 폭식에 선행하는 부정 감정으로 빈번하게 보고되어 왔으며(Herman, et al., 1987; Meyer, et al., 1998), 섭식문제는 기분장애나 불안장애와 같이 나타날 확률이 높은 것으로 알려져 있으며, 섭식문제를 갖고 있는 사람들의 반 이상이 기분장애나 불안장애와 같이 이환된다고 주장하였다(Meng & D'Arcy, 2015). 실제로 폭식장애를 지닌 사람의 73.8%가 공병을 보였으며, 공병을 지닌 사람 54.2%는 기분장애와의 공병을, 37.1%는 불안장애와의 공병을 가지고 있는 것으로 보고되었다(Grilo, et al., 2009).

선행연구에 의하면 우울, 불안 및 스트레스와 섭식태도와의 관계를 살펴보았을 때 불안이 섭식태도에 가장 많은 영향을 주는 요인으로 나타났다(Lee-Winn, et al., 2016). 또한 섭식장애에 있어서 우울과 불안이 같이 나타날 경우에는 섭식장애가 장기간 지속되며, 건강에 더 좋지 않은 영향과 높은 사망률을 보인다고 보고하였다(Button, et al., 2010). 특히, 불안은 폭식과 함께 이환될 경우 더욱 큰 심리사회적 손상을 야기한다고 하였다(Bodell, et al., 2012). 국내 연구에서도 대학생 52명에게 불안을 유발한 후 폭식 증상의 수준, 불안 수준 및 음식 섭취량의 관계를 알아보는 실험을 진행하였다. 그 결과 폭식경향이 높은 집단은 불안 수준이 높은 조건에서 음식 섭취량이 증가한 반면 폭식경향이 없는 통제집단에서는 음식섭취량이 감소하는 반대 양상을 보였다. 즉, 폭식경향이 높은 집단은 불안할 때 더 많은 음식을 먹는 반면 폭식경향이 낮은 집단은 불안할 때 더 적은 음식을 먹는 것으로 보고되었다(소원현, 2000). 따라서, 불안은 폭식에 선행하는 대표적인 부정 감정 중 하나로 불안에 따라 폭식 수준이 달라질 수 있으므로, 이를 적절하게 다뤄줄 필요성이 있다.

(4) 분노

분노는 인간이 표현하는 가장 원초적인 감정으로, 분노가 발생하는 데 있어서 무수한 원인이 존재한다. 일종의 자아보존감정인 분노는 첫째, 자신의 가치를 보존하려는 의지가 손상되었을 때 발생하거나 둘째, 본능적인 욕구가 충족되지 못했을 때 발생하며 마지막으로 개인이나 사회 등이 가지고 있는 가치나 신념이 위협받거나 무시당할 때 발생하게 된다. Spielberg(1996)에 따르면, 분노는 분노를 유발하는 상황에서 나타나는 즉각적인 반응으로 자율신경계의 활성화 및 근육긴장을 수반하면서 경증의 초조함이나 흥분에서부터 폭발적인 분노에 이르기까지 다양한 강도의 주관적인 감정으로 나타나는 정서적 상태로 정의된다고 하였다. 적응적인 분노의 표현은 스트레스 유발 상황을 해소시키는 긍정적인 역할을 수행하기도 하지만(Feindler & Ecton, 1986), 분노를 적절한 방식으로 표현하거나 해소하지 않을 경우에는 급작스러운 공격성을 표출하거나 심리내적인 병리 현상을 일으키게 되어 심각한 행동 및 사회적 문제를 일으킬 수 있다(권희주, 2014; 이근배, 2008; 최성일 외, 2001).

① 아동·청소년기 대인외상경험과 분노

분노는 분노 유발 상황 시 처리하는 과정에서 상대방이 강한 사람이거나 분노를 표출하는 것이 상대방으로부터 부정적으로 평가될 위험이 있다고 생각되어지는 경우, 혹은 보복을 당할 수 있는 두려운 상황이라고 판단될 때에는 분노를 표출하지 않고, 억누르는 방식으로 억제하게 된다(임혜은, 2021). 특히, 초기 대인외상경험자의 경우에는 다양한 이유로 인하여 가해를 가한 당사자에게 분노를 표출하지 못하고, 억압함으로써 실질적인 내면의 분노를 해소하지 못한 상태가 대다수이다. 외상경험자들은 이러한 해결되지 못한 분노를 직접적인 분노 유발 대상자가 아닌 다른 타인이나 특히 자신에게로 돌리는 경향이 높으며, 이는 추후에 더욱 공격적이면서도 강한 부적응적인 방식으로 분노가 표출되는 경향성이 있다(고은영, 1997; 박정호, 2019; Zahn-Waxler, et al., 2000).

이처럼 분노는 외상경험자들이 흔히 느끼는 정서 반응 가운데 하나로(안현의 외, 2012), 타인에게 비난을 받거나 모욕감, 수치심을 경험한 경우 혹은 부정적인 평가를 받았을 때 분노 반응은 증가한다. 또한 부모 혹은 중요한 대상에 의해 욕구가 좌절되

있거나 자기가치감이 손상되었다고 느낄수록 분노 정서는 더 강해진다. 즉, 어린 시절의 대인외상경험은 아동기부터 성인기까지에 나타날 수 있는 분노와 공격성의 한 근원이 될 수 있는 것이다(Schor, 2003).

국내 연구에서는 어린 시절의 외상경험은 사회성 문제점과 함께 불안, 우울, 공격성, 낮은 자아존중감을 비롯하여 분노를 발생시킨다고 주장하였다(황은수, 성영혜, 2006). 대인외상경험자들은 자신이 처한 상황을 통제할 수 없다고 인식할 때 높은 수준의 분노를 경험하지만 이를 적절하게 조절하지 못하며(김교현, 왕소정, 2000), 타인의 힘에 의해 일어난 외상은 그 당시에 일어난 강한 분노를 기능적으로 표현하지 못하고 억압하게 된다고 하였다(라영선 외, 2009). 따라서, 이들은 분노 유발 상황에서 역기능적 분노표현을 나타내는 것으로 보고되었고, 초기 대인외상경험이 초기 성인기 역기능적 분노표현에 의미 있는 영향력을 끼치는 것으로 밝혀졌다(조한익, 최종환, 2013). 실제로 대학생들 대상으로 대인외상경험과 역기능적 분노간의 관계를 살펴본 선행연구에서 초기 대인외상경험자는 타인과의 관계를 불안해하고, 자신을 스스로 부적절하거나 취약하다고 생각함으로써 분노억제와 같은 역기능적 분노를 나타낸다고 보고하였다. 다른 연구에서도 어린 시절의 대인외상경험이 비합리적 신념을 매개로 하여 초기 성인기의 분노억제에 간접적인 영향을 미치기도 하지만, 직접적으로도 영향을 미친다는 결과가 확인되었다(조한익, 최종환, 2013).

이와 같이 초기 대인외상경험과 분노간의 관계에 대한 선행연구들을 종합해 볼 때, 초기 대인외상경험자들은 분노를 억압하거나 역기능적으로 표출하는 경향이 있는 바, 일상생활에서 분노 유발 상황 시 발생된 분노를 적응적으로 표현할 수 있도록 돕는 방안이 필요할 것으로 보인다.

② 폭식장애와 분노

분노 또한 폭식에 선행하는 대표적인 부정 정서 중 하나로, 선행연구들에 의하면 분노는 폭식에 유의한 영향을 미치는 변인임이 밝혀졌다(Brunner, et al., 1989; Fassino, et al., 2003; Hatsukami, et al., 1982; Rebert, et al., 1991; Smith, et al., 1991; Waller, et al., 2003). 폭식을 정서 조절의 시도로 보는 관점에 기반한 선행연구를 살펴보았을 때, 분노를 느낄 때 이를 적절하게 조절할 수 있는 사람들은 폭식을 보이지 않을 수 있

으나 분노를 적절히 조절하지 못하는 경우에는 폭식의 증가로 이어질 수 있다고 하였다. 이는 폭식장애 환자들이 분노표현에 있어서 어려움을 경험하고 있으며, 분노를 조절하기 위한 방략으로 폭식을 사용할 수 있음을 보여주는 것임을 나타낸다고 주장하였다(Brytek-Matera, 2008; Krug, et al., 2008). 따라서, 분노를 적절하게 조절하지 못하고, 과도하게 억제하거나 표출하는 것은 더 많은 폭식을 하는데 영향을 미치는 것으로 설명된다(소원현, 2009; 오유라, 2017; 정희진, 2015; Meyer, et al., 2005; Peñas, et al., 2004).

비슷한 맥락에서 실제로 폭식장애 증상을 보인 여성들은 비임상군보다 높은 분노 수준을 보였을 뿐만 아니라 분노의 표출과 억제는 폭식 증상의 심각도와 유의한 연관성을 가지고 있었다(Krug, et al., 2008). 분노 조절의 어려움은 개인에게 분노를 경험하는 기간을 지속시키게 되며, 이때 자신의 정서에 대한 분노 자각을 차단시키기 위해 폭식을 한 가지 방법으로 사용한다(임지수, 박경, 2018). 정리하면, 폭식장애 환자들은 분노를 적절하게 조절하는 것에 어려움이 있으며, 분노를 조절하기 위한 부적절한 전략으로 폭식을 사용하는 바, 이들의 분노를 적절하게 다뤄줄 필요성이 있음이 시사된다.

3) 행동적 특성

(1) 스트레스 대처

Lazarus와 Folkman(1984)은 스트레스는 개인이 스트레스 사건을 어떻게 지각하는지와 대처하는지에 대한 자신의 능력의 평가 등에 의해 결정된다고 하며 스트레스의 특징을 설명하였다. 이는 동일한 사건에 대해서도 개인의 상황이나 보유하는 자원에 따라 개인이 받는 스트레스의 정도와 양상이 달라질 수 있음을 말한다(김지숙, 류상희, 2003). 더하여 스트레스 대처란 스트레스에 스스로 대처하는 능력으로 직접적으로나 잠재적으로 스트레스를 주는 상황 및 사건에 대하여 개인이 행동하는 모든 반응이 포함되는 것이다(Wortman & Silver, 1989). 즉, 스트레스나 위기, 역경의 상황을 경험했을 때 개인의 인지적 평가에 따라 상황을 해석하며 그러한 상황에 접근하는 대처방식이 달라진다는 것이다.

Lazarus(1981)는 스트레스에 대처하는 방식에 따라 그 유형을 적극적 대처와 소극

적 대처로 분류하였다. 적극적 대처방식은 스트레스에 대처하는 노력이 외부로 투여되는 것으로 다시 문제중심적 대처방식과 사회적 지지추구 대처방식으로 구분된다. 소극적 대처방식은 스트레스에 대처하는 노력이 자신의 감정이나 사고 등 내부로 투여되는 것으로 다시 정서중심적 대처방식과 소망적사고 대처방식으로 구분된다. 이는 스트레스 대처방식을 외부나 내부 어느 것에 초점을 두고 노력하는지에 따라 정의가 달라지며 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 문제중심 대처방식이란 스트레스를 유발한다고 생각되는 개인-환경 관련 문제에 직면하였을 때 능동적으로 문제를 변화시키고, 스트레스에 대처하려는 노력으로 문제 자체에 초점을 맞추어 대처하는 방식이다. 정서완화 대처방식은 스트레스와 관련되거나 스트레스로부터 초래되는 감정의 상태를 통제하려는 노력으로 스트레스 상황이 자극하는 감정을 조절 및 통제함으로써 이에 대처하는 방식이다. 이는 스트레스 요인을 근본적으로 해결하려고 하기보다는 잊으려고 노력하거나 무시해버리는 등의 회피적인 방식이다. 사회적 지지추구 대처방식이란 스트레스 사건이나 상황을 해결하기 위해 타인의 도움을 요청하는 대처방식으로 문제 해결을 도와주고 지지해줄 사람을 찾는 대처방식이다. 마지막으로 소망적 대처방식은 스트레스나 그것을 유발시킨 사건 및 상황에 거리를 두고 바람직한 상황을 생각하거나 상상하는 것을 말하며 소망적 공상으로 문제를 회피하려는 대처방식이다.

개인은 일반적으로 자신에게 위협적이거나 도전적인 환경 조건들을 스스로 수정하고, 변화시킬 가능성이 없다고 여겨지면 정서중심적 대처를 많이 사용하며, 이와 반대로 같은 상황에서도 그러한 상황들을 직접 수정할 수 있다고 인지적으로 평가한 경우에는 문제중심적 대처를 사용할 가능성이 더 많다고 하였다(Lazarus, et al., 1980). 이러한 맥락에서 문제중심적 대처방식과 사회적지지 추구를 포함하는 적극적 대처방식은 당면한 문제를 해결하기 위해 스트레스에 직면하고, 원인을 밝혀 이를 대처하기 위해 필요한 자원을 찾는 등의 대처노력이 외부로 투여되어 있어 문제 상황에 직면하며 이를 해결하려 한다. 반면, 정서완화적 대처와 소망적사고 대처방식은 상황 자체를 직접적으로 해결하기 어렵다고 판단하여 직접적인 문제해결이 아닌 감정을 조절하거나 생각의 변화를 통해서 문제를 해결하려고 하는 등의 대처노력이 내부로 투여되어 있다. 이와 같이 스트레스에 직면하였을 때, 대처하는 방식이 개개인마다 다르며 대부분은 이미 학습된 다양한 문제 해결방법과 스트레스 대처 방법을 사용하게 되지만 이러한 방법을 모르거나 부적절한 대처를 하였을 경우에는 정신적 부적응 등의 여러 가지

문제를 야기할 수 있다.

대부분의 선행연구에서는 문제중심적 대처를 사용하는 것이 정서중심적 대처를 사용하는 것보다 긍정적인 결과를 가져오는 것으로 밝혀졌다(이현승, 2019; 하예지, 서미경, 2014; Matheson, et al., 2007).

① 아동·청소년기 대인외상경험과 스트레스 대처

외상 사건에 따른 위험 수준은 개인의 대처능력에 따라 균형적인 상태를 만들어 내는데 필수적인 요인으로 보고되어 스트레스 대처능력이 대인외상경험의 주요한 보호 요인임이 밝혀졌다(Richardson, 2002). 외상경험자들의 스트레스 대처전략은 그들의 외상과 관련된 심리적 후유증과 관련이 있으며 스트레스 대처능력의 향상은 외상경험 후에 개인의 적응 수준에 있어 긍정적인 심리적 변화를 예측할 수 있는 주요 요인으로 작용한다(김현정 외, 2014; 최승미, 2008; Tedeschi & Calhoun, 2004).

한편, 어린 시절에 대인외상을 경험한 성인의 경우 이후 다른 사람과의 관계에서 뚜렷한 이유 없이 타인이 자신을 부당하게 대한다고 느끼거나 대인관계에서 상처받을 것 같은 느낌을 지속적으로 가지며(Drapeau & Perry, 2004), 자신이 타인에게 받아들이지 못할 것이라고 예상하는 경향이 높다(Kim & Cicchetti, 2006). 이와 같은 이유로 많은 선행연구들에서 초기 대인외상경험과 이후의 대인관계적 스트레스 상황의 관련성을 보고하고 있다(고나래, 2008; 이유경, 2006; 이태영, 심혜숙, 2011; 최나운, 이영호, 2018; 최은영, 안현의, 2011; 한수경, 정남운, 2014). 이렇듯, 어린 시절의 대인외상 경험자는 대인관계에 있어 예민하고, 타인의 의도를 의심하는 성향이 있어 관계적인 스트레스가 많으며, 이러한 상황에 놓였을 때 자신은 무능력하다는 부정적인 자기지각이 만연하여(van der Kolk, 2001), 적극적으로 문제를 해결하기 보다는 문제 상황에서 느낀 감정을 억압하고 회피하려는 방식으로 반응하는 경우가 많다고 하였다(윤경희 외, 2014; 조재희, 2017). 그러므로 대인외상경험자의 경우에는 외상 이후에 대인관계적 스트레스 상황에 당면하면 문제 상황과 관련하여 떠오르는 생각과 정서를 경험하지 않으려 하거나, 회피해버리는 소극적 대처의 정서중심대처를 사용할 가능성이 높다고 예측할 수 있다(백지예, 2020).

실제로 외상과 스트레스 대처능력과의 관련성을 살펴본 선행 연구에서 초기 대인

외상을 경험한 성인 여성의 경우 대체로 일상생활에서 소극적 대처를 많이 사용하는 것으로 보고되어 문제 상황을 직접적으로 해결하려고 하기 보다는 소극적으로 대처하려는 경향성이 있음이 나타났다(한유정, 2004). 다른 연구에서도 초기 대인외상경험자는 이후 성인기에 문제중심 대처방식을 적게 사용하며 사회적인 도움을 추구하거나 자기를 위로할 수 있는 스스로의 자기위로 능력이 부족한 반면, 정서중심대처 방식을 높게 사용하는 것으로 밝혀졌다고 하였다(김연, 2013).

대인외상경험과 이후의 외상 후 성장과의 관계에 관한 연구들에서도 외상 후 적극적인 대처 방식을 많이 사용할수록 외상 후 성장을 많이 경험한다는 연구결과(김고은, 2013; 이슬기, 2015; 최승미, 2008)가 다수 보고되어, 개인이 직면한 외상 경험에 대해 정서적으로 억압하거나 회피하기 보다는 적극적인 대처노력이 긍정적인 변화를 가져오는 것으로 보인다(송현, 이영순, 2011).

정리하자면, 대부분의 선행연구들에서 아동·청소년기의 대인외상경험자는 이후에 삶에서 대인관계적 스트레스 상황에 노출될 확률이 높으며(고나래, 2008; 박은미, 1999; 이유경, 2006; 조은정, 이기학, 2004; Harford, et al., 2014; Paradis & Boucher, 2010), 이러한 경우 소극적인 대처방식을 보인다는 연구가 우세하며, 각 개인의 스트레스 대처능력의 유형에 따라 부정적 영향을 완충하거나 긍정적 변화에 영향을 줄 수 있는 것으로 보인다. 따라서, 스트레스 대처능력의 향상은 외상경험 후에 개인의 적응수준에 있어 긍정적인 심리적 변화를 예측할 수 있는 주요 요인으로 작용하는바, 대인외상경험자의 외상경험으로 인하여 고착화된 소극적인 대처능력을 적극적인 스트레스 대처전략인 문제중심적 대처와 사회적지지 추구의 향상을 통해 대체한다면 외상경험 이후의 심리적 부적응을 완충하는 데 긍정적인 효과가 있을 것으로 보인다.

② 폭식장애와 스트레스 대처

폭식을 유발시키는 요인으로 부정 정서와 같이 가장 많이 언급되는 것으로 스트레스가 있다(Fairburn, 1995). 폭식자들은 스트레스와 부정 정서에 매우 취약하며, 이들은 스트레스로 인한 부정 정서에 의해 폭식과 같은 부적절한 대처방식을 사용하게 된다고 하였다(Shatford & Evans, 1986). 이러한 경향성에 대해 Heatherton과 Baumeister(1991)은 폭식자의 경우 타인의 가치가 반영된 부정적인 자기평가와 그로

인해 발생하는 부정적 정서 상태에 대한 회피의 방법으로 폭식을 선택한 것이라고 설명하였다. 즉, 스트레스로 인한 부정적인 감정에 압도되어 스스로가 매우 불안하고 혼란스럽다고 느껴질 때, 이에 대처하기 위해 폭식을 함으로써 불안을 감소시키고 자아감을 재조절할 수 있게 되는 것이다. 여기서 폭식은 적대감과 충동성을 간접적으로 표현하고, 보다 중요한 문제로부터 회피할 수 있게 해주는 기능을 한다(Hawkins & Clement, 1984; Thompson, et al., 1987). 그러나 이러한 회피기능은 일시적이며, 곧이어 자기비난과 같은 부정 사고가 다시 다양한 부정 감정들을 뒤따르게 하여(Abraham & Beumont, 1982; Elmore & de Castro, 1990; Lingswiler, et al., 1989) 폭식 후의 죄책감, 자기 비하감이 또 다른 형태의 스트레스가 되어 다시금 폭식하는 악순환을 반복하게 된다고 하였다(김준기, 1997).

Hansel과 Wittrock(1997)의 연구를 살펴보면 이 연구에 참여한 성인 여성들은 스트레스가 가장 높은 상황에서 매우 민감해졌고, 이때 높은 폭식 수준을 보고하는 것으로 나타났다. 국내연구에서도 성인을 대상으로 폭식과 스트레스에 대한 연구를 진행하였을 때, 스트레스 수준이 높을수록 폭식의 빈도가 더 늘어났으며 더 자주 폭식에 대한 욕구를 느꼈다고 보고하였다(오지원, 2000).

Yager 등(1995)은 스트레스와 폭식과의 관계에서 폭식은 스트레스뿐만 아니라 스트레스 대처방식과의 상호작용에 의하여 유발된다고 설명하였다. 실제로 폭식을 보이는 여성들을 대상으로 진행한 연구에서 대상자들은 자신의 문제를 해결하기 위한 대안적인 대처방식으로 폭식을 한다고 밝혔다. 다른 연구에서도 폭식장애를 포함하는 섭식장애 임상군들은 정상 집단에 비해 스트레스 상황에서 회피적이고 소극적인 대처방식을 사용하고, 문제해결 중심의 대처방식은 상대적으로 적게 사용하는 것으로 나타났다(Grau, et al., 2002; Janzen, et al., 1992). 또한, 폭식자들은 자신의 처한 문제에 직면하기보다는 회피하는 경향이 높다는 연구결과도 있다(Soukup, et al., 1990). 이처럼 폭식은 스트레스 경험자체뿐만 아니라 스트레스 대처방식에도 중요한 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있다. 특히, 폭식자들은 스트레스 대처방식에 있어서 소극적인 대처방식을 자주 사용하는 것으로 보이며 소극적 대처방식 중 하나인 사회적 지지의 연구결과를 살펴보면 사회적 지지가 우울, 낮은 자존감 등의 다른 여러 변인과 함께 폭식을 92%의 정확성으로 예측하는 것으로 나타났다(Stice, et al., 2002). 실제로 폭식과 사회적 지지와의 관계에서 폭식을 보이는 여성들은 통제 집단에 비해 가족과 친구로

부터의 사회적 지지가 적고, 타인과 상호작용이 부정적이며(Grisset & Norvell, 1992), 적극적으로 문제를 해결하려고 하거나 사회적인 지지를 덜 추구하는 경향이 있는 것으로 나타났다(Yager, et al., 1995). 이러한 낮은 사회적 지지추구의 스트레스 대처방식은 폭식을 예측하기도 하지만 이와 반대로 같은 날의 폭식 위험을 감소시키는 역할을 하는 것으로 보고되었다(Freeman & Gil, 2004). 이는 사회적 지지의 스트레스 완충효과 때문인 것으로 밝혀졌다(Olstad, et al., 2001). 종합하면, 사회적지지는 폭식의 발현에 중요한 요소인 것으로 보이며 낮은 사회적지지는 다른 변인들과의 조합으로 폭식을 예측하는 것으로 보인다. 그러나, 이와 대조적으로 사회적지지가 스트레스로 인한 폭식의 위험을 감소시키는 것으로도 보고되고 있어 폭식의 보호요인으로 기능할 수 있음이 시사된다.

한편, DSM-5에 따르면 대인관계적 스트레스는 일반적인 폭식의 선행사건이라고 하였다(APA, 2013). 일상생활의 대인관계적 스트레스 사건은 과제중의 문제가 아닌 폭식의 심각성과 중요하게 관련되어 있다고 보고되었다(Telch & Agras, 1994). 폭식장애 환자들은 가족관계 상황에서 문제를 경험하고 있을 뿐만 아니라 일반적인 대인관계에서도 만족스럽지 못한 상태에 놓여있어 사회적 적응이 원만하지 못하며 이는 높은 스트레스를 야기한다고 하였다(Williamson, et al., 1985). Garner(1991)에 의하면, 섭식장애 환자들이 대인관계적 스트레스를 보고하는 이유는 이들이 사회적 대인관계를 매우 위험하고, 긴장되며 자신으로 하여금 실망감을 안겨줄 수도 있는 관계라고 인식하기 때문이라고 하였고, 이와 같은 맥락으로 이상 섭식 태도는 경증의 정도에 따라 차이는 있지만 대인관계 사건이 섭식 태도에 영향을 끼치는 요인임을 보고하였다(장혜경, 손정남, 2014). 실제로 폭식자들은 가족이나 친구와 같은 대인관계에서 스트레스를 많이 받으며, 이러한 관계적인 스트레스는 특별히 배가 고프지 않아도 폭식을 유발하는 것으로 나타났다(최승혜, 2018). 또한, 섭식장애 환자들은 대인관계에서의 공허함을 채우기 위해 폭식을 하기도 하는데, 이는 Strieger-Moore 등(1999)의 연구를 통해 설명되어 진다. 연구에 따르면, 섭식장애 환자는 일반적으로 대인관계 기능 결함을 보이고 이러한 관계적인 스트레스가 폭식을 유발하는 것으로 보고되었다.

5. 이미지 재구성

1) 이미지 재구성 I

이미지 재구성(Imagery Rescripting: IR)은 현재의 정서적 어려움의 기원이 되는 이전의 기억을 심상 속에서 재경험하는 동시에, 개인의 적응적인 욕구를 반영하여 해당 기억을 재구성하는 과정을 포함하는 개입법이다(Arntz, et al., 2014). 이러한 치료법은 최근, 언어적 처리보다 심상이 정서에 더 큰 영향력을 갖고 있다는 측면에서 임상장면에서 주목받고 있는 상대적으로 최신의 기법이다(Hagenaars & Arntz, 2012).

이미지 재구성은 심상의 특성에 기반 하였으며, IR의 치료적 메커니즘을 이해하기 위해서는 심상이 정서에 어떠한 영향을 미치는지 아는 것은 중요하다. 심상 속의 경험은 마치 실제처럼 받아들여지게 되는데(Conway & Pleydell-Pearce, 2000), 이는 심상이 우리 뇌에서 지각정보와 매우 유사하게 처리되는 경향이 있으며, 단순히 사건을 언어적으로 기술하는 것보다 정서적 경험을 하기에 용이하기 때문이다(Holmes, et al., 2007; Laeng & Sulutvedt, 2014; Pearson, et al., 2015). 이미지 재구성의 선행연구에 의하면, 심상을 사용하는 것이 치료에 도움이 되는 세 가지 이유를 다음과 같이 보고하였다(Arntz, 2011). 첫째, 심상은 문제에 대해 단순히 언어적으로 이야기하는 것보다 더 정서적 반응을 이끌어낸다(Holmes, et al., 2007). 심상은 감각 신호에 대한 반응으로 뇌의 정서 시스템에 직접적으로 영향을 미친다. 뇌의 정서 체계는 특히 심상에 민감한데, 그 이유는 두려움과 같은 정서는 위험 혹은 보상에 용이하게 응답하기 위하여 진화되었기 때문이다. 감각 신호는 다른 피질영역의 높은 수준의 처리를 우회하여, 편도체와 같은 감정에 관한 뇌 영역으로부터 신속한 반응을 유도한다(LeDoux, 2000). 예를 들어, PTSD의 증상 중 하나인 ‘플래시백’이 심상으로 발생하면 실제로 과거의 외상경험이 현재 다시 발생하는 것처럼 자율신경증상이나 외상을 피하기 위한 행동 등이 나타난다. 둘째, 뇌는 실제 경험과 상상된 경험 간의 차이를 구별하지 않아서, 상상된 경험은 실제 경험과 매우 유사한 뇌 반응을 나타낸다(Holmes & Mathews, 2010). 즉, 심상은 유사한 형태의 지각과 관련된 뇌 시스템의 많은 부분을 활성화 시키며, 심상의 내용이 정서적인 경우 지각되거나 기억된 실제 사건처럼 뇌 시스템이 정서적 정보처리에 관여하게 된다. 따라서, 상상기법이 실제 연습과 유사한 차선의 선택이 될 수 있다. 셋째, 상

상된 지각은 실제 자극과 유사하기 때문에(Dadds, et al., 1997), 심상은 효과적인 정신 활동으로 언어적 합리화보다 더 효과적으로 정서와 행동에 영향을 미칠 수 있고, 실제 경험의 효과에 근접하다. 즉, 심상은 과거의 기억 중 정서를 강하게 불러일으키는 에피소드에 접촉할 수 있는 수단이 될 수 있다. 이러한 특성을 바탕으로 이미지 재구성을 활용함으로써 심상을 통해 어린 시절 사건의 기억을 활성화하고, 사건의 재경험을 통해 그때의 욕구에 적합한 다른 결말을 상상하게 하며, 과거 일화적 기억이 갖는 본래 사건의 의미 변화를 변경하도록 하며 치료적 효과를 얻을 수 있는 것이다(Arntz, 2011).

심상을 활용한 이미지 재구성 치료를 하는데 있어서의 또 다른 이득은 치료 중 참여자가 탈락하는 비율이 다른 치료에 비해 적다는 것이다(Stopa, 2009). 실제 선행연구에서도 이러한 이점이 나타났는데 Arntz 등(2007)이 외상경험으로 고통 받는 성인 외상 후 스트레스 장애(Post Traumatic Stress Disorder; 이하 PTSD) 환자를 대상으로 심상 노출에 이미지 재구성을 더한 집단과 심상 노출만을 실시한 집단을 비교했다. 결과를 살펴봤을 때 두 집단의 효과는 유사하였으나 이미지 재구성을 받은 집단은 중도 탈락이 더 적었고, 분노, 수치심 및 죄책감과 같은 부정 정서 측면에서 더 유의한 변화가 나타났다. 또한, 치료자와 환자 모두 이미지 재구성의 선호도가 더 높았다.

(1) 외상 초점 이미지 재구성

이미지 재구성은 불안 장애의 인지치료 모델(Beck, et al., 1985)을 확장시켜 개발된 기법으로, PTSD 증상을 완화시키고 외상과 관련된 신념과 도식을 변화시키는 다면적인 심상기반 치료이다(Smucker & Dancu, 1999; Smucker & Niederee, 1995).

기존의 외상에 대한 CBT의 경우 인지적 재구성과 노출이 중요한 치료적 구성요소인데 이러한 두 요소를 심상을 활용한 이미지 재구성으로 실시하였을 때 더 치료적 효과를 얻을 수 있다. 먼저, 인지적 재구성의 경우 외상을 경험한 내담자는 외상적 기억과 관련된 의미는 언어적 회상으로는 접근할 수 없는 생생한 이미지와 감각으로 저장되므로(van der Kolk & van der Hart, 1989), 언어적 표상이 아닌 심상을 통하여 고통스러운 외상경험과 관련된 부적응적 사고 및 신념을 교정하는 것이 PTSD 내담자에게 더 적합하고 건강한 처리를 도울 수 있다. Beck 등(1990)은 단순히 회상적 사건에 대해 언어적으로 표현하는 것은 내담자가 왜 부정적인 자기 이미지를 가지게 되었는지에 대

한 지적 통찰은 줄 수 있지만, 그 이미지를 바꿀 수는 없다고 하였다. 즉, 이미지 재구성은 이미지를 떠올린 상태에서 교정적인 이미지를 재구성하는 과정을 통해 이미지를 변화시키고, 그것과 관련된 의미의 인지적 변화를 가능하게 하여 기존의 언어적인 인지적 재구성보다 더 효율적으로 인지적 변화를 도모하는 것이다.

다음으로, 외상에 초점을 맞춘 인지행동치료는 노출의 소거 효과를 통해 PTSD의 증상을 감소시키는데, Arntz(2011)는 이미지 재구성이 지속적 노출을 통한 소거와는 다른 메커니즘을 갖는다고 주장하였다. Arntz(2011)는 이미지 재구성을 통하여 내담자가 외상 상황에서 원했던 지속적으로 충족되지 못한 욕구가 충족되는 것을 심상을 통해 경험함으로써 외상 기억의 의미가 변화되는 것이라고 하며, 이를 ‘무조건 자극(US: Unconditioned Stimulus) 재평가’로 설명하였다. 인지행동치료의 노출 치료는 소거 효과를 통하여 사람들이 어떠한 맥락에서 조건자극(CS: Conditioned Stimulus)이 더 이상 US를 예측하지 않는다는 것을 알게 되면서 동일한 맥락에서는 US를 예측하지 않게 될 수 있지만, 원래의 CS-US 연합은 여전히 기억 속에 저장되고, 다른 맥락의 상황에서는 또다시 원래의 기억흔적(Memory Trace)이 트리거가 되어 CS가 US에 대한 기대로 이어질 수 있다. 그러나 이미지 재구성에서는 ‘US 재평가’가 일어나게 되는데, US로 대표되는 기억(외상경험)에 새로운 정보가 유입되고, 만약 이 정보가 유용하다면 이것은 외상 기억 자체의 역기능적 의미를 감소시키게 된다. 즉, 외상을 상기시키는 자극은 상황적인 맥락과 독립적으로 변화된 외상 기억 표상(US)을 촉발시키게 되는데, 만약 이러한 의미의 변화가 성공적이라면 이 기억은 더 이상 외상이 일어날 것 같다는 불안한 기대와 같은 역기능적 반응을 유발시키지 않을 수 있다. 이러한 메커니즘을 이용한 이미지 재구성의 치료적 효과는 기존 인지행동치료의 소거와 다르게 맥락 의존적이 아니므로 특히 다양한 맥락의 외상경험이 있는 외상 내담자의 경우 더 효과적인 치료로 작용 될 수 있다.

한편, 외상에 초점을 맞춘 이미지 재구성의 실제 프로토콜을 살펴보면, Smucker와 Niederee(1995)는 아동기 대인외상 중 성학대로 인한 PTSD로 고통 받는 생존자를 위한 IR 프로토콜을 개발하였으며, 최근 효과적이며 근본적인 치료 과정에 대한 과학적 연구의 성장과 함께 인지행동치료의 주류 치료 기법으로 채택되기도 하였다(Arntz, 2012). Smucker(2005)는 이미지 재구성의 치료 기간은 내담자의 증상에 따라 조정될 수 있으나 표준적으로 한 회기에 60분에서 90분까지의 8회 세션으로 제안하였다. IR

기법의 특징은 심상을 수정하는 내용의 작성을 위해 소크라테스 기법을 활용한 심상 작업을 실시하는 것이다. 상담자는 내담자가 자신의 ‘대처/주도 심상’이나 ‘자기-진정/자기-위로 심상’을 만들 수 있도록 소크라테스식 기법을 적용하게 되는데, 이는 상담자가 제안하고, 지시하고, 받아쓰게 하는 것보다 내담자 스스로가 해결 방안을 찾아낼 수 있도록 권한을 주는 것이다(Smucker & Dancu, 1999). 이미지 재구성의 기본적인 원리는 외상 기억을 활성화한 상태에서 내담자의 욕구에 더 부합하는 기존과 다른 적응적인 결과를 상상하도록 한다. Smucker(2005)는 이미지 재구성 기법의 네 가지 주요 구성 요소를 제시하였는데, 첫째, 심상적 노출(Imaginal Exposure): 학대에 대한 심상 및 관련 정서 활성화 둘째, 주도 심상(Mastery Imagery): 피해(Victimization) 심상을 대처/주도(Cope/Mastery) 심상으로 대체 셋째, 자기위로/자기양육 심상: 외상을 겪은 아이(Child)를 진정시키고, 돌보고, 안심시키는 현재의 성인(Adult) 자아를 시각화 넷째, 정서적-언어적 처리: 고통스러운 심상 및 관련 정서를 서사적(Narrative) 언어로 변형시키며, 동시에 외상성 신념과 도식에 도전하고 재구성한다. 주도 심상 단계에서는 외상 기억의 장면에 들어가는 성인 자아를 시각화하는데 이 단계에서의 성인 자아의 역할은 필요한 어떠한 수단이든 사용하여 가해자에게 맞서고, 아동을 구출하고, 아동에게 돌봄을 제공하여 대인외상 심상을 재구성하고 더 나은 결과를 도출하는 것이다. 주도 심상 단계가 잘 마무리되면 자기-양육 단계로 넘어가게 되는데 이 단계에서는 ‘성인자아-양육-아동자아’ 심상화를 지시하게 된다. 상담자는 내담자에게 성인자아와 아동자아가 상호작용 하도록 지시한다. 성인 자아는 아이 자아를 껴안거나, 학대가 다시는 일어나지 않을 것이라는 것을 아이에게 확신시키며, 버리지 않고 지켜줄 것을 약속하게 된다. 그러나 이때 비합리적인 사고와 신념이 강한 내담자의 경우에는 어린 자신을 직면하기 힘들어하거나 부정 정서를 강하게 느끼고, 비난하거나 상처를 입히기 원하는 경우도 있다. 이러한 장면 또한 치료 과정 중 하나로 다룰 수 있는 기회로 작용할 수 있기 때문에 다양한 과정을 통하여 외상 증상을 완화하고, 외상과 관련된 신념과 도식(무력함, 사랑받을 수 없음, 자기비난 등)을 변화시키고, 자기 양육 능력을 향상시키는 것이 외상 초점 이미지 재구성의 치료 목표이다.

2) 이미지 재구성Ⅱ: 긍정적 미래 심상

앞서 이미지 재구성은 심상을 활용하여 과거 외상경험으로 되돌아가 정서 및 연합된 의미를 바꿀 수 있다고 하였다. 이에 더하여 이미지 재구성의 또 다른 이점은 미래로의 시간 여행이 가능하도록 도와주는 것이다(Schacter, et al., 2007).

최근 뇌의 공통 영역에서 과거를 기억하고, 미래를 상상하는 능력이 이루어진다는 신경학적 연구결과들이 밝혀졌다. 이는 과거를 기억하고 미래를 상상하는 능력이 모두 공통적으로 중복되는 뇌영역을 사용하여 이루어진다는 것이다(D'Argembeau & Van der Linden, 2006). 즉, 개인의 자서전적 기억 삽화가 미래의 개인적 삽화를 상상하는데 사용된다는 것이다. 이러한 흐름에 따라, 외상경험이 있는 경우에는 과거에 몰두 또는 고정되어 있는데, 고착화된 패턴을 바꾸기 위해 최근에는 긍정적인 미래에 초점을 맞추도록 하는 치료적 개입이 시도되고 있다.

따라서, 이미지 재구성과 같이 이미지 재구성 미래 심상은 사건의 의미 변화를 변경하도록 하여 인지와 정서적 변화를 도모할 수 있으며, 행동 및 동기적인 측면에서도 큰 치료적 기제를 발휘할 수 있다. 긍정적인 미래를 떠올리는 미래에 대한 긍정적인 시뮬레이션은 미래 사건이 일어날 주관적인 확률을 증가시키는 기능이 있기 때문에 자신의 미래 행동을 심상을 통하여 상상하는 것은 그 행동이 실제로 일어날 확률을 높인다(Carroll, 1978; Gregory, et al., 1982; Libby, et al., 2007; Pham & Taylor, 1999). 이는, 심상으로 특정 행동의 결말을 상상하는 것은 이러한 행동이 직관적으로 더 접근하기 쉬운 것처럼 여겨지기 때문인 것으로 보인다. 또한, 개인적인 목표의 달성과 관계되는 방향으로 행동을 안내하는데 있어서도 중요한 역할을 한다(Conway, 2001; Conway, et al., 2004). 특히, 자신이 원하는 목표를 탐색하고 방향을 수정하는데 심상을 활용하게 되면, 미래에 해야 할 행동의 준비성을 증가시킴으로써 자동적으로 긍정적인 해결 방법을 떠올리게 되며 실제로 목표를 달성하게 하는 데 기여할 수 있도록 한다. 일상 속의 다양한 상황에서 어떤 행동을 실행에 옮길지에 앞서, 이를 정신적으로 리허설해 봄으로써 미래의 상황을 예측하고 평가하는데 용이하게 되는 것이다. 즉, 정신적인 시뮬레이션을 통해 예상한 결과에 따라 행동에 미치는 영향이 달라질 수 있으며, 이때 긍정적인 미래의 결과를 상상하는 것은 그 자체로 긍정적인 기분과 자신감을 향상시킬 수 있다. 이처럼 심상을 통해 미래를 대리 경험하는 것은 개인

의 인지, 정서 및 행동의 적응적인 향상뿐만 아니라 이후 상상한 것들을 실행에 옮기도록 하는 데 동기를 높이는 효과를 가져 올 수 있다.

국외연구를 살펴보면, 대인외상경험과 폭식장애는 우울, 불안과 같은 정서와 밀접하게 관련되어 있는데 이러한 부정 정서를 경험하는 사람들은 미래의 부정적 사건을 더 빨리 상상하고, 부정적 사건이 일어나지 않을 이유를 더 적게 생각하는 해석편향이 있다는 연구결과가 보고되었다(MacLeod, et al., 1997; Raune, et al., 2005). 또한, 불안장애와 우울장애 대상군의 실험에서도 이들은 미래의 부정적 시나리오에 대한 심상을 생생하게 떠올리는 능력이 매우 뛰어나고, 두 장애 모두 통제집단보다 미래의 긍정적 시나리오에 대한 심상을 생생하게 떠올리기 어려워하였다(Morina, et al., 2011).

국내연구에서는 대인외상이나 폭식장애의 대상군은 아니지만 이 둘의 공통되는 정서인 사회불안장애 대상군의 불안을 감소시키는 이미지 재구성에 대한 연구가 진행되었다(최윤영, 권정혜, 2021). 연구에 의하면, 이미지 재구성 2회기와 미래의 긍정적 자기심상에 대한 이미지 재구성 2회기인 총 4회기의 이미지 재구성을 하였을 때 사회불안, 부정적 자기개념, 침습적 반추가 유의하게 감소하고, 사회불안 수용행동이 유의하게 증가되었다는 결과가 나타났다. 이미지 재구성과 이미지 재구성의 미래 심상이 같이 처치되어 미래심상에 대한 결과만을 확인할 수는 없었으나 미래 심상집단에서는 특히 기억에 대한 부정 정서의 감소가 두드러졌다고 하였다. 이는 심상과 정서가 서로 관련성이 있고 사회불안장애 환자들이 과거 부정적 사건에 대한 기억을 떠올릴 때 정서적 고통감을 경험하는 점을 고려할 때, 긍정적 자기 미래심상을 통해 보다 긍정적인 자아상을 형성해나가는 연습을 함으로써 기억과 연합된 부정 정서가 보다 감소하고 정서적 고통감이 줄어들고 있는 점은 사회불안 치료의 탈락률을 줄이고 보다 치료적 개입의 효과를 높일 수 있는 방법으로 의의가 있을 것이라고 하였다. 또한, 후반부에 실시한 이미지 재구성 미래심상은 긍정적 자기 미래심상의 적용이 사회불안을 회피하기보다는 적극적으로 수용할 수 있도록 도움을 줄 수 있는 가능성이 치료적 효과를 나타냈다고 시사하였다.

다음과 같이 이미지 재구성 긍정적 미래 심상에 대한 소수의 연구결과들이 보고되고 있으나 현재까지 긍정적 미래 심상을 다룬 연구가 매우 부족한 실정이고, 대인외상경험이 있는 폭식장애경향자를 대상으로 긍정적 미래 심상을 활용하여 치료를 한 연구는 없는 실정이다. 따라서, 본 연구에서는 대인외상경험이 있는 폭식장애경향자들의

치료에서 후반에 미래에 대한 긍정적 심상을 처치함으로써 과거에 적응적으로 해결하지 못한 최근 사건이 미래 상황에 당면했을 때 이를 적응적으로 해결할 수 있도록 하여 부정 정서를 줄이고 보다 목표지향적으로 행동할 가능성을 높일 수 있도록 이미지 재구성 I, II를 함께 시도해보고자 한다.

6. 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 위한 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램

1) 외상초점 인지행동치료

대인외상경험을 포함하는 외상 후 스트레스 장애(Post Traumatic Stress Disorder, 이하 PTSD)는 예기치 못한 외상 사건을 겪은 후에 발생하는 심리적 장애이다. PTSD 증상이 지속되는 환자들은 두 가지의 특징이 보고되었는데 첫 번째는 외상 사건 이후에 세상이 극도로 위험하며 자신은 신뢰할 수 있는 사람이 전혀 없다는 믿음을 지속적으로 가지는 것, 스스로를 매우 무기력한 사람이며 자신이 아닌 다른 사람이었으면 사고를 피할 수 있었을 것이라는 사고와 두 번째는 자신의 증상은 스스로가 취약한 사람이라는 것을 증명하는 명확한 증거라고 생각하는 믿음이다. 이렇듯, PTSD의 발병에는 부정적인 인지가 중요한 영향을 미치며(서호준, 채정호, 2006), 인지를 중요시하는 인지행동치료가 PTSD와 같은 외상 초점 치료 방법 중 가장 안전성과 치료적인 효과성을 입증 받았다.

앞서 살펴본 것과 같이 PTSD 환자의 부적응적인 믿음은 이들을 두렵게 만들며 일상생활을 잘 수행하지 못하게 하고, 외상 사건을 떠올리게 되는 생각이나 대화, 사물을 지속적으로 피하게 한다. 이러한 지속적인 억압 및 회피는 형성된 역기능적 사고를 수정할 기회를 잃게 하여 PTSD증상을 만성화시킨다.

이러한 PTSD 환자의 특징에 따라 CBT는 일반적으로 심리교육(Psychoeducation), 노출치료(Exposure), 인지적 재구성(Cognitive Restructuring), 불안조절훈련(Anxiety Management Training) 등으로 구성된다. 먼저 심리교육은 환자의 신체적, 정신적 증

상에 대한 정보를 제공하여 환자로 하여금 자신이 겪고 있는 증상을 구체화하는데 도움을 주며, 치료의 필요성에 대한 근거를 명확하게 이해하게 한다. 노출치료는 환자의 외상과 관련된 실제 자극에 대해 단계적인 노출을 시도함으로써 궁극적으로는 가장 힘들게 느껴지는 외상 사건을 재현하게 하여 불안감소, 불안의 지속성에 대한 인지 오류의 수정, 외상사건 및 관련 사고에 대한 인지적 재구성 등을 도모한다. 인지적 재구성은 환자가 가지고 있는 부적응적인 자동화사고를 파악할 수 있게 돕고, 사건과 자신, 세계 및 미래에 대한 잘못된 믿음을 평가할 수 있도록 돕는 것이다. 이 기법에서는 부적응적인 사고 및 신념을 밝혀내어 이러한 사고들이 타당한지를 검토하고, 올바르지 않은 부분에 대해 현실적이고 합리적인 대체 인지적 평가(Alternative Appraisal)를 할 수 있도록 한다. 불안조절훈련은 환자가 스스로 자신의 증상을 조절할 수 있는 방법을 터득하게 하고, 각성의 정도를 떨어뜨리는 것이 목적이다. 훈련 방법에는 스트레스 접종 훈련(Stress Inoculation Training), 이완훈련, 자신과 이야기하기(Self-Talk) 등이 포함될 수 있으며 다양한 방법을 동원하여 불안을 조절하는 법을 습득하게 한다.

2) 폭식장애 인지행동치료

폭식장애를 포함하는 섭식장애의 치료에서는 인지행동치료가 대표적으로 치료적 효과를 입증하였다(Bulik, et al., 1998; Fairburn, et al., 1986; Walsh, et al., 1997). 섭식장애의 치료를 위한 인지행동치료는 매우 상세하게 기술되어 있는 구체적인 접근이며 임상적인 자료도 풍부하고, 치료방법도 분명하게 제시되어 있다(Fairburn, et al., 1986).

폭식자들은 외부환경으로부터 스트레스원이 발생하거나 부정적인 사건을 경험할 때 이에 건강하게 대처할 수 있는 내적 자원들이 부족한 것으로 보이며(양윤경, 2018), 폭식과 관련된 여러 가지 요인들 중 특히 개인의 인지·정서적 요인이 폭식행동 발병에 주요한 역할을 하는 것으로 밝혀졌다(Amianto, et al., 2015). 폭식장애를 포함하는 폭식증 환자는 자신에 대한 무조건적인 부정적 평가와 같은 핵심믿음이 정상 집단보다 높은 수준으로 나타났다(Cooper, 2005; Fairburn, et al., 2003). 이러한 핵심믿음과 섭식장애와의 관계는 역기능적인 핵심믿음이 섭식장애를 가져올 수 있는 요인들과 관련이 있다고 하였다. 따라서, 폭식장애에 관한 인지행동치료의 목표는 역기능적인 사

고방식과 섭식행동의 변화이다(Agras, et al., 2000; Jansen, 2001). 핵심믿음과 섭식장애의 잠재적인 매개요인들에는 낮은 자아존중감, 완벽주의, 대인관계의 어려움, 자기비난적 사고와 관련된 역기능적인 사고 및 신념이 있으며 이와 연결된 대표적인 정서적 요인으로는 불안, 우울 및 분노의 부정적인 정서가 있다(Wolff, et al., 2000).

폭식장애를 지속시키는 인지행동 이론에 의하면, 식이 행동, 신체상과 체중, 자신에 대한 통제능력에 대해 과대평가를 하는 것은 폭식증 초기 증상을 지속시키는 것에 중요한 영향을 미친다고 하였다. 또한, 극단적인 체중조절 행동, 다양한 신체 체크, 회피적인 대처 행동과 섭식행동 등에 대해 끊임없이 몰두하는 사고도 동반된다고 밝혀졌다. 즉, 폭식은 제한적인 자신의 식이 행동과 체중조절을 하기 위해 극단적인 방법들을 고집하게 하며, 높은 수준의 특정한 식이 행동 기준들을 제시한다. 이러한 식이행동 기준들은 적은 칼로리를 섭취하는 것을 실패할 경우에도 자기 통제의 부족으로 생각하는 경향이 있으며, 그 결과 그들은 제한적인 식이 행동을 하기 위한 노력을 일시적으로 포기하게 되는데, 이러한 제한적인 식이 행동은 폭식 에피소드에 의해 반복적으로 나타나며 자신의 식이 행동, 신체상, 체중에 대한 능력과 관련 있는 것으로 보고되었다(한진화, 2003). 폭식자들의 경우 자신의 섭식행동, 자신의 통제능력에 대해서 표준보다 극단적인 자기 기준을 제시하여 보다 엄격하게 자신에게 책임을 두기도 하기 때문에, 그 결과로 부정적인 자기평가를 보인다(Fairburn, et al., 1993).

Fairburn(1981)이 처음으로 제시한 섭식장애의 CBT는 세 단계로 나누어 볼 수 있다. 첫째, 치료 전반에 폭식에 대한 인지적인 관점을 제시하고, 폭식을 안정적이고 정상적인 섭식으로 대체하기 위한 행동적인 방법을 사용한다. 둘째, 다이어트를 멈추게 함으로써 건강한 식습관을 형성하게 하고, 문제를 유지하게 만드는 사고, 믿음 및 가치에 초점을 둔 인지적인 절차를 사용한다. 셋째, 치료 이후의 변화 및 유지에 초점을 둔다. 즉, 폭식에 대한 인지적 관점의 제시, 왜곡된 식습관과 신체상 혼란에 초점을 둔 인지적 재구성, 이와 관련된 생각과 행동의 자기보고, 심리교육, 규칙적이고 건강한 식습관 패턴을 만들기 위한 자기통제, 회피하던 음식의 도입 등이 치료에 포함된다(Fairburn, 1988). 이후에는 Fairburn과 Cooper(1989)가 폭식장애 환자의 치료에서 폭식행동이 있기 이전의 선행 사건과 부정 정서를 확인하도록 하여 이를 수정하고, 부정 정서와 폭식의 연결을 끊기 위해 부정 정서가 발생하였을 때 대처할 수 있는 적응적인 대안 행동들을 가르치고 실행하였다. 그 이후에는 Fairburn 등(2003)이 섭식장애에 대한 공통된

새로운 매커니즘을 설명하였다. 이들은 섭식장애 중 폭식증을 지속시키는 증거 이론들을 설명하고, 치료에서 다루어야 하는 폭식증 유지의 매커니즘(임상적 완벽주의, 낮은 자아존중감, 편협한 기분 상태, 대인관계의 어려움)을 제안하였다. 첫째, 임상적 완벽주의(Clinical Perfectionism)로 이는 자신의 노력, 성취, 개인에게 요구되는 기준들을 지나치게 과대평가하는 것으로 도달하기 어려운 높은 목표를 설정하고, 그 목표에 도달하고자 노력하며, 그 기준을 근거로 판단한다(Shafran, et al., 2002). 특히, 섭식장애 환자는 자신의 식이 행동, 신체상, 체중과 관련된 영역에 높은 기준을 적용하고, 그 기준들을 달성하지 못하여 실패하는 것에 대한 두려움을 가지고 있다(Shafran, et al., 2002; Wonderlich, 2002). 이들은 과식, 똥똥해지는 것, 체중 증가에 대한 두려움을 가지고 반복적인 칼로리 계산, 빈번한 신체상과 체중을 점검하는 행동으로 자신의 식생활과 관련된 문제에 몰두한다. 또한, 자신이 실행한 행동에 대해 지속적으로 부정적인 평가를 내리며 자기비난을 반복한다. 이러한 부정적인 자기평가는 자신에 대한 더욱 더 높은 기준치를 부여하여 적용시킨다. 둘째, 낮은 자아존중감(Low Self-Esteem)으로 이는 폭식증 환자의 대부분이 자신이 설정한 목표를 달성하지 못하여 실패한 결과로 부정적인 자기평가와 같은 형태로 자기비난이 두드러지며 나타나는 것이다. 이로 인해 이들은 자신에 대해 전반적으로 더욱 부정적인 시각으로 보게 되고, 무조건적으로 부정적 태도를 가지게 되거나 실패에 대해 과잉일반화의 부적응적인 인지처리과정을 보인다. 이러한 낮은 자아존중감은 환자에게 절망감을 가져올 수 있고, 치료에 영향을 미칠 수 있는데 환자는 치료에 대한 효과를 부정적으로 보거나 변화하고자 하는 의지를 적게 보여 치료에 어려움을 가지게 한다(Fairburn, et al., 1987; Fairburn, et al., 1993). 셋째, 편협된 기분(Mood Intolerance)으로 정서상태에 따라 폭식이 유발되기도 하며, 이때의 정서상태와 폭식간의 관계는 매우 복잡하다(Meyer, et al., 1998; Polivy & Herman, 1993; Waller, 2002). 부정 감정인 우울, 불안 및 분노와 같은 정서 상태에서 폭식이 나타나고, 불안하고 우울한 개인은 경우 부정적인 정보를 기억하고 주의를 더 쉽게 두는 경향이 있어, 통제집단보다 부정적인 정서와 정보에 더욱 민감하게 반응하고, 쉽게 영향을 받는다(Musa, et al., 2003; Zack, et al., 2003). 이렇듯 정보를 정서적으로 편향되어 지각하는 개인은 자극을 부정적으로 재인지하고, 부정적인 측면을 더욱 두드러지게 지각하며 자신을 더욱 낮게 평가하는 다른 부정적인 정서와 인지를 유발하게 되는데, 이러한 부정적인 기분 변화를 이해하고 적절하게 대처하는 역기능적인 기분 조절 행동

(Dysfunctional Mood Modulatory Behavior)을 부적절하게 표현한다. 특히, 폭식장애를 가진 개인은 자신의 부정적인 기분변화를 가져오거나 촉발하는 요인들을 인식하는데 어려움을 나타내고 빈약한 대처 행동을 보인다. 넷째, 대인관계의 어려움(Interpersonal Difficulties)으로 섭식장애 환자는 대인관계의 어려움을 보이는데, 대인관계 치료연구에서도 그 치료적 효과가 인지행동치료와 같이 긍정적인 결과를 보인다(Agras, et al., 2000; Fairburn, 1995; Fairburn, et al., 1993). 대인관계는 섭식장애를 지속시키는 것에 영향을 미치는데, 예를 들어 아동 섭식장애 환자의 경우 가족의 긴장상태는 식이 행동을 저항하는 태도를 더욱 강화시킨다. 또한 폭식장애 환자의 대인관계적 문제상황은 폭식 에피소드를 촉진하는 것으로 나타났으며, 특히 사회적 상호작용에 대해 민감하게 반응한다(Steiger, et al., 1999). 나아가 장기적인 대인관계의 어려움은 자아존중감을 손상시키고, 대인관계의 어려움이 있는 경우에 폭식 치료 과정에서 빈약한 반응을 보이는 것으로 나타났다(Agras, et al., 2000; Steiger, et al., 1993). 따라서, 이러한 4가지 변인들에 초점을 맞추어 폭식장애 환자들에게 제공할 인지적 및 행동적 기법과 방법들을 형식화 하도록 하였다.

3) 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램 치료구성요인

본 연구의 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성이라는 대상자의 특성을 고려하여 외상과 폭식장애에 효과적이라고 보고된 기존의 전통적인 CBT와 이미지 재구성을 결합하여 새롭게 개발한 프로그램으로 치료적 구성요인은 자기관리, 인지적 재구성, 이미지 재구성, 이완훈련, 스트레스 대처훈련으로 구성되어 있다.

(1) 자기관리

자기관리(Self-Management)는 개인이 통제하였거나 변화시키고 싶은 특정 행동의 수정을 통해 책임감과 자율성을 키워나가는 과정을 의미한다. 폭식 초점 인지행동치료의 필수적인 자기관리 요소로는 심리교육, 식단계획일지 등이 있다. 폭식은 식사 조절 행동의 상실이기 때문에 이를 회복시키기 위하여 심리교육을 통해 하루 세 번의

식사와 두 번의 간식이 폭식을 줄이는 데 도움이 될 수 있음을 설명하여 규칙적인 식단의 필요성을 인식시키고, 적당한 식욕의 허용이 필요함을 교육한다. 이후 자신에게 맞는 개별적인 식단계획 작성을 통해 이전에 자신의 식습관과의 차이점을 파악하도록 하였다. 이러한 개인별 맞춤형 식단계획표에서 중요한 점은 그동안의 편협한 식습관 기준에 따라 계획하는 것이 아니라 사전에 연구자가 성인 여성 1인 칼로리에 맞춘 식단계획표 예시를 제시하여 개인별로 자신의 식사량과 비교하면서 보다 현실적으로 작성할 수 있도록 하고, 일일이 칼로리를 계산하지 않도록 하였다. 칼로리에 대한 계산은 음식에 대한 불안과 강박을 자극하므로 1인 기준의 식단계획 예시를 통해 적당한 양을 가늠할 수 있도록 한 것이다. 이후에 연구자 및 집단원과 함께 적절한지 살펴보고 수정하였고, 프로그램 진행 동안에도 점차적으로 수정함으로써 자신에 맞는 최적의 식단계획표에 따라 규칙적인 식사를 하도록 하였다. 이러한 식단계획표에 따라 본 프로그램에서는 두 가지의 과제를 제시하였다. 첫 번째는 섭식DTR일지로, 이는 폭식에 압도되지 않도록 평상시 자신의 폭식패턴을 관찰하도록 하기 위함이다. 주로 어느 시간대, 어떠한 이유로 폭식을 하는지를 알아내기 위하여 폭식 전의 구체적인 상황, 생각, 감정, 행동(섭취한 음식 목록), 폭식 이후의 사고, 감정까지 적도록 하였다. 이를 통해 폭식 패턴을 스스로 분석하고, 반복되는 패턴의 상황과 부적응적인 사고는 없었는지를 알 수 있도록 하여 사고의 수정을 통한 폭식 증상의 감소를 도왔다. 두 번째는 폭식 피드백 일지로, 식단계획과 섭식DTR일지를 확인하며 일별로 잘 지킨 부분과 지키지 못한 부분을 일차적으로 분석하고, 이차적으로 전체 피드백을 작성하도록 하여 폭식에 대한 자기관리가 체계적이고도 용이하게 이루어질 수 있도록 하였다.

(2) 인지적 재구성

인지적 재구성(Cognitive Restructuring)은 부적응적인 자동적 사고와 왜곡된 비합리적 신념을 찾아내고, 이를 평가하여 적응적이고 합리적인 사고 및 신념으로 변화시키는 체계적인 절차를 의미한다(Beck, et al., 1985).

아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 경우 초기 외상경험 및 그와 연결된 폭식으로 인한 자기(Self), 타인, 외상경험에 대한 인지왜곡이나 역기능적인 신념이 있다. 특히, 대인외상경험은 예기치 못한 사건이었기 때문에 개인으

로 하여금 ‘나는 무능해’, ‘다른 사람은 믿을 수 없어’, ‘그 사건이 내 인생을 망가트렸어’ 등의 인지 왜곡을 갖게 하거나(Leahy & Holland, 2000), 외상경험 전에 자신이 가지고 있던 신념에도 위협을 가한다(Brewin, et al., 1996). 이러한 왜곡된 사고 및 신념에는 자기비난, 흑백논리, 과묵화, 독심술 등이 있으며 이와 같은 인지적 오류는 부정 정서를 유발하여 폭식과 같은 이상섭식 행동에 영향을 미치고, 폭식은 또 다시 개인으로 하여금 인지왜곡을 되풀이하게 한다. 따라서, 이러한 악순환을 중단시키기 위해서는 이들의 특징적인 왜곡된 사고 및 신념의 패턴을 수정하여 대안적인 사고를 창출하게 하는 인지적 재구성 작업이 필수적일 것이다.

인지적 재구성 과정에서 가장 빈번하게 사용되는 기법으로는 소크라테스식 기법과 사고기록지(Thought Records)가 있다. 소크라테스식 기법은 개인이 스스로의 답을 찾아갈 수 있도록 도와주는 질문법으로 내담자가 질문에 대한 답을 하면서 경직되어 있던 사고의 폭을 넓히고 다양한 관점을 가지도록 도와준다. 그 밖의 방법으로는 인지적 오류 찾아내기, 증거 검토하기, 재귀인, 합리적 대안 찾기, 인지적 예행연습 등이 있다.

인지적 재구성의 핵심은 부적응적인 인지와 부정 정서를 완전히 없애는 것이 아니라 이를 인식하고, 줄이며 보다 적응적인 관점으로 변화시키는 데 있다. 따라서, 이를 위한 전략은 치료 회기 안에서 내담자의 자동적 사고와 핵심신념을 먼저 찾아내고, 이러한 특징적인 인지를 변화시키기 위한 기술을 가르친 후, 과제를 통해 이 과정을 연습하도록 만들어야 한다(Wright, et al., 2009). 그러한 이유는 내담자들의 습관적으로 왜곡된 인지패턴을 쉽게 수정할 수 있도록 돕기 위한 반복적인 연습이 필요하기 때문이며, 궁극적으로는 회기에서 배운 것들을 스스로 일상생활에 적용하도록 하기 위함이다(Wright, et al., 2009). 이러한 과정을 통해 언어적인 접근의 인지적 재구성이 잘 선행되어 왜곡된 사고 및 신념을 빠르게 인식하여 변화시킬 수 있게 된다면, 이후에 개입되는 이미지 재구성, 스트레스 대처훈련이 더 효과적으로 작용할 수 있을 것이다.

(3) 이미지 재구성

이미지 재구성(Imagery Rescripting)은 과거 개인의 자서전적 기억을 심상 속에서 재경험하고, 이후에 개인의 적응적인 욕구를 반영하는 방식으로 해당 기억을 재구성하는 단계를 통해 기억과 연합된 정서 및 의미를 적응적으로 바꾸는 3단계 개입법이다

(Arntz, et al., 2014; Arntz & Weertman, 1999). 이는 심상의 특성에 기반한 치료법으로 심상은 인간의 뇌에서 지각정보를 처리하는 것과 유사하게 작동하는 경향이 있으므로, 단순히 언어적으로 사건을 기술하는 것보다 심상을 활용하면 정서적 경험을 더욱 용이하게 할 수 있다(Holmes, et al., 2007; Laeng & Sulutvedt, 2014; Pearson, et al., 2015). 또한, 심상은 과거 또는 미래로의 시간 여행이 가능하도록 하기 때문에 (Schacter, et al., 2007), 이러한 특성을 바탕으로 본 프로그램에서는 이미지 재구성을 I, II로 나누어 시행하였다. 이미지 재구성 I은 아동·청소년기 대인외상경험을 다뤄주는 작업을, 이미지 재구성 II는 최근 폭식을 유발한 대인관계적 문제 상황 및 폭식 상황이 미래에 비슷하게 발생했다고 가정하여, 현재 시점에서 다뤄주는 작업을 하였다.

이렇듯, 심상을 활용한 이미지 재구성의 치료적 기제를 충분히 활용하기 위해 본 프로그램에서는 인지, 정서, 행동적 측면에 모두 사용하였다. 먼저, 인지적 측면에서는 심상을 통한 이미지 재구성 I으로 초기 대인외상경험을 다시금 재경험 및 재구성하였다. 이는 비록 과거 외상경험을 삭제하거나 왜곡시킬 수는 없으나(Arntz, 2012), 해당 기억이 가지는 의미를 변경하거나, 기존의 부정적인 자기개념과 대립하는 긍정적인 자기개념으로 변화시킬 수 있다. 더불어 대인외상경험으로 인한 폭식장애의 발달 및 유지에 작용하는 핵심적인 자기개념, 즉 핵심신념이 개인의 자서전적 경험에서 기인한 스스로의 부정적 속성 모두를 포함하는 응축된 개념이라는 점을 고려하면(Moscovitch, 2009), 핵심신념 또한 이미지 재구성을 통해 변화할 수 있음을 의미한다. 또한, 이미지 재구성 II를 통해 최근 폭식을 유발한 대인관계적 문제 상황을 재경험하며 ‘최고로 가능한 자기’가 되어 긍정적으로 상황을 해결하며 기존의 폭식까지 가는 패턴을 수정하는 작업을 통해 이미지 재구성 I으로 변화된 사고 및 신념을 공고히 하도록 하였다.

다음으로, 정서적 측면에서는 심상을 통한 이미지 재구성을 정서 처리(Emotional Processing)의 변화가 일어나도록 도왔다. 즉, 외상경험 당시에 억제되었던 욕구와 정서를 표현하는 경험의 정서적 재처리가 치유요인으로 작용하여 정서적 처리를 돕는 것이다(Arntz, 2012). 대인외상과 같이 과거 어린 시절의 고통스러운 외상경험을 겪은 개인은 정서를 표현할 때 안정감을 느끼지 못하거나 위협을 느껴 정상적인 정서적 처리를 하지 못했을 가능성이 매우 높다. 이것은 성인이 된 이후에도 감정처리의 불편감과 두려움을 경험시킨다. 따라서 이미지 재구성은 해당 사건을 떠올리고 정서를 처리

하는데 편안해지도록 하고, 정서에 대한 기본적인 역기능적 관점을 변화시키므로 정서 조절의 어려움이 개선되도록 도울 수 있다(Arntz, 2011).

마지막으로, 행동적 측면에서는 이미지 재구성이 실제 경험과 매우 유사한 뇌 반응을 나타내기 때문에 실제 연습 못지않게 상상하는 기법이 좋은 대안이 될 수 있다는 점과(Holmes & Mathew, 2010), 긍정적 미래 심상이 개인의 동기 수준을 높이며 목표 지향적 행동을 향상시킨다는 것을 고려하여(Libby, et al., 2007; Pictet, et al., 2011), 이미지 재구성Ⅱ를 통해 긍정적 미래심상을 다뤄줌으로써 폭식을 일으키는 유사한 미래 상황에 당면했을 때 목표지향적으로 문제를 해결하여 상황에 잘 대처할 수 있을 가능성을 높일 수 있도록 하였다.

(4) 이완훈련

이완훈련은 불안, 긴장, 스트레스로 인한 고통 혹은 자율신경계 각성에서 오는 신체 증상(근육, 긴장, 복통, 땀 등)을 줄이는 상태가 되도록 훈련하는 것을 말한다(권정혜, 2020). 이완훈련에는 호흡, 점진적 근육이완, 심상 등의 형태로 진행될 수 있다(Domar, 2004). 이완 훈련법은 개인의 살아온 삶의 방식, 집중 정도, 스트레스 수준에 따라 달라지므로 각자에게 맞는 적절한 방법을 찾아 훈련한다면 더욱 효과적이다(Domar, 2004). 이완훈련은 인지행동치료 개입의 필수적인 구성요소로 외상의 경우에는 외상경험자의 사건과 관련된 상황, 장면, 사람 및 플래시백 등의 불안 상황에서 급격한 과호흡, 심장박동 수의 증가, 근육의 높은 긴장도 등의 신체증상을 느낄 때 불안 상황으로부터 스스로 벗어나는 계기가 될 수 있으며, 폭식의 경우에도 폭식을 야기한 스트레스적 상황에서 주의를 전환시키는 데 도움이 된다.

성인 여성에게 주로 적용하는 이완 기법으로는 호흡, 점진적 근육, 심상이 있다. 호흡이완이나 점진적인 근육이완은 Jacobson(1987)에 의해 개발된 것을 토대로 하며 초기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 폭식 전후로 느끼는 부정 정서에 따른 신체·생리적 반응을 잘 통제하기 위해 제시하였다. 호흡이완법은 가장 쉽고 일상생활에 용이하게 적용이 가능한 전통적인 이완요법이며(Kim & Song, 1993; Warfield, 1999), 과호흡 등의 증상을 보이는 대상자들에게 유용하다고 보고되었다. 특히, 호흡 이완법은 숨을 내어 쉴 때의 이완된 상태를 기억하게 하는 것이 중요하며,

점진적으로 시간을 늘리는 것이 도움이 된다(Kendall, 1991). 근육이완의 기본적인 목적은 긴장, 불안 및 스트레스를 받은 사람들에게 근육이완을 학습하게 함으로써 현재 받고 있는 스트레스에서 벗어나게 하는 것이며(Conrad & Roth, 2007), 근육 이완이 효과적인 부교감신경을 자극하여 스트레스 호르몬을 감소시키기 때문이다(이미라, 2005). 점진적인 근육 이완훈련 기법의 단계는 총 일곱 단계로 첫째, 내담자에게 이완훈련의 원리를 설명한다. 둘째, 내담자에게 자신의 근육 긴장 수준과 불안을 평가하도록 가르친다. 이때, 0~100점 척도를 사용한다(0은 긴장감이나 불안이 전혀 없는 상태이며, 100은 최대한의 긴장이나 불안을 가리킨다). 셋째, 내담자에게 근육 긴장의 범위를 탐색하도록 한다. 이러한 훈련을 통해 내담자는 자신의 근육 긴장 상태에 대해 자의적인 통제를 할 수 있다는 것을 깨닫게 된다. 넷째, 내담자에게 근육의 긴장을 감소시키는 방법을 가르친다. 다섯째, 내담자를 도와 체계적으로 몸의 주요 근육 부위를 이완시키도록 한다. 여섯째, 이완에 도움이 되는 심상을 떠올리도록 제안하여 걱정스러운 생각으로부터 주의를 돌리도록 함으로써 내담자가 이완 반응에 도달하도록 돕는다. 일곱째, 내담자가 이완을 유도하는 기법을 정기적으로 연습하도록 한다. 이러한 심도 깊은 이완 기법을 익혀서 일상생활에서 활용하기까지는 상당한 연습이 필요하므로 이완훈련을 과제로 내주는 것도 좋은 방법이다(Wright, et al., 2009). 심상이완은 개인으로 하여금 그들의 마음속에 가장 편안함을 주는 특별한 장소 등을 설정하여 눈을 감고, 떠올리도록 하여 스트레스나 긴장을 억제하도록 하는 것이다. 이때, 심상을 구체화 및 심화시키기 위하여 무엇을 보고 느끼는지 등과 같은 부가적인 것들의 질문을 통해 오감을 촉진할 수 있다. 이러한 묘사가 세밀할수록 편안함과 안전함을 주는 마음속의 심상 영역은 더욱 생생히 경험하게 되어, 더 깊은 수준의 이완상태를 느낄 수 있다.

(5) 스트레스 대처훈련

스트레스 대처훈련은 개인으로 하여금 스트레스의 본질을 이해하고, 이에 대처하는 기술 및 방법을 습득하게 함으로써 효율적으로 스트레스를 관리할 수 있도록 돕는 훈련이다(김정숙, 1994; 원호택, 1991). Lazarus(1981)는 스트레스 자체가 개인의 부적응을 유발시키기 보다는 스트레스에 대한 심리적인 특성과 스트레스에 대한 부적절한 대처가 개인의 적응에 악영향을 끼친다고 하였다. 즉, 스트레스를 경험하는 개인이 어

떻게 받아들이고 해석하는지를 통해 이후에 어떠한 대처를 하였는지가 적응에 중요한 영향을 미친다는 것이다. 폭식과 스트레스의 관계를 살펴보면, 폭식자들은 부정 정서와 스트레스에 매우 취약하며 우울, 불안, 외로움 및 긴장감과 같은 부정 정서에 의해 폭식을 하게 된다고 하였다(Fairburn, 1995). Hawkins와 Clement(1984)는 폭식장애 환자들이 스트레스 상황에서 취약한 대처전략을 갖고 있으며, 스트레스의 증가에 대한 인식이 폭식의 빈도를 증가시킬 것이라고 보고 하였다. 또한, Hansel과 Wittrock(1997)은 스트레스 상황을 유도하여 폭식수준을 평가하는 것과 더불어 폭식에 몰두하는 사람과 그렇지 않은 사람이 스트레스 상황에 어떻게 대처하고 평가하는지를 살펴보았다. 폭식집단은 일상생활에서 대인관계 스트레스를 통제집단 보다 더 파국적인 상황으로 인식하고, 대처전략에 있어서도 통제집단과 큰 차이를 보였는데, 폭식 집단은 회피적이고 정서중심적인 대처 방식을 많이 사용하며, 문제 중심적 대처 방식은 적게 사용하는 것으로 나타났다. 따라서, 폭식자들은 일상생활의 대인관계적 문제상황을 높은 스트레스로 지각하며, 이때 스트레스에 대처하기 위해 적극적으로 당면한 문제를 해결하기 보다는 회피적인 대처를 통해 폭식을 하나의 수단으로 사용하는 것으로 보인다.

Lazarus와 Folkman(1984)은 스트레스 대처기법들에는 이완훈련, 문제해결기술, 인지적 재구성, 주장훈련 등이 있다고 소개하였는데, 이중 문제해결기술은 회피 전략을 다루어 주며 적극적으로 당면한 문제를 해결하는데 유용한 기술이다. 구체적으로 문제해결기술은 어떠한 문제가 발생하였을 때 그 문제를 해결할 수 있는 가장 작은 단위로 나누어서 효율적으로 문제를 해결하도록 돕는 기법이다(Wright, et al., 2009). 인지행동치료에서 문제해결전략을 세우는 유용한 방법은 문제들을 선별하고, 목표를 세우고, 문제를 정확하게 정의한 후 해결책들을 찾아보는 것이다. 그 후에 가장 합리적인 해결책을 선택하여 실행한 후 결과를 평가한다. 이때, 필요에 따라서는 다시 위의 단계들을 반복하여 합리적으로 문제가 해결될 때까지 이러한 순서를 반복한다(Wright, et al., 2009). 구체적으로 살펴보면, 1단계에서 현재 문제가 무엇인지 정의한다. 2단계에서는 그 문제를 해결할 수 있는 실제적인 방법을 여러 가지 생각한 다음 각각에 대한 이득과 손해를 확인한다. 3단계는 고안해낸 방법들 중 가장 효율적인 방법을 선택한다. 4단계는 선택한 방법을 구체화시켜 실행해본다. 실제로 실행한 후에 문제가 발생하면 다시 문제해결 방법의 고려 단계로 돌아간다. 다른 방법으로 다시 실행 계획을 수립하여 실시하고 효과가 있다면 결과를 확인한다. 이러한 문제해결기술은 개인이

처한 상황이나 문제의 종류, 이전에 사용했던 대응 전략 방식, 문제해결 능력이나 자원 등에 따라 달라질 수 있다.

아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 경우에는 증상의 특성상 대인관계의 어려움으로 문제해결 전략을 모델링 할 수 있는 기회가 부족하여 이들에게 높은 스트레스를 유발하는 대인관계적 문제상황을 효율적으로 해결하기 보다는 폭식을 통하여 이에 대처한다. 따라서, 초기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성은 높은 스트레스를 야기하는 대인관계적 상황에 대한 문제해결 능력을 키우는 기술을 습득하여 대인관계에서의 스트레스에 적절하게 대처하는 훈련이 필요할 것으로 보인다.

Ⅲ. 연구문제 및 용어정의

본 연구의 목적은 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 위한 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램을 개발, 실시한 후 그 효과를 비교 검증하는 것이다. 본 연구의 목적에 따라 다음과 같이 구체적인 연구 문제를 설정하였다.

1. 연구문제

[연구문제1] 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램의 주요 구성 요인은 무엇인가?

[연구문제2] 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 위한 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램 실시 후 각 변인의 변화는 어떠한가?

2-1. 프로그램 실시 후 섭식 변인(부정적인 정서로 유발된 섭식동기·섭식행동)의 변화는 어떠한가?

2-2. 프로그램 실시 후 인지 변인의 변화는 어떠한가?

2-2-1. 인지 내용 변인(역기능적 신념, 부정적 자동적 사고)의 변화는 어떠한가?

2-2-2. 인지 과정 변인(자아존중감)의 변화는 어떠한가?

2-3. 프로그램 실시 후 정서 변인(정서조절곤란, 우울, 상태-특성 불안, 상태-특성 분노)의 변화는 어떠한가?

2-4. 프로그램 실시 후 행동 변인(스트레스 대처방식)의 변화는 어떠한가?

[연구문제3] 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 위한 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램의 효과는 프로그램 종결 3개월 후에도 유지되는가?

2. 용어 정의

1) 폭식장애경향(Binge Eating Disorder Tendency)

폭식장애는 섭식장애의 한 유형으로 DSM-5에 따르면 폭식행동(Binge Eating)을 ‘일정한 시간 및 유사한 상황에서 대부분의 사람들이 동일한 시간 동안 먹는 것보다 분명하게 더 많은 양의 음식을 먹으며, 먹는 것에 대한 통제력을 상실한 상태를 경험하는 것으로 정의되며(APA, 2013), 폭식장애는 이러한 반복적인 폭식을 경험하지만 신경성 폭식증과 달리 부적절한 보상행동(스스로 유도하는 구토, 이뇨제, 관장약이나 다른 치료 약물의 남용, 금식 혹은 과도한 운동)을 보이지 않는 상태를 의미한다. 본 연구에서는 폭식장애의 임상적 진단 기준에는 충족하지 못하더라도, 폭식장애의 전조 증상들을 나타내는 것을 폭식장애경향이라고 정의하였다.

2) 대인외상경험(Interpersonal Traumatic Experience)

대인외상경험은 대인관계 안에서 타인에 의해 고의적으로 발생한 외상 사건의 경험을 말한다. 즉, 타인과의 관계 안에서의 학대, 폭력, 소외, 이별 등 주관적으로 지각한 삶의 위기나 감정을 뒤흔드는 사건으로, 부정적인 심리적 결과를 유발하여 극심한 수준의 스트레스를 만들어내는 사건들을 직접적으로 경험하는 것이다. 따라서 대인외상경험은 한사람의 인지·정서·행동을 포괄하는 전 영역을 황폐화시키는 대인 간 폭력 경험을 의미한다(Courtois & Ford, 2009).

3) 인지적 재구성(Cognitive restructuring)

인지적 재구성은 인지행동치료에서 비합리적이고 부적응적인 사고 및 신념들을 찾아내어 그것들을 적응적이고 합리적인 사고 및 신념으로 수정하는 것을 의미한다. 즉, 부적응적이고 왜곡된 사고를 찾아내어 현실검증을 통해 합리적이고 대안적인 사고로 수정하는 치료적 작업이다(Beck, et al., 2005). 인지적 재구성의 일반적인 전략은 내담

자의 자동적 사고와 신념을 찾아내어, 대안적 사고와 신념으로 변화시키는 방법을 연습하고, 과제를 통해 재적용하는 것이다.

4) 이미지 재구성(Imagery Rescripting)

이미지 재구성 I 은 개인의 자서전적 기억을 떠올리고 재구성하는 단계를 통해 기억과 연합된 정서 및 의미를 바꾸는 것을 목표로 하는 3단계 기법이다(Arntz & Weertman, 1999). 기억에 직접 개입하기 위해 이미지 재구성 1단계에서는 사건 당시의 과거 자기 관점으로 기억을 회상하고, 2단계에서는 현재 자기 관점으로 사건을 관찰하면서 현재의 성인인 자기가 개입하여 이전의 어린 자기에게 더 긍정적이고 만족스러운 결과를 위해 필요하다고 여기는 것을 무엇이든 시도해보도록 하며, 3단계에서는 다시 과거 어린 자기의 관점에서 2단계에서 나타난 새로운 내용들을 통합한 뒤 변화를 요약하고 새롭게 학습한 것을 응고화하도록 돕는 과정으로 이루어진다.

이미지 재구성 II는 미래의 긍정적인 심상을 다뤄주는 것으로 최근 가장 심하게 폭식했던 상황과 이러한 폭식을 유발한 대인관계적 스트레스 상황을 선정하여 2단계로 개입한다. 1단계는 대인관계적 스트레스 상황으로, 2단계는 최근 가장 심하게 폭식했던 상황으로 선정하여 심상을 통해 각 상황들이 미래에 비슷하게 발생하였다고 가정하고 ‘최고로 가능한 자기’가 되어 문제 상황을 스스로 해결하고, 적응적으로 대처해 나가는 과정으로 이루어진다.

5) 인지적 특성(Cognitive Traits)

(1) 자동적 사고(Automatic Thought)

자동적 사고는 특정 상황 및 사건과 관련하여 자신도 모르게 순간적으로 떠오르는 생각을 말한다(Beck, 1967). 심사숙고하거나 합리적으로 판단한 생각이 아닌 의식적 자각 없이 자동적으로 일어나기 때문에 무비판적으로 받아들이게 되며 이러한 반복되는 사고 패턴이 습관화되면 자신의 자동적 사고를 마치 사실인 것처럼 무비판적으로 받아들이기 쉽고, 사고의 오류 또한 많아지게 된다(Beck & Clark, 1997). 자동적 사고

는 사건에 대한 강렬한 감정이 발생했을 때 인식할 수 있다.

(2) 역기능적 신념(Dysfunctional Belief)

역기능적 신념은 개인의 성장과정에서 다양한 경험을 통해 자기 자신, 타인 및 세상에 대해 형성한 일반적인 원리나 신념들 중에서 왜곡된 신념을 뜻하며, 이러한 신념은 절대주의적이고 완벽주의적이며 융통성이 없는 비현실적인 내용으로 이루어져 있다(Beck, 1985). 또한, 상황의 다양성 및 가변성을 고려하지 않고 모든 상황에 적용되는, 추상적이고 일반적인 부적응적 신념으로(조용래, 2000), 비교적 안정적이며 고정화되어 있다.

(3) 자아존중감(Self-Esteem)

자아존중감(Self-Esteem)은 자기 자신에 대한 개인적인 인지적 평가로서 긍정적인거나 부정적인 태도로 평가되며 자신에 대한 능력, 자신의 중요성, 성공 및 가치 등에 대해서 스스로 믿는 정도를 말한다(Coopersmith, 1967).

6) 정서적 특성(Emotional Traits)

(1) 정서조절곤란(Emotional Dysregulation)

정서조절(Emotion Regulation)은 자신의 정서에 대한 자각과 이해, 정서의 수용, 부정적인 정서를 경험할 때 극단적이거나 충동적인 행동을 억제하고, 개인이 설계한 목표와 일관되게 행동하는 능력, 설정한 목표와 개인의 상황적인 요구를 충족시키기 위한 정서 반응을 조절하기 위해 상황에 맞는 정서조절전략을 적절하게 사용하는 능력을 말한다(Gratz & Roemer, 2004). 이러한 능력이 부족할 경우 정서조절곤란이 있음을 나타낸다. 즉, 정서조절곤란(Emotional Dysregulation)은 정서의 자각과 이해, 수용, 충동통제능력, 목표에 맞게 행동하는 능력, 목표와 상황의 요구를 충족하기 위해 정서조절 전략을 융통성 있게 사용하는 능력에 있어서의 어려움을 말한다. 따라서 정서조절에 반복적으로 실패

패하거나 지속적인 정서조절의 어려움을 경험하는 상태이다(Cole, et al., 1994).

(2) 우울(depression)

우울은 실패와 상실에 대한 심리적 반응으로 개인이 부정적으로 인식한 것에 대한 결과를 의미하며 내면화된 수치심과 죄책감에서 기인된다(Gilbert, 1998; 2003). 또한, 근심, 침울, 실패감, 상실감, 무기력 및 무가치감과 같은 정서를 나타내는 정서장애의 한 형태이다(Beck, 1964).

(3) 상태·특성 불안(State-Trait Anxiety)

불안은 뚜렷한 원인이 없이 막연한 미래에 대한 두려움과 걱정 및 자율신경계통 활동의 증가로 인해 기분이 좋지 않은 부정적인 정서 상태로서, 주관적이고 자의적인 특성을 가진 상태를 의미한다(Spielberger, 1972).

(4) 상태·특성 분노(State-Trait Anger)

분노는 일상생활에서 자주 경험할 수 있는 정서 가운데 가장 기본적이고 핵심적인 정서이다(한덕웅 외, 1996). 불쾌한 사건을 초래한 사람이나 사물을 향한 생리적 각성과 적대적 인지를 수반하는 주관적인 정서 상태이며 이는 자동적인 과정으로 진행된다(Novaco, 1994).

7) 행동적 특성(Behavioral Traits)

(1) 스트레스 대처방식(Stress Coping Style)

스트레스 대처방식은 부정적 사건 및 상황을 경험한 후 이러한 스트레스 상황에서 자신의 스트레스를 지각하고 이를 극복하기 위한 인지적, 행동적 대처(Coping) 또는 대처행동(Coping Behavior)을 의미한다(Lazarus & Folkman, 1984). 스트레스 대처방

식은 외부나 내부 어느 것에 초점을 두고 노력을 투자하느냐에 따라 나뉘지며 본 연구에서 의미하는 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 스트레스 대처방식은 이들이 스트레스 상황에 직면하였을 때, 스트레스를 해결하고자 개인이 선택하는 특정한 행동전략 방식을 뜻한다.

8) 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램(Imagery Rescripting Cognitive-Behavioral Therapy Program)

이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 Beck(1985)의 인지행동치료 이론을 기반으로 하고 Arntz와 Weertman(1999)의 이미지 재구성 프로토콜을 활용하여 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 대상으로 자기관리, 인지적 재구성, 이미지 재구성, 이완훈련, 스트레스 대처훈련의 치료구성요인으로 개발한 총 10회기의 프로그램으로 정의한다. 10회기 중 7회기는 집단 회기(회기 당 약 120분 소요)로, 3회기는 이미지 재구성의 특성상 개별 회기(개인 당 약 50분 소요)로 진행된다.

IV. 연구방법

1. 연구설계

본 연구는 실험집단, 비교집단, 통제집단에 대한 사전·사후·추후검사 설계로 구성되었다. 실험, 비교, 통제집단을 대상으로 처치 전(사전), 처치 후(사후)에 대한 평가가 이루어졌으며, 실험집단과 비교집단에 한하여 프로그램 처치 3개월 후 추후검사를 실시하였다. 연구 설계는 <표 IV-1>에 제시하였다.

<표 IV-1> 연구 설계

집단	사전검사		사후검사	추후검사
실험집단	O ₁	x	O ₂	O ₇
비교집단	O ₃	y	O ₄	O ₈
통제집단	O ₅		O ₆	

x : 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램 실시

y : 전통적인 인지행동치료 프로그램 실시

O₁ : 실험집단 사전검사

O₃ : 비교집단 사전검사

O₅ : 통제집단 사전검사

O₇ : 실험집단 추후검사

O₂ : 실험집단 사후검사

O₄ : 비교집단 사후검사

O₆ : 통제집단 사후검사

O₈ : 비교집단 추후검사

2. 연구대상

1) 연구 대상 선정

본 연구의 대상은 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성이며 민법 제4조(성년)에 따라 성인 여성의 선별 연령 기준을 만 19세 이상으로 하였다. 또한, 폭식장애는 주로 성인기에 발병하며(Hudson, et al., 2005), 전 연령대의 성인 여성 중 20~30대가 가장 높은 비율을 차지하는 것으로 보고되었기 때문에(건강보험심사평가원, 2018) 폭식장애경향이 있는 20~30대의 성인 여성을 연구대상자로 선정하였다.

대상의 모집을 위하여 연구의 목적과 의의, 프로그램의 특성 및 기대 효과 등을 기술한 홍보지를 제작하여 2020년 05월 20일부터 2020년 11월 15일까지 전국 대학교의 온라인 게시판, 섭식장애 온라인 커뮤니티 홍보 게시판 및 지역사회 지면의 연구 공고 등에 게시하였다. 또한, 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 선별하고자 1차적으로 대인외상경험 체크리스트와 신경성 폭식증 검사 개정판(BULITR-R)을 온라인으로 실시하였고, 만 19세 이전에 대인외상경험을 겪은 사람들 중 주관적 고통의 정도가 5점 이상이면서(박애실, 2016), BULIT-R의 점수가 88점 이상이면(윤화영, 1996) 대인외상경험과 폭식장애경향이 있는 것으로 보고 연구 참여 대상으로 선별하였다. 그 결과 총 67명의 지원자 중 선별기준에 부합하는 26명을 선정하였고, 2차적으로 전화 면접을 실시하여 프로그램에 적극 참여할 의지가 있는지, 상담 및 약물 치료중이 아닌지 등을 확인하여 연구취지에 부합하지 않거나 프로그램 일정이 맞지 않는 5명을 제외하고 21명이 선발되었다. 마지막으로 최종 선발된 성인 여성 21명을 대상으로 심상 면접을 실시하여 실험, 비교, 통제집단으로 각 7명씩 배정하였다. 통제집단에는 윤리적 문제를 고려하여 세 집단의 사후 검사가 종결된 이후, 참여를 희망하는 대상자들에 한하여 전통적인 인지행동치료 프로그램을 실시하였다. 본 연구대상의 제외 기준은 <표 IV-2>와 같다.

<표 IV - 2> 연구 대상 제외기준

연구 대상 제외기준
1) 폭식 후 부적절한 보상행동(자발적 구토, 이뇨제, 관장약 등의 약물남용, 금식, 과도한 운동)을 보이는 성인 여성
2) 기혼 여성
3) 우울장애 외 불안장애와 같은 공존 장애를 수반하는 성인 여성
4) 상담센터나 정신과에서 상담 또는 약물치료를 받고 있는 성인 여성

2) 연구 대상의 일반적 특성

실험집단, 비교집단 및 통제집단 모두 성별은 여성이며, 각 7명씩 총 21명으로 연구 대상자의 일반적인 특성은 <표 IV-3>과 같다. 연구 대상의 연령은 만 19~24세가 7명, 만 25~30세가 8명, 만 31~36세가 6명이고, 결혼의 여부는 21명 모두 미혼이었다. 거주 상태는 가족(부모, 형제)은 13명, 친척은 0명, 친구는 1명, 혼자(자취, 기숙사)는 1명, 기타는 1명이었다. 경제적 수준은 하위층은 3명, 중하위층은 6명, 중층은 8명, 중상층은 4명, 상층은 0명이었다. 초기 외상 시기는 아동기(초등학교 입학 전)는 2명, 아동기(초등학교 입학 후)는 14명, 청소년기(중학생)는 3명, 청소년기(고등학생)는 2명이었다. 폭식 시작 시기는 아동기는 0명, 청소년기(중학생)는 3명, 청소년기(고등학생)는 4명, 성인기는 14명이었다.

<표 IV-3> 연구 대상의 일반적 특성

N=21

구분		실험집단		비교집단		통제집단		전체	
		n	%	n	%	n	%	n	%
연령 (만)	19세~24세	1	14.3	2	28.6	4	57.1	7	33.3
	25세~30세	4	57.1	3	42.9	1	14.3	8	38.1
	31세~36세	2	28.6	2	28.6	2	28.6	6	28.6
거주 상태	가족(부모, 형제)	5	71.4	3	42.9	5	71.4	13	61.9
	친척과 함께	0	0	0	0	0	0	0	0
	친구와 함께	0	0	0	0	1	14.3	1	4.8
	혼자(자취, 기숙사)	2	28.6	3	42.9	1	14.3	6	28.6
	기타	0	0	1	14.3	0	0	1	4.8
경제적 수준	하위층	1	14.3	1	14.3	1	14.3	3	14.3
	중하위층	3	42.9	1	14.3	2	28.6	6	28.6
	중층	2	28.6	3	42.9	3	42.9	8	38.1
	중상층	1	14.3	2	28.6	1	14.3	4	19.0
	상층	0	0	0	0	0	0	0	0
초기 외상 시기	아동기(초등학교 입학 전)	1	14.3	0	0	1	14.3	2	9.5
	아동기(초등학교 입학 후)	4	57.1	7	100	3	42.9	14	66.7
	청소년기(중학생)	1	14.3	0	0	2	28.6	3	14.3
	청소년기(고등학생)	1	14.3	0	0	1	14.3	2	9.5
폭식 시작 시기	아동기	0	0	0	0	0	0	0	0
	청소년기(중학생)	1	14.3	1	14.3	1	14.3	3	14.3
	청소년기(고등학생)	1	14.3	2	28.6	1	14.3	4	19.0
	성인기	5	71.4	4	57.1	5	71.4	14	66.7

3. 측정 도구

1) 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성 선별 도구

본 연구에서는 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 선별하기 위해 자기보고식 질문지인 대인외상경험 체크리스트, 폭식증 검사-개정판(BULIT-R), 및 심상 면접을 실시하였다. 각 측정 도구에 대한 목적, 형태에 대해 <표 IV-4>에 제시하였다.

<표 IV-4> 본 연구의 대인외상경험 및 폭식장애경향 대상자 선별 도구

항목	선별도구	목적	유형	문항 수	시점
대인외상경험	대인외상경험 체크리스트	아동·청소년기 대인외상경험 측정	자기보고식	4	사전
폭식장애경향	신경성 폭식증 검사 개정판(BULIT-R)	폭식장애경향 측정	자기보고식	36	사전
대인외상경험 및 폭식장애경향의 연결성	심상 면접	아동·청소년기 대인외상경험과 폭식장애경향의 연결성 확인	면담	-	사전

(1) 아동·청소년 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성 선별 도구

① 대인외상경험 체크리스트

본 연구에서는 아동·청소년기 대인외상 경험에 있는 성인 여성을 선별하기 위하여 Tedeschi와 Calhoun(1996)이 외상 후 성장 척도에서 사용된 외상 사건 목록과 Holmes와 Rahe(1967)가 개발한 사회 재적응 척도(Social Readjustment Rating Scale: SRRS)의 부정적 사건을 포함한 목록을 수정하여 송승훈 등(2009)이 사용한 외상 체크리스트를 다시 고아름(2012)이 보완한 척도를 사용하였다. 본 척도의 외상 사건은 사고 및 상해, 적응의 어려움, 자연재해, 부모님의 이혼 및 별거, 구타·폭행 등의 범죄피해, 학업·과업 문제, 성추행 및 성폭력, 배신·충격, 본인의 심각한 신체질환, 가정의 경제적 어려움, 사랑하는 사람의 질병, 어린 시절 학대, 사랑하는 사람의 사망, 대인관계 파탄

이라는 총 14개의 유형으로 구성되어있다. 본 연구에서는 대인외상사건으로 한정하여 14개 유형 중 비대인외상인 4개(사고 및 상해, 자연재해, 학업·과업 문제, 본인의 심각한 신체질환) 유형을 제외한 총 10개의 유형만을 사용하였다. 만 19세 이전에 경험한 대인외상 사건에 모두 응답하며, 그 중에서 가장 충격적이고, 고통스러웠던 사건 하나에 체크하고, 그 사건에 대한 경험 시기와 주관적 고통 정도를 Likert 7점 척도(1점=전혀 고통스럽지 않았다, 7점=매우 고통스러웠다)로 평정하며, 해당 사건의 내용을 구체적으로 기술하는 문항으로 구성되어 있다. 국내 연구에서는 5점 이상을 대인외상경험에 의한 주관적인 고통이 수반되었다고 간주하였다(박애실, 2016).

② 신경성 폭식증 검사 개정판(Bulimia Test Revised: BULIT-R)

본 연구에서는 폭식장애경향이 있는 성인 여성을 선별하기 위하여 Smith와 Thelen(1984)이 개발한 신경성 폭식증 검사(Bulimia Test: BULIT)를 Thelen 등(1991)이 개정하여 윤화영(1996)이 변안한 척도를 사용하였다. 본 척도는 총 36문항으로 구성되어 있으며, 폭식을 측정하는 28문항과 체중 조절 행동을 포함하는 8개 문항으로 이루어져 있다. 각 문항은 Likert 5점 척도(1점~5점)로 평정되며, 전체 점수의 범위는 36-180점으로 총점이 높을수록 폭식 증상이 높음을 의미한다. 국내 연구에서는 88점 이상을 폭식 경향이 있는 것으로 간주하였으며, 121점 이상을 섭식장애의 진단 및 치료가 필요한 상태로 보았다(윤화영, 1996; 이정애, 1997). Thelen 등(1991)의 연구에서 내적합치도 Cronbach's α 는 .97로 나타났다.

③ 심상 면접(Imagery Interview)

본 연구에서는 아동·청소년기 대인외상 경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 대상 선정과 프로그램 내 이미지 재구성 회기의 진행을 위해 심상 면접을 실시하였다. 심상 면접은 폭식장애경향과 연결된 아동·청소년기의 대인외상에 대한 초기기억 및 핵심신념을 탐색하는 면접이다. 본 연구에서는 Wild와 Clark(2011)의 사회불안장애에 대한 심상 면접 과정을 참고하고, Cooper(2011)의 제안에 따라 최근 가장 심하게 폭식했던 상황, 이와 관련된 초기 아동·청소년기의 대인외상관련 기억, 그리고 심상 및 기억과 관련된 핵심신념을

확인하였다. 심상과 기억의 생생함, 고통감, 핵심신념을 얼마나 사실로 믿는가에 대해 단일 문항으로 0점에서 100점 척도로 측정하였다. 참여자가 자신의 핵심신념의 식별에 어려움이 있을 경우 역기능적 스키마(신념) 체크리스트(Wright, et al., 2009)를 활용하였다. 심상 면접 질문에는 “최근에 가장 심하게 폭식했던 상황에서 ~씨의 마음속을 스쳐가는 생각을 살펴볼 것입니다.”, “폭식하는 자신을 보면 어떤 생각이 스쳐지나 가나요?/어떤 기분이 드나요?”, “만일 ~씨의 생각이 사실이라면 그건 스스로에게 무엇을 의미하나요?”, “폭식하는 상황에서 가장 마음에 안 드는 것은 무엇인가요?/그 심상이 ~씨 스스로에 대해 말해주고 있는 것은 무엇인가요?”, “만일 폭식하는 상황을 다른 사람이 본다면 자신은 다른 사람에게 어떻게 보이고/어떤 인상을 주고 있을 것 같나요?/특별히 떠오르는 사람이 있나요?”, “이제 ~씨가 어린 시절에 가장 고통스러웠다고 한 ~상황에 대해 살펴볼 것입니다.”, “바로 그때 어떤 생각이 스쳐지나 가나요?”, “그 당시의 자신/다른 사람을 보면 ~라는 생각과 ~라는 기분이 느껴진다고 하셨는데 이전의 폭식했던 상황을 떠올렸을 때 느꼈던 느낌과 비슷한 것 같나요?” 등이 있다.

2) 프로그램 효과 측정 도구

본 연구에서는 프로그램의 효과를 객관적으로 측정하기 위해 프로그램 실시 전후 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 인지적, 정서적 및 행동적 변화를 측정하기 위해 각각 자기 보고식 질문지 및 실험과제를 실시하였다. 각 측정 도구에 대한 목적, 형태, 문항 수에 대해 <표 IV-5>에 제시하였다.

<표IV-5> 본 연구의 사전·사후·추후 효과 측정 도구

항목	측정 도구	형태	문항 수	시점
섭식	부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동	자기보고식	24	사전, 사후, 추후
인지	부정적 자동적 사고	자기보고식	30	사전, 사후, 추후
	역기능적 신념	자기보고식	36	사전, 사후, 추후
	자아존중감	자기보고식	10	사전, 사후, 추후
정서	정서조절곤란	자기보고식	35	사전, 사후, 추후
	우울	자기보고식	21	사전, 사후, 추후
	상태·특성 불안	자기보고식	40	사전, 사후, 추후
	상태·특성 분노	자기보고식	44	사전, 사후, 추후
행동	스트레스 대처방식	자기보고식	24	사전, 사후, 추후

(1) 폭식장애경향 변인 측정 도구

① 부정적 정서로 유발된 섭식 동기 척도와 섭식 행동 척도(Negative Emotion-Induced Eating Motive and Eating Behavior Scale: NEIEMEBS)

본 연구에서는 부정적 정서로 유발된 섭식 동기 및 행동의 정도를 측정하기 위하여 Arnow 등(1995)이 개발한 정서적 섭식척도(Emotional Eating Scale: EES)를 배하영과 이민규(2004)가 한국 정상인 집단을 대상으로 개선하여 정진영 등(2019)이 수정한 척도를 사용하였다. 본 척도는 기존에 부정적 정서로 유발된 폭식 동기 12문항에 부정적 폭식 행동을 측정하는 12문항이 추가되어 총 24문항으로 구성되어 있으며, ‘우울하거나 낙심하면 음식이 먹고 싶어진다.’, ‘우울하거나 낙심하면 실제로 음식을 먹는다.’, ‘누군가에게 무시를 당하면 음식이 먹고 싶어진다.’, ‘누군가에게 무시를 당하면 실제로 음식을 먹는다.’, ‘뜻대로 일이 안되거나 잘못될 때 음식이 먹고 싶어진다.’, ‘뜻대로 일이 안되거나 잘못될 때 실제로 음식을 먹는다.’ 등의 문항으로 구성되어 있다. 이 척도는 2개의 하위 요인으로 섭식 동기(12문항), 섭식 행동(12문항)이 있다. 각 문항은 Likert 7점 척도(0점=전혀 그렇지 않다~6점=매우 그렇다)로 평정되며, 총점이 높을수록 문제 섭식 동기 및 행동이 높음을 의미한다. 정진영, 이훈진, 박세란(2019)의 연구에서 내적합치도 Cronbach’s α 는 .95이었으며, 본 연구에서 사용한 전체 척도의 내적합치도 Cronbach’s α 는 .97로 나타났다. 하위영역별로 해당되는 문항번호 및 문항 수, 신뢰도는 <표 IV-6>에 제시하였다.

<표 IV-6> 부정적 정서로 유발된 섭식 동기 척도와 섭식 행동 척도

하위척도	문항번호	문항 수	Cronbach’s α
섭식동기	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23	12	.95
섭식행동	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	12	.95
전체		24	.97

(2) 인지 변인 측정 도구

① 역기능적 신념 척도(Short Version of the Dysfunctional Beliefs Test: SDBT)

본 연구에서는 역기능적 신념의 정도를 측정하기 위하여 조용래와 원호택(1999)이 70문항으로 개발한 역기능적 신념검사(Dysfunctional Belief Test: DBT)를 홍세희, 조용래(2006)가 단축하여 재구성한 척도를 사용하였다. 본 척도는 총 36문항으로 구성되어 있으며, ‘사람들로부터 인정을 받으려면 항상 일을 잘해야만 한다.’, ‘내 기분이나 행동은 나에게 대한 다른 사람의 태도나 평가에 의해 좌우되는 것 같다.’, ‘사람들이 나를 알게 되면 내가 정말 열등하다는 것을 알아차리고 말 것이다.’, ‘나는 어딘가 부족한 사람이다.’, ‘긴장감이 느껴지는 대인관계를 일찍 그만두지 않는다면, 나중에는 끔찍한 결과를 경험하게 될 것이다.’, ‘다른 사람이 나를 싫어한다면, 나는 견딜 수가 없다.’ 등의 문항으로 구성되어 있다. 이 척도는 3개의 하위 요인으로 사회적 자기에 대한 부정적인 신념(12문항), 타인의 인정에 대한 과도한 요망(12문항), 타인 및 대인관계에 대한 부정적인 신념(12문항)이 포함된다. 각 문항은 Likert 6점 척도(1=전혀 일치하지 않는다~6=전적으로 일치한다)로 총점이 높을수록 역기능적 신념이 높음을 의미한다. 홍세희와 조용래(2006)의 연구에서 내적합치도(Cronbach's α)는 .95이었으며, 본 연구에서 사용한 전체 척도의 내적합치도 Cronbach's α 는 .98로 나타났다. 하위영역별로 해당되는 문항번호 및 문항 수, 신뢰도는 <표 IV-7>에 제시하였다.

<표 IV-7> 역기능적 신념 척도

하위척도	문항번호	문항 수	Cronbach's α
사회적 자기에 대한 부정적인 신념	2, 3, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 31, 36	12	.97
타인의 인정에 대한 과도한 요망	1, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 17, 24, 29, 30, 33	12	.96
타인 및 대인관계에 대한 부정적인 신념	9, 11, 13, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35	12	.95
전체		36	.98

② 부정적 자동적 사고 척도(Automatic Thoughts Questionnaire-Negative: ATQ-N)

본 연구에서는 부정적 자동적 사고의 정도를 측정하기 위하여 Hollon과 Kendall(1980)이 개발한 부정적 자동적 사고 척도(Automatic Thoughts Questionnaire-Negative: ATQ-N)를 권석만과 윤호균(1994)이 한국판으로 번안하고 타당화한 척도를 사용하였다. 본 척도는 총 30문항으로 구성되어 있으며, ‘나는 쓸모없는 사람이다.’, ‘나는 내 자신에 대해 매우 실망하고 있다.’, ‘나는 내 자신을 싫어한다.’, ‘도대체 나에겐 무엇이 문제란 말인가?’, ‘나는 인생의 패배자다.’, ‘나는 실패자다.’, ‘나에겐 틀림없이 무언가 잘못되어 있다.’ 등의 문항으로 구성되어 있다. 이 척도는 3개의 하위 요인으로 부정적인 자기상과 부정적인 기대(11문항), 현실에 대한 불만과 변화 욕구(14문항), 무기력과 의욕 상실(5문항)이 있다. 각 문항은 Likert 5점 척도(0=전혀 한적 없다~4=매우 자주 한다)로 평정되며, 총점이 높을수록 부정적 자동적 사고가 높음을 의미한다. 권석만과 윤호균(1994)의 연구에서 내적합치도(Cronbach's α)는 .93이었으며, 본 연구에서 사용한 전체 척도의 내적합치도 Cronbach's α 는 .97로 나타났다. 하위영역별로 해당되는 문항번호 및 문항 수, 신뢰도는 <표 IV-8>에 제시하였다.

<표 IV-8> 부정적 자동적 사고 척도

하위척도	문항번호	문항 수	Cronbach's α
부정적인 자기상과 부정적인 기대	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	11	.94
현실에 대한 불만과 변화 욕구	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	14	.95
무기력과 의욕 상실	26, 27, 28, 29, 30	5	.87
전체		30	.97

③ 자아존중감 척도(Rosenberg Self-Esteem Scale: RSS)

본 연구에서는 자아존중감의 정도를 측정하기 위하여 Rosenberg(1965)가 제작한 자아존중감 척도(Rosenberg Self-Esteem Scale: RSS)를 노은여(1997)가 번안한 척도를 사용하였다. 본 척도는 긍정적 자존감 5문항과 부정적 자존감 5문항이 포함되어 총 10문항으로 구성되어 있으며, ‘나는 나 자신을 긍정적으로 생각한다.’, ‘나는 대체적으로

나 자신에게 만족한다.', '나도 남들만큼 가치가 있는 사람이라고 느낀다.', '나의 삶은 크게 쓸모 있는 것은 아니다.', '나에게 나 자신을 존중하는 마음이 좀 더 있었으면 한다.', '때때로 나는 전혀 좋은 사람이 아니라고 느껴진다.' 등의 문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 Likert 5점 척도(0=전혀 그렇지 않다~5=매우 그렇다)로 평정되며, 총점이 높을수록 긍정적 자아존중감이 높음을 의미한다. Rosenberg(1965)의 연구에서 내적합치도(Cronbach's α)는 .92이었으며, 본 연구에서 사용한 전체 척도의 내적합치도 Cronbach's α 는 .92로 나타났다. 전체 척도의 문항번호 및 문항 수, 신뢰도는 <표 IV-9>에 제시하였다.

<표 IV-9> 자아존중감 척도

전체척도	문항번호	문항 수	Cronbach's α
자아존중감	1, 2, 3, 4, 5, 6*, 7*, 8*, 9*, 10*	10	.92

*는 역채점 문항

(3) 정서 변인 측정 도구

① 정서조절곤란(Korean Version of Difficulties in Emotional Regulation Scale: K-DERS)

본 연구에서는 정서조절곤란의 정도를 측정하기 위하여 Gratz와 Roemer(2004)가 개발한 정서조절곤란 척도(Difficulties in Emotional Regulation Scale: DERS)를 조용래(2007)가 번안, 타당화한 척도를 사용하였다. 본 척도는 DERS에 대한 조용래(2007)의 연구 결과, 문항 분석 및 요인분석에서 예상과 반대 방향의 결과가 나온 17번 문항이 제외되어 총 35문항으로 구성되어 있으며, '나는 내 감정에 대해 분명하게 알고 있다.', '나는 감정에 압도되고 감정을 통제하기 힘들다고 여긴다.', '나는 화가 나거나 기분이 나쁠 때, 내 감정을 알아차린다.', '나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 일을 끝마치기가 어렵다.', '나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 결국에는 내가 아주 우울하게 느낄 것이라고 믿는다.' 등의 문항으로 구성되어 있다. 이 척도는 6개의 하위 요인으로 충동통제곤란(8문항), 정서자각부족(8문항), 정서비수용(7문항), 정서적 명료성 부족(3문항), 정서조절전략 접근 제한(6문항), 목표지향행동 수행 어려움(3문항)이 있다. 각 문항은 Likert 5점 척도(1점=전혀 그렇지 않다~5점=매우 그렇다)로 평정되며, 총점이 높을수록 정서조

절곤란이 높음을 의미한다. 조용래(2007)의 연구에서 내적합치도(Cronbach's α)는 .93이었으며, 본 연구에서 사용한 전체 척도의 내적합치도 Cronbach's α 는 .97로 나타났다. 하위영역별로 해당되는 문항번호 및 문항 수, 신뢰도는 <표 IV-10>에 제시하였다.

<표 IV-10> 정서조절곤란 척도

하위척도	문항번호	문항 수	Cronbach's α
충동통제곤란	3, 14, 18, 19*, 21*, 23*, 26, 31	8	.91
정서에 대한 주의/자각 부족	1*, 2*, 6*, 7*, 8*, 10*, 32, 33*	8	.89
정서에 대한 비수용성	11, 12, 20, 22, 24, 28, 29	7	.94
정서적 명료성 부족	4, 5, 9	3	.86
정서조절전략 접근 제한	15, 16, 27, 30, 34, 35	6	.91
목표지향행동 수행 어려움	13, 17, 25	3	.82
전체		35	.97

② 한국판-벡 우울척도(Korean-Beck Depression Inventory: K-BDI)

본 연구에서는 우울의 정도를 측정하기 위하여 Beck(1967)이 개발한 벡 우울 척도(Beck Depression Inventory: BDI)를 이영호와 송종용(1991)이 한국판으로 번안한 척도를 사용하였다. 본 척도는 총 21문항으로 구성되어 있으며, '나는 슬프다.', '나는 앞날에 대해서 비관적인 느낌이 든다.', '나는 실패자라고 느끼지 않는다.', '나는 항상 죄책감을 느낀다.', '나는 아마 벌을 받을 것 같다.', '나는 나 자신에게 실망하고 있다.', '내가 다른 사람보다 못한 것 같지는 않다.' 등의 문항으로 구성되어 있다. 각 문항은 Likert 4점 척도(0점~3점)로 평정되며, 전체 점수의 범위는 0-63점으로 총점이 높을수록 우울이 높음을 의미한다. Beck에 의하면, 총점 9점 이하는 '우울하지 않은 상태', 10~15점은 '경미한 우울 상태', 16~20점은 '임상적 경계선 상의 우울 상태', 21~30점은 '중증 우울 상태', 31-40점은 '심한 우울 상태', 40점 이상은 '매우 심한 우울 상태'로 분류하였다. Beck(1967)의 연구에서 내적합치도 Cronbach's α 는 .84이었으며, 본 연구에서 사용한 전체 척도의 내적합치도 Cronbach's α 는 .86으로 나타났다. 전체 척도의 문항번호 및 문항 수, 신뢰도는 <표 IV-11>에 제시하였다.

<표 IV-11> 우울 척도

전체척도	문항번호	문항 수	Cronbach's α
우울	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	21	.86

③ 상태-특성 불안 척도(State-Trait Anxiety Inventory-Korean Version: STAI-K)

본 연구에서는 상태-특성 불안의 정도를 측정하기 위하여 Spielberger 등(1970)이 개발한 상태-특성 불안 척도(State-Trait Anxiety Inventory: STAI)를 김정택(1978)이 한국판으로 번안하고 한덕웅 등(1993)이 표준화한 척도를 사용하였다. 본 척도는 총 40문항으로 구성되어 있으며, ‘나는 마음이 차분하다.’, ‘나는 긴장되어 있다.’, ‘나는 앞으로 불행이 있을까 걱정하고 있다.’, ‘나는 불안하다.’, ‘나는 편안하게 느낀다.’, ‘나는 걱정하고 있다.’, ‘나는 마음이 놓인다.’, ‘나는 자신감이 부족하다.’ 등의 문항으로 구성되어 있다. 이 척도는 특정한 상황에서 긴장과 불안에 대한 주관적으로 지각된, 현재의 기분 상태를 측정하는 상태불안과 개인의 성향으로 비교적 변하지 않고 지속된, 일반적으로 느끼는 평소의 기분 상태를 측정하는 특성불안이 있다. 각 문항은 Likert 4점 척도(1점=전혀 그렇지 않다~4점=매우 그렇다)로 평정되며, 전체 점수의 범위는 40-160점으로 총점이 높을수록 불안이 높음을 의미한다. 이형주와 최해림의 연구(2010)에서 내적합치도 Cronbach's α 는 .94이었으며, 본 연구에서 사용한 전체 척도의 내적합치도 Cronbach's α 는 .97로 나타났다. 전체 척도의 문항번호 및 문항 수, 신뢰도는 <표 IV-12>에 제시하였다.

<표 IV-12> 상태-특성 불안 척도

전체척도	문항번호	문항 수	Cronbach's α
상태-특성 불안	1*, 2*, 3, 4, 5*, 6, 7, 8*, 9, 10*, 11*, 12, 13, 14, 15*, 16*, 17, 18, 19*, 20*, 21*, 22, 23, 24, 25, 26*, 27*, 28, 29, 30*, 31, 32, 33*, 34, 35, 36*, 37, 38, 39*, 40	40	.97

*는 역채점 문항

④ 상태-특성 분노 척도(State-Trait Anger Expression Inventory-Korean Version: STAXI-K)

본 연구에서는 상태-특성 분노의 정도를 측정하기 위하여 Spielberger(1988)가 개발한 상태-특성 분노 척도(State-Trait Anger Expression Inventory-Korean Version: STAXI-K)를 한덕웅 등(1997)이 한국판으로 변안한 척도를 사용하였다. 본 척도는 총 44문항으로 구성되어 있으며, ‘나는 성미가 급하다’, ‘나는 쉽게 화를 낸다.’, ‘나는 짜증을 느끼고 있다.’, ‘나는 미칠 듯이 화가 나 있다.’, ‘나는 화를 참는다.’, ‘나는 사람들에게 인내심을 가지고 대한다.’, ‘나는 사람들을 피한다.’, ‘나는 소리를 지른다.’, ‘나는 속으로는 다른 사람들을 비판한다.’, ‘나는 자제심을 잃고 화를 낸다.’ 등의 문항으로 구성되어 있다. 이 척도는 특정한 상황에서 분노에 대해 주관적으로 지각된, 현재의 기분 상태를 측정하는 상태분노, 개인의 성향으로 비교적 변하지 않고 지속된, 일반적으로 느끼는 평소의 기분 상태를 측정하는 특성분노, 화가 나면 자신의 분노를 환경 속의 타인이나 대상에게 겉으로 드러내어 표현하는 분노표출, 화가나 있지만 분노를 자신 내부로 돌리거나 억압하여 이를 밖으로 드러내지 않는 분노억제, 화가 난 상태를 인식하고 이를 진정시키기 위해 다양한 책략을 구사하여 상대방을 이해하고자 노력하는 분노조절이 있다. 각 문항은 Likert 4점 척도(1점=전혀 그렇지 않다~4점=매우 그렇다)로 평정되며, 전체 점수의 범위는 40-176점으로 총점이 높을수록 분노가 높음을 의미한다. 정호준 등(2017)의 연구에서 내적합치도 Cronbach’s α 는 .90이었으며, 본 연구에서 사용한 전체 척도의 내적합치도 Cronbach’s α 는 .94로 나타났다. 전체 척도의 문항번호 및 문항 수, 신뢰도는 <표 IV-13>에 제시하였다.

<표 IV-13> 상태-특성 분노 척도

전체척도	문항번호	문항 수	Cronbach’s α
상태-특성 분노	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	44	.94

(4) 행동 변인 측정 도구

① 스트레스 대처방식 척도(Stress Coping Style Checklist: SCSC)

본 연구에서는 스트레스 대처방식의 유형 및 정도를 측정하기 위하여 Lazarus와 Folkman(1984)이 개발한 스트레스 대처방식 척도(The Ways of Stress Coping Checklist)를 김정희(1987)가 요인 분석하여 선택, 개발한 것을 박주영(1995)이 하위 영역별로 6개씩 발췌하여 구성한 척도를 사용하였다. 본 척도는 총 24문항으로 구성되어 있으며, ‘활동계획을 세우고 그것에 따른다.’, ‘문제를 구체화시킬 수 있는 사람과 이야기한다.’, ‘모든 것을 잊어버리려고 노력한다.’, ‘일이 잘 되어 나갈 수 있도록 무엇인가를 변화시킨다.’, ‘자신이 느끼고 있는 바를 누구에게 말한다.’, ‘그 문제를 더 잘 이해하기 위해서 그것을 자세히 분석해본다.’ 등의 문항으로 구성되어 있다. 이 척도는 4개의 하위 요인으로 적극적 대처인 문제중심적 대처(6문항)와 사회적지지 대처(6문항), 소극적 대처인 정서완화적 대처(6문항), 소망적 사고(6문항)가 있다. 각 문항은 Likert 5점 척도(0=전혀 그렇지 않다~4=매우 그렇다)로 평정되며, 총점이 높을수록 대처수준이 높음을 의미한다. 박주영의 연구(1995)에서 하위 척도의 내적합치도 Cronbach's α 는 문제중심적 대처는 .62, 사회적지지 추구는 .69, 정서완화적 대처는 .79, 소망적 사고는 .84이었으며, 본 연구에서 사용한 하위 척도의 내적합치도 Cronbach's α 는 문제중심적 대처는 .79, 사회적지지 추구는 .75, 정서완화적 대처는 .70으로 나타났다. 하위 척도 중 소망적 사고의 경우 Cronbach's α 가 .50으로 신뢰도 기준치인 .70을 충족시키지 못하여(Nunnally, 1978), 제외하였다. 하위영역별로 해당되는 문항번호 및 문항 수, 신뢰도는 <표 IV-14>에 제시하였다.

<표 IV-14> 스트레스 대처방식 척도

하위척도	문항번호	문항 수	Cronbach's α
문제중심적 대처	1, 2, 9, 10, 17, 18	6	.79
사회적지지 추구	5, 6, 15, 16, 23, 24	6	.75
정서완화적 대처	7, 8, 11, 12, 19, 20	6	.70
전체		18	

4. 자료분석

본 연구에서는 수집된 자료의 분석을 위해 SPSS 21.0 통계 프로그램을 사용하였으며, 자료 분석 방법은 다음과 같다.

첫째, 연구 대상자의 사회 인구학적 배경의 일반적 특성을 알아보기 위해 빈도분석을 실시하였다.

둘째, 실험집단, 비교집단 및 통제집단 간 각 변인의 사전검사 점수 차이를 알아보기 위해 각 집단의 연구 대상 수가 적은 점을 감안하여 비모수 검정인 Kruskal Wallis 검정을 실시하였다.

셋째, 실험집단, 비교집단 및 통제집단 간 사후검사 점수 차이를 알아보기 위해 비모수 검정인 Kruskal Wallis 검정을 실시하였고, Bonferroni Correction을 통해 사후검정을 실시하였다.

넷째, 실험집단, 비교집단 및 통제집단 내 각 변인의 사전-사후검사 점수 차이를 알아보기 위해 비모수 검정인 Wilcoxon Signed-Rank Test를 실시하였다.

다섯째, 실험집단 및 비교집단 내 각 변인의 집단 간 추후검사 차이를 알아보기 위해 비모수 검정인 Mann-Whitey U 검정을 실시하였다.

여섯째, 실험집단 및 비교집단 내 각 변인에 대한 사전-사후-추후검사 점수의 변화를 알아보기 위해 비모수 검정인 Friedman Test를 실시하였다.

일곱째, 점수 변화에 따른 양적 분석에서 나타난 결과의 신뢰성을 보완하고, 프로그램 진행 과정에서 나타난 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 부적응적 사고 및 신념의 변화를 살펴보기 위하여 대상자 각각의 개인적 특성, 회기 내 진행했던 Worksheet 및 활동 결과물, 회기 녹음 내용을 전사한 것 등에서 추출된 내용을 바탕으로 내용분석을 실시하였다.

V. 프로그램 개발

1. 프로그램의 개발 과정 및 절차

본 프로그램 개발 과정은 총 8단계로 진행되었다. 1단계에서는 프로그램을 개발하기 위해 선행 연구 및 문헌들을 고찰하였고 이를 토대로 목표를 설정하였다. 2단계에서는 선행 연구들을 기반으로 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성에게 적합한 구성 요인을 선정하고, 이를 근거로 세부 활동 내용을 고안하였다. 예비 프로그램은 인지행동치료 전문가인 지도교수와 논의를 거쳐 구성하였고, 심리치료 석사 및 박사로 구성된 집단에서 논의를 거쳐 프로그램 진행의 적절성과 프로그램 구성의 이론적 근거와 논리성 등을 수정, 보완하였다. 3단계에서는 예비 프로그램을 구성하여 실험집단을 대상으로 6회기에 걸쳐 프로그램을 실시한 후 예비 프로그램에서의 참여자들의 피드백을 토대로 프로그램 세부 내용을 보완하였다. 이후, 인지행동치료 전문가 지도교수 1인과 인지행동치료사 박사 3인의 총 4명의 지도 및 논의를 거쳐 프로그램 구성의 이론적 근거 및 논리적 연결성, 프로그램 운영의 적절성, 프로그램 활동 내용 등을 확인하고 수정·보완하였다. 4단계에서는 예비 프로그램을 진행하면서 보완해야 할 사항을 추가하여 최종 프로그램을 구성하였다. 5단계에서는 연구 대상자들의 섭식 동기 및 태도(부정적 정서로 유발된 섭식 동기·행동), 인지적 특성(역기능적 신념, 부정적 자동적 사고, 자아존중감), 정서적 특성(정서조절곤란, 우울, 상태-특성 불안, 상태-특성 분노), 행동적 특성(스트레스 대처방식)을 측정한 후 선별된 총 21명의 성인 여성들을 실험집단, 비교집단 및 통제집단에 각 7명씩 임의 배정하였다. 6단계에서는 실험집단과 비교집단을 대상으로 10회기에 걸쳐 프로그램을 시행하였다. 각 프로그램은 주 2회, 회기당 120분씩 진행되었다. 7단계에서는 실험집단, 비교집단 및 통제집단을 대상으로 사후검사를 시행하였다. 8단계에서는 프로그램 종결 3개월 후 실험집단과 비교집단을 대상으로 추후검사를 시행하였다. 프로그램 개발 과정은 <표 V-1>과 같다. 모든 심상 면접과 프로그램 진행은 인지행동상담사 1급, 임상심리전문가 2급, 청소년상담사 2급 자격을 지닌 본 연구자가 담당하였다.

<표 V-1> 프로그램 개발 과정

단계	항목	프로그램 개발과정
1단계	기초 연구 및 목표 수립	• 선행연구 고찰 및 이론 정립
2단계	프로그램 예비구성	• 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램 예비 구성 및 자료 개발
3단계	예비 프로그램 실시 및 프로그램 수정·보완	• 기존 프로그램 수집 및 타당성 검증 • 프로그램의 구성요인선정 • 세부 활동내용 선정(전체 프로그램 및 회기별 프로그램)
4단계	본 프로그램 구성	• 예비 프로그램 대상 선정 - 대상 및 참여인원: 미혼 여성 5명 - 대인외상경험 체크리스트와 BULIT-R 실시 후 선별된 미혼 여성 중 5명을 대상으로 예비 프로그램 진행 - 실시회기: 6회기(주2회, 120분씩 진행) • 전문가 확인 절차 • 프로그램 수정 및 보완
5단계	사전검사 실시	• 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램 구성 • 참여자 선정(실험집단, 비교집단 및 통제집단) - 대인외상경험 체크리스트와 BULIT-R 실시 후 - 심상 면접 실시 • 측정 도구 1) 섭식 변인: 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동 2) 인지 변인: 역기능적 신념, 부정적 자동적 사고, 자아존중감 3) 정서 변인: 정서조절곤란, 우울, 상태-특성 불안, 상태-특성 분노 4) 행동 변인: 스트레스 대처방식
6단계	본 프로그램 실시	• 프로그램 실시 - 대상: 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성 - 참여인원: 21명 - 실험집단: 7명, 비교집단: 7명, 통제집단: 7명 - 실시 회기: 10회기(주 2회, 1회 120분으로 진행)
7단계	사후검사 실시	• 실험집단, 비교집단, 통제집단을 대상으로 사전검사와 동일한 측정도구를 사용하여 사후검사를 실시
8단계	추후검사 실시	• 실험집단, 비교집단을 대상으로 프로그램 종결 3개월 후 추후검사를 실시

1) 예비 프로그램의 구성 및 실시

(1) 예비 프로그램의 구성

이미지 재구성 인지행동치료 예비 프로그램의 치료구성요인은 자기관리, 인지적 재구성, 이미지 재구성, 이완훈련, 스트레스 대처훈련으로 이루어져 있으며, 도입, 전개 및 종결의 총 3단계로 구성하였다. 구체적으로 도입(1회기), 전개(2~5회기), 종결(6회기)로 이루어져있다. 도입단계는 대인외상경험, 폭식장애경향 및 인지행동치료 모델에 대한 심리교육, 폭식에 대한 자기관리, 이완훈련이 실시되었으며, 전개 단계(2~5회기)에서는 인지적 재구성, 이미지 재구성 및 이완훈련으로 구성되었다. 마지막 종결단계(6회기)에서는 스트레스 대처훈련 및 인지적 예행연습이 함께 진행되었다. 예비 프로그램의 세부 활동은 <표 V-2>에 제시하였다.

(2) 예비 프로그램의 실시

대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 위한 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램을 실시하기에 앞서 예비 프로그램을 실시하였다. 이는 프로그램의 목적을 달성하기 위한 진행 및 운영상의 문제, 치료구성의 적절성, 활동 내용의 이해도 등의 타당성을 검증하기 위함이다. 예비 프로그램의 대상은 본 프로그램의 대상선정 절차대로 대인외상경험 체크리스트 5점 이상, BULIT-R 88점 이상의 중복 기준에 해당되는 20~30대 미혼 여성 5명을 대상으로 선정하였다. 예비 프로그램은 경기도 소재 사설 H 심리상담센터 집단 상담실에서 진행하였으며, 2020년 03월 24일부터 2020년 04월 10일까지 운영되었다. 회기는 주 2회(화, 금)씩 총 6회기로 진행하였으며 집단 4회기는 회기 당 약 100분씩, 이미지 재구성 개별 회기는 개인 당 약 35~50분씩 2회기로 진행되었다. 예비 프로그램은 본 연구자가 진행하였으며, 연구보조자는 심리치료 전공 박사 2명과 함께 하였다. 연구보조자 교육은 프로그램 예비 실시 전 본 연구자가 프로그램의 오리엔테이션 및 매회기 전, 후로 모임을 통해 회기에 대한 내용 및 집단원들의 행동과 태도에 대한 의견을 나누고, 다음 치료 프로그램의 계획에 대한 적용 및 수정, 보완할 사항을 의논하였다. 또한, 프로그램 시작에 앞서 사전에 집단원들에게 비밀보

장, 녹음 등과 관련하여 서면으로 동의서를 받은 후 진행하였으며, 매 회기별 프로그램에 대한 의견을 나누었다.

<표 V-2> 예비 프로그램 구성 내용

단계	회기	치료구성요인	내용
도입	1	- 심리교육 - 자기감찰 - 이완훈련(호흡)	1. 프로그램 설명, 구조화 및 서약서 작성 2. 본 활동 - 대인외상경험, 폭식장애경향 및 CBT모델에 대한 심리교육 - 자기감찰: 폭식패턴 파악 3. 이완훈련(호흡): 쉼표 쓰기
	2	- 인지적 재구성 I (자동적 사고) - 이완훈련(점진적 근육)	1. 본 활동 - 자동적 사고 찾기 및 수정(대인외상경험, 폭식) 2. 이완훈련(점진적 근육): 순차적인 레몬짜기
전개	3	이미지 재구성 (개별 회기)	1. 심리교육: 이미지 재구성 2. 본 활동: 아동·청소년기 대인외상경험에 대한 이미지 재구성 3. 이완훈련(호흡&점진적 근육): 쉼표 쓰기&순차적인 레몬짜기
	4	- 인지적 재구성 II (핵심신념) - 이완훈련(심상)	2. 본 활동 - 핵심신념 찾기 및 수정(대인외상경험) 3. 이완훈련(심상): 오감을 활용한 나를 편안하게 하는 장소
	5	이미지 재구성 (개별 회기)	1. 심리교육: 이미지 재구성 2. 본 활동 - 아동·청소년기 대인외상경험에 대한 이미지 재구성 3. 이완훈련: 호흡&점진적 근육
종결	6	- 스트레스 대처훈련 - 인지적 예행연습 - 마무리	1. 스트레스 대처훈련: 문제해결기술 2. 인지적 예행연습 3. 자신에게 편지쓰기 4. 소감나누기

2) 예비 프로그램의 수정 및 보완

예비 프로그램 실시 후 프로그램에 참여한 대상자들의 피드백과 연구보조자들의 피드백을 바탕으로 프로그램을 1차 수정 및 보완하였다. 그 다음 심리치료 전공의 인

지행동치료사 3인과의 논의를 통해 2차 수정·보완을 실시하고, 마지막으로 인지행동 치료전문가인 지도교수 1인의 지도를 받아 최종적인 프로그램을 완성하였다. 전문가의 의견에 따라 프로그램 운영의 적절성에 관한 수정, 보완과 프로그램 활동 내용에 대한 수정, 보완이 이루어졌다. 수정, 보완된 내용은 다음 <표 V-3>과 같다.

첫째, 예비 프로그램을 실시한 결과 본 프로그램에서는 인지적 재구성, 이미지 재구성, 이완훈련, 스트레스 대처훈련, 인지적 예행연습을 추가로 더 구성하여 실시할 것이 요구되어 본 회기의 시간을 120분, 10회기로 구성하였다.

둘째, 인지적 재구성 단계를 2회기에서 4회기로 수정하였다. 인지적 재구성은 인지행동치료에서 중요한 과정으로, 부정적인 자동적 사고들과 핵심 신념들을 찾아내어 그것들을 적응적으로 수정하는 것에 중점을 둔다. 정해진 회기 안에서 자신의 자동적 사고와 핵심신념을 찾아내고, 이를 변화시키기 위한 기술 및 과제를 통한 연습으로 사고를 옹고화 시키는 데 2회기는 부족한 것으로 보였다. 이후 총 2회기를 추가로 구성하여 프로그램 참여자들이 반복적인 연습을 통해 습관화된 부적응적 인지를 수정하여, 기존의 핵심신념의 변화를 이끌 수 있도록 하였다.

셋째, 기존 이미지 재구성에 이미지 재구성 미래 심상 1회기를 추가하여 예비 프로그램에서 2회기로 진행된 이미지 재구성을 3회기로 수정하였다. 기존 이미지 재구성의 경우 초기의 대인외상경험에 대한 일화적 사건을 다루는 것에 그쳤지만 이미지 재구성 미래 심상 회기는 가장 최근의 폭식을 일으킨 대인관계문제 사건을 토대로 ‘최고로 가능한 자기’가 되어 대인관계문제를 적응적으로 대처하게 하여 수정된 핵심신념을 공고히 하는 동시에 프로그램에서 학습된 문제해결기술 및 대처기술까지 충분히 연습할 수 있도록 하였다.

넷째, 자기관리의 구성요소에 포함되는 규칙적인 식단계획에 대한 심리교육에서 기존 예비 프로그램에서는 규칙적인 식단에 대한 중요성만 교육하게 되며 현재 자신의 폭식 정도와 앞으로 지켜나가야 할 식단계획이 구체적이지 못하였다는 피드백을 수렴하여 본 프로그램에서는 자신에게 맞는 개별적인 식단계획과 식단계획을 잘 지키고 있는지를 여부를 살펴보는 식단계획 피드백 일지를 추가하여 폭식에 대한 자기관리를 도모하고자 하였다.

다섯째, 예비 프로그램에서는 스트레스 대처훈련을 1회기에 진행하였으나 대인외상경험이 있는 폭식장애경향자의 경우 스트레스를 적절하게 해소하지 못하고, 폭식으로

해결하려는 경향이 습관화되어 있기 때문에 스트레스에 적절하게 대처할 수 있는 문제해결 전략을 계획하고, 일상생활에서 과제로 시행한 후 점검까지 할 수 있도록 기존 1회기에서 2회기로 수정하였다.

여섯째, 연구대상자의 특성으로 프로그램에서 대인외상경험과 폭식장애경향에 대한 두 가지 주제의 연결성을 다루었기 때문에 참여자들의 이해가 부족한 경향이 있어 프로그램 활동 시작 전에 각각의 활동에 대한 목표, 의미 및 설명이 원활하게 이루어질 수 있도록 본 프로그램에서는 익숙하지 않은 용어와 워크시트 작업 등의 활동 과정을 그림 자료, 유인물 및 PPT자료 등 다양한 시각적인 자료와 매체를 활용하여 참여자들의 이해를 돕도록 구성하였다.

<표 V-3> 예비 프로그램 실시 후 수정 및 보완 사항

항목		예비 프로그램	본 프로그램	수정 · 보완 사항
운영과정 관련 수정 및 보완	프로그램 시간	- 100분	- 120분	- 인지적 재구성, 이미지 재구성, 이완훈련, 스트레스 대처기술 훈련 등을 위한 전반적인 영역에 대한 내용들을 충분히 다루는 데 시간과 회기 수가 부족하여 본 프로그램에서는 회기 진행시간과 전체 회기 수를 늘려 부족한 부분을 보완하였음.
	및 회기 수	- 6회기	- 10회기	
프로그램 내용 관련 수정 및 보완	인지적 재구성	- 2회기 실시	- 4회기 실시	- 부적응적인 사고를 찾아 수정하는 데 2회기는 부족한 것으로 판단되어 추가로 2회기를 더 구성하여 반복적인 연습을 통해 습관화된 부적응적인 인지를 원활하게 수정할 수 있도록 하였음.
	이미지 재구성	- 2회기 실시	- 3회기 실시	- 기존의 초기 어린시절의 대인외상경험을 다뤄주는 이미지 재구성으로 과거에 대한 핵심인념을 수정시켰다면

		이러한 변화된 적응적인 인지를 공고히 하는 폭식을 유발한 최근 대인관계문제 상황을 미래에 비슷하게 발생하였다고 가정하고 ‘최고로 가능한 자기’가 되어 적절하게 대처하도록 함. 따라서 문제해결기술 및 대처기술의 충분한 연습까지 도모할 수 있도록 하였음.	
규칙적인 식단계획	- 식단계획의 중요성만 교육	- 개인 맞춤형 식단계획표 작성 - 폭식 피드백 일지 추가	- 개인 맞춤형 식단계획표 작성하기와 폭식 피드백 일지를 추가하여 폭식에 대한 자기관리를 도모함.
스트레스 대처훈련	- 스트레스 대처 훈련을 위한 문제해결기술 1회기 실시	- 스트레스 대처 훈련을 위한 문제해결 전략 및 계획, 실행 및 점검으로 나누어 2회기 실시	- 스트레스 대처 훈련을 위한 문제해결기술을 전략 및 계획하고, 일상생활에서의 실행 및 점검까지 할 수 있도록 시간이 필요함.
각각의 활동들에 대한 목표, 의미 및 설명에 대한 효율적인 전달	- 유인물 및 구두설명	- 그림 자료, 유인물 및 PPT자료 등 다양한 매체 활용	- 익숙하지 않은 용어와 유인물 등의 훈련 과정을 보다 이해하기 쉽도록 다양한 매체 활용함.

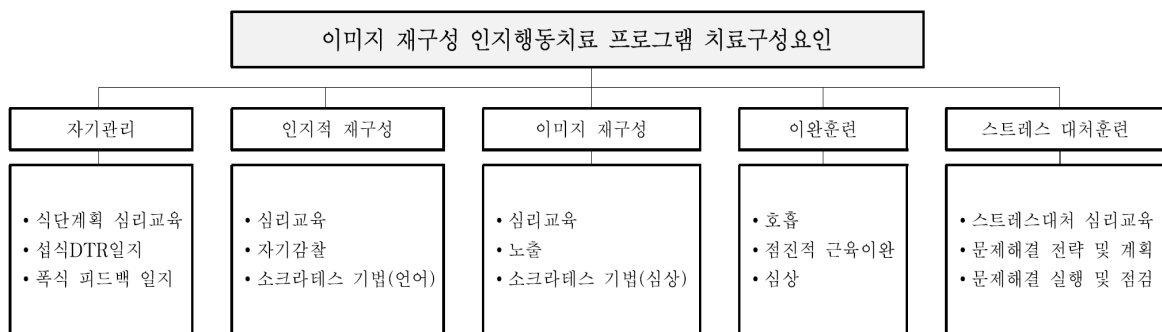
2. 프로그램의 구성

1) 프로그램의 목표 및 치료구성요인

아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 위한 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램을 시행하기 위하여 이론적 배경, 선행 연구의 고찰을 바탕으로

구성 방향을 잡았다. 구체적으로 자기관리, 인지적 재구성, 이미지 재구성, 이완훈련, 스트레스 대처훈련으로 구성되었으며 다음과 같은 목표를 세우고 실시하였다. 첫째, 폭식에 대한 자기관리인 식단계획과 폭식 피드백 일지를 통해 폭식 감소를 도모하였다. 둘째, 심리교육, 자기감찰 및 소크라테스 기법 등을 통해 자신의 사고, 정서 및 행동을 감찰하도록 하여 개인이 겪고 있는 비합리적이고 부적응적인 사고를 찾아 수정하도록 하여 언어적 접근의 인지적 재구성으로 왜곡된 사고 내용을 변화시키고자 하였다. 셋째, 이미지 재구성 I 을 통하여 대인외상경험에 대한 노출과 핵심신념을 수정시키고자 하였다. 또한, 이미지 재구성 II 인 미래 심상을 통해 ‘최고로 가능한 자기’가 되어 최근 폭식을 유발한 대인관계문제 상황 및 폭식 상황을 적응적으로 해결하며 수정된 핵심신념을 공고히 하는 동시에 문제해결기술 및 대처기술을 증진시키고자 하였다. 넷째, 호흡, 점진적 근육이완 및 심상 훈련을 통해 부정감정(우울, 분노, 불안)의 정서조절과 신체 증상을 완화시키는데 도움을 주고자 하였다. 다섯째, 문제해결기술을 통한 스트레스 대처훈련을 하여 폭식을 일으키는 대인관계적 스트레스 상황 및 폭식 상황을 효과적으로 대처할 수 있도록 하였다.

본 연구의 프로그램은 초기 단계에서는 인지행동치료 모델, 대인외상경험과 폭식장애에 대한 심리교육 및 자기감찰을 실시하였고, 전개 단계에서는 자동적 사고와 핵심신념을 변화시키는 인지적 재구성 및 이미지 재구성 I 을 실시하였으며 이미지 재구성 I 은 아동·청소년기 대인외상경험을 다루는 노출의 기능 또한 하였다. 이후 이미지 재구성 II 를 통해 최근 폭식을 일으킨 대인관계적 문제 상황과 폭식 상황을 긍정적으로 해결하였고, 이때 문제해결기술 및 대처기술의 연습을 도모하였다. 종결 단계에서는 스트레스 대처훈련, 인지적 예행연습을 시행하는 것으로 진행되었다. 프로그램 구성요인은 <그림 V-1>에 제시하였다.



<그림 V-1> 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램 치료구성요인

(1) 자기관리

자기관리(Self-Management)는 자신의 삶을 보다 적극적이고 자율적으로 살아가도록 도와주는 접근으로 개인이 통제 및 변화시키고 싶은 특정한 행동의 수정뿐만 아니라, 자신의 행동에 대한 책임감, 주도성 및 자율성을 키울 수 있는 전략이다. 자기관리의 목표는 단지 문제 상황을 제거하거나 문제 행동을 수정하는 것이 아니라, 더 나아가 앞으로 미래에 문제 상황이 발생하였을 때 이를 스스로 판단하여 효과적으로 대처하는 기술들도 배우는 것이다. Rehm과 Rokke(1988)는 인지행동치료에서 ‘자기관리’는 치료자가 내담자에게 어떻게 자기관리가 진행되는지 자기관리의 과정을 교육하고 실생활에서 과제의 형태로 실습하고 난 뒤, 치료자와 내담자가 함께 진행 상황을 점검하는 과정이라고 하였다. 따라서, 본 연구에서는 폭식과 관련된 부적절한 행동패턴에 대한 이해와 폭식에 선행하는 인지적 반응의 수정으로 폭식의 감소를 도모하기 위하여 우선적으로 심리교육을 통해 규칙적인 식단의 필요성과 식단계획을 작성하도록 하였으며 이후에 폭식 피드백 일지 및 섭식DTR일지를 과제로 작성하여 이를 토대로 폭식의 감소에 대한 목표 달성 정도를 점검하였다.

(2) 인지적 재구성

① 인지행동모델, 대인외상 및 폭식행동의 심리교육

인지적 재구성의 첫 단계로는 생각, 감정 및 행동이 서로 연결되어 있다는 인지행동치료 모델을 교육하는 것으로 시작된다. 이 심리교육을 통해 집단원들이 인지행동치료 모델을 이해하고, 사고와 감정 그리고 행동과의 연결성에 대한 관계를 명확하게 이해하게 한다. 또한, 이후에는 아동·청소년기 대인외상과 대인외상으로 인한 폭식행동에 관한 심리교육이 이루어진다. 인지행동치료에서는 아동·청소년기 대인외상경험으로 인한 폭식행동을 보이는 성인 여성이 인지를 수정하고, 감정을 조절하며 행동을 적극적으로 변화시키는 등의 기술을 습득하는 것에 중점을 두기 때문에 이러한 심리교육은 매우 중요하다.

② 자기감찰

자기감찰(Self-Monitoring)은 개인의 사고, 감정 및 행동에 대한 인식을 돕기 위한 과정이다. 자기감찰은 자신의 사고, 감정 및 행동을 파악하는 과정으로 인지적 재구성을 위한 필수 단계이다. 대인외상경험으로 인한 폭식행동을 보이는 성인 여성의 경우 자신의 행동이나 태도, 감정, 사고가 자동화되어 쉽게 인식하지 못하는 경향이 많으므로 자기감찰을 통해 자신의 사고와 감정을 감찰하고 폭식행동까지 이어지는 메커니즘을 정확하게 인지하는 것이 필요하다. 인지적 재구성은 자기감찰을 통해 인지적 왜곡과 자동적 사고를 평가하고, 비합리적인 사고를 대안적인 사고로 바꾸는 과정을 거치도록 한다. 본 프로그램에서는 자동적 사고를 찾기 위해 구체적으로 감정의 변화 인식하기, 폭식과 관련된 자동적 사고 기록지(Daily Thought Recode: DTR) 작성하기 등의 과제를 통해 실생활에서도 자기감찰을 훈련할 수 있도록 하였다.

③ 인지적 재구성

인지적 재구성은 인지행동치료에서 가장 중요한 구성요인으로 정서장애의 원인이나 심리적 고통의 원인이 되는 부적응적인 자동적 사고 및 핵심신념을 찾아 이를 적응적이고 대안적인 사고로 수정하여 변화할 수 있도록 돕는 체계적인 과정이다(Eisen & Silverman, 1993). 또한, 불안이나 우울 등 부정 정서를 유발하는 비현실적 사고와 왜곡된 신념으로부터 주의를 돌리는 데 중점을 둔 작업이기도 하다. 즉, 인지적 재구성은 내담자의 부적응적인 인지를 찾아 현실검증을 통해 보다 적응적이며 합리적인 인지로 재구성하는 치료적 개입이라고 할 수 있다(Beck, et al., 1985). 인지적 재구성은 인지 왜곡과 결핍을 확인, 사고 점검(Thought Monitoring), 부적응적 사고를 대안적인 사고로 수정하는 과정, 자동적 사고를 평가하는 과정을 거치게 된다.

인지적 재구성의 첫 번째 단계에서는 자동적 사고를 탐색하고, 이를 합리적인 사고 방식으로 수정하는 것이다. 자동적 사고는 일상생활에서 일어나는 수많은 인지 과정으로 삶에서 일어나는 사건들의 의미를 평가할 때 속사포처럼 빠르게 스쳐 지나가는 연속적인 생각이나 심상이다. 이때, 자동적 사고는 정확할 때도 있지만 부정확할 때도

있다. 자동적 사고는 어떤 사건 및 상황에서 본인이 원하지 않아도 불현듯 자신도 모르게 머릿속에 스치듯 생각이 떠오르기 때문에 마치 사실인 것처럼 무비판적으로 받아들이는 경향이 있으며, 개인의 지각에 영향을 주기 때문에 이에 따라 감정, 생리적 반응 및 행동에도 영향을 미친다(Beck & Beck, 1995). 자동적 사고는 부적응적인 사고와 왜곡된 핵심신념의 변화를 위한 인지적 재구성을 가능하게 해주기 때문에, 자기감찰로 자동적 사고를 파악하는 것은 반드시 필요한 과정이다. 부적응적인 사고를 하는 초기 대인외상경험이 있으며 폭식장애경향이 있는 성인 여성의 경우 자동적 사고의 근원인 우울, 불안 및 분노에 취약할 수 있다. 그 이유는 자신을 무능하거나, 사랑스럽지 않거나, 무가치한 사람으로 생각하는 핵심신념이 있기 때문이다. 이러한 신념들은 아동·청소년기의 대인외상경험으로 인해 외상사건을 자신의 탓으로 돌리며 자신을 비난하여 자신에 대한 부정적인 자기상을 가지고 있어 자기 자신에게 엄격한 잣대를 들이대며 냉정하게 평가한다. 따라서, 자신은 무능하고 별로이기 때문에 자신이 정한 실현 불가능한 규칙과 기준에 도달하지 못했을 때 스스로를 확대하며 우울, 불안 및 분노의 불편한 감정을 회피하며 폭식으로 풀어낸다. 즉, 이러한 사람들의 경우 문제의 원인을 자기 자신의 부족함이나 결점에서 찾기 때문에 ‘내가 좀 더 잘해야 한다.’, ‘나는 늘 일을 망친다.’, ‘나에게 뭔가 잘못된 것이 있다.’ 등의 부적응적인 자동적 사고들이 나타난다.

자동적 사고를 찾는 방법으로는 감정의 변화 인식, 심리교육, 사고 기록하기, 자동적 사고 체크리스트 등이 있다. 본 프로그램에서는 자동적 사고를 찾기 위한 방법으로 감정과 신체·생리적 변화 인식하기, 섭식DTR일지, 자동적 사고 체크리스트 등을 실시하였고, 자동적 사고를 수정하기 위한 방법으로는 인지적 오류 찾기, 대안적 사고 기록하기, 대처카드, 소크라테스식 질문하기, 인지행동적 예행연습 등을 실시하였다(Wright, et al., 2009).

인지적 재구성의 두 번째 단계에서는 왜곡된 핵심신념을 찾고, 이를 수정하는 작업을 한다. 핵심신념은 자신, 타인 및 세상에 대한 지식과 정보를 기억 속에 조직하여 저장하는 인지구조로 외부 자극을 선택적으로 지각하여 해석하며 저장하는 기능을 한다. 사람들마다 동일한 객관적인 사건에 대해 각자 다르게 반응하는 것은 개인마다 해당 사건을 어떻게 받아들이고 처리하는가의 고유한 사고체계가 있기 때문이다. 이러한 사고체계가 반복적으로 사용되면 신념화 되면서 고정적인 가치관을 형성한다. 초기 대

인외상경험으로 인해 형성된 핵심신념은 오래 지속된 믿음으로 ‘나는 무능해’, ‘다른 사람들은 믿을 수 없어’ 등과 같은 신념들을 갖고 있다. 이러한 핵심신념을 수정하기 위해 본 프로그램에서는 소크라테스 기법으로 사고를 재탐색하여 인지 변화를 경험하도록 하였고, 이외에도 범정역할극, 대안적 사고 기록하기, 대처카드, 소크라테스식 질문하기 등을 실시하여 새로운 대안적 신념을 만들 수 있도록 구성하였다. 이러한 구성과 함께 과제를 통해 인지적 재구성을 반복 연습하도록 함으로써 학습된 내용들을 일상 생활에서 보다 쉽게 적용할 수 있도록 하였다.

④ 이미지 재구성

대인외상경험자와 폭식장애경향자의 경우 자기비난이 심하여 기존의 전통적인 인지행동치료의 언어적인 접근 방식으로 핵심신념을 다룰 때 그 기원을 파악하고 타당성과 효용성을 검토하는 것에 어려움이 따를 수 있다. 분명 이러한 접근방식은 효과적이나 자기비난적이며 기원이 매우 오래된 핵심신념의 경우 개인이 오랫동안 익숙하게 사용하고 있는 인지의 패턴을 변화시키는 것에 거부감과 양가감정이 일어날 가능성이 있기 때문이다. 또한 기존의 인지행동치료가 머리로는 이해할 수 있으나 마음으로 잘 받아들이지 않을 수 있기에(Butler, et al., 2010), 본 프로그램에서는 대상자의 특성을 고려하여 심상을 활용한 접근 방식인 이미지 재구성을 통해 사고 및 신념을 효과적으로 수정하고자 하였다. 이때, 대상자의 경우 초기 대인외상경험과 폭식 관련 사고 및 신념을 전체적으로 다루어주어야 하였기에 이미지 재구성을 I, II로 나누어 개입하였다. 먼저, 이미지 재구성 I은 아동·청소년기 대인외상경험을 다룬다. 세부적으로, 이미지 재구성 I은 심상 면접을 통해 선정한 초기 대인외상경험을 대상으로 3단계로 진행되며 심상 안에서 외상경험에 대한 노출을 하게하고, 이후에 개인의 욕구를 적응적인 방식으로 반영하여 해당 기억을 재구성한다(Arntz, et al., 2014). 이때, 노출은 외상경험자에게 필수적이지만 기억하고 싶지 않은 사건을 떠올리도록 하기 때문에 어려움이 따르지만 이미지 재구성의 경우 노출 후에 외상 기억을 적응적으로 재구성하기 때문에 외상 사건에 대한 거부감, 불안을 다루는 데 효과적으로 작용하였다. 이는 반복적인 노출은 개인 스스로 두려움을 야기하는 자극들을 다룰 수 있게 하며 통제감을 얻게 하기에 불안에 대한 둔감화 혹은 습관화가 되어 정서를 조절할 수 있게 되기 때

문이다(Wright, et al., 2009). 따라서, 이러한 이미지 재구성의 치료적 기제에 따른 이미지 재구성 I의 3단계를 살펴보면, 1단계는 아동·청소년기 대인외상 기억에 개입하기 위해 사건 당시의 과거 자신(아동, 청소년)의 관점으로 기억을 회상하며 노출한다. 2단계는 현재의 자신(성인)의 관점으로 과거 사건을 관찰하며 현재의 성인인 자신이 개입하여 과거 자신의 반응이 어떤지 물어보고, 과거 자신을 위해 더 이상 해줄 말이나 행동이 없을 때까지 이 과정을 반복한다. 3단계는 다시 과거 자신(아동, 청소년)의 관점으로 돌아가 2단계에서 성인인 자신에게 도움 받은 내용들을 통합한 뒤 새롭게 배운 것을 응고화하도록 돕는 과정이 이루어진다. 이때, 과거 자신이 현재의 자신에게 바라는 것 없이 만족스러울 만큼 위안과 도움을 준다. 이러한 3단계 과정을 통해서 대상자는 기존의 고통스러운 초기 기억과 연관된 심상을 새롭게 변화시켜 자신의 기억에 통합시키게 된다. 각각의 단계마다 관점에 따라 대상자가 느끼는 욕구 및 감정들을 정확하게 인식하게 하고, 이를 스스로 해결하게 하면서 대상자는 기존의 부정적이었던 심상을 긍정적인 심상으로 수정하는 과정에서 심상을 통한 인지, 정서, 행동적 개입의 측면들이 서로에게 긍정적인 영향을 미치게 된다. 이처럼 이미지 재구성은 언어적 접근이 주가 되는 인지 수정과 비교하여 풍부한 정서경험을 가능하도록 하며, 정서가 동반된 심상작업이 더욱 빠르고 강렬한 인지 수정을 가능토록 하므로, 대상자로 하여금 고통스러운 초기 외상 기억에 대처할 수 있는 힘을 가질 수 있게 된다(Mathews, et al., 2013).

다음으로, 이미지 재구성 I을 통해 핵심신념이 수정된 후에는 대안적인 핵심신념을 공고히 할 수 있는 이미지 재구성 II를 시행하였다. 대인외상경험자와 폭식장애경향자의 경우 공통적으로 낮은 자존감과 우울, 불안 및 분노와 같은 부정 정서에 매우 취약한 경향성이 있다. 또한, 이들과 같이 우울, 불안한 사람들은 긍정적인 미래에 대한 심상의 선명도가 낮게 나타나며(Holmes, et al., 2008; Morina, et al., 2011) 부정적 미래 사건을 더 빨리 상상하고, 부정적 사건이 일어나지 않을 이유를 더 적게 생각한다(MacLeod, et al., 1997). 즉, 미래의 부정적 사건에 대한 심상을 더 쉽고 생생하게 떠올리며, 미래에 부정적 사건이 발생할 확률을 주관적으로 더 높게 보고하는 것이다(Raune, et al., 2005). 따라서, 이미지 재구성 II에서는 대상자의 습관화된 부정적인 심상 패턴의 특성을 고려하여 수정된 핵심신념을 공고히 하기 위한 긍정적인 미래 심상 시뮬레이션을 진행하고자 하였다. 이미지 재구성 II는 2단계로 이루어지며 1단계는 가

장 최근에 폭식을 일으켰던 대인관계적 스트레스 상황을, 2단계는 최근에 가장 심하게 폭식한 상황으로 선정하여 자신이 원하는 모습으로 대처하는 ‘최고로 가능한 자기 (Best Possible Self)’가 되어 심상을 통해 문제 상황을 긍정적으로 해결도록 구성하였다. 이때, 각각의 상황들은 과거에 발생했던 사건과 비슷하게 미래에 당면할 수 있는 상황으로 가정하여 문제 상황을 스스로 해결하도록 실시하였다. 개입은 선정한 미래 사건이 현재 일어나고 있는 것처럼, 현재 시점을 사용해서 이미지를 떠올린 후 ‘최고로 가능한 자기’가 되어 원하는 말과 행동을 실천하며 필요에 의해 물건이나 타인의 도움을 구하는 등 무엇이든 사용하고 요청해본다. 이때, 프로그램에서 배웠던 기법과 전략들을 충분히 연습해 볼 수 있도록 하며 미래상황의 내용을 스스로 구성하여 미래의 자기가 부정 감정 수준이 낮아지고 만족하도록 하였다. 이러한 미래에 대한 심상 시뮬레이션 과정은 상상된 시나리오에 그치지 않고 실제 경험과 같이 풍부한 의미와 정서적 정보를 제공할 수 있는 과정이 된다(Moulton & Kosslyn, 2009). 따라서, 새롭게 형성된 긍정적인 미래심상이 개인으로 하여금 적응적인 인지, 정서적 반응을 유발하고 자신에게 도움이 되는 행동적인 방안을 시도해볼 수 있도록 하므로, 일상생활에서의 미래에 대한 전망에도 영향을 미칠 것으로 예상하였다.

(3) 이완훈련

이완훈련은 스트레스로 인해 긴장된 신체가 안정되도록 마음을 가라앉히는 방법을 훈련하는 행동기법이다. 이완방법으로는 호흡, 점진적 근육, 심상 이완법이 있으며 본 프로그램에서는 호흡 이완훈련, 점진적 근육 이완훈련, 심상 이완훈련을 실시하였다. 또한, 회기마다 필요에 따라 개별로 진행하거나 두 가지 이완훈련을 병행하여 실시하였다. 구체적으로 호흡 이완훈련은 촛불 끄기와 같은 적절한 비유를 통해 들숨과 날숨을 사용하여 자신이 숨을 쉬고 있다는 것 자체에 집중할 수 있도록 하였다. 또한, 점진적 근육이완은 신체의 가장 위쪽에 있는 머리부터 시작하여 가장 아래에 있는 발까지 차례로 해당 부위의 근육을 긴장했다가 풀어내며 이완하도록 하였다. 심상 이완법의 경우 먼저 유인물을 통해 오감을 편안하게 하는 장소, 맛, 촉각 등을 찾게 하고, 이를 눈을 감고 떠올려 보게 한 다음 오감을 하나씩 느껴볼 수 있도록 하여 자신만의 심상에 편안하게 머무를 수 있도록 하였다. 이러한 이완훈련은

반복적인 연습을 통해 습관화 된다면 스트레스를 받거나 불편한 감정을 일으키는 상황에서 스트레스를 낮추고, 정서조절을 원활히 하는데 도움이 될 수 있다. 치료 회기에서는 연구자가 이완훈련의 원리와 방법에 대해서 심리교육 한 뒤 집단원이 연습할 수 있도록 하고, 회기마다 과제로 부여하여 실생활에서 충분히 활용하여 도움을 받을 수 있도록 구성하였다.

(4) 스트레스 대처훈련

폭식자는 스트레스를 받는 문제 상황에 직면했을 때 이에 대한 해결방법으로 많은 양의 음식을 혼자 은밀히 먹는 것으로 대처하는 경향이 있다(유진, 김광자, 2002). 특히, 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향자의 경우 초기 대인외상경험으로 인해 자신과 타인에 대한 왜곡된 핵심신념을 가지게 되어 대인관계적 문제상황을 큰 스트레스로 받아들이며 이를 적절하게 대처하지 못할 확률이 높다. 이러한 초기 대인외상경험이 있는 폭식자의 특성상 다양한 합리적인 문제 해결 전략을 모델링할 수 있는 기회가 부족하여 문제해결기술이 결여되어 있다. 따라서, 폭식 전의 촉발 문제와 이후의 폭식문제를 해결하는 방법을 직접적으로 교육하는 것이 도움이 되며 다른 집단원들과의 상호작용을 통해 자신만의 문제에 대처할 수 있는 대안을 세우게 하는 훈련은 치료 회기 과정에서 매우 중요할 것으로 보인다. 본 연구에서는 스트레스 대처훈련을 시행할 때 문제해결기술에 중점을 두었는데 문제해결기술은 실제로 어떤 문제가 발생하였을 때, 그 문제를 해결할 수 있는 여러 가지 방안을 생각한 다음 그 중에서 가장 효율적인 방안을 선택하여 문제에 대처시키는 유용한 기술이다. 인지행동치료에서 문제해결기술은 문제들을 선별하고, 목표를 고른 뒤 문제를 정확하게 정의하여 해결책들을 찾아보는 것이다. 이후에는 가장 합리적인 해결책을 선택하여 계획을 시행한 후 결과를 평가하고, 필요한 경우 다시 위의 단계들을 반복한다(Wright, et al., 2009). 이러한 문제해결기술을 습득시킴으로써, 스트레스 대처방식의 변화를 도모하므로 스트레스 상황에 효과적으로 대처하고, 행동할 수 있게 도움으로써 개인의 정서적 안정에 기여하여 부적응적 자동적 사고 및 왜곡된 핵심신념, 정서적 회피로 인한 폭식행동의 빈도를 감소시킬 수 있는 적극적인 방안이 될 수 있도록 하였다.

2) 프로그램의 회기별 구조

본 프로그램의 개입은 인사 나누기 및 기분 점검하기, 이전 회기 연결 및 과제 점검하기, 인지행동치료 및 이미지 재구성 작업하기, 피드백 나누기, 요약하기 및 과제 제시하기의 5단계로 회기별로 매뉴얼을 구조화해서 회기에 따라 프로그램 차이를 최소화하고, 참여자들이 프로그램 진행 과정에 대해 예측할 수 있게 하였다.

(1) 인사 나누기 및 기분 점검하기

프로그램의 도입에서는 인사를 나눈 뒤 오늘 하루 동안 느꼈던 자신의 감정을 점검해보고, 감정을 유발한 사건에 대해 폭식행동과의 연결 혹은 폭식 외에도 자유롭게 표현하는 활동을 진행하였다. 자신의 감정을 표현함으로써 자신의 감정에 대한 자기감찰을 할 수 있도록 하였으며, 집단원 서로의 감정들을 공유하면서 참여자 간의 친밀감을 도모하고자 하였다. 프로그램의 전반부에서는 하나의 감정을 표현하기 어려워하거나 여러 가지 뒤섞인 감정을 한꺼번에 표현하는 등 자신의 감정을 정확하게 표현하기 어려웠으나, 후반부에서는 자신의 감정을 인식하고 표현하는 것에 익숙해지면서 증진된 자기이해력을 보였다.

(2) 이전 회기 연결 및 과제 점검하기

이전 회기에 진행한 활동의 요약을 통해 본 회기에서 진행할 활동과 원활하게 연결되도록 하였고, 지난 회기의 과제를 점검하였다. 2회기부터 종결회기까지 매 회기 과제를 점검하였으며 특히, 섭식일지 및 식단계획표 점검에 대해서는 매일 꾸준히 시행하였는지, 방해 요소는 없었는지를 중점적으로 다루었고, 이완훈련 및 다른 과제들은 실생활에 어떠한 도움이 되었는지 구체적으로 파악하였다. 과제를 점검함으로써 과제가 자신에게 어떠한 도움이 되는지 확인하게 하여 과제참여에 대한 동기를 높였다. 또한, 과제점검에 대한 소그룹 작업과 대그룹 작업의 이분화를 통해 자신의 어려움이 개인만의 문제라는 생각에서 벗어날 수 있도록 돕는 동시에 각자 다른 관점과 피드백을 통해 같은 혹은 비슷한 문제(Agenda) 상황에서 다른 집단원은 어떻게 생각하며 해

결해 나갔는지 경험에 대한 공유를 하였다.

(3) 인지행동치료 및 이미지 재구성 작업하기

① 인지행동치료

본 활동에서는 각 회기의 목표에 따라 자기관리, 인지적 재구성, 이미지 재구성, 이완 훈련, 스트레스 대처훈련을 실시하였다. 심리교육(인지행동치료 모델 소개, 폭식장애와 대인외상에 대한 안내, 자기관리)과 자기감찰을 통해 자동적 사고에 대해 인식할 수 있도록 하였고, 비합리적인 사고와 부적응적인 사고를 합리적 사고로 수정할 수 있도록 하였다. 회기 내에서 대부분의 시간 동안 부적응적인 자동적 사고와 신념을 찾아내어 평가하고 대안적인 사고로 수정하도록 하였는데, 주로 언어적 접근의 인지적 재구성과 심상적 접근의 이미지 재구성 I, II를 활용하였다. 언어적 접근의 인지적 재구성은 소크라테스 기법, 증거 점검하기, 인지적 오류 찾기, 대안 찾기, 대처카드, 문제해결훈련, 인지적 예행연습 등이었다. 심상적 접근의 이미지 재구성은 I, II로 나뉘어져 있었으며 이미지 재구성 I에서는 폭식장애경향성에 영향을 미친 아동·청소년기 대인외상경험을 심상을 통해 노출시키며 3단계를 통해 고통스러운 자서전적 기억을 갱신(Update)하고, 부정적 자기심상과 고통스러운 자서전적 기억 모두에 수반되는 핵심믿음을 보다 기능적으로 변화시키도록 하였다. 이미지 재구성II에서는 2단계로 진행되며 1단계는 가장 최근에 폭식을 일으켰던 대인관계적 스트레스 상황을 선정하고, 2단계는 1단계의 가장 최근에 폭식했던 상황으로 선정하여 심상을 통해 각 상황들이 미래에 비슷하게 발생하였다고 가정하고 ‘최고로 가능한 자기’가 되어 문제 상황을 스스로 해결하고, 적응적으로 대처해 나가도록 하였다.

(4) 피드백 나누기

프로그램의 후반부에서는 피드백 나누기를 통해 각 회기를 마무리 하면서 회기 활동에 대한 전체적인 소감과 함께 가장 기억에 남는 활동을 선택하도록 하여 선택한 이유를 구체적으로 나누었다. 이러한 피드백 나누기 과정을 통해 연구자는 각 참여자들의 작업에 대한 이해 수준을 점검할 수 있었으며 다음 회기에 중점적으로 다루어야

할 집단의 전체적인 방향성과 각 개인에게 필요한 요소에 대한 정보를 얻을 수 있었다. 초기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성들은 무능감을 느끼거나 자기비난을 하는 경우가 있으므로 작업 과정에서의 어려움에 대해서도 스스로의 무능함으로 일반화하는 경향이 있다. 따라서, 다른 참여자들과의 피드백 작업을 통해 회기에서 어려움을 느끼는 것을 공유함으로써 자신만 어려운 것이 아니라는 것을 알고 안도감을 가지는 경험이 되었다. 또한, 서로 공통적인 문제를 가지고 있다는 것을 인식하고 나서는 공감대와 응집력이 형성되어 이후의 인지적 재구성 과정에서 보다 적극적인 상호 피드백이 가능해지도록 하는 계기가 되었다.

(5) 요약하기 및 과제 제시하기

매회기 전체적 요약을 함으로써 회기의 목표를 다시 확인하고, 그 회기에 학습된 내용을 되돌아보는 시간을 통해 집단원들의 이해를 높이하고자 하였다. 또한, 회기 중 습득한 기술들에 대한 과제를 제시하여 실생활에 적용해 볼 수 있도록 하였다.

3. 프로그램의 실시

1) 실험집단 대상 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램 실시

아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 위한 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 ZOOM 화상 회의 프로그램으로 시행되었다. 본 프로그램은 선별된 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성 7명을 대상으로 2020년 11월 28일부터 2020년 12월 30일까지 주 2회, 매 회기 120분으로 10회기 진행하였다. 프로그램의 전체 회기는 참여자들의 동의를 받아 녹음 및 녹화하였고, 회기에 활용했던 워크시트 결과물을 연구에 활용하는 것에 대해서도 동의를 받았다. 연구자는 각 참여자들에게 수집된 자료는 연구 목적 이외에 다른 용도로는 사용되지 않음을 명시하였으며, 대상자가 원할 경우 언제든지 프로그램 참여를 거부하거나 중단할 수 있음을 설명하였다. 프로그램 진행은 인지행동치료 수련 과정을 이수한 연구자가 회기마다 구조화된 매뉴얼에 따라 진행하였다. 인지행동치료 프로그램 개요는 <표 V-4>에 제시하였다.

<표 V-4> 실험집단 프로그램 구성 내용

단계	회기	치료구성요인	내용
도입	1	- 심리교육 - 자기관리 - 자기감찰 - 이완훈련: 호흡	1. 프로그램 오리엔테이션 및 자기소개(별칭 짓기) 2. 본 활동 - 대인외상경험, 폭식장애경향 및 CBT모델에 대한 심리교육 - 자기관리: 규칙적인 식단계획 - 자기감찰: 폭식패턴 파악 3. 이완훈련(호흡) 4. 과제: 섭식DTR일지, 폭식 피드백 일지, 이완훈련
	2	- 자기감찰 - 인지적 재구성 I: 자동적 사고 찾기 - 이완훈련: 호흡	1. 본 활동 - 자기감찰 심화(우울, 불안, 분노) - 자동적 사고 찾기: 토끼와 거북이, 자동적 사고 체크리스트, 7가지 파배기 오류 사고 2. 이완훈련(호흡) 3. 과제: 섭식DTR일지, 폭식 피드백 일지, 이완훈련
	3	- 인지적 재구성 I: 자동적 사고 수정 - 이완훈련: 근육	1. 본 활동 - 심리교육: 컵에 담긴 물(자동적 사고 수정) - 자동적 사고 수정하기: 파배기를 푸는 8가지 방법 2. 이완훈련(근육) 3. 과제: 섭식DTR일지, 폭식 피드백 일지, 이완훈련
전개	4	- 인지적 재구성 II: 핵심신념 찾기 및 점검 - 이완훈련: 근육	1. 본 활동 - 심리교육: 빙산(핵심신념 찾기) - 핵심신념 찾기 2. 이완훈련(근육) 3. 과제: 섭식DTR일지, 폭식 피드백 일지, 이완훈련
	5	- 심리교육: 이미지 재구성 I - 이미지 재구성 I - 이완훈련: 호흡&근육	1. 심리교육: 이미지 재구성 I 2. 본 활동 - 아동·청소년기 대인외상경험에 대한 이미지 재구성 I 3. 이완훈련(호흡&점진적 근육) 4. 과제: 섭식DTR일지, 폭식 피드백 일지, 이완훈련
	6	- 인지적 재구성 II: 핵심신념 수정 - 이완훈련: 점진적 근육	1. 심리교육: 색안경(핵심신념 수정하기) 2. 본 활동 - 핵심신념 수정하기: 법정 역할극(검사vs변호사) 3. 이완훈련(점진적 근육) 4. 과제: 섭식DTR일지, 폭식 피드백 일지, 이완훈련
	7	- 이미지 재구성 I - 이완훈련: 점진적 근육	1. 본 활동 - 아동·청소년기 대인외상경험에 대한 이미지 재구성 I 2. 이완훈련(점진적 근육) 3. 과제: 섭식DTR일지, 폭식 피드백 일지, 이완훈련

마무리	8	• 스트레스 대처훈련 I	1. 본 활동 - 스트레스 대처훈련 I: 문제해결기술 전략 및 계획
		• 인지적 예행연습 I	2. 이완훈련(심상): 오감을 활용한 심상
		• 이완훈련: 심상	3. 과제: 섭식DTR일지, 폭식 피드백 일지, 이완훈련
		• 심리교육: 이미지 재구성 II	1. 심리교육: 이미지 재구성 II 2. 본 활동
	9	• 이미지 재구성 II: 긍정적인 미래 심상	- 최근 폭식을 유발한 대인관계적 문제 상황의 이미지 재구성 II 3. 이완훈련(심상): 오감을 활용한 심상
		• 이완훈련: 심상	4. 과제: 섭식DTR일지, 폭식 피드백 일지, 이완훈련
			1. 본 활동
		• 스트레스 대처훈련 II	- 스트레스 대처훈련 I: 문제해결기술 실행 및 점검
종결	10	• 인지적 예행연습 II	- 인지적 예행연습: 대처카드(coping card) 만들기
		• 자신에게 편지쓰기	2. 이완훈련(심상): 오감을 활용한 심상
			3. 편지쓰기: 대인외상 당시의 어린 나와 현재의 나에게)

(1) 도입 단계

도입 단계인 1회기는 본 프로그램에 대한 목적 및 진행과정에 대해 소개를 하고 프로그램 참여와 관련하여 적극적인 상담 참여 및 시간 엄수, 비밀유지 등에 대한 안내를 하였다. 또한, 녹취 및 녹음에 대한 동의를 구했다. 이후 집단원 간 친밀감을 형성할 수 있도록 ‘나를 표현해요’를 통해 별칭을 짓도록 하고, 별칭을 중심으로 하여 자신을 나타내는 특징적인 그림 및 문구를 통해 자신에 대한 소개를 하며 프로그램에 참여하게 된 동기를 말하고, 프로그램 목표를 세워 보도록 하였으며, 목표 달성 정도는 중간 회기와 마지막 회기에 확인하는 시간을 가져보도록 하였다. 다음 활동으로는 인지행동치료 모델, 대인외상경험 및 폭식장애경향, 규칙적인 식단계획에 대한 심리교육을 차례로 진행하였다. 특히, 심리교육에서는 시각적인 매체를 제공하여 해당 내용들을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 하였고, 교육이 끝난 후에는 퀴즈를 통해 교육된 내용들을 잘 숙지하였는지 확인하였다. 잘 이해하였음을 확인한 다음에는 초기 대인외상경험과 폭식장애경향성의 인생그래프를 각자 그리도록 하고, 발표하는 시간을 가졌다. 인생그래프 작업 후에는 연구자가 전체 집단원들에게 개방하기 어려운 대인외상경험을 집단원들과 함께 이야기 나눈 것에 대한 감사함을 전달하고, 전체 집단원들이 각자의 소감을 얘기하며 자신의 대인외상경험과 폭식장애경향성 간의 이해와 함께 자신만이 아닌 다른 집단원들도 각자의 어려움과 그것을 헤쳐나가기 위해 노력하고 있음을 깨닫게 되며 집단원

간의 깊이 있는 공감을 나누었다. 마지막으로 부정 감정과 폭식에 도움이 되는 이완 훈련에 대한 심리교육을 하여 긴장상태와 이완상태가 공존할 수 없음을 중점적으로 교육한 뒤 호흡이완훈련인 촛불 끄기를 다 같이 연습해보며 들숨과 날숨의 반복을 통해 편안함을 느끼도록 하였다. 모든 활동이 끝난 후에는 과제안내 시간을 통해 집단원이 앞으로 매회기마다 제출해야 하는 과제에 대한 안내와 필요성을 설명하며 폭식 피드백 일지와 섭식DTR일지(사고기록 칸 제외) 작성법을 교육하고, 관련된 감정 단어 목록을 나눠주었다. 과제 안내까지 마무리한 다음 전체 집단원이 오늘 회기 중 가장 기억에 남거나 자신에게 가장 도움이 되었던 활동 및 내용을 채팅창에 남기도록 하고, 차례로 돌아가며 남겨놓은 문구를 중심으로 오늘 회기에 대한 소감을 나누도록 하였다.

(2) 전개 단계

전개 단계는 2회기부터 7회기까지 구성되었다. 전개 단계에서는 회기 시작 전에 집단원과 정한 과제 제출 시간에 폭식 피드백 일지와 섭식 DTR일지를 연구자의 이메일 또는 오픈 채팅방에 올리도록 하여 전체 참여자가 과제를 수행할 수 있도록 하고, 치료자가 체크하여 과제를 하지 못한 경우에는 회기 참여 전까지 과제를 제출할 수 있도록 하였다. 전기 단계의 회기가 시작되면 먼저 전체 집단원에게 오늘의 상황-기분을 연결시켜 말하도록 하였으며 이후 2~3명의 소그룹 별로 과제를 깊이 있게 탐색하며 서로 간의 피드백을 하고, 이것을 요약하게 해서 다시 전체 집단원이 모였을 때 소집단별로 정리한 내용을 나누며 필요에 따라 피드백을 할 수 있도록 하였다. 2회기에서는 1회기에서 간략하게 배운 자기감찰을 정확하게 배우기 위해 자기감찰 심화 훈련을 하였다. 소그룹 별로 감정 빙고 칸을 주고, 폭식 전에 느끼는 감정을 정해진 시간 안에 채우도록 하고, 시간이 다 되면 전체 회의실로 모여 감정 빙고 게임을 하였다. 이후 폭식할 때 대표적으로 느끼는 부정 감정인 우울, 불안 및 분노 감정에 중점을 두고, 유인물을 통해 폭식 직전의 우울, 불안 및 분노의 신체·생리적 반응이 각각 어떻게 표출되는지를 그림과 글로 표현할 수 있게 하여 폭식 직전에 느끼는 감정에 대한 정확한 이해를 도울 수 있도록 하였다. 이후 개인의 섭식DTR일지를 살펴보고 최근 폭식 직전에 느꼈던 상황과 감정을 떠올려보며 감정의 강도가 1~10점 중 몇 점 정도인지 그 강도를 파악해서 적도록 하였다. 이 활동을 통해 집단원은 폭식 직전에 자신이 어떠한 감정을 자

주 느끼는지와 감정마다 강도에 차이가 있음을 인식하게 하였다. 이어서 회기 핵심 작업인 자동적 사고를 찾기 위해 ‘토끼와 거북이’라는 시각적 자료를 사용하여 자동적 사고에 대한 심리교육을 실시함으로써 객관적인 상황에서도 자신이 어떻게 사고하고, 해석하는지에 따라 느껴지는 것들이 다를 수 있음을 인식하게 하였다. 이후 자동적 사고 체크리스트(Hollon & Kendall, 1980)와 섭식DTR일지를 활용하여 최근 폭식을 일으킨 대인관계와 관련된 상황을 떠올리게 하고, 사건을 경험한 순간 스쳐 지나간 생각을 찾아내고, 신체·생리적 변화, 감정의 강도 및 행동을 기록해 보도록 하였다. 참여자들의 자동적 사고에는 자신에 대한 비난 및 자책, 평가절하, 흑백논리, 독심술 등의 자신이 잘 수행하지 못한 실패 및 포기 경험이 많았으며, 타인의 의도에 대한 확대 해석이 주로 관찰되었다. 이후 7가지 직업적 파배기 오류(흑백논리, 당위적 진술, 과국화, 선택적 추론, 자기비난, 잘못된 명명, 독심술)를 통해 대표적인 인지 왜곡이 무엇인지 알아보고, 유인물 퀴즈를 통해 해당 내용을 이해하였음을 확인하였다. 이후 섭식DTR일지와 3회기의 자동적 사고 체크리스트에서 찾은 자동적 사고의 패턴을 찾아 7가지 파배기오류 중 어디에 해당되는지를 찾도록 하였다. 자동적 사고를 탐색한 이후에는 자동적 사고의 평가 기준에 대한 심리교육을 한 후 자신의 자동적 사고를 타당성, 유용성 및 현실성에 빚대어 평가하도록 하였다. 이때, 소집단 별로 토론할 수 있는 시간을 주어 먼저 개인이 발표한 후 나머지 집단원들이 피드백하여 해당 내용을 정리한 뒤, 전체 집단원이 모여 소집단 별로 정리한 내용을 간략하게 발표하고, 나머지 집단원이 피드백 하도록 하였다. 마지막으로 이완훈련은 지난 회기와 동일하게 이완호흡훈련을 하며 자신의 신체 감각의 변화를 느끼고, 편안감을 느끼며 회기가 마무리될 수 있도록 하였다.

3회기에서는 ‘컵에 담긴 물’과 이것을 활용한 사고 변화 CBT모델을 통해 상황을 바라보는 관점이 변화될 수 있으며 각 관점의 변화에 따라 감정과 행동이 바뀌는 것을 이해하고, 집단원들은 어떤 관점으로 상황을 바라보고 싶은지를 생각하게 하여 발표하였다. ‘컵에 담긴 물’은 컵에 물이 반쯤 담긴 그림으로, 먼저 제시된 그림을 보고 어떤 생각이 떠오르는지 생각에 따라 느끼는 감정과 연결되는 행동을 말해보도록 하였다. 이후 제시된 그림과 연결된 사고 변화 CBT모델 PPT자료를 통해 개인의 관점과 사고변화에 따라 자신이 원하는 방향으로 앞으로의 상황을 이끌 수 있다는 것을 인지시켰다. 특별히 대인외상경험이 있는 폭식장애경향자의 경우 대인외상경험으로 인한 자기비난 및 무능감과 관련된 사고가 두드러지므로 이 작업을 통해 전체 집단원들이 자동적 사고 수정

작업에 동기를 부여받도록 구성하였다. 다음으로 8가지 자동적 사고를 수정하는 대안 방법인 파배기를 푸는 8가지 대안 방법을 교육하며 각각의 방법마다 집단원들이 제출한 섭식DTR일지를 토대로 상황 및 사고를 선정하여 연구자가 제시하였고, 소그룹 별로 제시된 상황 및 자동적 사고를 8가지 대안 방법을 활용하여 수정하게 하였다. 8가지 대안 방법에는 ‘브레인스토밍 기법, 이익과 손실, 증거 점검하기(지지하는vs반하는), 최악과 최선의 상황, 관점취하기, 타임머신 기법, 파이 기법, 소크라테스 기법’이 있다. 소그룹 활동 후에는 전체 집단원이 모여 정리한 내용을 발표하였다. 다음으로는 문제해결사 활동을 통해 앞서 배웠던 8가지 대안 방법을 연습하였다. 문제해결사 활동의 절차는 전체 집단원들이 최근 대인관계적 문제로 인해 폭식하게 된 상황을 최대한 간결하게 적고, 이에 따른 자동적 사고도 같이 명시하게 하여 연구자만 해당 내용을 볼 수 있도록 비밀 채팅으로 보낸다. 연구자가 확인하여 회기에 가장 적합한 사례를 선정하여 전체 집단원이 내용을 확인할 수 있도록 전체 채팅방에 올린다. 연구자가 집단원 중 한 사람에게 마치 자신의 사연처럼 글을 읽어달라고 부탁하거나, 지원자가 있으면 지원자가 글을 읽도록 한다. 이후 모든 집단원이 문제해결사가 되어 앞서 배운 8가지 대안 방법 중 본인이 사용하고 싶은 방법을 선정하여 격려의 말과 함께 피드백 하도록 하였다. 마지막으로 8가지 대안 방법 중 본인이 사용하고 싶은 방법을 1개 이상 선정하여 자신의 대표적인 자동적 사고를 수정하게 하고, 발표하였다. 이때, 대표적인 자동적 사고는 2회기 때 자동적 사고 체크리스트에서 찾은 것과 섭식DTR일지를 살펴보면 반복되는 자동적 사고로 선정하게 하였다. 개인 작업 후에는 자신의 대안적 사고를 대처 카드(Coping Cards)에 작성하여 만들도록 하였고, 개인 작업이 끝나면 최종적으로 전체 집단원이 모여 차례로 돌아가며 자신의 대안적 대처 카드를 발표하도록 하였다. 마지막 활동으로 이완훈련에서는 근육이완훈련을 실시하여 호흡이완훈련과 다르게 다른 사람에게 보이지 않고, 손쉽게 사용할 수 있는 기법임을 알려주며 다 같이 연습하였다. 근육이완훈련은 양손에 샛노란 레몬이 쥐어져 있다고 생각하고, 이것을 맛있는 레몬에이드로 만들기 위해 손으로 있는 힘껏 찢다가 조금씩 손을 펴면서 변화되는 긴장과 이완의 신체감각을 느껴보게 하였다.

4회기에서는 핵심신념에 대한 심리교육과 핵심신념 찾기를 진행하였다. 핵심신념에 대한 심리교육은 PPT를 통해 진행하였으며 ‘빙산’그림을 통해 자동적 사고는 핵심신념에 비해 겉으로 쉽게 드러나서 찾을 수 있지만 자동적 사고에서 되풀이 되는 주제인 핵심신념은 물속에 잠겨있어서 겉으로 잘 드러나지만 앎을 뿐 우리의 인생에 큰

영향력을 미치고 있음을 알려주며 자동적 사고와 핵심신념의 관계를 설명하였다. 다음으로 핵심신념의 영역을 찾는 간이검사를 하였고, 자신이 어떤 영역에 해당하는지는 확인하기 전에 그다음 활동인 ‘당신은 누구편인가?’를 진행하였다. 이 활동에서는 이야기 줄거리를 읽고, 등장하는 5명의 인물 중 자신에게 가장 호감인 인물과 비호감인 인물을 각각 1명씩 선정하여 상황-생각-감정에 집중하여 선택한 이유를 발표하도록 하였다. 이후 앞서 진행한 간이 검사의 핵심신념 영역(인정, 사랑, 성취, 완벽, 대접, 자기 비난, 부정적·절망적), 3회기에서 찾은 반복되는 자동적 사고 및 심상 면접에서 찾은 핵심신념을 확인한 후 다시 ‘당신은 누구편인가?’에서 선택한 인물들을 살펴보고 연결성을 확인하고, 발표하였다. 마지막 활동인 이완훈련에서는 4회기의 손을 활용한 근육 이완훈련을 손과 발을 차례로 사용하며 이완할 수 있도록 하였다.

5회기는 이미지 재구성 I 과 3단계 절차에 대해 PPT로 심리교육한 뒤 집단원들 개별로 정해진 시간에 실시하였다. 이미지 재구성 I 은 윤혜영과 권정혜(2010)의 프로토콜 내용을 참조한 최윤영(2018)의 프로토콜 절차대로 실시하였다. 자세한 내용은 <표 V-5>에 제시하였다. 이미지 재구성 I 작업 후에는 이완훈련으로 앞서 배웠던 호흡 및 근육이완 훈련을 이어서하고, 재구성 작업에 대한 소감을 듣고 마무리하였다.

<표 V-5> 이미지 재구성 I 의 3단계 절차

단계	내용
1단계	내담자는 눈을 감고, 초기기억 당시 자신의 나이를 상상하고 마치 그 사건이 다시 발생한 것처럼 구체적으로 당시 상황을 상상, 체험한다. 상담자는 이 과정을 돕기 위해 당시의 주변 환경, 사람들, 당시 생각, 느낌, 행동 등의 세부적인 사항을 물어볼 수 있다. 내담자는 해당 사건의 시작 부분부터 끝나는 시점까지 사건 당시를 ‘어린 나’의 관점으로 경험한다.
2단계	내담자는 다시 기억의 첫 부분으로 돌아가는데, 이제는 ‘성인이 된 나’가 ‘어린 나’와 함께 사건 당시에 공존하며, ‘성인이 된 나’의 관점으로 해당 사건을 경험한다. ‘성인이 된 나’는 ‘어린 나’에게 일어나는 일들을 바라보며 ‘어린 나’에게 필요해 보이거나 주고 싶은 어떠한 도움이든 제공할 수 있다. 이 과정을 통해 내담자는 초기 기억의 내용을 재구성한다. 재구성 이후 상담자는 내담자의 생각, 감정, 감정의 수준 등을 반복적으로 확인하며, ‘어린 나’의 부정 감정의 수준이 충분히 낮아지고 만족할 때까지 ‘성인이 된 나’가 개입을 제공하도록 돕는다.
3단계	내담자는 2단계에서 재구성된 초기 기억을 ‘어린 나’의 관점으로 재경험 한다. ‘어린 나’는 부정 감정의 수준을 낮추고 추가적으로 바라는 것을 이루기 위해 ‘성인이 된 나’에게 개입을 요구할 수 있다. 이 과정 역시 ‘어린 나’가 충분히 만족하고, 부정 감정의 수준이 충분히 낮아질 때까지 지속한다.

6회기에서는 폭식 피드백 일지 중간점검으로 1회기 때 세운 목표에 도달한 정도를 수치로 측정하였다. 1~5회기까지의 과제인 섭식DTR과 폭식피드백 일지를 살펴보고 각 회기별로 식단계획을 잘 지켰는지, 지키지 못했다면 그 이유는 무엇인지에 대한 성공 및 실패 경험의 피드백을 상세하게 적도록 하고, 주차별로 달성 정도를 그래프로 그려, 수치화시켰다. 이후 프로그램 종결까지 앞으로의 목표를 달성하기 위해 그동안의 성공 및 실패 경험을 충분히 활용하여 구체적인 성공 전략을 세우게 하였다. 개인 작업이 끝난 후에는 전체 집단원이 차례대로 자신의 성공 및 실패 경험을 얘기하고, 앞으로의 목표 달성을 위한 전략을 발표하였다. 이때, 집단원들이 다양한 의견 및 정보를 교류하며 서로 피드백 하도록 하였다. 전체 집단원 모두 자신의 폭식 정도가 줄어 들고 있음을 그래프와 수치로 확인하며 서로 격려하는 시간을 가졌다. 다음으로 인지적 재구성 작업으로 집단원들의 핵심신념을 수정하는 작업을 하였다. 먼저, 핵심신념의 수정을 쉽게 설명하기 위해 ‘색안경’으로 비유하여 증거 점검하기 심리교육을 하였다. 자신의 핵심신념을 지지하는 증거들은 색안경을 쓰고 보는 것과 같고, 반하는 증거들은 색안경을 벗고 보는 것과 같다고 설명하였다. 이후 집단원 중 지원자의 사례로 핵심신념에 대한 지지증거와 반하는 증거들을 찾아 평가하는 과정을 시범 보였다. 이후에는 개별 작업 후에 2~3인의 소그룹을 나누어 서로 피드백 하고, 전체 집단원에서 발표하며 전체 피드백을 하였다. 이후 두 집단으로 나누어 핵심신념 증거를 점검하는 활동인 법정 역할극을 하였다. 법정 역할극은 총 3명의 역할이 주어지고, 2단계로 진행된다. 1단계에서 핵심신념의 주인은 변호사 역할을 해서 자신의 핵심신념을 지지하고, 검사는 핵심신념의 반하는 증거를 얘기한다. 이때 판사는 기록자의 역할을 하며 핵심신념의 지지와 반하는 증거들을 기록하고, 검사를 도와주며 핵심신념의 주인이 자신의 핵심신념을 믿는 정도를 수치화하여 충분히 낮아졌다고 보고하면 판사가 판결을 내려서 2단계로 넘어간다. 2단계에서는 핵심신념의 주인이 검사 역할을 해서 핵심신념에 반하는 증거를 반론하고, 1단계에서 검사는 판사의 역할을 하며 해당 임무를 하고, 판사는 변호사 역할을 하며 1단계에서 핵심신념의 주인이 지지하는 증거로 말했던 것들을 다시 얘기한다. 이때도 검사인 핵심신념의 주인이 자신의 핵심신념을 믿는 정도가 충분히 낮아졌다고 보고하면 수치를 확인하며 판사가 판결을 내린다. 이와 같은 과정을 두 그룹으로 나뉜 집단원 전체가 돌아가며 경험한다. 다음으로 연구자가 개입하지 않은 상태에서 집단원은 법정 역할극에서 판사가 기록한 핵심신념의 지지하는 증

거와 반하는 증거들을 확인하며 워크시트지를 통해 스스로 핵심신념의 이익과 손실을 따져보고, 기존의 핵심신념을 새로운 대안적인 신념으로 수정하여 발표하였다. 마지막 활동인 이완훈련에서는 점진적 근육이완법을 통해 신체의 상체부터 하체까지 차례로 전신을 사용하여 긴장과 이완을 느끼며 편안함을 느끼도록 하였다.

7회기에서는 5회기와 동일하게 이미지 재구성 I 을 집단원들 개별로 정해진 시간에 실시하였다. 이미지 재구성 I 작업 후에는 이완훈련으로 앞서 배웠던 점진적 근육이완 훈련을 이어서하고, 재구성 작업에 대한 소감을 듣고 마무리하였다.

(3) 마무리 단계

마무리 단계는 8회기부터 9회기까지 구성되었다. 8회기에서는 스트레스 대처훈련으로 폭식을 일으키는 대인관계 스트레스 상황에서 활용할 수 있는 문제해결기술 전략을 심리교육하고, 문제해결에 대한 계획을 세우도록 하였다. 사전에 연구자가 집단원들의 섭식DTR에서 해결하지 못한 문제 상황을 선정하여 6단계에 맞게 문제해결 한 예시를 보여주고, 각자 1~5단계까지 계획을 세우도록 하고, 소그룹을 통해 피드백을 주고받으며 정리하게 하였다. 이후 전체 집단원이 모여 발표한 후에 필요에 따라 피드백을 하도록 하였다. 문제해결 기술의 6단계는 먼저 1단계에서 문제를 선별한다. 2단계에서 문제를 정확하게 정의하여 구체화시킨다. 3단계에서 브레인스토밍을 활용하여 가능한 한 많은 해결책들을 찾아낸다. 4단계에서 이익과 손실을 확인하며 가장 합리적인 해결책을 선택한다(점수에 따라 우선순위 정하기). 5단계에서 선택한 해결책을 시행할 때 성공을 방해하는 환경에 대해 알아보거나, 문제가 발생할 경우 대처할 방안을 마련한다. 6단계에서 최종적으로 결과를 평가하는 데 이때, 성공했다면 자신의 만족감을 살펴보고, 성공할 수 있었던 효과적인 요인을 구체적으로 파악한다. 만약 실패했다면 4단계로 돌아가서 위의 내용을 반복한다. 다음으로 대인관계 영역에서 발생하는 스트레스에 잘 대처할 수 있는 기법 중 하나인 ‘좋은소식-나쁜소식-좋은소식’을 배우고, 인지 행동적 예행연습과 연결하여 역할극으로 연습하였다. 역할극 활동에 앞서, 먼저 연구자가 사전에 섭식DTR을 살펴보고 대부분의 집단원이 실제로 겪었던 상대방에게 적절하게 거절하지 못하여 스트레스 받았던 상황을 공동의 과제로 제시하여 좋은소식-나쁜소식-좋은소식의 기술을 활용하여 실제 거절해야 할 대상에게 이야기하는 형식

의 역할극을 구성하였다. 2~3명의 소그룹으로 짝을 지어 서로의 의견을 통해 대사를 미리 만들고 나서 역할극으로 연습하도록 하였다. 연습이 끝난 후에는 전체 집단원이 모여 소그룹 별로 발표하였다. 마지막 활동인 이완훈련에서는 ‘나를 편안하게 하는 오감’의 워크시트지를 통해 시각, 청각, 촉각, 후각, 미각의 각 카테고리에 맞춰 자신을 가장 편안하게 하는 오감을 구체적으로 명시하게 하였다. 이후 시각 카테고리 중 자신을 가장 편안하게 하는 모습을 종이에 직접 그리도록 해서 발표하고, 집단원 전체가 편안한 상태에서 눈을 감고, 차례로 오감을 자극하며 심상 이완훈련을 하였다.

9회기는 이미지 재구성Ⅱ와 절차에 대해 PPT로 심리교육한 뒤 집단원들 개별로 정해진 시간에 실시하였다. 이미지 재구성Ⅱ는 최윤영(2018)의 프로토콜 절차를 참조하여 2단계로 실시하였다. 1단계는 최근 가장 심하게 폭식을 일으킨 대인관계적 문제 상황으로 실시하였고, 2단계는 1단계의 최근 가장 심하게 폭식한 상황이 미래에 비슷하게 발생하였다고 가정하고 ‘최고로 가능한 나’가 되어 적응적으로 상황을 해결하였다. 자세한 내용은 <표 V-6>에 제시하였다. 이미지 재구성Ⅱ 작업 후에는 이완훈련으로 앞서 배웠던 심상 이완 훈련을 이어서하고, 재구성 작업에 대한 소감을 듣고 마무리하였다.

<표 V-6> 이미지 재구성Ⅱ의 절차

절차
이미지 재구성Ⅱ인 미래심상은 2단계로 나누어져 있다. 1단계는 최근 폭식을 일으킨 대인관계적 스트레스 상황으로, 2단계는 최근 폭식한 상황을 선정하여 미래에 해당 상황이 비슷하게 발생하였다고 가정하고, 자신이 원하는 긍정적인 모습으로 ‘최고로 가능한 자기’가 되어 문제 상황을 해결하는 것이다. 치료자: 재구성 작업 시작 전 ‘최고로 가능한 자기’에 대해 간단히 설명하고, 내담자가 선정한 과거 상황을 미래에 비슷하게 발생했다고 가정하여 떠올린 다음 긍정적인 방향으로 구성하도록 한다. “최고로 가능한 나는 미래 상황에서 원하는 대로 만족스럽게 삶의 목표를 실천하며 열심히 노력하는 모습으로, 문제 상황에서도 자신이 원하고 바라며 되고자하는 모습대로 이루어질 수 있으며 잠재력이 충분히 발휘될 수 있는 모습입니다. 선정한 상황이 현재 일어나고 있는 것처럼 떠올리고, 자신이 말하고 행동하고 싶은 것은 무엇이든지 시도하며 그동안 프로그램에서 배웠던 것들을 최대한 활용하여 문제 상황을 해결합니다. 내담자: ‘지금 여기에서 그 사건이 일어나고 있는 것처럼, 현재 시점을 사용해서 가능한 한 구체적이고 생생하게’ 사건 내에서 경험하는 것들을 이야기한다. 치료자: 이 과정을 돕기 위해 미래 상황의 주변 환경, 사람들, 생각, 느낌, 행동 등의 세부적인 사항을 물어볼 수 있고, 치료자는 필요에 따라 그동안 프로그램에서 배웠던 기술들의

팁을 알려줄 수도 있다.

내담자는 해당 사건의 시작 부분부터 끝나는 시점까지 미래 상황을 ‘최고로 가능한 자기’의 관점으로 경험한다. 미래상황에서 원하는 말과 행동을 실천해보며, 미래의 자기가 필요로 하는 물건이나 타인의 도움 등 어떠한 것도 사용하고, 요청할 수 있다. 이 과정을 통해 내담자는 미래상황의 내용을 구성한다. 치료자는 내담자의 생각, 감정, 감정의 수준 등을 반복적으로 확인하며, 미래의 자기가 충분히 부정 감정의 수준이 낮아지고, 만족할 때까지 이 과정을 지속하도록 한다.

(4) 종결 단계

종결 단계인 10회기에서는 마무리 단계에 이어 과제로 제시되었던 스트레스 대처 훈련에서 세운 계획으로 폭식이 감소되었는지 혹은 중단되었는지를 점검하였고, 잘 된 경우와 잘되지 않았던 이유를 개인적으로 파악하게 하였다. 다음으로 소그룹 작업으로 서로의 의견을 나누며 성공경험에 대한 전략, 실패경험에 대한 보완전략을 같이 세우도록 한 뒤 다시 전체 집단원이 모여 조별로 발표할 수 있도록 하는 동시에 전체 집단원이 발표된 내용에 대한 피드백을 다시 한 번 할 수 있도록 하였다. 이후 인지적 예행연습Ⅱ로 1~9회기까지 진행한 프로그램의 내용들을 간략하게 소개하고, 각각의 활동과 대표적인 기법들이 어떠한 목표와 효과가 있는지를 되돌아봄으로써 전체 프로그램에 대한 이해도를 높였다. 인지 행동적 예행연습 마무리로 대처 카드(Coping Card)를 만들도록 하여 대인관계문제부터 폭식의 연결성을 끊을 수 있는 자신만의 개별적인 무기 카드를 만들어 연습하도록 하였다. 대처 카드는 중요한 상황에 대처하기 위해 그동안 집단 프로그램 활동 중 자신에게 가장 도움이 되었던 것들을 A4지에 칸을 나누어 만들도록 하였다. 이때, 수정된 사고와 신념 및 활동을 떠올릴 수 있는 자신만의 그림 및 문구 등 다양한 방법을 활용하여 표현할 수 있도록 하여 대처카드를 보면 바로 대처전략을 떠올릴 수 있도록 하였다. 대처 카드 작업이 끝난 뒤에는 스마트폰으로 사진을 찍어서 저장하도록 하여 필요할 때 열어보거나 휴대폰 배경화면, 카카오톡 프로필 사진 등 쉽게 노출될 수 있는 자신만의 방식을 선택하여 자유롭게 활용할 수 있도록 하였다. 다음으로 목표달성에 대한 최종점검으로 6회기의 폭식 피드백 일지 중간점검과 동일한 방법으로 최종 점검 그래프를 만들도록 하여 프로그램의 처음, 중간, 최종 목표 달성 정도를 파악할 수 있도록 하였다. 목표달성에 대한 최종점검

이 끝난 후에는 연구자가 사전에 준비한 이미지 재구성 I, II 회기에서 확인한 참여자의 대인외상 당시와 현재 자신에 대한 이미지의 내용을 정리한 것과 변화에 따른 새로운 대안적인 핵심신념이 적힌 파일을 보내주어 개인별로 확인할 수 있도록 하였다. 마지막으로 그동안 프로그램에 참여하며 폭식을 극복하고자 애쓴 자신과 이미지 재구성 작업을 통해 만난 어린 시절의 자신에게 편지를 쓰는 작업을 하였다. 이 과정에서 연구자가 준비한 조용한 음악을 틀어 각자 편지쓰기에 집중하도록 하고, 자신이 쓴 편지를 읽어보며 성장한 자신을 격려 및 칭찬하는 시간을 갖도록 하였으며, 원하는 집단원에 한해서는 발표할 수 있도록 하였다. 최종적으로는 프로그램의 종결을 맞이하며 전체 소감을 나누고 마무리하였다.

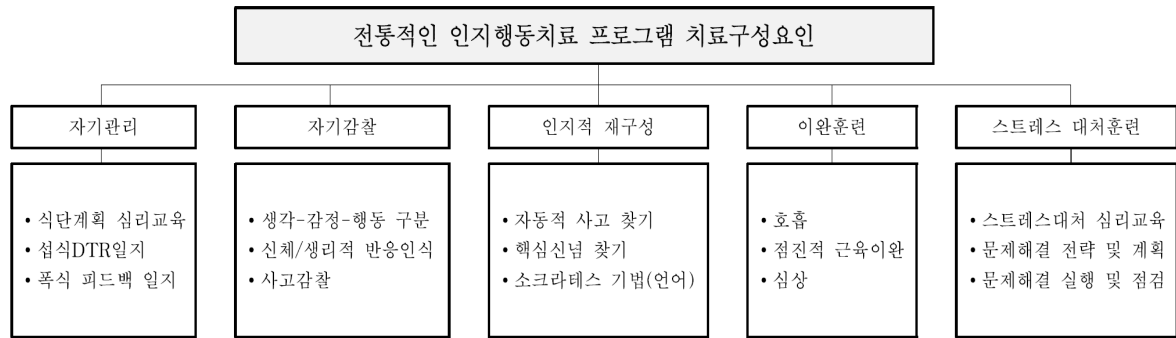
2) 비교집단 대상 전통적인 인지행동치료 프로그램 실시

비교집단에게 실시된 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 위한 전통적인 인지행동치료 프로그램은 ZOOM 화상 회의 프로그램으로 시행되었다. 선별된 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성 7명을 대상으로 2020년 11월 28일부터 2020년 12월 29일까지 주 2회, 매 회기 120분으로 10회기 진행하였다. 프로그램의 전회기는 참여자들의 동의를 받아 녹음 및 녹화하였고, 회기에 활용했던 워크시트 결과물을 연구에 활용하는 것에 대해서도 동의를 받았다. 연구자는 각 참여자들에게 수집된 자료는 연구 목적 이외에 다른 용도로는 사용되지 않음을 명시하였으며, 대상자가 원할 경우 언제든지 프로그램 참여를 거부하거나 중단할 수 있음을 설명하였다. 프로그램 진행은 인지행동치료 수련 과정을 이수한 연구자가 회기마다 구조화된 매뉴얼에 따라 진행하였다.

(1) 프로그램 목표 및 치료구성요인

비교집단에게 실시된 전통적인 인지행동치료 프로그램은 폭식을 위한 자기관리로 식단계획 심리교육, 섭식DTR일지 및 폭식 피드백 일지로 구성되어 있으며 자신의 자동적 사고, 감정 및 행동을 구분하여 파악하는 자기감찰 및 부정응적 자동적 사고와 핵심신념을 적응적으로 수정하는 인지적 재구성을 실시하였다. 또한, 정서조절에

도움이 되는 이완훈련과 스트레스에 적절하게 대처할 수 있는 문제해결기술을 중점으로 한 스트레스 대처훈련을 구성하였다. 프로그램 구성요인은 <그림 V-2>에 제시하였다.



<그림 V-2> 전통적인 인지행동치료 프로그램 치료구성요인

(2) 프로그램 진행 과정

프로그램은 도입, 전개, 종결의 세 단계로 구성되었고, 단계별 과정을 살펴보면 1회기는 도입 단계, 2~8회기는 전개 단계, 9~10회기는 종결 단계에 해당한다. 도입 단계에서는 전통적인 인지행동치료 프로그램의 목적 및 내용에 대한 소개, 친밀감 형성, 인지행동치료 모델, 대인외상경험, 폭식장애경향, 식단계획표에 대한 심리교육, 이완훈련을 실시하였다. 전개 단계에서는 자기감찰과 부적응적인 자동적 사고 및 핵심신념을 찾고 수정하는 인지적 재구성 작업, 이완훈련, 스트레스 대처훈련에 중점을 두었다. 종결단계에서는 참여자가 그동안 프로그램에서 배운 기법들을 활용하여 폭식의 빈도를 감소시키는 데 도움이 될 수 있도록 폭식을 일으키는 대인관계적 스트레스 상황을 설정한 후 역할극을 진행하여 프로그램 집단원들의 변화된 대처법을 확인하고, 과거 자신의 모습과 비교해 보도록 하였다.

3) 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램과 전통적인 인지행동치료 프로그램 비교

본 연구에서 실시된 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램(실험집단)과 전통적인 인지행동치료 프로그램(비교집단)의 목표는 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 부적응적인 자동적 사고 및 왜곡된 핵심신념을 찾아 대안적이고 적응적인 사고와 신념으로 수정하여 폭식 빈도를 감소시키는 것이다. 특히, 아동·청소년기 대인외상경험자들은 부정 정서를 회피하고, 정서를 조절하는 방식으로 폭식을 사용하므로(Heatherton & Baumeister, 1991), 인지행동치료의 패러다임에 따라 합리적인 인지 수정, 정서조절능력 향상 및 스트레스에 대한 대처능력 증진에 초점을 두고, 폭식이 악순환 되는 것을 방지 및 폭식의 감소를 도모하였다.

본 연구에서 실시한 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램과 전통적인 인지행동치료 프로그램은 성인 여성을 대상으로 한 ‘인지행동치료’라는 공통점이 있으나, 심상의 특성에 기반한 이미지 재구성 개입으로 인한 인지, 정서, 행동적 측면에서의 차이점이 있다.

먼저, 인지적 측면에서는 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 언어적인 접근 방법과 심상적인 접근 방법을 단계적으로 활용하여 인지적 재구성을 체계적으로 실시하였다. 구체적으로 언어적인 접근의 소크라테스 기법으로 인지적 재구성을 시행한 이후에는 심상을 활용한 이미지 재구성 I, II를 순차적으로 실시하였다. 이미지 재구성 I은 참여자의 초기 대인외상경험을 재경험 및 재구성시키며 해당 기억이 가지는 부적응적 의미를 변경시키고, 자동적 사고 및 핵심신념을 효과적으로 수정시킨다. 특히, 초기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향자들의 경우 자기비난적인 사고가 두드러져서 사고 수정 및 대안적인 사고를 찾거나 이를 실제로 믿는 것에 어려움이 있는데 이미지 재구성 I에서는 어른인 자신이 외상경험 당시의 어린 자기 자신을 진심으로 보살펴주고, 위로해주는 경험을 함으로써 자기비난적 태도가 수정되어 이후의 왜곡된 사고 및 신념을 수정하는 데 유효유적인 역할을 한다. 또한, 대인외상 당시 어린 아이 사고 수준에서의 피해(Victimization) 심상에서 성인 사고 수준의 대처/주도(Cope/Mastery) 심상으로 대체되며 아이보다 개선된 성인 수준의 인지기능이 상황을 객관적으로 파악하고, 대안적인 사고를 원활하게 찾아낼 수 있도록 도움으로써 보다 적응적으로 인지를 재구성하도록 한다. 이러한 이미지 재구성 I의 작업으로 인지를 적응적으로 수정한 이후에는 이미

지 재구성Ⅱ를 통해 ‘최고로 가능한 자기’가 되어 최근의 대인관계적 스트레스 상황부터 폭식까지로 연결된 악순환적 패턴을 끊어내는 작업을 통해 수정된 합리적인 사고를 강화시켰다. 반면, 전통적인 인지행동치료 프로그램에서는 왜곡된 사고 및 핵심신념을 찾고, 이를 수정하는 데 언어적인 접근의 인지적 재구성만을 시행하였다.

다음으로, 정서적 측면에서는 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램의 경우 이미지 재구성 I 을 통해 과거 어린 시절의 대인외상경험을 직접적으로 다뤄줌으로써 당시에 처리되지 못하였던 억제된 욕구와 다양한 부정 정서를 처리하는데 편안해지도록 하였다. 구체적으로, 과거 어린 시절의 고통스러운 외상 사건은 어린 아이로 하여금 정서를 표현할 때 안전감을 경험하지 못하게 하였고, 오히려 위협감을 느끼게 하거나 혹은 정서적인 지지를 받기위한 노력으로 정서적인 처리를 하지 못하였기 때문에 성인이 된 이후에도 감정 인식 및 감정 처리에 있어 어려움, 불편감 및 두려움을 경험하게 한다. 따라서, 이미지 재구성 I 의 3단계 프로토콜에 따라 개인의 자서전적 대인외상경험에서 개인의 두려움, 슬픔, 불안 등의 정서를 표출하거나 자신에게 해를 입힌 가해자에게 직접적으로 분노를 표출하는 등의 부정 정서를 표출시킨 이후에 스스로를 직접 돌보며 편안함, 안락함, 위로, 위안 등의 긍정 정서를 느끼게 함으로써 정서에 대한 기본적인 역기능적 관점을 수정시키며 정서 처리(Emotional Processing)의 변화를 일으켜 정서조절능력이 향상될 수 있도록 도왔다. 반면, 전통적인 인지행동치료 프로그램은 언어적 접근의 인지적 재구성으로 역기능적 사고 및 신념의 수정을 통한 정서의 변화를 도모하고, 이완훈련으로 정서조절에 도움이 될 수 있도록 하였다.

마지막으로, 행동적 측면에서는 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램의 경우 이미지 재구성 I 으로 아동·청소년기 대인외상경험에 대한 노출이 실행되었고, 스트레스 대처훈련에서도 언어적인 접근뿐만 아니라 이미지 재구성Ⅱ를 통해 심상적 접근의 문제해결기술을 기반으로 한 스트레스 대처훈련을 실시하였다. 이는 인간의 뇌가 실제 경험과 상상된 경험 간의 차이를 구별하지 않아서, 이미지 재구성 I, Ⅱ를 통해 상상된 경험이 실제 경험과 매우 유사한 뇌 반응을 나타내기 때문에 이러한 심상적 시뮬레이션 훈련이 실제 연습 못지않게 좋은 대안이 될 수 있다. 또한, 이미지 재구성Ⅱ에서의 긍정적인 미래 심상을 경험하는 것은 개인의 부정 정서를 낮춰주고, 목표지향적 행동을 향상시키므로 일상생활의 대인관계적 문제 상황 및 폭식 상황에서 보다 합리적으로 문제를 해결하여 스트레스 상황에 잘 대처할 수 있을 가능성을 높일 수 있도

록 하였다. 반면, 전통적인 인지행동치료 프로그램은 대인외상경험에 대한 노출이 진행되지 않았고, 스트레스 대처훈련에서도 언어적 접근의 문제해결기술만을 실시하였다.

이미지 재구성 인지행동치료 프로그램과 전통적인 인지행동치료 프로그램의 비교는 <표 V-7>에 제시하였다.

<표 V-7> 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램과 전통적인 인지행동치료 프로그램의 치료 구성요인 비교

세부항목	실험집단		비교집단	
	이미지 재구성 인지행동치료		전통적인 인지행동치료	
자기관리 접근	• 자기관리 - 식단계획표 - 폭식 피드백 일지 - 섭식DTR일지		• 자기관리 - 식단계획표 - 폭식 피드백 일지 - 섭식DTR일지	
치료 구성 요인	인지적 접근	• 인지적 재구성 - 언어적 접근의 소크라테스 기법 • 이미지 재구성 - 심상적 접근의 인지적 재구성	• 자기감찰 • 인지적 재구성 - 언어적 접근의 소크라테스 기법	
	행동적 접근	• 노출 - 이미지 재구성 I 을 활용한 노출 • 이완훈련 • 스트레스 대처훈련 - 언어&심상적 접근의 문제해결 기술	• 이완훈련 • 스트레스 대처훈련 - 언어적 접근의 문제해결기술	

VI. 프로그램 효과 검증

본 연구는 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 위한 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램을 개발 및 실시한 후 그 효과를 검증하고자 한다. 따라서 연구 목적을 달성하기 위해 통계적 검증을 실시하였고, 통계적 검증 결과는 다음과 같다.

1. 집단 간 사전검사 비교

프로그램의 사전검사 시 실험집단, 비교집단 및 통제집단 간 섭식 변인(부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동), 인지 변인(역기능적 신념, 부정적 자동적 사고, 자아존중감), 정서 변인(정서조절곤란, 우울, 상태-특성 불안, 상태-특성 분노), 행동 변인(스트레스 대처방식)의 동질성을 검증하고자 Kruskal-Wallis 검정을 실시하였다. 집단 간 변인별 사전 동질성 검증 결과는 <표 VI-1>에 제시하였다.

<표 VI-1> 집단 간 사전 동질성

변수	하위요인	평균순위			χ^2	p
		실험 집단 (n=7)	비교 집단 (n=7)	통제 집단 (n=7)		
부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동	전체	8.71	12.86	11.43	1.616	.446
	섭식동기	8.43	12.79	11.79	1.898	.387
	섭식행동	9.21	13.29	10.50	1.578	.454
역기능적 신념	전체	11.43	13.43	8.14	2.597	.273
	사회적 자기에 대한 부정적인 신념	10.71	13.07	9.21	1.377	.502
	타인의 인정에 대한 과도한 요망	13.29	12.93	6.79	4.877	.087
	타인 및 대인관계에 대한 부정적인 신념	10.14	12.86	10.00	0.947	.623
부정적 자동적 사고	전체	8.79	13.36	10.86	1.907	.385
	부정적인 자기상과 부정적인 기대	10.00	12.43	10.57	0.589	.745
	현실에 대한 불만과 변화 욕구	8.21	13.36	11.43	2.456	.293
	무기력과 의욕상실	9.43	13.86	9.71	2.274	.321
자아존중감	전체	13.86	8.14	11.00	2.998	.223

정서조절곤란	전체	8.14	12.43	12.43	2.232	.328
	충동통제곤란	7.71	13.00	12.29	3.012	.222
	정서에 대한 주의/자각 부족	9.14	12.21	11.64	0.977	.614
	정서에 대한 비수용성	9.86	11.86	11.29	0.387	.824
	정서적 명료성 부족	9.64	13.00	10.36	1.164	.559
	정서조절전략 접근 제한	9.43	11.86	11.71	0.682	.711
	목표지향행동 수행 어려움	10.50	13.00	9.50	1.236	.539
우울	전체	12.21	12.14	8.64	1.522	.467
상태-특성 불안	전체	8.86	12.07	12.07	1.259	.533
상태-특성 분노	전체	10.36	12.71	9.93	0.819	.664
스트레스 대처방식	문제중심적 대처	8.93	9.71	14.36	3.231	.199
	사회적지지 추구	11.07	13.00	8.93	1.538	.463
	정서완화적 대처	12.21	9.86	10.93	0.510	.775

1) 집단 간 섭식 변인 사전검사 비교

섭식 변인이 사전에 집단 간 동질한지 검증하기 위해 Kruskal-Wallis 검정을 실시한 결과, 부정적 정서로 유발된 섭식동기와 섭식행동 모두 유의한 차이를 보이지 않았다. 즉 실험집단, 비교집단, 통제집단 간 섭식 변인인 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동의 사전 동질성이 $p=.446(p>0.05)$ 으로 확보되었다.

2) 집단 간 인지 변인 사전검사 비교

인지 변인이 사전에 집단 간 동질한지 검증하기 위해 Kruskal-Wallis 검정을 실시한 결과, 역기능적 신념, 부정적 자동적 사고, 자아존중감 모두 유의한 차이를 보이지 않았다. 역기능적 신념의 하위요인인 사회적 자기에 대한 부정적인 신념, 타인의 인정에 대한 과도한 요망, 타인 및 대인관계에 대한 부정적인 신념 모두 집단 간 유의한 차이를 보이지 않았고, 부정적 자동적 사고의 하위요인인 부정적인 자기상과 부정적인 기대, 현실에 대한 불만과 변화 욕구, 무기력과 의욕상실도 모두 집단 간 유의한 차이를 보이지 않았다. 즉 실험집단, 비교집단, 통제집단 간 인지 변인인 역기능적 신념 $p=.273(p>0.05)$, 부정적 자동적 사고 $p=.385(p>0.05)$, 자아존중감 $p=.223(p>0.05)$ 모두

사전 동질성이 확보되었다.

3) 집단 간 정서 변인 사전검사 비교

정서 변인이 사전에 집단 간 동질한지 검증하기 위해 Kruskal-Wallis 검정을 실시한 결과, 정서조절곤란, 우울, 상태-특성 불안, 상태-특성 분노 모두 유의한 차이를 보이지 않았다. 정서조절곤란의 하위요인인 충동통제곤란, 정서에 대한 주의/자각 부족, 정서에 대한 비수용성, 정서적 명료성 부족, 정서조절전략 접근 제한, 목표지향행동 수행 어려움도 모두 집단 간 유의한 차이를 보이지 않았다. 즉 실험집단, 비교집단, 통제집단 간 정서 변인인 정서조절곤란 $p=.328(p>0.05)$, 우울 $p=.467(p>0.05)$, 상태-특성 불안 $p=.533(p>0.05)$, 상태-특성 분노 $p=.664(p>0.05)$ 모두 사전 동질성이 확보되었다.

4) 집단 간 행동 변인 사전검사 비교

행동 변인이 사전에 집단 간 동질한지 검증하기 위해 Kruskal-Wallis 검정을 실시한 결과, 스트레스 대처방식의 하위요인인 문제중심적 대처, 사회적지지 추구, 정서완화적 대처 모두 집단 간 유의한 차이를 보이지 않았다. 즉 실험집단, 비교집단, 통제집단 간 행동 변인인 스트레스 대처방식의 문제중심적 대처 $p=.199(p>0.05)$, 사회적지지 추구 $p=.463(p>0.05)$, 정서완화적 대처 $p=.775(p>0.05)$ 모두 사전 동질성이 확보되었다.

2. 집단 간 사후검사 비교

1) 집단 간 섭식 변인 사후검사 비교

프로그램 사후검사 시 실험집단, 비교집단, 통제집단 간 섭식 변인(부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동)의 차이를 검증하기 위해 Kruskal-Wallis 검정을 실시하였고, Bonferroni Correction에 의한 사후검정을 실시하였다. 그 결과는 <표 VI-2>에 제시하였다. 그 결과 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동의 총점은 집단 간 유의한 차이를

보였고($\chi^2=11.490$, $p<.01$), 하위요인인 섭식동기($\chi^2=12.246$, $p<.01$)와 섭식행동($\chi^2=10.787$, $p<.01$)도 집단 간 유의한 차이를 보였다.

사후검정 결과 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동의 총점은 실험집단($M=36.71$)이 통제집단($M=112.57$)보다 유의하게 낮았고, 섭식동기도 실험집단($M=19.71$)이 통제집단($M=60.00$)보다 유의하게 낮았으며, 섭식행동도 실험집단($M=17.00$)이 통제집단($M=52.57$)보다 유의하게 낮은 것으로 검증되었다.

<표 VI-2> 집단 간 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동의 사후검사 비교

변수	하위요인	집단	$M\pm SD$	평균 순위	Kruskal-Wallis		Bonferroni
					χ^2	p	
부정적 정서로 유발된 섭식동기 · 행동	전체	실험집단	36.71±20.30	5.21	11.490**	.003	a
		비교집단	78.86±39.36	11.36			ab
		통제집단	112.57±23.29	16.43			b
	섭식동기	실험집단	19.71±10.83	5.00	12.246**	.002	a
		비교집단	42.14±19.79	11.43			ab
		통제집단	60.00±9.83	16.57			b
	섭식행동	실험집단	17.00±9.68	5.36	10.787**	.005	a
		비교집단	36.71±20.26	11.43			ab
		통제집단	52.57±14.03	16.21			b

** $p<.01$

2) 집단 간 인지 변인 사후검사 비교

프로그램 사후검사 시 실험집단, 비교집단, 통제집단 간 인지 변인(역기능적 신념, 부정적 자동적 사고, 자아존중감)의 차이를 검증하기 위해 Kruskal-Wallis 검정을 실시하였고, Bonferroni Correction에 의한 사후검정을 실시하였다. 그 결과는 <표 VI-3>~<표 VI-5>에 제시하였다.

(1) 집단 간 역기능적 신념의 사후검사 비교

역기능적 신념의 사후검사 분석 결과, 역기능적 신념의 총점은 집단 간 유의한 차이를 보였고($\chi^2=12.252$, $p<.01$), 하위요인인 사회적 자기에 대한 부정적인 신념($\chi^2=10.020$, $p<.01$), 타인의 인정에 대한 과도한 요망($\chi^2=12.865$, $p<.01$), 타인 및 대인관계에 대한 부정적인 신념($\chi^2=10.207$, $p<.01$)도 모두 집단 간 유의한 차이를 보였다.

사후검정 결과 역기능적 신념 총점은 실험집단($M=52.86$)이 비교집단($M=105.57$)과 통제집단($M=126.86$)보다 유의하게 낮았고, 사회적 자기에 대한 부정적인 신념은 실험집단($M=16.00$)이 통제집단($M=42.43$)보다 유의하게 낮았으며, 타인의 인정에 대한 과도한 요망은 실험집단($M=19.29$)이 비교집단($M=39.86$)과 통제집단($M=42.71$)보다 유의하게 낮았고, 타인 및 대인관계에 대한 부정적인 신념은 실험집단($M=17.57$)이 통제집단($M=41.71$)보다 유의하게 낮았다.

<표 VI-3> 집단 간 역기능적 신념의 사후검사 비교

변수	하위요인	집단	$M \pm SD$	평균 순위	Kruskal-Wallis		Bonferroni
					χ^2	p	
역기능적 신념	전체	실험집단	52.86±7.82	4.43	12.252**	.002	a
		비교집단	105.57±40.29	13.14			b
		통제집단	126.86±45.24	15.43			b
	사회적 자기에 대한 부정적인 신념	실험집단	16.00±2.83	5.36	10.020**	.007	a
		비교집단	31.14±16.53	11.93			ab
		통제집단	42.43±18.48	15.71			b
	타인의 인정에 대한 과도한 요망	실험집단	19.29±2.56	4.14	12.865**	.002	a
		비교집단	39.86±10.17	14.29			b
		통제집단	42.71±15.89	14.57			b
	타인 및 대인 관계에 대한 부정적인 신념	실험집단	17.57±2.82	5.07	10.207**	.006	a
		비교집단	34.57±15.05	12.71			ab
		통제집단	41.71±13.33	15.21			b

** $p<.01$

(2) 집단 간 부정적 자동적 사고의 사후검사 비교

부정적 자동적 사고의 사후검사 분석 결과, 부정적 자동적 사고의 총점은 집단 간 유의한 차이를 보였고($\chi^2=12.767$, $p<.01$), 하위요인인 부정적인 자기상과 부정적인 기대($\chi^2=12.661$, $p<.01$), 현실에 대한 불만과 변화 욕구($\chi^2=9.311$, $p<.05$), 무기력과 의욕 상실($\chi^2=12.335$, $p<.01$)도 모두 집단 간 유의한 차이를 보였다.

사후검정 결과 부정적 자동적 사고 총점은 실험집단($M=18.00$)과 비교집단($M=30.14$)이 통제집단($M=77.14$)보다 유의하게 낮았고, 부정적인 자기상과 부정적인 기대는 실험집단($M=7.29$)과 비교집단($M=13.14$)이 통제집단($M=30.86$)보다 유의하게 낮았으며, 현실에 대한 불만과 변화 욕구는 실험집단($M=8.71$)이 통제집단($M=34.14$)보다 유의하게 낮았고, 무기력과 의욕상실도 실험집단($M=2.00$)이 통제집단($M=12.14$)보다 유의하게 낮았다.

<표 VI-4> 집단 간 부정적 자동적 사고의 사후검사 비교

변수	하위요인	집단	$M\pm SD$	평균 순위	Kruskal-Wallis		Bonferroni
					χ^2	p	
부정적 자동적 사고	전체	실험집단	18.00±15.26	6.07	12.767**	.002	a
		비교집단	30.14±17.95	9.36			a
		통제집단	77.14±26.66	17.57			b
	부정적인 자기상과 부정적인 기대	실험집단	7.29±6.32	6.21	12.661**	.002	a
		비교집단	13.14±9.19	9.21			a
		통제집단	30.86±7.49	17.57			b
	현실에 대한 불만과 변화 욕구	실험집단	8.71±8.83	7.14	9.311*	.010	a
		비교집단	11.71±6.75	9.14			ab
		통제집단	34.14±16.36	16.71			b
	무기력과 의욕상실	실험집단	2.00±1.29	5.64	12.335**	.002	a
		비교집단	5.29±3.90	10.21			ab
		통제집단	12.14±4.45	17.14			b

* $p<.05$, ** $p<.01$

(3) 집단 간 자아존중감의 사후검사 비교

자아존중감의 사후검사 분석 결과, 자아존중감은 집단 간 유의한 차이를 보였다($\chi^2=10.941$, $p<.01$). 사후검정 결과 통제집단($M=24.29$)보다 실험집단($M=41.71$)이 유의하게 높은 것으로 검증되었다.

<표 VI-5> 집단 간 자아존중감의 사후검사 비교

변수	집단	$M \pm SD$	평균순위	Kruskal-Wallis		Bonferroni
				χ^2	p	
자아존중감	실험집단	41.71±4.68	16.79	10.941**	.004	b
	비교집단	31.43±9.98	10.29			ab
	통제집단	24.29±4.92	5.93			a

** $p<.01$

3) 집단 간 정서 변인 사후검사 비교

프로그램 사후검사 시 실험집단, 비교집단, 통제집단 간 정서 변인(정서조절곤란, 우울, 상태-특성 불안, 상태-특성 분노)의 차이를 검증하기 위해 Kruskal-Wallis 검정을 실시하였고, Bonferroni Correction에 의한 사후검정을 실시하였다. 그 결과는 <표 VI-6>~<표 VI-9>에 제시하였다.

(1) 집단 간 정서조절곤란의 사후검사 비교

정서조절곤란의 사후검사 분석 결과, 정서조절곤란의 총점은 집단 간 유의한 차이를 보였고($\chi^2=10.539$, $p<.01$), 하위요인인 충동통제곤란($\chi^2=12.263$, $p<.01$), 정서에 대한 주의/자각 부족($\chi^2=10.434$, $p<.01$), 정서적 명료성 부족($\chi^2=6.684$, $p<.05$), 정서조절전략 접근 제한($\chi^2=10.118$, $p<.01$), 목표지향행동 수행 어려움($\chi^2=11.205$, $p<.01$) 모두 집단 간 유의한 차이를 보였다.

사후검정 결과 정서조절곤란은 실험집단($M=62.86$)이 통제집단($M=123.86$)보다 유의하게 낮았다. 하위요인인 충동통제곤란은 실험집단($M=13.29$)이 통제집단($M=27.71$)보다 유의하게 낮았고, 정서에 대한 주의/자각 부족도 실험집단($M=12.86$)이 통제집단

(M=24.71)보다 유의하게 낮았으며, 정서적 명료성 부족도 실험집단(M=5.86)이 통제집단(M=11.57)보다 유의하게 낮았다. 정서조절전략 접근 제한도 실험집단(M=9.86)이 통제집단(M=22.57)보다 유의하게 낮았고, 목표지향행동 수행 어려움도 실험집단(M=7.00)이 통제집단(M=12.43)보다 유의하게 낮았다.

<표 VI-6> 집단 간 정서조절곤란의 사후검사 비교

변수	하위요인	집단	$M \pm SD$	평균 순위	Kruskal-Wallis		Bonferroni
					χ^2	p	
정서 조절 곤란	전체	실험집단	62.86±14.57	5.93	10.539**	.005	a
		비교집단	86.14±32.15	10.43			ab
		통제집단	123.86±26.35	16.64			b
	충동통제곤란	실험집단	13.29±1.98	5.57	12.263**	.002	a
		비교집단	18.86±6.67	10.36			ab
		통제집단	27.71±5.56	17.07			b
	정서에 대한 주의/자각 부족	실험집단	12.86±1.86	5.29	10.434**	.005	a
		비교집단	20.86±9.15	11.86			ab
		통제집단	24.71±7.13	15.86			b
	정서에 대한 비수용성	실험집단	14.00±7.05	8.79	5.980	.050	
		비교집단	14.71±8.83	8.57			
		통제집단	24.86±9.26	15.64			
	정서적 명료성 부족	실험집단	5.86±2.54	7.64	6.684*	.035	a
		비교집단	7.57±4.83	9.57			ab
		통제집단	11.57±3.36	15.79			b
	정서조절전략 접근 제한	실험집단	9.86±3.34	6.14	10.118**	.006	a
		비교집단	14.43±7.07	10.29			ab
		통제집단	22.57±5.09	16.57			b
	목표지향행동 수행 어려움	실험집단	7.00±1.83	5.71	11.205**	.004	a
		비교집단	9.71±2.69	10.64			ab
		통제집단	12.43±0.98	16.64			b

* $p < .05$, ** $p < .01$

(2) 집단 간 우울의 사후검사 비교

우울의 사후검사 분석 결과 집단 간 유의한 차이를 보였고($\chi^2=14.420$, $p<.01$), 사후검정 결과 우울 정도는 실험집단($M=6.57$)이 비교집단($M=13.86$)과 통제집단($M=19.00$)보다 유의하게 낮았다.

<표 VI-7> 집단 간 우울의 사후검사 비교

변수	집단	$M\pm SD$	평균순위	Kruskal-Wallis		Bonferroni
				χ^2	p	
우울	실험집단	6.57±2.64	4.36	14.420**	.001	a
	비교집단	13.86±3.18	11.79			b
	통제집단	19.00±4.93	16.86			b

** $p<.01$

(3) 집단 간 상태-특성 불안의 사후검사 비교

상태-특성 불안의 사후검사 분석 결과 집단 간 유의한 차이를 보였고($\chi^2=11.852$, $p<.01$), 사후검정 결과 불안 정도는 실험집단($M=72.43$)이 통제집단($M=125.29$)보다 유의하게 낮았다.

<표 VI-8> 집단 간 상태-특성 불안의 사후검사 비교

변수	집단	$M\pm SD$	평균순위	Kruskal-Wallis		Bonferroni
				χ^2	p	
상태-특성 불안	실험집단	72.43±15.35	5.86	11.852**	.003	a
	비교집단	89.14±26.12	10.00			ab
	통제집단	125.29±17.34	17.14			b

** $p<.01$

(4) 집단 간 상태-특성 분노의 사후검사 비교

상태-특성 분노의 사후검사 분석 결과 집단 간 유의한 차이를 보였고($\chi^2=9.719$, $p<.01$), 사후검정 결과 상태-특성 분노 정도는 실험집단($M=68.43$)이 통제집단($M=103.57$)보다 유의하게 낮았다.

<표 VI-9> 집단 간 분노의 사후검사 비교

변수	집단	$M\pm SD$	평균순위	Kruskal-Wallis		Bonferroni
				χ^2	p	
상태-특성 분노	실험집단	68.43±6.16	5.57	9.719**	.008	a
	비교집단	86.86±19.35	11.57			ab
	통제집단	103.57±18.80	15.86			b

** $p<.01$

4) 집단 간 행동 변인 사후검사 비교

프로그램 사후검사 시 실험집단, 비교집단, 통제집단 간 행동 변인(스트레스 대처방식)의 차이를 검증하기 위해 Kruskal-Wallis 검정을 실시하였고, Bonferroni Correction에 의한 사후검정을 실시하였다. 그 결과는 <표 VI-10>에 제시하였다.

문제중심적 대처($\chi^2=8.647$, $p<.05$), 사회적지지 추구($\chi^2=13.246$, $p<.01$), 정서완화적 대처($\chi^2=9.233$, $p<.05$) 모두 집단 간 유의한 차이를 보였다.

사후검정 결과 문제중심적 대처는 실험집단($M=15.86$)이 통제집단($M=9.43$)보다 유의하게 높았으며, 사회적지지 추구는 실험집단($M=19.71$)이 통제집단($M=12.71$)보다 유의하게 높았다. 정서완화적 대처는 실험집단($M=9.57$)이 통제집단($M=17.43$)보다 유의하게 낮았다.

<표 VI-10> 집단 간 스트레스 대처방식의 사후검사 비교

변수	하위요인	집단	$M\pm SD$	평균 순위	Kruskal-Wallis		Bonferroni
					χ^2	p	
스트레스 대처방식	문제중심적 대처	실험집단	15.86±2.85	15.43	8.647*	.013	b
		비교집단	13.71±3.15	11.71			ab
		통제집단	9.43±3.46	5.86			a
	사회적지지 추구	실험집단	19.71±2.29	17.00	13.246**	.001	b
		비교집단	16.29±1.25	11.00			ab
		통제집단	12.71±2.98	5.00			a
	정서완화적 대처	실험집단	9.57±3.55	6.14	9.233*	.010	a
		비교집단	13.71±2.75	10.71			ab
		통제집단	17.43±4.96	16.14			b

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

3. 집단 내 사전-사후검사 비교

1) 집단 내 섭식 변인 사전-사후검사 비교

집단 내 섭식 변인(부정적 정서로 유발된 섭식 동기·행동)의 사전검사 대비 사후

검사에서 유의하게 증가 또는 감소하였는지를 검증하기 위해 Wilcoxon Signed-Rank Test를 실시하였다. 그 결과는 <표 VI-11>에 제시하였다.

부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동 총점은 실험집단에서만 사전과 사후 간 유의한 차이를 보였다($Z=-2.366$, $p<.05$). 중위수 비교 결과 사전보다 사후가 낮게 나타나, 사후검사에서 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다.

하위요인 중 섭식동기도 실험집단에서만 사전과 사후 간 유의한 차이를 보였다($Z=-2.366$, $p<.05$). 중위수 비교 결과 사전검사보다 사후검사가 낮게 나타나, 사후검사에서 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다. 섭식행동은 실험집단($Z=-2.366$, $p<.05$)과 비교집단($Z=-2.028$, $p<.05$)에서 사전과 사후 간 유의한 차이를 보였다. 중위수 비교 결과 실험집단과 비교집단 모두 사전검사보다 사후검사가 낮게 나타나, 실험집단과 비교집단 모두 섭식행동이 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다.

<표 VI-11> 집단 내 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동의 사전-사후검사 비교

하위요인	집단	사전		사후		Wilcoxon	
		중위수	범위	중위수	범위	Z	p
전체	실험집단	87.00	72.00-123.00	27.00	24.00-51.00	-2.366*	.018
	비교집단	113.00	103.00-130.00	74.00	56.00-113.00	-1.863	.063
	통제집단	112.00	74.00-130.00	116.00	83.00-132.00	-1.367	.172
섭식동기	실험집단	44.00	36.00-62.00	17.00	11.00-28.00	-2.366*	.018
	비교집단	59.00	52.00-65.00	44.00	29.00-59.00	-1.859	.063
	통제집단	57.00	48.00-66.00	62.00	49.00-67.00	-1.572	.116
섭식행동	실험집단	43.00	36.00-60.00	13.00	10.00-23.00	-2.366*	.018
	비교집단	56.00	51.00-65.00	27.00	26.00-54.00	-2.028*	.043
	통제집단	55.00	34.00-61.00	55.00	38.00-65.00	-0.921	.357

* $p<.05$

2) 집단 내 인지 변인 사전-사후검사 비교

집단 내 인지 변인(역기능적 신념, 부정적 자동적 사고, 자아존중감)의 사전검사 대비 사후검사에서 유의하게 증가 또는 감소하였는지를 검증하기 위해 Wilcoxon Signed-Rank Test를 실시하였다. 그 결과는 <표 VI-12>~<표 VI-14>에 제시하였다.

(1) 집단 내 역기능적 신념 사전-사후검사 비교

역기능적 신념 총점은 실험집단에서만 사전과 사후 간 유의한 차이를 보였다 ($Z=-2.366$, $p<.05$). 중위수 비교 결과 사전보다 사후가 낮게 나타나, 사후검사에서 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다.

역기능적 신념의 하위영역 중 사회적 자기에 대한 부정적인 신념($Z=-2.366$, $p<.05$), 타인의 인정에 대한 과도한 요망($Z=-2.366$, $p<.05$), 타인 및 대인관계에 대한 부정적인 신념($Z=-2.366$, $p<.05$) 모두 실험집단만이 유의하게 감소하였다.

<표 VI-12> 집단 내 역기능적 신념의 사전-사후검사 비교

하위요인	집단	사전		사후		Wilcoxon	
		중위수	범위	중위수	범위	Z	p
전체	실험집단	148.00	119.00-157.00	53.00	47.00-56.00	-2.366*	.018
	비교집단	154.00	134.00-178.00	103.00	62.00-149.00	-1.352	.176
	통제집단	130.00	98.00-148.00	142.00	73.00-164.00	-0.674	.500
사회적 자기에 대한 부정적인 신념	실험집단	45.00	28.00-51.00	16.00	14.00-17.00	-2.366*	.018
	비교집단	48.00	45.00-55.00	25.00	17.00-51.00	-1.524	.128
	통제집단	35.00	30.00-48.00	46.00	23.00-56.00	-1.084	.279
타인의 인정에 대한 과도한 요망	실험집단	55.00	49.00-61.00	19.00	17.00-20.00	-2.366*	.018
	비교집단	57.00	52.00-60.00	40.00	28.00-49.00	-1.690	.091
	통제집단	43.00	36.00-49.00	43.00	25.00-55.00	-0.674	.500
타인 및 대인 관계에 대한 부정적인 신념	실험집단	42.00	37.00-49.00	16.00	16.00-20.00	-2.366*	.018
	비교집단	48.00	37.00-60.00	34.00	20.00-49.00	-1.352	.176
	통제집단	48.00	28.00-51.00	49.00	28.00-52.00	-1.219	.223

* $p<.05$

(2) 집단 내 부정적 자동적 사고 사전-사후검사 비교

부정적 자동적 사고 총점은 실험집단($Z=-2.371$, $p<.05$), 비교집단($Z=-2.366$, $p<.05$), 통제집단($Z=-2.023$, $p<.05$)에서 모두 사전과 사후 간 유의한 차이를 보였다. 중위수 비교 결과 실험집단과 비교집단은 사전보다 사후가 낮게 나타났고, 통제집단은 사전보다 사후가 높게 나타났다. 즉 부정적 자동적 사고는 실험집단과 비교집단에서 유의하게

감소하였고, 통제집단에서는 오히려 유의하게 증가하였다.

하위요인 중 부정적인 자기상과 부정적인 기대는 실험집단($Z=-2.366$, $p<.05$), 비교집단($Z=-2.375$, $p<.05$), 통제집단($Z=-2.032$, $p<.05$)에서 모두 사전과 사후 간 유의한 차이를 보였다. 중위수 비교 결과 실험집단과 비교집단은 사전보다 사후가 낮게 나타났고, 통제집단은 사전보다 사후가 높게 나타났다. 즉 부정적인 자기상과 부정적인 기대는 실험집단과 비교집단에서 유의하게 감소하였고, 통제집단에서는 유의하게 증가하였다. 그리고 현실에 대한 불만과 변화 욕구는 실험집단($Z=-2.371$, $p<.05$)과 비교집단($Z=-2.366$, $p<.05$)이 유의한 결과를 보였고, 무기력과 의욕상실도 실험집단($Z=-2.371$, $p<.05$)과 비교집단($Z=-2.371$, $p<.05$)이 유의한 결과를 보였다. 중위수 비교 결과 실험집단과 비교집단은 사전보다 사후가 낮게 나타나, 현실에 대한 불만과 변화 욕구는 실험집단과 비교집단에서 유의하게 감소하였고, 무기력과 의욕상실도 실험집단과 비교집단에서 유의하게 감소하였다.

<표 VI-13> 집단 내 부정적 자동적 사고의 사전-사후검사 비교

하위요인	집단	사전		사후		Wilcoxon	
		중위수	범위	중위수	범위	Z	p
전체	실험집단	64.00	32.00-76.00	17.00	5.00-32.00	-2.371*	.018
	비교집단	73.00	68.00-90.00	36.00	12.00-42.00	-2.366*	.018
	통제집단	66.00	50.00-97.00	77.00	51.00-106.00	-2.023*	.043
부정적인 자기상과 부정적인 기대	실험집단	27.00	12.00-36.00	9.00	0.00-12.00	-2.366*	.018
	비교집단	29.00	25.00-36.00	14.00	4.00-25.00	-2.375*	.018
	통제집단	27.00	23.00-34.00	30.00	25.00-38.00	-2.032*	.042
현실에 대한 불만과 변화 욕구	실험집단	25.00	12.00-31.00	5.00	3.00-18.00	-2.371*	.018
	비교집단	34.00	28.00-38.00	12.00	7.00-18.00	-2.366*	.018
	통제집단	29.00	16.00-46.00	38.00	18.00-53.00	-1.761	.078
무기력과 의욕상실	실험집단	13.00	8.00-15.00	2.00	1.00-3.00	-2.371*	.018
	비교집단	15.00	13.00-16.00	4.00	2.00-10.00	-2.371*	.018
	통제집단	12.00	7.00-17.00	13.00	10.00-15.00	-1.134	.257

* $p<.05$

(3) 집단 내 자아존중감 사전-사후검사 비교

자아존중감은 실험집단($Z=-2.366$, $p<.05$), 통제집단($Z=-2.023$, $p<.05$)에서 사전과 사후 간 유의한 차이를 보였다. 중위수 비교 결과 실험집단은 사후가 높고, 통제집단은 사후가 낮게 나타나, 통제집단은 자아존중감이 오히려 감소한 반면, 실험집단은 자아

존중감이 유의하게 증가한 것으로 판단할 수 있다.

<표 VI-14> 집단 내 자아존중감의 사전-사후검사 비교

변수	집단	사전		사후		Wilcoxon	
		중위수	범위	중위수	범위	Z	p
자아존중감	실험집단	30.00	26.00-39.00	43.00	37.00-46.00	-2.366*	.018
	비교집단	21.00	17.00-35.00	35.00	20.00-39.00	-1.183	.237
	통제집단	26.00	20.00-35.00	24.00	20.00-28.00	-2.023*	.043

* $p<.05$

3) 집단 내 정서 변인 사전-사후검사 비교

집단 내 정서 변인(정서조절곤란, 우울, 상태-특성 불안, 상태-특성 분노)의 사전검사 대비 사후검사에서 유의하게 증가 또는 감소하였는지를 검증하기 위해 Wilcoxon Signed-Rank Test를 실시하였다. 그 결과는 <표 VI-15>~<표 VI-18>에 제시하였다.

(1) 집단 내 정서조절곤란 사전-사후검사 비교

정서조절곤란 총점은 실험집단($Z=-2.366$, $p<.05$)과 비교집단($Z=-2.197$, $p<.05$)에서 사전과 사후 간 유의한 차이를 보였다. 중위수 비교 결과 모두 사전보다 사후가 낮게 나타나, 실험집단과 비교집단 모두 사후검사에서 정서조절곤란 수준이 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다.

정서조절곤란 하위요인 중 충동통제곤란, 정서에 대한 비수용성, 정서조절전략 접근제한은 실험집단과 비교집단에서 유의한 차이를 보였고, 정서적 명료성 부족은 비교집단에서만 유의한 결과를 보였으며, 목표지향행동 수행 어려움은 실험집단에서만 유의한 결과를 보였다. 중위수 비교 결과 모두 사전보다 사후가 낮게 나타나, 충동통제곤란, 정서에 대한 비수용성, 정서조절전략 접근제한은 실험집단과 비교집단에서 유의하게 감소하였고, 정서적 명료성 부족은 비교집단에서만 유의하게 감소하였으며, 목표지향행동 수행 어려움은 실험집단에서만 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다.

<표 VI-15> 집단 내 정서조절곤란의 사전-사후검사 비교

하위요인	집단	사전		사후		Wilcoxon	
		중위수	범위	중위수	범위	Z	p
전체	실험집단	100.00	94.00-113.00	62.00	51.00-73.00	-2.366*	.018
	비교집단	125.00	109.00-135.00	76.00	57.00-121.00	-2.197*	.028
	통제집단	114.00	99.00-139.00	122.00	109.00-149.00	-1.826	.068
충동통제 곤란	실험집단	21.00	15.00-25.00	13.00	12.00-14.00	-2.371*	.018
	비교집단	26.00	24.00-34.00	20.00	14.00-25.00	-2.366*	.018
	통제집단	29.00	24.00-33.00	27.00	25.00-33.00	-0.135	.892
정서에 대한 주의/자각 부족	실험집단	17.00	12.00-31.00	13.00	11.00-15.00	-1.690	.091
	비교집단	22.00	19.00-27.00	16.00	12.00-31.00	-0.762	.446
	통제집단	20.00	18.00-29.00	22.00	20.00-34.00	-1.289	.197
정서에 대한 비수용성	실험집단	19.00	13.00-31.00	13.00	7.00-21.00	-2.232*	.026
	비교집단	25.00	22.00-30.00	15.00	7.00-19.00	-2.207*	.027
	통제집단	27.00	18.00-29.00	31.00	18.00-32.00	-1.732	.083
정서적 명료성 부족	실험집단	7.00	5.00-14.00	5.00	4.00-8.00	-1.696	.090
	비교집단	12.00	8.00-14.00	5.00	3.00-13.00	-1.992*	.046
	통제집단	11.00	10.00-13.00	13.00	10.00-14.00	-1.633	.102
정서조절 전략 접근 제한	실험집단	20.00	19.00-21.00	9.00	8.00-10.00	-2.366*	.018
	비교집단	24.00	18.00-27.00	11.00	9.00-23.00	-2.371*	.018
	통제집단	21.00	17.00-28.00	20.00	20.00-28.00	-0.743	.458
목표지향 행동 수행 어려움	실험집단	12.00	9.00-14.00	8.00	7.00-8.00	-2.371*	.018
	비교집단	12.00	12.00-15.00	9.00	7.00-12.00	-1.577	.115
	통제집단	12.00	11.00-12.00	12.00	12.00-13.00	-1.518	.129

* $p < .05$

(2) 집단 내 우울 사전-사후검사 비교

우울은 실험집단($Z = -2.371$, $p < .05$)과 비교집단($Z = -2.028$, $p < .05$)에서 사전과 사후 간 유의한 차이를 보였다. 중위수 비교 결과 실험집단과 비교집단 모두 사전보다 사후가 낮게 나타나, 실험집단과 비교집단의 우울 정도는 사후검사에서 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다.

<표 VI-16> 집단 내 우울의 사전-사후검사 비교

변수	집단	사전		사후		Wilcoxon	
		중위수	범위	중위수	범위	Z	p
우울	실험집단	22.00	11.00-30.00	6.00	2.00-9.00	-2.371*	.018
	비교집단	23.00	15.00-31.00	13.00	8.00-18.00	-2.028*	.043
	통제집단	19.00	9.00-24.00	19.00	10.00-25.00	-0.577	.564

* $p < .05$

(3) 집단 내 상태-특성 불안 사전-사후검사 비교

상태-특성 불안은 실험집단($Z=-2.366$, $p<.05$)에서만 사전과 사후 간 유의한 차이를 보였다. 중위수 비교 결과 사전보다 사후가 낮게 나타나, 실험집단의 상태-특성 불안 정도는 사후검사에서 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다.

<표 VI-17> 집단 내 불안의 사전-사후검사 비교

변수	집단	사전		사후		Wilcoxon	
		중위수	범위	중위수	범위	Z	p
상태-특성 불안	실험집단	117.00	88.00-124.00	76.00	63.00-85.00	-2.366*	.018
	비교집단	130.00	96.00-134.00	88.00	77.00-101.00	-1.577	.115
	통제집단	122.00	102.00-126.00	130.00	108.00-139.00	-1.572	.116

* $p<.05$

(4) 집단 내 상태-특성 분노 사전-사후검사 비교

상태-특성 분노는 실험집단($Z=-2.366$, $p<.05$)과 비교집단($Z=-2.201$, $p<.05$)에서 사전과 사후 간 유의한 차이를 보였다. 중위수 비교 결과 실험집단과 비교집단 모두 사전보다 사후가 낮게 나타나, 상태-특성 분노 정도는 사후검사에서 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다.

<표 VI-18> 집단 내 상태-특성 분노의 사전-사후검사 비교

변수	집단	사전		사후		Wilcoxon	
		중위수	범위	중위수	범위	Z	p
상태-특성 분노	실험집단	99.00	94.00-116.00	69.00	64.00-73.00	-2.366*	.018
	비교집단	109.00	97.00-127.00	91.00	68.00-101.00	-2.201*	.028
	통제집단	98.00	93.00-110.00	105.00	89.00-114.00	-0.593	.553

* $p<.05$

4) 집단 내 행동 변인 사전-사후검사 비교

집단 내 행동 변인(스트레스 대처방식)의 사전검사 대비 사후검사에서 유의하게 증가 또는 감소하였는지를 검증하기 위해 Wilcoxon Signed-Rank Test를 실시하였다. 그 결과는 <표 VI-19>에 제시하였다.

하위요인 중 문제중심적 대처는 실험집단과 비교집단에서 유의하게 증가했고, 사회

적지지 추구는 실험집단, 비교집단, 통제집단에서 모두 유의하게 증가하였다.

하위요인 중 정서완화적 대처가 실험집단에서만 유의한 차이를 보였다. 중위수 비교 결과 정서완화적 대처는 실험집단에서 사전보다 사후에 유의하게 감소하였다.

<표 VI-19> 집단 내 스트레스 대처방식의 사전-사후검사 비교

하위요인	집단	사전		사후		Wilcoxon	
		중위수	범위	중위수	범위	Z	p
문제중심적 대처	실험집단	8.00	6.00-12.00	16.00	15.00-18.00	-2.371*	.018
	비교집단	10.00	7.00-10.00	12.00	12.00-16.00	-2.375*	.018
	통제집단	11.00	10.00-14.00	10.00	7.00-13.00	-1.857	.063
사회적지지 추구	실험집단	12.00	6.00-14.00	20.00	19.00-21.00	-2.371*	.018
	비교집단	12.00	11.00-12.00	16.00	15.00-18.00	-2.375*	.018
	통제집단	9.00	8.00-11.00	12.00	12.00-14.00	-2.460*	.014
정서완화적 대처	실험집단	15.00	12.00-21.00	8.00	8.00-10.00	-2.201*	.028
	비교집단	13.00	11.00-17.00	15.00	12.00-16.00	-0.211	.833
	통제집단	15.00	10.00-17.00	18.00	18.00-20.00	-1.781	.075

* $p < .05$

4. 실험집단과 비교집단 간 추후검사 비교

1) 집단 간 섭식 변인 추후검사 비교

프로그램 추후검사 시 실험집단, 비교집단 및 통제집단 간 섭식 변인의 차이를 검증하기 위해 Mann-Whitney U 검정을 실시하였고, 그 결과는 <표 VI-20>에 제시하였다.

그 결과 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동의 총점은 집단 간 유의한 차이를 보였고($Z = -3.134$, $p < .01$), 하위요인인 섭식동기($Z = -3.134$, $p < .01$)와 섭식행동($Z = -3.137$, $p < .01$)도 집단 간 유의한 차이를 보였다.

평균순위 비교 결과, 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동의 총점은 실험집단이 비교집단보다 유의하게 낮았고, 하위요인인 섭식동기와 섭식행동도 실험집단이 비교집단보다 유의하게 낮았다.

<표 VI-20> 집단 간 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동의 추후검사 비교

변수	하위요인	집단	$M \pm SD$	평균순위	Mann-Whitney	
					Z	p
부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동	전체	실험집단	27.57±8.18	4.00	-3.134**	.002
		비교집단	84.00±26.43	11.00		
	섭식동기	실험집단	17.00±4.65	4.00	-3.134**	.002
		비교집단	49.00±14.54	11.00		
	섭식행동	실험집단	10.57±4.04	4.00	-3.137**	.002
		비교집단	35.00±12.14	11.00		

** $p < .01$

2) 집단 간 인지 변인 추후검사 비교

프로그램 추후검사 시 실험집단, 비교집단 및 통제집단 간 인지 변인의 차이를 검증하기 위해 Mann-Whitney U 검정을 실시하였고, 그 결과는 <표 VI-21>~<표 VI-23>에 제시하였다.

(1) 집단 간 역기능적 신념의 추후검사 비교

역기능적 신념의 추후검사 분석 결과, 역기능적 신념의 총점은 집단 간 유의한 차이를 보였고($Z = -3.137$, $p < .01$), 하위요인인 사회적 자기에 대한 부정적인 신념($Z = -3.077$, $p < .01$), 타인의 인정에 대한 과도한 요망($Z = -3.080$, $p < .01$), 타인 및 대인관계에 대한 부정적인 신념($Z = -2.762$, $p < .01$)도 집단 간 유의한 차이를 보였다.

평균순위 비교 결과, 역기능적 신념의 총점은 실험집단이 비교집단보다 유의하게 낮았고, 하위요인인 사회적 자기에 대한 부정적인 신념, 타인의 인정에 대한 과도한 요망, 타인 및 대인관계에 대한 부정적인 신념도 모두 실험집단이 비교집단보다 유의하게 낮았다.

<표 VI-21> 집단 간 역기능적 신념의 추후검사 비교

변수	하위요인	집단	$M \pm SD$	평균 순위	Mann-Whitney	
					Z	p
역기능적 신념	전체	실험집단	47.57±2.99	4.00	-3.137**	.002
		비교집단	107.14±38.14	11.00		
	사회적 자기에 대한 부정적인 신념	실험집단	13.86±1.77	4.07	-3.077**	.002
		비교집단	31.57±14.22	10.93		
	타인의 인정에 대한 과도한 요망	실험집단	17.43±2.99	4.07	-3.080**	.002
		비교집단	40.86±12.10	10.93		
	타인·대인 관계에 대한 부정적 신념	실험집단	16.29±2.06	4.43	-2.762**	.006
		비교집단	34.71±13.76	10.57		

** $p < .01$

(2) 집단 간 부정적 자동적 사고의 추후검사 비교

부정적 자동적 사고의 추후검사 분석 결과, 부정적 자동적 사고의 총점은 집단 간 유의한 차이를 보였고($Z = -3.151$, $p < .01$), 하위요인인 부정적인 자기상과 부정적인 기대($Z = -2.692$, $p < .01$), 현실에 대한 불만과 변화 욕구($Z = -2.891$, $p < .01$), 무기력과 의욕상실($Z = -2.486$, $p < .05$)도 집단 간 유의한 차이를 보였다.

평균순위 비교 결과, 부정적 자동적 사고의 총점은 실험집단이 비교집단보다 유의하게 낮았고, 하위요인인 부정적인 자기상과 부정적인 기대, 현실에 대한 불만과 변화 욕구, 무기력과 의욕상실도 모두 실험집단이 비교집단보다 유의하게 낮았다.

<표 VI-22> 집단 간 부정적 자동적 사고의 추후검사 비교

변수	하위요인	집단	$M \pm SD$	평균 순위	Mann-Whitney	
					Z	p
부정적 자동적 사고	전체	실험집단	11.71±2.93	4.00	-3.151**	.002
		비교집단	33.29±18.59	11.00		
	부정적인 자기상과 부정적인 기대	실험집단	6.14±2.61	4.50	-2.692**	.007
		비교집단	15.00±7.48	10.50		
	현실에 대한 불만과 변화 욕구	실험집단	4.00±1.91	4.29	-2.891**	.004
		비교집단	12.29±8.52	10.71		
	무기력과 의욕상실	실험집단	1.57±0.53	4.79	-2.486*	.013
		비교집단	6.00±3.83	10.21		

* $p < .05$, ** $p < .01$

(3) 집단 간 자아존중감의 추후검사 비교

자아존중감의 추후검사 분석 결과 집단 간 유의한 차이를 보였고($Z = -3.137$, $p < .01$), 실험집단이 비교집단보다 추후 자아존중감이 유의하게 높았다.

<표 VI-23> 집단 간 자아존중감의 추후검사 비교

변수	집단	$M \pm SD$	평균순위	Mann-Whitney	
				Z	p
자아존중감	실험집단	43.57±2.64	11.00	-3.137**	.002
	비교집단	30.57±4.58	4.00		

** $p < .01$

3) 집단 간 정서 변인 추후검사 비교

프로그램 추후검사 시 실험집단, 비교집단, 통제집단 간 정서 변인의 차이를 검증하기 위해 Mann-Whitney U 검정을 실시하였고, 그 결과는 <표 VI-24>~<표 VI-27>에 제시하였다.

(1) 집단 간 정서조절곤란의 추후검사 비교

정서조절곤란의 추후검사 분석 결과, 정서조절곤란 총점은 실험집단과 비교집단 간 유의한 차이를 보였고($Z=-3.130$, $p<.01$), 모든 하위요인도 유의한 차이를 보였다. 평균 순위 비교 결과, 실험집단보다 비교집단이 높게 나타나, 정서조절곤란과 모든 하위요인은 실험집단이 비교집단보다 유의하게 낮은 것으로 판단할 수 있다.

<표 VI-24> 집단 간 정서조절곤란의 추후검사 비교

변수	하위요인	집단	$M\pm SD$	평균순위	Mann-Whitney	
					Z	p
정서조절 곤란	전체	실험집단	50.29±7.70	4.00	-3.130**	.002
		비교집단	90.00±12.25	11.00		
	충동통제곤란	실험집단	10.86±2.12	4.21	-2.952**	.003
		비교집단	19.29±4.31	10.79		
	정서에 대한 주의/자각 부족	실험집단	11.14±1.46	4.00	-3.155**	.002
		비교집단	20.43±3.10	11.00		
	정서에 대한 비수용성	실험집단	9.86±5.49	5.00	-2.266*	.023
		비교집단	16.43±5.26	10.00		
	정서적 명료성 부족	실험집단	4.29±1.38	4.86	-2.407*	.016
		비교집단	7.57±2.76	10.14		
	정서조절전략 접근 제한	실험집단	8.71±2.36	4.64	-2.573*	.010
		비교집단	15.14±4.02	10.36		
	목표지향행동 수행 어려움	실험집단	5.43±1.72	4.07	-3.084**	.002
		비교집단	11.14±2.19	10.93		

* $p<.05$, ** $p<.01$

(2) 집단 간 우울의 추후검사 비교

우울의 추후검사 분석 결과, 우울은 실험집단과 비교집단 간 유의한 차이를 보였다($Z=-3.144$, $p<.01$). 평균 순위 비교 결과 실험집단이 비교집단보다 낮게 나타나, 실험집단이 비교집단보다 추후 우울 수준이 유의하게 낮은 것으로 판단할 수 있다.

<표 VI-25> 집단 간 우울의 추후검사 비교

변수	집단	$M\pm SD$	평균순위	Mann-Whitney	
				Z	p
우울	실험집단	5.43±2.30	4.00	-3.144**	.001
	비교집단	14.57±3.21	11.00		

** $p<.01$

(3) 집단 간 상태-특성 불안의 추후검사 비교

상태-특성 불안의 추후검사 분석 결과, 상태-특성 불안은 실험집단과 비교집단 간 유의한 차이를 보였다($Z=-2.878$, $p<.01$). 평균 순위 비교 결과 실험집단이 비교집단보다 낮게 나타나, 실험집단이 비교집단보다 추후 상태-특성 불안 수준이 유의하게 낮은 것으로 판단할 수 있다.

<표 VI-26> 집단 간 상태-특성 불안의 추후검사 비교

변수	집단	$M\pm SD$	평균순위	Mann-Whitney	
				Z	p
상태-특성 불안	실험집단	68.00±8.93	4.29	-2.878**	.004
	비교집단	94.43±11.79	10.71		

** $p<.01$

(4) 집단 간 상태-특성 분노의 추후검사 비교

상태-특성 분노의 추후검사 분석 결과, 상태-특성 분노는 실험집단과 비교집단 간 유의한 차이를 보였다($Z=-3.134$, $p<.01$). 평균 순위 비교 결과 실험집단이 비교집단보다 낮게 나타나, 실험집단이 비교집단보다 추후 분노 수준이 유의하게 낮은 것으로 판단할 수 있다.

<표 VI-27> 집단 간 상태-특성 분노의 추후검사 비교

변수	집단	$M\pm SD$	평균순위	Mann-Whitney	
				Z	p
상태-특성 분노	실험집단	62.71±5.19	4.00	-3.134**	.002
	비교집단	83.43±7.23	11.00		

** $p<.01$

4) 집단 간 행동 변인 추후검사 비교

프로그램 추후검사 시 실험집단, 비교집단, 통제집단 간 행동 변인의 차이를 검증하기 위해 Mann-Whitney U 검정을 실시하였고, 그 결과는 <표 VI-28>에 제시하였다.

스트레스 대처방식의 추후검사에 대한 분석 결과, 하위요인인 문제중심적 대처 ($Z=-2.655$, $p<.01$), 사회적지지 추구($Z=-2.449$, $p<.05$)는 유의한 차이를 보였다. 평균순위 비교 결과, 실험집단이 비교집단보다 높게 나타나, 하위요인인 문제중심적 대처, 사회적지지 추구는 모두 실험집단이 비교집단보다 유의하게 높은 것으로 판단할 수 있다. 또한, 나머지 하위요인인 정서완화적 대처($Z=-2.823$, $p<.01$)도 유의한 차이를 보였다. 평균순위 비교 결과, 실험집단이 비교집단보다 낮게 나타나, 하위요인인 정서완화적 대처는 실험집단이 비교집단보다 유의하게 낮은 것으로 판단할 수 있다.

<표 VI-28> 집단 간 스트레스 대처방식의 추후검사 비교

변수	하위요인	집단	$M\pm SD$	평균순위	Mann-Whitney	
					Z	p
스트레스 대처방식	문제중심적 대처	실험집단	20.00±2.08	10.43	-2.655**	.008
		비교집단	14.71±4.46	4.57		
	사회적지지 추구	실험집단	21.29±1.98	10.21	-2.449*	.014
		비교집단	16.29±3.30	4.79		
	정서완화적 대처	실험집단	6.29±2.29	4.36	-2.823**	.005
		비교집단	13.29±4.57	10.64		

* $p<.05$, ** $p<.01$

5. 실험집단과 비교집단 내 사전-사후-추후검사 비교

1) 집단 내 섭식 변인 사전-사후-추후검사 비교

집단 내 섭식 변인의 사전-사후-추후검사의 변화를 확인하고, 통계적 유의성을 검

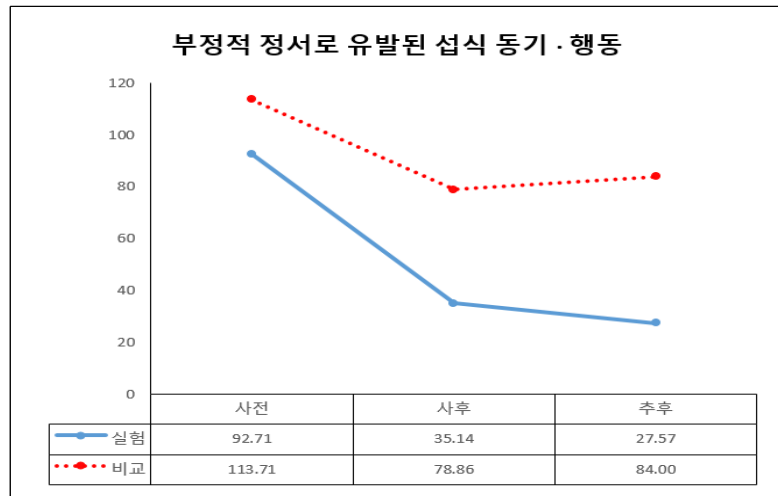
증하기 위해 Friedman test를 실시하였다. 실험집단과 비교집단 내에서 섭식 변인의 사전-사후-추후검사의 변화를 검증한 결과는 <표 VI-29>에 제시하였다.

그 결과 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동의 총점은 실험집단에서만 유의하게 변화한 것으로 검증되었고($\chi^2=10.571$, $p<.01$), 하위요인 중 섭식동기도 실험집단에서만 유의하게 변화한 것으로 검증되었으며($\chi^2=10.571$, $p<.01$), 섭식행동은 실험집단($\chi^2=13.231$, $p<.01$)과 비교집단($\chi^2=6.889$, $p<.05$)에서 모두 유의하게 변화한 것으로 검증되었다. 전반적으로 평균순위가 감소하는 추이를 보여, 프로그램 종결 3개월 후까지 섭식동기는 실험집단에서만 유의하게 감소하였고, 섭식행동은 실험집단과 비교집단 모두에서 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다<그림 VI-1>.

<표 VI-29> 집단 내 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동의 사전-사후-추후검사 비교

하위요인	집단	n	검사	$M\pm SD$	평균순위	χ^2	p
전체	실험집단	7	사전검사	92.71 $\pm$ 28.95	3.00	10.571**	.005
			사후검사	35.14 $\pm$ 18.85	1.57		
			추후검사	27.57 $\pm$ 8.18	1.43		
	비교집단	7	사전검사	113.71 $\pm$ 22.09	2.71	5.429	.066
			사후검사	78.86 $\pm$ 39.36	1.57		
			추후검사	84.00 $\pm$ 26.43	1.71		
섭식동기	실험집단	7	사전검사	46.71 $\pm$ 14.96	3.00	10.571**	.005
			사후검사	19.29 $\pm$ 10.47	1.57		
			추후검사	17.00 $\pm$ 4.65	1.43		
	비교집단	7	사전검사	57.00 $\pm$ 13.19	2.57	5.407	.067
			사후검사	42.14 $\pm$ 19.79	1.36		
			추후검사	49.00 $\pm$ 14.54	2.07		
섭식행동	실험집단	7	사전검사	46.00 $\pm$ 14.02	3.00	13.231**	.001
			사후검사	15.86 $\pm$ 8.65	1.86		
			추후검사	10.57 $\pm$ 4.04	1.14		
	비교집단	7	사전검사	56.71 $\pm$ 9.20	2.79	6.889*	.032
			사후검사	36.71 $\pm$ 20.26	1.71		
			추후검사	35.00 $\pm$ 12.14	1.50		

* $p<.05$, ** $p<.01$



<그림 VI-1> 실험집단과 비교집단 내 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동 사전-사후-추후검사 비교

2) 집단 내 인지 변인 사전-사후-추후검사 비교

집단 내 인지 변인의 사전-사후-추후검사의 변화를 확인하고, 통계적 유의성을 검증하기 위해 Friedman test를 실시하였다. 실험집단과 비교집단 내에서 인지 변인의 사전-사후-추후검사의 변화를 검증한 결과는 <표 VI-30>~<표 VI-32>에 제시하였다.

(1) 집단 내 역기능적 신념 사전-사후-추후검사 비교

역기능적 신념에 대한 분석 결과, 역기능적 신념 총점은 실험집단에서만 유의하게 변화한 것으로 검증되었고($\chi^2=12.286$, $p<.01$), 하위요인인 사회적 자기에 대한 부정적인 신념($\chi^2=12.074$, $p<.01$), 타인의 인정에 대한 과도한 요망($\chi^2=11.143$, $p<.01$), 타인 및 대인관계에 대한 부정적인 신념($\chi^2=10.571$, $p<.01$) 모두 실험집단에서만 유의하게 변화하였다. 전반적으로 평균 순위는 점차 낮아지는 경향을 보여, 역기능적 신념과 모든 하위요인은 실험집단에서 프로그램 종결 3개월 후까지 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다<그림 VI-2>.

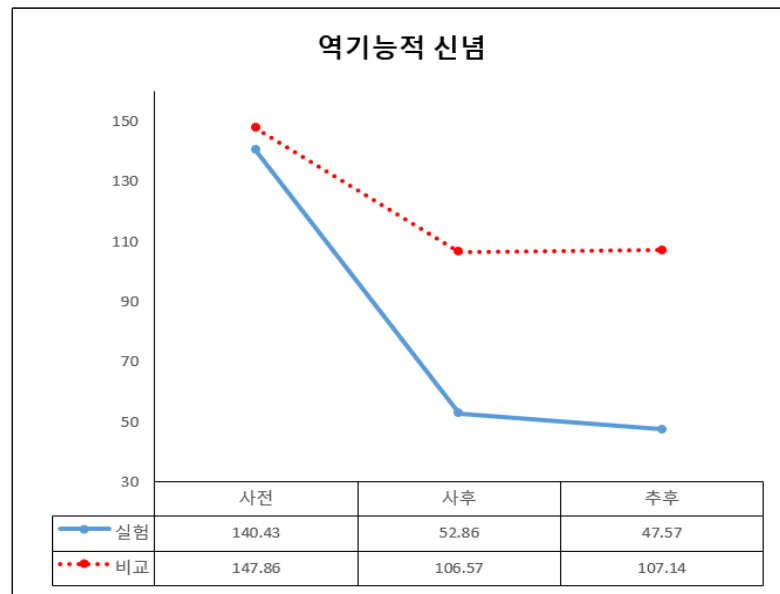
(2) 집단 내 부정적 자동적 사고 사전-사후-추후검사 비교

부정적 자동적 사고에 대한 분석 결과, 부정적 자동적 사고 총점은 실험집단($\chi^2=11.143$, $p<.01$)과 비교집단($\chi^2=8.000$, $p<.05$)에서 모두 유의하게 변화한 것으로 검증되었고, 하위요인인 부정적인 자기상과 부정적인 기대, 현실에 대한 불만과 변화 욕구, 무기력과 의욕상실 모두 실험집단과 비교집단에서 모두 유의하게 변화하였다. 전반적으로 평균 순위는 점차 낮아지는 경향을 보여, 부정적 자동적 사고는 실험집단과 비교집단에서 모두 프로그램 종결 3개월 후까지 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다 <그림 VI-3>.

<표 VI-30> 집단 내 역기능적 신념의 사전-사후-추후검사 비교

하위요인	집단	n	검사	$M\pm SD$	평균순위	χ^2	p
전체	실험집단	7	사전검사	140.43 $\pm$ 24.08	3.00	12.286**	.002
			사후검사	52.86 $\pm$ 7.82	1.86		
			추후검사	47.57 $\pm$ 2.99	1.14		
	비교집단	7	사전검사	147.86 $\pm$ 35.19	2.29	0.963	.618
			사후검사	106.57 $\pm$ 40.96	1.93		
			추후검사	107.14 $\pm$ 38.14	1.79		
사회적 자기에 대한 부정적인 신념	실험집단	7	사전검사	41.86 $\pm$ 14.69	3.00	12.074**	.002
			사후검사	16.00 $\pm$ 2.83	1.79		
			추후검사	13.86 $\pm$ 1.77	1.21		
	비교집단	7	사전검사	47.43 $\pm$ 11.87	2.43	2.160	.340
			사후검사	31.43 $\pm$ 16.96	1.79		
			추후검사	31.57 $\pm$ 14.22	1.79		
타인의 인정에 대한 과도한 요망	실험집단	7	사전검사	56.14 $\pm$ 7.69	3.00	11.143**	.004
			사후검사	19.29 $\pm$ 2.56	1.71		
			추후검사	17.43 $\pm$ 2.99	1.29		
	비교집단	7	사전검사	53.29 $\pm$ 12.07	2.71	5.846	.054
			사후검사	40.29 $\pm$ 10.70	1.57		
			추후검사	40.86 $\pm$ 12.10	1.71		
타인· 대인 관계에 대한 부정적 신념	실험집단	7	사전검사	42.43 $\pm$ 7.14	3.00	10.571**	.005
			사후검사	17.57 $\pm$ 2.82	1.57		
			추후검사	16.29 $\pm$ 2.06	1.43		
	비교집단	7	사전검사	47.14 $\pm$ 13.21	2.14	0.286	.867
			사후검사	34.86 $\pm$ 14.63	2.00		
			추후검사	34.71 $\pm$ 13.76	1.86		

** $p<.01$

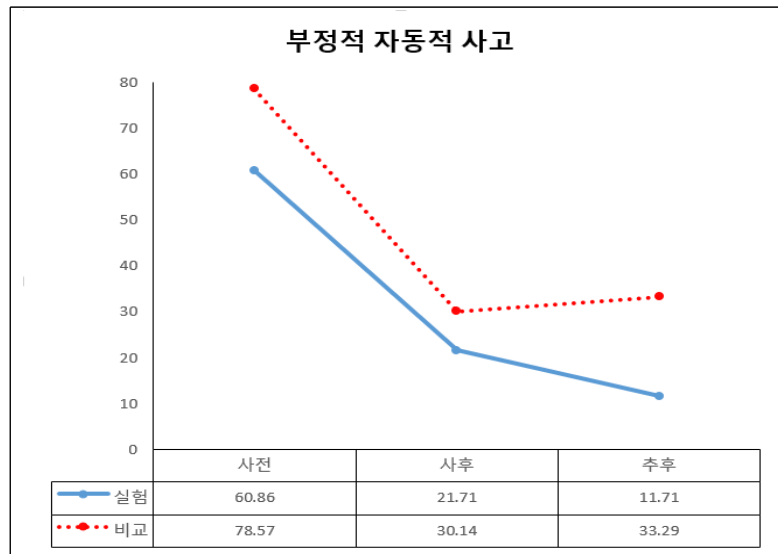


<그림 VI-2> 실험집단과 비교집단 내 역기능적 신념 사전-사후-추후검사 비교

<표 VI-31> 집단 내 부정적 자동적 사고의 사전-사후-추후검사 비교

하위요인	집단	n	검사	$M \pm SD$	평균순위	χ^2	p
전체	실험집단	7	사전검사	60.86±24.60	3.00	11.143**	.004
			사후검사	21.71±13.24	1.71		
			추후검사	11.71±2.93	1.29		
	비교집단	7	사전검사	78.57±15.99	2.86	8.000*	.018
			사후검사	30.14±17.95	1.71		
			추후검사	33.29±18.59	1.43		
부정적인 자기상과 부정적인 기대	실험집단	7	사전검사	25.29±10.55	2.93	9.407**	.009
			사후검사	8.14±5.46	1.57		
			추후검사	6.14±2.61	1.50		
	비교집단	7	사전검사	30.14±6.15	2.86	8.000*	.018
			사후검사	13.14±9.19	1.43		
			추후검사	15.00±7.48	1.71		
현실에 대한 불만과 변화 욕구	실험집단	7	사전검사	24.14±11.70	3.00	12.286**	.002
			사후검사	10.43±7.55	1.86		
			추후검사	4.00±1.91	1.14		
	비교집단	7	사전검사	34.14±9.08	2.86	8.000*	.018
			사후검사	11.71±6.75	1.71		
			추후검사	12.29±8.52	1.43		
무기력과 의욕상실	실험집단	7	사전검사	11.43±3.78	3.00	12.286**	.002
			사후검사	3.14±1.57	1.86		
			추후검사	1.57±0.53	1.14		
	비교집단	7	사전검사	14.29±2.43	3.00	11.185**	.004
			사후검사	5.29±3.90	1.64		
			추후검사	6.00±3.83	1.36		

* $p < .05$, ** $p < .01$



<그림 VI-3> 실험집단과 비교집단 내 부정적 자동적 사고 사전-사후-추후검사 비교

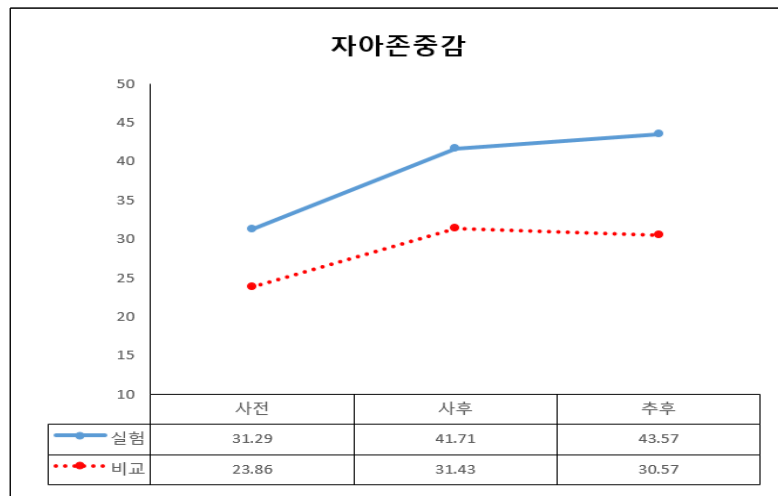
(3) 집단 내 자아존중감 사전-사후-추후검사 비교

자아존중감에 대한 분석 결과, 실험집단($\chi^2=10.571$, $p<.01$)에서만 유의하게 변화한 것으로 검증되었다. 전반적으로 평균 순위는 점차 높아지는 경향을 보여, 자아존중감은 실험집단에서만 프로그램 종결 3개월 후까지 유의하게 증가한 것으로 판단할 수 있다<그림 VI-4>.

<표 VI-32> 집단 내 자아존중감의 사전-사후-추후검사 비교

변수	집단	n	검사	$M\pm SD$	평균순위	χ^2	p
자아 존중감	실험집단	7	사전검사	31.29±6.63	1.00	10.571**	.005
			사후검사	41.71±4.68	2.43		
			추후검사	43.57±2.64	2.57		
	비교집단	7	사전검사	23.86±9.30	1.71	0.857	.651
			사후검사	31.43±9.98	2.14		
			추후검사	30.57±4.58	2.14		

** $p<.01$



〈그림 VI-4〉 실험집단과 비교집단 내 자아존중감 사전-사후-추후검사 비교

3) 집단 내 정서 변인 사전-사후-추후검사 비교

집단 내 정서 변인의 사전-사후-추후검사의 변화를 확인하고, 통계적 유의성을 검증하기 위해 Friedman test를 실시하였다. 실험집단과 비교집단 내에서 정서 변인의 사전-사후-추후검사의 변화를 검증한 결과는 <표 VI-33>~<표 VI-36>에 제시하였다.

(1) 집단 내 정서조절곤란 사전-사후-추후검사 비교

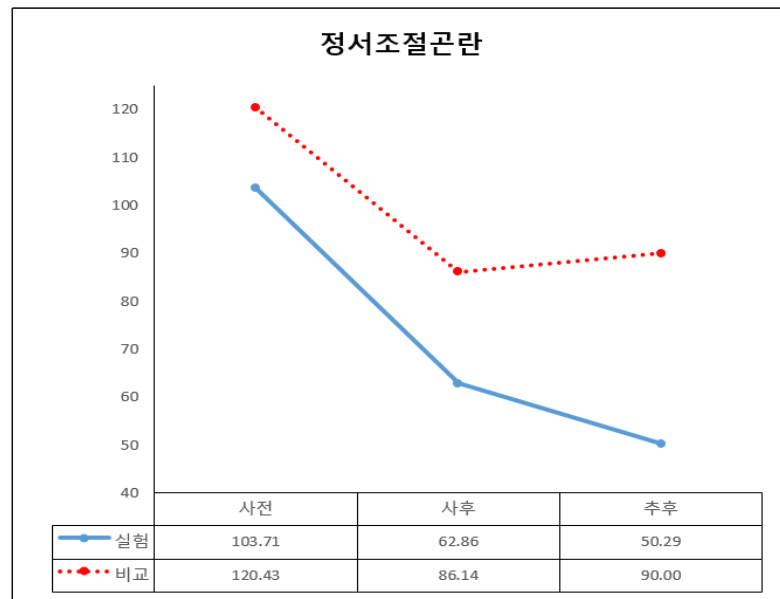
정서조절곤란에 대한 분석 결과, 정서조절곤란 총점은 실험집단($\chi^2=11.143$, $p<.01$)과 비교집단($\chi^2=7.714$, $p<.05$)에서 모두 유의하게 변화한 것으로 검증되었다. 그리고 하위영역 중 충동통제곤란, 정서에 대한 비수용성, 정서적 명료성 부족, 정서조절전략 접근 제한은 실험집단과 비교집단에서 모두 유의하게 변화하였고, 정서에 대한 주의/자각 부족, 목표지향행동 수행 어려움은 실험집단에서만 유의하게 변화하였다.

평균순위는 전반적으로 감소하는 추이를 보여, 실험집단과 비교집단에서 정서조절곤란 수준은 프로그램 종결 3개월 후까지 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다. 하위요인에서는 충동통제곤란, 정서에 대한 비수용성, 정서적 명료성 부족, 정서조절전략 접근 제한의 경우 실험집단과 비교집단에서 모두 유의하게 감소하였고, 정서에 대한 주의/자각 부족, 목표지향행동 수행 어려움은 실험집단에서만 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다<그림 VI-5>.

<표 VI-33> 집단 내 정서조절곤란의 사전-사후-추후검사 비교

하위요인	집단	n	검사	$M \pm SD$	평균순위	χ^2	p
전체	실험집단	7	사전검사	103.71±20.09	3.00	11.143**	.004
			사후검사	62.86±14.57	1.71		
			추후검사	50.29±7.70	1.29		
	비교집단	7	사전검사	120.43±18.03	2.86	7.714*	.021
			사후검사	86.14±32.15	1.57		
			추후검사	90.00±12.25	1.57		
충동통제 곤란	실험집단	7	사전검사	21.57±7.02	3.00	12.074**	.002
			사후검사	13.29±1.98	1.79		
			추후검사	10.86±2.12	1.21		
	비교집단	7	사전검사	27.29±8.62	2.86	8.074*	.018
			사후검사	18.86±6.67	1.50		
			추후검사	19.29±4.31	1.64		
정서에 대한 주의/자각 부족	실험집단	7	사전검사	20.43±8.96	2.71	8.222*	.016
			사후검사	12.86±1.86	2.07		
			추후검사	11.14±1.46	1.21		
	비교집단	7	사전검사	22.86±4.10	2.36	1.556	.459
			사후검사	20.86±9.15	1.71		
			추후검사	20.43±3.10	1.93		
정서에 대한 비수용성	실험집단	7	사전검사	20.71±9.95	2.71	6.870*	.032
			사후검사	14.00±7.05	1.79		
			추후검사	9.86±5.49	1.50		
	비교집단	7	사전검사	23.71±8.30	2.79	7.630*	.022
			사후검사	14.71±8.83	1.36		
			추후검사	16.43±5.26	1.86		
정서적 명료성 부족	실험집단	7	사전검사	9.14±4.30	2.71	6.741*	.034
			사후검사	5.86±2.54	1.93		
			추후검사	4.29±1.38	1.36		
	비교집단	7	사전검사	11.43±2.57	2.79	7.154*	.028
			사후검사	7.57±4.83	1.71		
			추후검사	7.57±2.76	1.50		
정서조절 전략 접근 제한	실험집단	7	사전검사	20.29±2.50	3.00	10.571**	.005
			사후검사	9.86±3.34	1.57		
			추후검사	8.71±2.36	1.43		
	비교집단	7	사전검사	22.57±4.43	3.00	11.143**	.004
			사후검사	14.43±7.07	1.29		
			추후검사	15.14±4.02	1.71		
목표지향 행동 수행 어려움	실험집단	7	사전검사	11.57±2.82	3.00	12.074**	.002
			사후검사	7.00±1.83	1.79		
			추후검사	5.43±1.72	1.21		
	비교집단	7	사전검사	12.57±2.07	2.21	0.720	.698
			사후검사	9.71±2.69	1.79		
			추후검사	11.14±2.19	2.00		

* $p < .05$, ** $p < .01$



<그림 VI-5> 실험집단과 비교집단 내 정서조절곤란 사전-사후-추후검사 비교

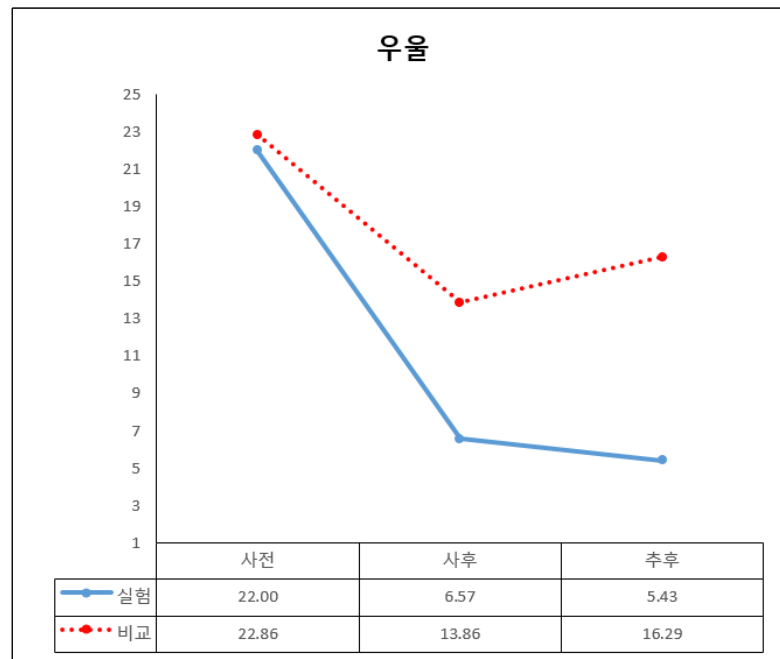
(2) 집단 내 우울 사전-사후-추후검사 비교

우울에 대한 분석 결과, 실험집단($\chi^2=13.040$, $p<.01$)과 비교집단($\chi^2=11.630$, $p<.05$)에 서 모두 유의하게 변화한 것으로 검증되었다. 평균 순위가 점차 감소하는 추이를 보 여, 우울은 실험집단과 비교집단 모두 프로그램 종결 3개월 후까지 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다<그림 VI-6>.

<표 VI-34> 집단 내 우울의 사전-사후-추후검사 비교

변수	집단	n	검사	$M\pm SD$	평균순위	χ^2	p
우울	실험집단	7	사전검사	22.00±6.32	3.00	13.040**	.001
			사후검사	6.57±2.63	1.79		
			추후검사	5.43±2.29	1.21		
	비교집단	7	사전검사	22.86±6.36	3.00	11.630*	.034
			사후검사	13.86±3.18	1.29		
			추후검사	16.29±3.35	1.71		

* $p<.05$, ** $p<.01$



<그림 VI-6> 실험집단과 비교집단 내 우울 사전-사후-추후검사 비교

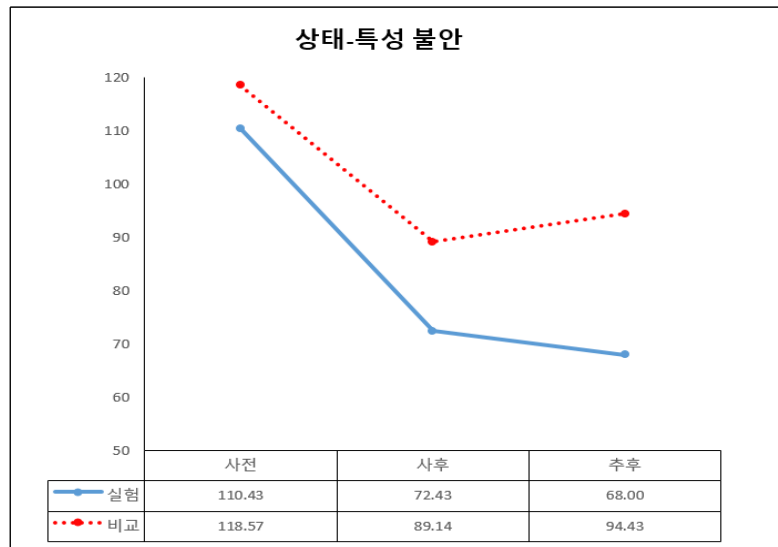
(3) 집단 내 상태-특성 불안 사전-사후-추후검사 비교

상태-특성 불안에 대한 분석 결과, 실험집단($\chi^2=11.143$, $p<.01$)에서만 유의하게 변화한 것으로 검증되었다. 평균 순위가 점차 감소하는 추이를 보여, 상태-특성 불안은 실험집단에서만 프로그램 종결 3개월 후까지 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다 <그림 VI-7>.

<표 VI-35> 집단 내 상태-특성 불안의 사전-사후-추후검사 비교

변수	집단	n	검사	$M\pm SD$	평균순위	χ^2	p
상태-특성 불안	실험집단	7	사전검사	110.43±21.48	3.00	11.143**	.004
			사후검사	72.43±15.35	1.71		
			추후검사	68.00±8.93	1.29		
	비교집단	7	사전검사	118.57±20.87	2.64	4.667	.097
			사후검사	89.14±26.12	1.79		
			추후검사	94.43±11.79	1.57		

** $p<.01$



<그림 VI-7> 실험집단과 비교집단 내 상태-특성 불안
사전-사후-추후검사 비교

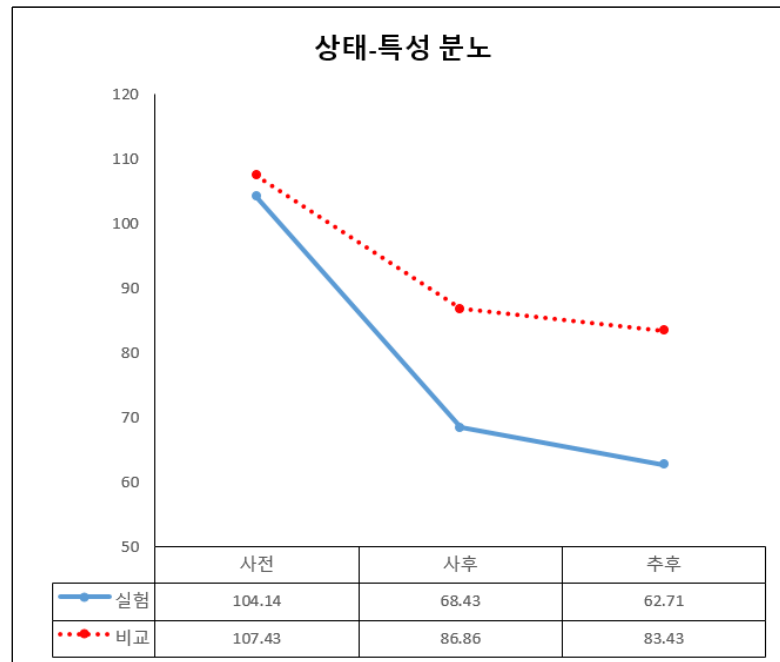
(4) 집단 내 상태-특성 분노 사전-사후-추후검사 비교

상태-특성 분노에 대한 분석 결과, 실험집단($\chi^2=11.143$, $p<.01$)과 비교집단($\chi^2=6.000$, $p<.05$)에서 모두 유의하게 변화한 것으로 검증되었다. 평균 순위가 점차 감소하는 추이를 보여, 상태-특성 분노는 실험집단과 비교집단 모두 프로그램 종결 3개월 후까지 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다<그림 VI-8>.

<표 VI-36> 집단 내 상태-특성 분노의 사전-사후-추후검사 비교

변수	집단	n	검사	$M\pm SD$	평균순위	χ^2	p
상태-특성 분노	실험집단	7	사전검사	104.14±14.14	3.00	11.143**	.004
			사후검사	68.43±6.16	1.71		
			추후검사	62.71±5.19	1.29		
	비교집단	7	사전검사	107.43±23.64	2.71	6.000*	.050
			사후검사	86.86±19.35	1.86		
			추후검사	83.43±7.23	1.43		

* $p<.05$, ** $p<.01$



〈그림 VI-8〉 실험집단과 비교집단 내 상태-특성 분노
사전-사후-추후검사 비교

4) 집단 내 행동 변인 사전-사후-추후검사 비교

집단 내 행동 변인의 사전-사후-추후검사의 변화를 확인하고, 통계적 유의성을 검증하기 위해 Friedman Test를 실시하였다. 실험집단과 비교집단 내에서 행동 변인의 사전-사후-추후검사의 변화를 검증한 결과는 <표 VI-37>에 제시하였다.

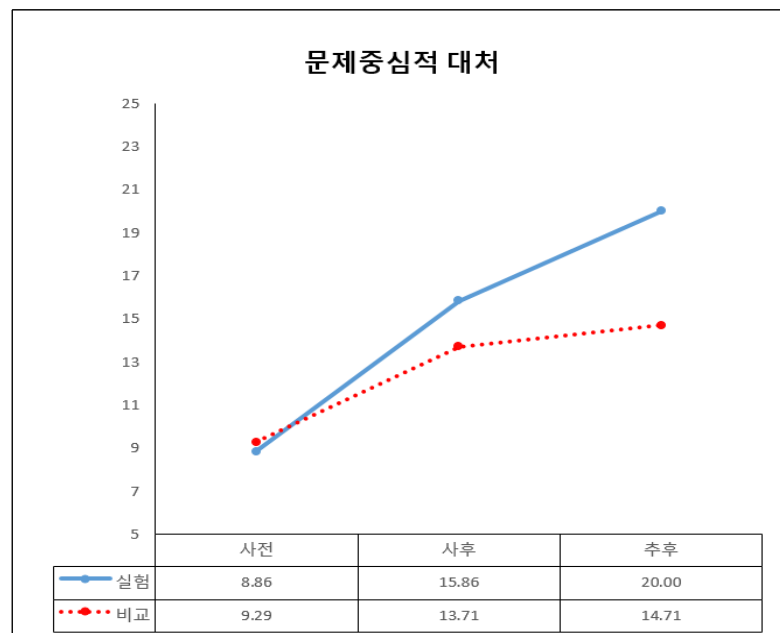
그 결과 하위요인인 문제중심적 대처, 사회적지지 추구는 실험집단과 비교집단 모두 유의한 결과를 보였다. 전반적으로 평균순위가 높아지는 경향을 보여, 문제중심적 대처, 사회적지지 추구는 실험집단과 비교집단에서 모두 프로그램 종결 3개월 후까지 유의하게 증가한 것으로 판단할 수 있다<그림 VI-9>~<그림 VI-10>.

하위요인인 정서완화적 대처는 실험집단($\chi^2=11.630$, $p<.01$)만 유의한 결과를 보였고, 전반적으로 평균 순위는 낮아지는 추이를 보여, 정서완화적 대처는 실험집단에서 프로그램 종결 3개월 후까지 유의하게 감소한 것으로 판단할 수 있다<그림 VI-11>.

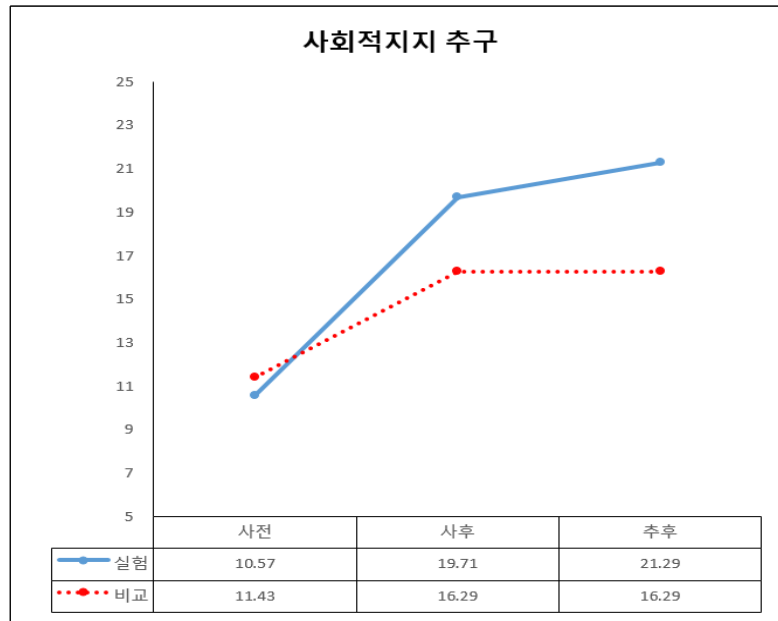
<표 VI-37> 집단 내 스트레스 대처방식의 사전-사후-추후검사 비교

하위요인	집단	n	검사	$M \pm SD$	평균순위	χ^2	p
문제중심적 대처	실험집단	7	사전검사	8.86±3.29	1.00	14.000**	.001
			사후검사	15.86±2.85	2.00		
			추후검사	20.00±2.08	3.00		
	비교집단	7	사전검사	9.29±2.81	1.14	8.308*	.016
			사후검사	13.71±3.15	2.43		
			추후검사	14.71±4.46	2.43		
사회적지지 추구	실험집단	7	사전검사	10.57±5.22	1.00	12.074**	.002
			사후검사	19.71±2.29	2.21		
			추후검사	21.29±1.98	2.79		
	비교집단	7	사전검사	11.43±2.37	1.07	9.556**	.008
			사후검사	16.29±1.25	2.57		
			추후검사	16.29±3.30	2.36		
정서완화적 대처	실험집단	7	사전검사	15.71±4.31	2.86	11.630**	.003
			사후검사	9.57±3.55	2.07		
			추후검사	6.29±2.29	1.07		
	비교집단	7	사전검사	13.86±3.44	2.21	0.636	.727
			사후검사	13.71±2.75	1.93		
			추후검사	13.29±4.57	1.86		

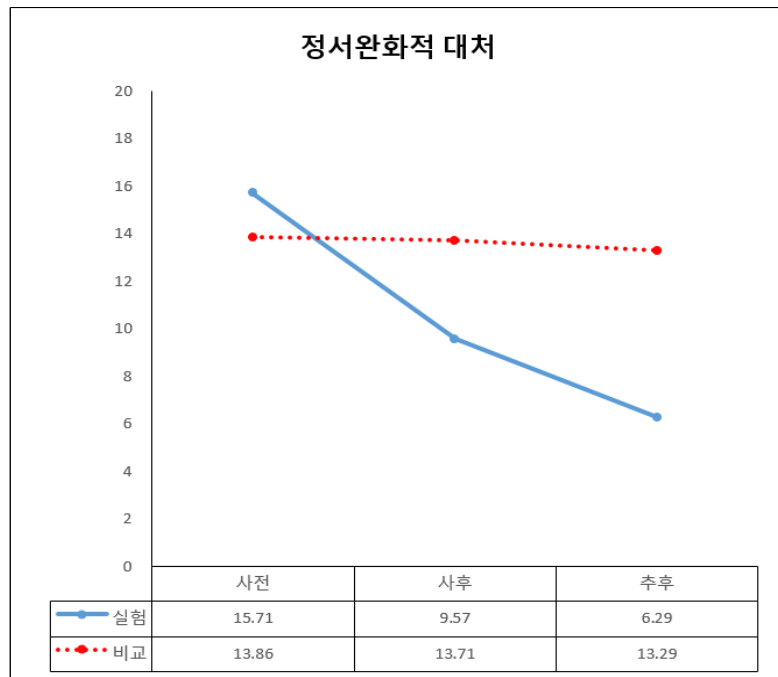
* $p < .05$, ** $p < .01$



<그림 VI-9> 실험집단과 비교집단 내 문제중심적 대처 사전-사후-추후검사 비교



<그림 VI-10> 실험집단과 비교집단 내 사회적지지 추구
대처 사전-사후-추후검사 비교



<그림 VI-11> 실험집단과 비교집단 내 정서완화적 대처
사전-사후-추후검사 비교

6. 실험집단의 인지 내용의 변화 분석

본 연구에서는 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 위한 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램을 개발하여 그 효과성을 검증하는 것으로 프로그램 실시 후 양적 분석 결과 실험집단, 비교집단 및 통제집단 간 사전, 사후, 추후 검사를 통해 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램이 참여자들의 폭식 증상에 효과적임을 확인하였다. 이러한 양적 분석을 통해 섭식 변인(부정적 정서로 유발된 섭식 동기·행동)의 수준, 인지 변인(부적응적 자동적 사고, 핵심신념, 자아존중감)의 수준, 정서 변인(정서조절곤란, 우울, 불안, 분노)의 수준, 행동 변인(스트레스 대처행동)의 수준 등 전반적인 영역에 걸쳐 점수의 변화는 확인할 수 있었으나 프로그램 참여자들의 인지 내용의 구체적인 경험적 변화에 대한 충분한 정보를 제공해주지 못한다는 제한점이 있었다. 따라서, 양적 분석을 보완하는 동시에 프로그램 참여자들의 경험적인 측면을 파악하기 위해, 초기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성들의 폭식 및 대인외상과 관련된 인지 내용에 대한 변화를 분석하였다. 본 연구에서 살펴보고자 한 것은 인지 내용의 변화로 인지행동치료의 창시자인 Beck(1963, 1964)은 정서장애를 가진 사람들의 사고에는 개인화, 흑백논리, 과극화 등의 인지적 오류(Cognitive Error)가 있으며 이러한 인지적 오류를 해석하는 패턴 방식이 병리적인 정보 처리의 내용과 관련이 있다고 강조하였다. 즉, 인지적 오류의 해석 패턴에 따라 인지적 내용이 달라지므로, 개인의 인지적 오류의 범주를 찾아서 이를 해석한 패턴을 수정시키는 것은 중요하다. 따라서, 본 연구에서는 인지적 내용의 변화를 살펴보기 위해 선행연구의 범주화된 사례 분석 방법을 바탕으로 하여(Cockell, et al., 2004), 참여자들이 보인 부적응적인 사고 및 신념의 오류 패턴을 범주화하였으며 중점적으로 살펴보아야 할 부분은 축어록 내용을 추가하여 보완시켰다.

본 연구는 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 폭식에 대한 부적응적인 인지 내용에 초점을 두었으므로 프로그램 진행 과정의 결과물인 Worksheet, 과제물, 녹음 및 녹화 자료 등에서 참여자들의 인지 내용에 대한 자료를 추출하였다. 1단계로 녹음 자료를 여러 번 반복해서 듣고, 워크시트 및 과제물을 면밀히 조사하였다. 이를 통해 대상자가 특정 상황에서 반복하는 부적응적인 사고 및 신념을 찾아내었다. 특히, 인지적 왜곡이 나타나는 부분은 유의 깊게 관찰하여 기록하였다. 2단

계는 인지행동치료 이론을 토대로 하여 참여자들의 생각에 대한 유사점을 발견해냈다. 3단계로 추출된 자료들에서 핵심어들을 찾아내어 인지 오류를 범주화하여 분류하고, 프로그램 회기의 진행 흐름에 따라 참여자들의 사고가 어떻게 변화되는지 분석하였다.

자료를 분류한 결과, 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성들의 경우 대인외상경험 및 폭식과 관련된 사고로 크게 나눌 수 있었으며 대인외상경험의 경우 다시 자기 지각과 대인 지각으로 분류하였고, 폭식의 경우에도 다시 폭식과 관련된 자기 지각, 대인 지각에 대한 인지 내용으로 분류되었다. 본 프로그램에 참여한 대상자의 개인별 특성은 <표 VI-38>에 제시하였다.

<표 VI - 38> 실험집단의 개인별 특성

사례 (나이/성별)	개인별 특성
A (20대/여성)	자매 중 첫째로 가족과 거주 중이다. 초기 대인외상경험 시기는 아동기(초등학교 입학 후)이며 성인기부터 폭식이 시작되었다. 대인외상경험의 내용은 아동기(초등학교 입학 후)에 온라인 그루밍 성폭력 경험이다. 이러한 대인외상경험으로 인해 자신을 과도하게 탓하는 자기비난적 태도와 실수에 대한 자책을 많이 한다.
B (20대/여성)	자매 중 첫째로 혼자 자취를 하고 있다. 초기 대인외상경험 시기는 아동기(초등학교 입학 후)이며 성인기부터 폭식이 시작되었다. 대인외상경험의 내용은 아동기(초등학교 입학 후)에 왕따 경험이다. 이러한 대인외상경험으로 관계에서 타인을 잘 믿지 못하고, 자신에게 해를 가할 것이라고 여긴다.
C (20대/여성)	외동으로 가족과 거주 중이다. 초기 대인외상경험 시기는 아동기(초등학교 입학 후)이며 성인기부터 폭식이 시작되었다. 대인외상경험의 내용은 아동기(초등학교 입학 후)에 부모님의 지인으로부터 성추행을 당한 경험이며 당시에 자신이 잘 대처하지 못한 것에 대한 자신을 탓하는 경향이 있다.
D (20대/여성)	남매 중 둘째로 가족과 거주 중이다. 초기 대인외상경험 시기는 청소년기(중학생)이며 청소년기(중학생)부터 폭식이 시작되었다. 대인외상경험의 내용은 청소년기(중학생)에 왕따 경험이다. 이러한 대인외상경험으로 타인의 평가에 민감하며 자기주장과 거절하는 것에 어려움이 있다.
E (30대/여성)	세 자매 중 첫째로 가족과 거주 중이다. 초기 대인외상경험 시기는 청소년기(고등학생)이며 청소년기(고등학생)부터 폭식이 시작되었다. 대인외상경험의 내용은 청소년기(고등학생)에 친동생의 죽음이다. 대인외상경험 이후부

	터 감정 억압으로 인한 감정 인식 및 정서조절의 어려움이 있다.
F (30대/여성)	삼남매 중 셋째로 혼자 자취를 하고 있다. 초기 대인외상경험 시기는 아동기(초등학교 입학 전)이며 성인기부터 폭식이 시작되었다. 대인외상경험의 내용은 아동기(초등학교 입학 전)에 정서적 학대이다. 이러한 대인외상경험으로 인해 타인의 얼굴 표정, 말투, 행동 등에 민감하며 자신은 무가치하기 때문에 모두가 자신을 좋아하지 않는 것은 당연하다고 여긴다.
G (30대/여성)	남매 중 첫째로 혼자 자취를 하고 있다. 초기 대인외상경험 시기는 아동기(초등학교 입학 후)이며 성인기부터 폭식이 시작되었다. 대인외상경험의 내용은 아동기(초등학교 입학 후)에 왕따 경험이다. 이러한 대인외상경험으로 인해 타인의 표정과 의도를 왜곡하는 경향이 있으며, 타인을 잘 믿지 못한다.

1) 대인외상경험(자기 지각, 대인 지각) 관련 인지 내용의 변화 분석

이미지 재구성 인지행동치료 프로그램의 참여자들은 대인외상경험과 이로 인해 관련된 자기 지각과 대인 지각의 인지 내용에 부적응적인 사고 및 비합리적인 핵심신념이 두드러졌고, 왜곡된 사고와 연결하여 정서적으로 우울, 불안, 분노를 느꼈으며 이러한 부정 정서를 적응적으로 조절하지 못하여 폭식하는 패턴이 반복되었다. 따라서, 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램을 통해 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성들은 대인외상과 관련된 자신, 타인에 대한 부적응적인 사고 및 역기능적인 핵심신념을 객관적으로 평가하고 수정하는 과정을 연습하면서 적응적인 사고로 변화되었고, 프로그램 후반으로 갈수록 결국 자신이 어떻게 생각하느냐에 따라 감정 및 행동이 변화될 수 있음도 깨달았음을 표현하였다. 프로그램 내에서 대인외상경험에 따른 왜곡된 사고의 내용은 자기 지각과 대인 지각으로 분류하여 집단 회기와 개인 회기(이미지 재구성)에서 공통적인 오류를 보인 인지적 오류(Cognitive Error)의 패턴으로 구성하여 기술하였고, 범주화한 내용은 <표 VI-39>에 제시하였다.

<표 VI-39> 실험집단의 대인외상경험 관련 인지적 오류 범주 분류

범주명		범주기술		구체적 예시
대인 외상	자기 지각	자기비난 및 개인화	근거가 전혀 없음에도 사건에 대해 자신과 연관시켜 과도하게 비난하는 것	‘이런 일을 겪은 건 대처를 잘 하지 못한 내 탓이야’
		흑백논리	자신과 타인에 대한 판단이 양극단적이며 상반된 두 개의 범주중 하나로만 생각하는 것	‘나는 별로고, 가치 없는 사람이야’
	대인 지각	과잉일반화	부정적인 하나의 사건 혹은 하나 이상의 별개의 사건들의 결론을 도출하여 모든 사건, 인물, 상황에 비논리적으로 확장시켜 적용하는 것	‘(과거 왕따 경험으로)다른 사람들은 믿을 수 없어. 내가 맞춰주지 않거나 혹시라도 거슬리게 한다면 언제라도 쉽게 돌변해서 나에게 상처 줄 거야’
		파국화	실제로 그렇지 않음에도 항상 자동적으로 최악의 상황을 예측하는 것	‘거절하면 나한테 실망할 거고, 이 관계에 문제가 생길 거야’

(1) 자기 지각 관련 인지 내용의 변화

① 자기비난 및 개인화

대인외상경험자와 폭식장애경향자들의 공통된 자기 지각적 변인에는 자기비난과 개인화에 대한 인지적 왜곡이 있다. 어린 시절 타인으로 인한 외상경험은 자기 자신을 무가치하고 결함이 있는 사람으로 느끼게 하였으며 무능하고 열등한 느낌의 부정적인 자기감의 형성은 수치심 및 죄책감을 느끼게 하는 부정적인 자기 지각을 형성하게 된다. 즉, 스스로 부정적인 사건의 원인을 자신의 탓으로 돌리며 과도한 책임이나 비난을 감수한다. 실험집단의 참여자들 역시 타인의 표정, 행동 및 말투 등에 민감하며 타인의 기분이 좋지 않거나 문제가 발생하였을 때 자기비난 및 개인화의 부적응적인 사

고들을 보였으며 해당 내용은 <표 VI-40>에 제시하였다.

<표 VI-40> 대인외상경험의 자기 지각과 관련된 자기비난 사고의 변화 내용

참여자	부적응적 사고	⇒	적응적 사고
A	이런 일을 겪은 건 전부 다 내 탓이야		네 탓이 아니야. 어떻게 아무것도 모르고 채팅한 어린 너의 탓만이 되겠어... 나쁜 짓 하려고 의도하고 채팅하는 걸 비난해야지 그걸 욕해야지 너는 그냥 우연히 채팅방에 들어간 것뿐이야 알고 시작한 것도 아닌데 너를 너무 몰아세우지 마 네 탓이 아니야. 괜찮아. 이런 일이 있어도 그래도 잘 견뎌낼 수 있어. 그때 잘못된 선택이든 실수든 뭐든 괜찮아. 처음에 이렇게 될 줄 알고 시작한 것도 아니잖아. 넌 아무것도 모르는 어린 아이일 뿐이었어. 뭐라고 비난만 하지 말고 자책도 하지 말고 차라리 위로해주고 받아들여줘
C	완강하게 거부했다면 이런 일을 겪지 않았을 텐데 대처를 잘하지 못한 내 탓이야		너무 무서운데도 최선을 다했어요. 이 아이의 탓이 아니에요. 그 아저씨가 나쁘고 잘못된 거지 그러니까 제 잘못이 아니에요... 네 탓이 아니야... 넌 잘못된 거 하나도 없어... 저 사람이 나쁜 사람이야 (Weeping) 어른이 어린 아이한테 잘못된 행동을 했어. 나쁜 사람이야

가. A참여자의 사례

A참여자의 경우, 초기 대인외상인 온라인 그루밍 성폭력 경험에 대해 채팅을 처음 시작한 것부터 잘못되었다고 생각하며 자신을 과도하게 탓하는 자기비난과 함께 과거

자신의 행동에 대한 자책을 많이 하였다. 따라서, 연구자는 A참여자가 생각하는 ‘이런 일을 겪은 건 전부 다 내 탓이야’라는 자기비난적 사고에 대한 인지적 재구성의 과정이 필요할 것으로 판단되어 이미지 재구성 I 을 통해 다음과 같이 개입을 진행하였다. 사전에 언어적 접근의 인지적 재구성으로 A참여자가 자신만의 잘못이 아님을 인지하였으나 머리로만 이해하였는데 자신에 대한 용서가 잘 되지 않는다고 하여 이미지 재구성 I 개입 시 연구자가 자기비난적 사고에 초점을 맞출 수 있는 질문과 개입들을 하여 A참여자의 자기비난적 사고를 수정시켰다.

[이미지 재구성 I: 과거 대인외상]

A참여자: (온라인 그룹팅 성폭력 관련 외상 심상 후 2단계 성인의 관점으로 얘기함)

연구자: 어린 아이가 내가 왜 그런 선택을 했는지, 처음부터 시작하지 말걸 이런 일을 겪은 건 전부 다 자신의 탓이라고 생각하면서 계속 자기를 비난하고 자책하면서 울고 있어요. 아이의 생각과 자기비난, 자책에 집중해본다면 어른이 된 내가 어떤 것들을 해주고 싶으신가요? 어떤 말과 행동도 다 괜찮아요.

A참여자: 안아주고 싶어요. 무슨 일 있어? 왜 그래. 괜찮다고 말해주고 어리기 때문에 누구나 실수할 수 있어. 그 정도 실수는 아무것도 아니야 네가 잘못된 거 하나도 없어 (Weeping) 내가 도와줄게. 내가 부모님한테 말씀드릴게 내가 널 도와줄 거야 이렇게...

연구자: 그때의 어린 아이가 처음 채팅을 시작하고, 중간에 끊어내지 못한 이유가 있었을까요?

A참여자: 잘 몰랐고... 외로웠던 것 같아요... 외로움 너무 외로웠어요... (Weeping) 그럴 수밖에 없었어요.

연구자: 어린 아이는 순전히 외로워서 그리고 잘 몰라서 채팅을 시작한 건가 봐요. 결과는 어떻게 될지 모르고 시작한 일인데 반대로 어른인 상대방은 처음부터 의도하고 채팅을 시작했어요. 그럼에도 실수했다고 혼자 자책하고, 비난하고 있는 건 어린 OO이네요. 혹시 어린 OO이에게 더 하고 싶은 말이나 행동이 있으신가요? 만약에 원하신다면 성인인 OO 씨가 어린 OO이를 위해 나쁜 짓을 한 상대방에게 하고 싶은 말이나 행동을 해도 괜찮아요. 둘 중 어떤 것도 가능합니다.

A참여자: 네... 맞아 네 탓이 아니야. 어떻게 아무것도 모르고 채팅한 어린 너의 탓만이

되겠어... 나쁜 짓 하려고 의도하고 채팅하는 걸 비난해야지 그걸 욕해야지 너는 그냥 우연히 채팅방에 들어간 것뿐이야 알고 시작한 것도 아닌데 너를 너무 몰아세우지 마

연구자: 다시 한 번 말해주면서 어린 OO이를 안아주거나 OO이를 위해 해주고 싶은 행동도 같이 해줄 수 있을까요?

(중략)

연구자: 혹시 이 어린 아이를 위해서 A님이 무언가 더 해줄 말이나 행동은 없으신가요?

A참여자: 만약에 힘든 일이 있거나 함께할 누군가가 필요하면 엄한 사람 찾지 말고 곁에 있는 가족들에게 도움을 요청하거나 어른이 된 나에게 말을 해줘. 네 탓이 아니야. 괜찮아. 이런 일이 있어도 그래도 잘 견뎌낼 수 있어. 그때 잘못된 선택이든 실수든 뭐든 괜찮아. 처음에 이렇게 될 줄 알고 시작한 것도 아니잖아. 넌 아무것도 모르는 어린 아이일 뿐이었어. 뭐라고 비난만 하지 말고 자책도 하지 말고 차라리 위로해 주고 받아들여줘. 극복할 수 있어. 괜찮아. 모든 걸 잃진 않아. 정말 괜찮아. 내가 도와줄게.

이미지 재구성 I 를 통해 A참여자는 “네 탓이 아니야. 어떻게 아무것도 모르고 채팅한 어린 너의 탓만이 되겠어... 나쁜 짓 하려고 의도하고 채팅하는 걸 비난해야지 그걸 욕해야지 너는 그냥 우연히 채팅방에 들어간 것뿐이야 알고 시작한 것도 아닌데 너를 너무 몰아세우지 마”, “네 탓이 아니야. 괜찮아. 이런 일이 있어도 그래도 잘 견뎌낼 수 있어. 그때 잘못된 선택이든 실수든 뭐든 괜찮아. 처음에 이렇게 될 줄 알고 시작한 것도 아니잖아. 넌 아무것도 모르는 어린 아이일 뿐이었어. 뭐라고 비난만 하지 말고 자책도 하지 말고 차라리 위로해 주고 받아들여줘.” 등의 자기이해 및 자기수용적 사고로 전환시켜 자기비난적 사고에서 벗어났다.

나. C참여자의 사례

C참여자의 경우에도, 초기 대인외상인 지인으로부터의 성추행 경험에 대해 사건 당시 자신이 완강하게 거부했다면 상황이 달라졌을 것이라고 생각하며 적절하게 대처하지 못했던 자신에 대한 자기비난적 사고가 두드러졌으며 사건의 원인을 가해자가 아닌 제대로 반항하지 못한 자신의 행동에 초점을 맞추고 있었다. 따라서, 연구자는 C참

여자가 생각하는 ‘완강하게 거부했다면 이런 일을 겪지 않았을 텐데 대처를 잘 하지 못한 내 탓이야’라는 사고에 대한 인지적 재구성의 과정이 필요할 것으로 판단되어 이미지 재구성 I 을 통해 다음과 같이 개입을 진행하였다. 이미지 재구성 I 개입 시 연구자가 어린 아이가 아무런 대처를 하지 못했는지 혹은 그 상황에서 가능한 일인지에 대해 질문들을 하여 C참여자의 자기비난적 사고를 수정시켰다.

[이미지 재구성 I: 과거 대인외상]

C참여자: (성추행 당한 관련 외상 심상 후 2단계 성인의 관점으로 얘기함)

연구자: 성인으로써 바라봤을 때 아이의 모습은 어떤가요? 완강하게 반항할 수 있어 보이나요?

C참여자: 아니요... 너무 떨고 있어요. 작은 목소리로 하지 말아달라고 한 마디 했던 게 최선이에요.... (Weeping) 너무 무서워서 더 이상 어떤 것도 할 수 없어요...

(중략)

연구자: 그럼 아이는 너무 무서운데도 최선을 다해서 거부의 말을 했네요.

C참여자: 네. 너무 무서운데도 최선을 다했어요. 이 아이의 탓이 아니에요. 그 아저씨가 나쁘고 잘못된 거지 그러니까 제 잘못이 아니에요...

연구자: 아이에게 말해주세요.

C참여자: 네 탓이 아니야... 넌 잘못된 거 하나도 없어... 저 사람이 나쁜 사람이야 (Weeping) 어른이 어린 아이한테 잘못된 행동을 했어. 나쁜 사람이야.

연구자: 맞아 네 잘못이 아니야. 저 사람이 잘못된 거지. 넌 그 상황에서 어린 아이로써 할 수 있는 최선을 다했어. 넌 정말 최선을 다했어. 절대 네 잘못이 아니야

이미지 재구성 I 를 통해 C참여자는 “너무 무서운데도 최선을 다했어요. 이 아이의 탓이 아니에요. 그 아저씨가 나쁘고 잘못된 거지 그러니까 제 잘못이 아니에요...”, “네 탓이 아니야... 넌 잘못된 거 하나도 없어... 저 사람이 나쁜 사람이야 (Weeping) 어른이 어린 아이한테 잘못된 행동을 했어. 나쁜 사람이야.” 등의 외상경험 당시의 현실적인 상황 이해 및 자기수용적 사고로 전환시켜 자기비난적 사고에서 벗어났다.

② 흑백논리

흑백논리는 자기 자신, 개인적 경험 또는 타인에 대한 판단이 두 개의 범주 중 하나에 해당되는 것으로 중간의 회색지대 없이 나쁘거나 좋거나, 완전히 실패하거나 완전히 성공하거나, 결함투성이거나 완벽하거나 등의 인지왜곡으로 나타난다. 참여자들의 경우 흑백논리 시 두 개의 범주 중 부정적인 범주에 자신을 국한시키는 인지 오류를 보였으며 흑백논리 사고의 내용은 <표 VI-41>에 제시하였다.

<표 VI-41> 대인외상경험의 자기 지각과 관련된 흑백논리 사고의 변화 내용

참여자	부적응적 사고	⇒	적응적 사고
B	나는 별로고, 가치 없는 사람이야		제가 저 자신을 확 드러낸 기억은 없기 때문에 실제로 제가 정말 가치도 없는 별로인 사람인지 아닌지 알 수 없었던 것 같기도 해요. 정말 그렇네... 이번에 좋은 기회가 돼서 저를 완전히 다 드러냈는데도 많은 분들이 위로해주고, 지지해주고, 격려해주신 경험들이 뭔가 내 본모습도 아예 별로인 건 아니지 않을까? 라는 생각이 들었어요. 실제로 내 본모습을 드러냈는데 괜찮게 생각해주는 사람들이 있었으니까 나도 나름 괜찮은 구석도 있는 사람이다.
F	나는 사랑받을 만하지 않아. 가치 없는 사람이야		제가 어린 나를 안아주고, 위로해주고 되게 사랑스럽고, 아기처럼 귀하게 대해줬더니 제가 저를 보는 관점이 바뀌었어요. 내가 나 자신을 사랑해 주어야 한다는 말이 뭔지 한 번에 와 닿고 그 말뜻이 이제야 이해가 돼요. 이런 이해만으로도 내가 진짜 나를 정말 생각해주고, 사랑해주는 방법이 아닐까요? 저는 그래도 하나밖에 없는데... 저는 저 자체로 가치가 있다고 생각해요.

가. B참여자의 사례

B참여자의 경우, 초기 대인외상인 왕따 경험으로 자신은 별로이고, 가치 없는 사람이라고 생각하며 타인에 대한 불신으로 관계에 대한 불안이 크다. 따라서, 연구자는 B참여자가 생각하는 ‘나는 별로고, 가치 없는 사람이야’라는 흑백논리 사고에 대한 인지적 재구성의 과정이 필요할 것으로 판단되어 증거점검 및 소크라테스 기법을 통해 다음과 같이 개입을 진행하였다. 사전에 집단 활동에서 익명으로 자신의 고민을 얘기하여 인지적 재구성을 하는 시간에 C의 사례를 채택하여 관점취하기를 통해 C가 그동안과 다른 반대 관점에서 자신의 사고에 도전할 수 있도록 하였고, 이후에 이 경험을 토대로 다시 한 번 아래의 축어록과 같이 인지적 재구성을 하여 B참여자의 흑백논리 사고를 수정시켰다.

[언어적 접근의 인지적 재구성]

연구자: 외상경험과 연결된 B님의 핵심신념을 보면 그 당시에 본 모습을 드러냈기 때문에 친구들이 B님을 좋아하지 않게 되었다고 생각하시는 것 같아요. 그 말은 B님이 자신의 본모습을 어떻게 생각하신다는 건가요?

B참여자: 내 본모습은 완전 별로이다. 이기적이고 다른 사람들에게 들키지 말아야 하는 숨겨야 하는 모습. 그렇게 생각해요. 완전 별로이고 가치도 없는 사람. 그래서 내 생각이나 기분이나 있는 그대로 표현하면 안 될 것 같아요.

(중략)

연구자: 저희 집단 활동으로 탐정이 되어 익명으로 생각바꾸기 했던 것 기억나시나요? 그때 B님의 사연으로 다뤘다가 프로그램 마무리 소감얘기 할 때 갑자기 B님이 자신인 걸 밝히셨잖아요. 굳이 밝히지 않았어도 괜찮았는데 정말 놀랍게도 본인임을 밝히시면서 진심어린 조언과 격려를 받아서 감사하다고 모두에게 감사 인사하셨던 것 기억나요. 그때 익명으로 글 쓰실 때 혹은 감사인사 전할 때 자신의 별로이거나 가치 없는 모습이 드러나지 않도록 숨기려고 노력하셨나요? 아니면 있는 그대로의 나를 표현하셨나요.

B참여자: 아뇨. 글은 어차피 익명이라 누가 누군지 모르니까 정말 제 생각과 기분을 다 넣어서 길게 적었어요. 감사인사 때도 새로운 경험이라 마음가는대로 진심으로 감사함을 전했어요. 지금 생각해보면 조금 벅차기도 했었던 것 같아요.

(중략)

연구자: 이번에 B님의 진짜 생각과 기분도 표현하고 그러니까 쉽게 얘기해서 본모습을 드러내고 나서 다른 집단원들의 태도가 어땠나요? B님의 생각대로라면 별로이거나 가치 없는 본모습을 보였기 때문에 다른 사람들이 B님을 대하는 태도가 달라졌을 것 같아요.

B참여자: 어... 달라지긴 했어요. 제 생각과는 좀 반대로요. 제가 용기 있다고 응원해주시기도 하고, 자기 일처럼 안타까워하기도 하고, 저를 도와주려고 모두 최선을 다했어요. 진심으로 걱정을 해줬어요.

연구자: 본모습을 드러냈을 때 사람들이 싫어해야 하는데 오히려 원래의 생각이나 반응 말고 다른 긍정적인 반응들이 나왔어요. 그렇다면 가치 없는 본모습을 드러낸 B님은 별로인 사람이 아닌 건가요?

B참여자: 모르겠어요... 그래도 완전 별로인 것 같지는 않은? 그냥 제가 생각했을 때 저 자신이 너무 별로인 사람 같아서 드러내고 싶지가 않았었는데 실제로 다 드러냈을 때 괜찮게 생각해주는 사람들도 있네요.

연구자: 그렇다면 B님은 실제로 자신에 대해 드러낸 적이 거의 없기 때문에 혹은 있어도 그냥 넘어갔기 때문에 B님을 좋아하는지 안 좋아하는지 알 수 없었던 게 아니었을까요? 그니까 저희 증거 찾기에서 내 생각에 대한 증거만 찾지 반대의 증거를 찾는 건 하지 않아서 증거점검을 제대로 하지 못한다고 제가 알려드렸던 거 기억나시죠?

B참여자: 네... 어쩌면 제가 저 자신을 확 드러낸 기억은 없기 때문에 실제로 제가 정말 가치도 없는 별로인 사람인지 아닌지 알 수 없었던 것 같기도 해요. 정말 그렇게... 이번에 좋은 기회가 돼서 저를 완전히 다 드러냈는데도 많은 분들이 위로해주고, 지지해주고, 격려해주신 경험들이 뭔가 내 본모습도 아예 별로인 건 아니지 않을까? 라는 생각이 들었어요.

연구자: 실제로 이번에 B님의 말씀처럼 전부가 진심으로 걱정해주고, 도와주려고 노력했었어요. B님의 생각이 처음과 조금 달라지신 것 같은데 B님이 말씀하신 아예 별로인 것 같지는 않다는 말을 한 번 바꿔보면 어떨까요? 완전 별로이지 않다는 건 괜찮은 구석도 있다는 거잖아요.

B참여자: 네. 그럼 실제로 내 본모습을 드러냈는데 괜찮게 생각해주는 사람들이 있었으니까 나도 나름 괜찮은 구석도 있는 사람이다.

연구자: 잘 바꾸셨어요. 그렇게 생각하니까 기분이 어떠세요?

B참여자: 한결 나아요. 나쁘지 않아요. 음... 기분... 이상하게 홀가분해요.

증거점검 및 소크라테스식 기법을 통해 B참여자는 “제가 저 자신을 확 드러낸 기억은 없기 때문에 실제로 제가 정말 가치도 없는 별로인 사람인지 아닌지 알 수 없었던 것 같기도 해요. 정말 그렇네... 이번에 좋은 기회가 돼서 저를 완전히 다 드러냈는데도 많은 분들이 위로해주고, 지지해주고, 격려해주신 경험들이 뭔가 내 본모습도 아예 별로인 건 아니지 않을까? 라는 생각이 들었어요.”, “실제로 내 본모습을 드러냈는데 괜찮게 생각해주는 사람들이 있었으니까 나도 나름 괜찮은 구석도 있는 사람이다.” 등의 적응적인 사고로 전환시켜 흑백논리 사고에서 벗어났다.

나. F참여자의 사례

F참여자의 경우에도, 초기 대인외상인 정서적 학대로 부모님도 자신을 사랑하지 않았고, 결국 엄마도 자신을 버리고 떠났기 때문에 자신은 가치가 없는 사람이라고 생각하였다. 따라서, 연구자는 F참여자가 생각하는 ‘나는 사랑받을 만하지 않아. 가치 없는 사람이야’라는 사고에 대한 인지적 재구성의 과정이 필요할 것으로 판단되어 이미지 재구성 I 을 통해 다음과 같이 개입을 진행하였다.

[이미지 재구성 I: 과거 대인외상]

F참여자: (1단계에서 부모님의 이혼으로 모가 갑작스럽게 집을 떠나는 외상경험을 심상으로 얘기함)

연구자: 엄마가 떠나는 모습을 보면서 어린 F는 무슨 생각을 하였나요?

F참여자: 엄마가 나를 버리네. 나를 낳아준 엄마에게도 사랑받지 못해서 버림 받네. 이런 나를 누가 좋아할까. 진짜 나는 사랑받을 만하지 않으니까 버림 받은 거고, 진짜 나는 가치 없다. 그러니까 엄마도 나를 버렸겠지.

(중략: 2단계에서 성인의 관점으로 심상을 떠올림)

연구자: 성인의 관점에서 보니까 지금 상황이 어떻게 보이세요.

F참여자: 사정이 있었던 것 같아요. 말 못할 사정이. 오죽했으면 어린 애를 놓고 집을 나가고 그랬을까... 엄마의 마음이 정말 조금 아주 조금 이해가 간다... 진짜 버릴 거였으면 나중에 아예 연락도 오지 않았겠죠. 그래도 밍다. 엄마가 미워요... (Weeping)

(중략)

연구자: 1단계에서는 F님이 아닌 다른 것들에 예를 들어, 엄마나 주변 환경에 초점이 맞추어져 있다면 2단계에서는 F님에게 초점을 맞춰서 생각, 기분을 잘 얘기하고 있어요. 특히, F님이 어린 아이에게 하는 말과 행동을 듣고 정말 많은 사랑을 주고 싶어 한다는 생각이 들었어요. 제 생각이 맞나요?

F참여자: 네. 이거하면서 계속 드는 생각이 내가 저 불쌍한 어린 아이를... 나 자신을 사랑해줘야 한다. 내가 나를 사랑해야지 다른 사람도 나를 좋아하고, 사랑해주지 않을까 그래야지 나도 가치가 있는 사람이... 사랑받을만한 사람이 되지 않을까?란 생각이 들었어요.

연구자: 1단계에서는 나를 낳아준 엄마조차도 나를 버렸기 때문에 나는 사랑받을만하지 않고 가치 없는 사람이라고 생각하셨는데 지금은 말씀을 들어보니 처음의 생각과 많이 바뀐 것 같은데 맞을까요?

F참여자: 네. 제가 어린 나를 안아주고, 위로해주고 되게 사랑스럽고, 아기처럼 귀하게 대해줬더니 제가 저를 보는 관점이 바뀌었어요. 내가 나 자신을 사랑해 주어야 한다는 말이 뭔지 한 번에 와 닿고 그 뜻이 이제야 이해가 돼요. 이런 이해만으로도 내가 진짜 나를 정말 생각해주고, 사랑해주는 방법이 아닐까요? 저는 그래도 하나밖에 없는데... 저 자체로 가치가 있다고 생각해요.

이미지 재구성 I 를 통해 F참여자는 “제가 어린 나를 안아주고, 위로해주고 되게 사랑스럽고, 아기처럼 귀하게 대해줬더니 제가 저를 보는 관점이 바뀌었어요. 내가 나 자신을 사랑해 주어야 한다는 말이 뭔지 한 번에 와 닿고 그 뜻이 이제야 이해가 돼요. 이런 이해만으로도 내가 진짜 나를 정말 생각해주고, 사랑해주는 방법이 아닐까요? 저는 그래도 하나밖에 없는데... 저는 저 자체로 가치가 있다고 생각해요.” 등의 사고의 전환으로 흑백논리 사고에서 벗어났다.

(2) 대인 지각 관련 인지 내용의 변화

① 과잉일반화

과잉일반화는 부정적인 하나의 사건 혹은 하나 이상의 별개의 사건들을 가지고

결론을 도출하여 이러한 결론을 모든 사건, 인물, 상황에 비논리적으로 확장시켜 적용하는 인지적 오류이다. 참여자들의 경우 초기 대인외상경험으로 인해 타인에게 깊은 상처를 받게 되면서 대인 지각에 있어 가해자에 대한 부정적인 인식을 다른 관련 없는 사람들에게까지 적용하였다. 특히, 대인 지각에 있어 부정적인 인식이 발생하면 이때부터 타인과의 상호작용이나 외부 현실과의 접촉이 감소될 확률이 크기 때문에 이러한 사고가 더 굳어지게 된다. 결국, 타인과의 관계에서 직접 증거를 점검하거나 확인하기 보다는 혼자서 생각하고, 판단하는 경향으로 이러한 강화된 사고와 태도가 관계적 어려움과 스트레스를 야기한다. 따라서, 이러한 관계적 스트레스는 우울, 불안 및 분노와 같은 부정 감정에 영향을 미쳐 폭식까지 연결된다. 참여자들의 경우 초기 대인외상경험의 가해자와 연결하여 다른 사람을 믿지 못하는 인지 오류를 보였으며 이러한 과잉일반화 사고의 내용은 <표 VI-42>에 제시하였다.

<표 VI-42> 대인외상경험의 대인 지각과 관련된 과잉일반화 사고의 변화 내용

참여자	부적응적 사고	⇨	적응적 사고
D	(과거 왕따 경험으로) 다른 사람들은 믿을 수 없어. 내가 맞춰주지 않거나 혹시라도 거슬리게 한다면 언제라도 쉽게 돌변해서 나에게 상처 줄 거야		지금 너의 주변 사람들도 앞으로 만날 사람들도 그때의 개네들과 똑같은 사람들이 아니야 이제는 잘못된 판단은 내려두고 앞으로의 만남들에서 네 마음도 잘 표현하고 너도 다른 사람도 상처주지 않는 괜찮은 관계들을 만들어 나갈 수 있게 노력해보자
G	다른 사람들은 모두 나를 싫어하기 때문에 나는 다른 사람들과 있을 때 절대 편안할 수 없을 거야		반 아이들 모두가 너를 싫어해서 왕따 시킨 건 아닐 거야. 너가 모든 사람들을 다 싫어하거나 다 좋아할 수 없듯이 어떻게 모든 사람들이 너를 싫어할 수 있겠어 말도 안 돼 나도 어렸을 때 왕따 당한 적 있었는데 지금 돌이켜 생각해 보면 주동자가 있었고 아직 모두 어리고 미숙하기 때문에 분위기에 휩쓸려서 동참한 아이들도 있었다는 생각이 들어.

			앞으로 너는 커가면서 많은 사람들을 만날 건데 너를 괴롭히던 애들하고는 다른 사람들이야 그니까 절대 똑같다고 생각해서 오해하지 말고 너 스스로를 혼자 가두지마 이제 너도 다른 사람들과 있을 때 충분히 편안할 수 있어 이미 경험했으니까
--	--	--	---

가. D참여자의 사례

D참여자의 경우, 초기 대인외상인 왕따 경험으로 인해 다른 사람들을 믿지 못하고, 타인의 평가에 민감하며 자기주장을 하는 것과 거절하는 것에 어려움을 겪었다. 따라서, 연구자는 D참여자가 사고하는 ‘다른 사람들은 믿을 수 없어. 내가 맞춰주지 않거나 혹시라도 거슬리게 한다면 언제라도 쉽게 돌변해서 나에게 상처 줄 거야’라는 과잉일반화 사고에 대한 인지적 재구성의 과정이 필요할 것으로 판단되어 이미지 재구성 I을 통해 다음과 같이 개입을 진행하였다. 개입 시 D참여자가 어린 시절의 초기 대인외상경험에서 겪었던 일반적이지 않은 타인과의 관계를 보편적으로 생각하는 관점에서 당시 상황과 관계가 예외적이었음을 인식할 수 있도록 하는 것에 초점을 맞춰 소크라테스 기법을 사용하여 D참여자의 과잉일반화 사고를 수정시켰다.

[이미지 재구성 I: 과거 대인외상]

연구자: 이번에는 2단계예요. 어른이 된 OO 씨가 1단계 장면으로 들어갈 거예요. 어떻게 보이세요?

D참여자: 엘리베이터 안에서 어린 제가 혼자 문이 안 닫히게 열림 버튼을 누르고 있고, 그 친구랑 나머지 친구들이 분명히 저랑 눈이 마주쳤는데 혼잣말로 제 욕을 하는 것 같고 어린 저를 무시하고 계단으로 내려갔어요. 1층으로 가서 다시 만났는데 개네들끼리 뭉쳐있고 제 욕을 하고, (Weeping, pause) 저는 떨어져서 혼자 서있어요...

연구자: 어린 OO이를 보니까 어떤가요?

D참여자: (Weeping) 불쌍하고 화가 나고 너무 안쓰러워요

연구자: 어린 OO이에게 하고 싶은 말이나 도와주고 싶은 행동이 있나요?

D참여자: 어린 나를 막아서고 그 친구들한테 “뭐하는 거야! 친구한테! 사람을 대하는 태도가 아주 바닥이구나. 너네들 진짜 이상하다 이게 보통의 친구관계 같니?” 이렇게 말하고 어린 나한테 내가 지켜줄 테니까 재네한테 하고 싶은 말 다 하라고 할 거예요. 그동안 마음속에 쌓인 말 다 하라고 기회를 만들어 줄 거예요.

연구자: 어린 OO이가 OO 씨 덕분에 하고 싶은 말을 다 해볼 수 있는 기회가 생겼어요. 지금부터 충분히 표현해보면 좋겠네요.

(중략)

연구자: 어린 OO이를 위해 더 해주고 싶은 말이나 행동이 있나요?

D참여자: 네. 개네들한테 대체 왜 그런지 물어보고 어린 나랑 같이 놀기 싫다든지 이런 걸 차라리 확실하게 좀 표현해줘서 이 관계를 좀 차라리 정리하게끔 포기하게끔 하고 싶어요. 그리고 어린 나한테 친구를 좀 잘 골라서 사귀고 네가 싫은 건 오늘 한 것처럼 다른 사람들에게 싫다고 표현하고 이런 행동은 좀 안 해줬으면 좋겠다고 표현하고 지금부터 안 하면 성인이 돼서도 스트레스 받을 일이 많이 생겨서 계속 먹는 걸로 푼다고 그런 어른이 되고 싶냐고 말해주고 싶어요.

연구자: 그렇게 말하고 나니까 어린 아이의 반응이 어떤가요? 기분이라든지...

D참여자: 조금 당황한 것 같은데... 그래도 웃으면서 그러겠다고 대답했어요.

연구자: 혹시 더 해주고 싶은 말이나 행동은요?

D참여자: 정말 해주고 싶은 말은 더 이상 관계에서 눈치 보면서 두려워하거나 무서워하지 말고 의견을 얘기하라고 말해주고 싶어요. 이런 친구관계는 정상이 아니니까 그냥 좀 어린 나이에 일찍 액땜했다고 생각하고 너는 나한테만큼은 소중한 존재이기 때문에 아무도 너를 무시하거나 함부로 대할 수 없다고 그렇게 만들지 말라고 얘기해주고 싶어요.

연구자: 어린 OO이가 겪었던 친구 관계는 일반적이지 않기 때문에 앞으로 만나는 다른 사람들과의 관계에서 그 친구들처럼 다른 사람들이 어린 OO이를 함부로 대하지 않을 거라는 걸 함부로 상처 줄 수 없다는 걸 다시 한 번 OO이에게 말해줄 수 있을까요?

D참여자: 네. 개네들이 나쁜 거고 이상한 애들이었어. 빨리 액땜했다고 생각하자 저 관계는 비정상적이야 무조건 한쪽만 맞춰주는 관계는 좋은 친구관계가 아니야

넌 이제 저 일로 인해서 좋은 친구를 사귀는 눈이 한층 더 생긴 거야

연구자: 그렇게 확실하고 진심 어리게 얘기를 해주니까 이 어린아이의 반응은 어떤가요?

D참여자: 다 이해하진 못한 것 같은데... 표정 보니까 공감한 것 같아요.

연구자: 만약 어린 OO이가 이 일로 인해서 어른이 되어서도 다른 사람들을 믿지 못하고, 계속 맞춰줘야 한다고 생각하거나 사람들이 또다시 자신을 상처 줄 것 같아서 거절도 못하고 의사표현도 못하고 그런다면 어떨 것 같나요? 어린OO이에게 혹시 해주고 싶은 말이 있다면 해주세요.

D참여자: 생각만 해도 안쓰럽네요... (pause) 음... 아이에게... 있잖아 왕따 당했던 일이나 왕따 시켰던 애들과 연결해서 앞으로 만날 사람들을 선불리 판단하지 말았으면 좋겠어 모든 사람들을 다 믿을 수도 없고 믿기도 힘들겠지만 괜찮아 너는 이제 이 일을 겪으면서 사람 보는 눈이 좀 더 생겼고, 또다시 인간관계에서 상처받았다고 해도 다르게 생각하면 또 다른 좋은 사람을 보는 눈이 더 생긴 거니까 그니까 그때의 일과 잘못된 관계로 앞으로의 네가 만날 어쩌면 괜찮을 사람들을 놓치지 않았으면 좋겠어.

연구자: 그때의 경험으로 모든 사람들을 똑같이 부정적으로 판단하고 믿지 못해서 상처받지 않으려고 다 맞춰준다고 해서 상처받지 않는 건 아니라고 이런 말들을 해 줄 수 있을까요?

D참여자: 네... OO아 네가 그때의 잘못된 관계로 다른 사람들을 믿지 못하고 그때처럼 상처받지 않으려고 다 맞춰주면서 너는 상처받지 않고 있다고 생각하겠지만 사실 너가 너에게 계속 상처주고 있는 거야... 지금 너의 주변 사람들도 앞으로 만날 사람들도 그때의 개네들과 똑같은 사람들이 아니야 이제는 잘못된 판단은 내려두고 앞으로의 만남들에서 네 마음도 잘 표현하고 너도 다른 사람도 상처주지 않는 괜찮은 관계들을 만들어 나갈 수 있게 노력해보자 내가 도와줄게

이미지 재구성 I 를 통해 D참여자는 중요한 어린 시절 기억을 생생하게 재경험하면서 그 안에 내포되어 있는 타인에 대한 부적응적인 사고 및 신념을 새로운 관점에서 보게 되었다. 따라서, “지금 너의 주변 사람들도 앞으로 만날 사람들도 그때의 개네들과 똑같은 사람들이 아니야 이제는 잘못된 판단은 내려두고 앞으로의 만남들에서 네 마음도 잘 표현하고 너도 다른 사람도 상처주지 않는 괜찮은 관계들을 만들어 나갈 수 있게 노력해보자” 등의 사고확장 및 합리적인 사고의 전환으로 과거의 경험으로 인한 과잉

일반화 사고에서 벗어나 현재와 미래의 적응적인 관계들을 위해 노력하는 것에 초점을 맞춰 자신감을 찾으려는 모습이 관찰되었다. 이러한 사고의 전환은 D참여자로 하여금 과거의 대인외상 사건이 예외적이고, 보편적이지 않은 상황임을 인식하게 됨으로써 앞으로의 건강한 대인관계를 형성하는 적응적인 사고의 기반이 될 것으로 예상된다.

나. G참여자의 사례

G참여자의 경우에도, 초기 대인외상인 왕따 경험으로 인해 다른 사람들은 모두 자신을 싫어하고, 다른 사람과의 관계는 자신을 불편하게 해서 절대 편안할 수 없다고 생각하였다. 이로 인해 과거의 일이 계속적으로 영향을 미치며 현재에도 타인의 표정과 의도를 왜곡하는 경향이 있었다. 따라서, 연구자는 G참여자가 사고하는 ‘다른 사람들은 모두 나를 싫어하기 때문에 나는 다른 사람들과 있을 때 절대 편안할 수 없을 거야’라는 과잉일반화 사고에 대한 인지적 재구성의 과정이 필요할 것으로 판단되어 이미지 재구성 I 을 통해 다음과 같이 개입을 진행하였다. 개입 시 G참여자가 어린 시절의 초기 대인외상경험에서 겪었던 따돌림 경험과 따돌림 시켰던 아이들의 태도를 다른 관련 없는 관계들까지 일반화시키는 것을 인식할 수 있도록 하는 것에 초점을 맞춰 소크라테스 기법을 사용하여 G참여자의 과잉일반화 사고를 수정시켰다.

[이미지 재구성 I: 과거 대인외상]

연구자: 어른이 된 OO 씨가 방금 앞의 장면에 들어가 볼게요. 아까 말씀하신 갈색 바닥에 왁스칠 냄새가 가득 나는 추운 교실에 성인이 된 OO 씨가 보이시나요?
어때보이나요?

G참여자: 네 화난 얼굴로 어린 아이 앞에 막아섰어요.

연구자: 반 아이들 때문에 화가 많이 났나보네요. 지금 OO 씨 몸은 어떻게 느껴지세요?
가장 크게 느껴지는 부위라든지.

G참여자: 너무 화가 나서 몸 전체가 떨리고 손에서 제일 많이 느껴져요.

연구자: 어른인 OO 씨가 어린 OO이를 보니까 어떤가요?

G참여자: 아이는 너무 안쓰럽고 불쌍하고 저는 계속 화가 나고 괴롭힌 애들을 때려주고 싶어요.

연구자: 어린 OO이의 기분은 어떤가요?

G참여자: 모르겠어요... 굳어있긴 한데 화가 난건지 슬픈 건지

연구자: 어린 아이의 얼굴이나 몸에 집중해 볼까요? 표정이 어때요?

G참여자: 표정은 잘 모르겠어요. 모르는 굳은 표정. 몸은 많이 떠는 것 같은데 저랑은 다르게... (pause) 심하게 불안한 것 같아요... 어떡해... (Weeping) 이렇게 불안 해하는지 몰랐어요...

연구자: 심하게 불안해서 떨고 있는 어린 OO이의 불안의 강도는 0~10 중에 어느 정도인가요?

G참여자: 10이요. 너무 많이 불안해해요...

연구자: 불안에 떨고 있는 어린 OO이를 위해 해주고 싶은 말이나 행동이 있을까요?

G참여자: 일단 담요를 덮어줘서 따뜻하게 해주고 제가 안아준 다음 손으로 등을 쓸어 내리면서 내가 있으니까 괜찮다고 얘기해주고 싶어요. 안정될 때까지 계속...

연구자: 어린 OO이를 위해서 따뜻하게 담요도 덮어주고, 안아주고, 손으로 등도 쓸어 내리면서 다 괜찮다고 계속 얘기해주었어요. 지금 OO이의 기분과 강도는 어떤가요?

G참여자: 아직 교실 안이라서 불안하기는 한데 지켜주는 어른이 있으니까 6점 정도예요.

연구자: 혹시 아이의 불안이 더 낮춰지도록 OO이를 위해 하고 싶은 말이나 행동이 있으신가요?

G참여자: 네. 괴롭힌 친구들을 다 모아서 OO이가 보는 앞에서 혼내주고 “친구를 괴롭히는 건 나쁜 짓이야!!”라고 소리치고 꿀밤 한 대씩 때려주고 엎드려 뺄쳐 한 다음에 반성하는 애들이 있으면 OO이에게 직접 진심 어리게 사과시킬 거예요. 한명씩

(중략)

연구자: 그럼 이제는 어떤 말과 행동을 해야지 OO이의 기분이 더 나아져서 만족하거나 편안해질까요?

G참여자: 제일 심하게 괴롭혔던 그 주동자 남자아이를 강제전학 시키고 다시는 우리 동네에 발도 못 붙이게 하면 좋겠어요. 이제 그 아이와는 다시는 만날 일이 없게 이제 반 친구들이랑 맛있는 과자도 같이 먹고 놀이터 가서 같이 놀고 같이 웃고 이러면 너무 즐겁고 편안할 것 같아요.

연구자: 그렇게 해본다면 어떤가요?

G참여자: 아이의 표정이 한결 편안해 보이고 행복해 보여서 이제 제가 좀 마음이 놓여

요. 이제 잘 클 것 같아요. 제 마음이 뿌듯하고 만족스러워요. 아이가 행복해 보여요.

연구자: 정말 다행이네요. 어린 OO이가 원래는 교실에서 항상 불안해하고 나중에는 학원에서도 그렇고 점점 다른 사람들과 있을 때 긴장하고 불안해했었잖아요. 그 불안을 일으킨 생각이 ‘다른 사람들은 나를 싫어하고, 나는 다른 사람들과 있을 때 절대 편안할 수 없을 거야’였어요. 그런데 지금은 교실에서 아이들이 많은데도 편안함을 느끼고 있는 것처럼 보여요. 맞나요?

G참여자: (Pause) 네... 그러네요. 저도 다른 아이들과도 있어도 편안할 수도 있네요...

연구자: 혹시 어린 OO이가 앞으로 좀 더 잘 커나갈 수 있게 다른 사람과의 관계에서 편안함을 느끼게 하려면 어떻게 해야 한다고 말해주고 싶은 부분이 있으신가요?

G참여자: 네... 정말 해주고 싶은 말이 있어요. OO아 반 아이들 모두가 너를 싫어해서 왕따 시킨 건 아닐 거야. 너가 모든 사람들을 다 싫어하거나 다 좋아할 수 없듯이 어떻게 모든 사람들이 너를 싫어할 수 있겠어 말도 안 돼 나도 어렸을 때 왕따 당한 적 있었는데 지금 돌이켜 생각해보면 주동자가 있었고 아직 모두 어리고 미숙하기 때문에 분위기에 휩쓸려서 동참한 아이들도 있었다는 생각이 들어. 나는 이 일로 오랫동안 사람들이 속으로 나를 싫어하고 미워해서 다른 사람과 있을 때 항상 불안하고 긴장감만 느꼈었는데 너는 그러지 않았으면 좋겠어.

연구자: 어린 OO에게 괴롭히던 아이들과 앞으로 네가 만날 사람들과는 다르다고 더 이상 너의 삶에 영향을 미칠 수 없다고 얘기해 줄 수 있을까요?

G참여자: 네. 앞으로 너는 커가면서 많은 사람들을 만날 건데 너를 괴롭히던 애들과고는 다른 사람들이야 그니까 절대 똑같다고 생각해서 오해하지 말고 너 스스로를 혼자 가두지마 이제 너도 다른 사람들과 있을 때 충분히 편안할 수 있어 이미 경험했으니까

연구자: 혹시 어린 OO이에게 편안함과 관련해서 또 해주고 싶은 말이 있다면 해볼까요?

G참여자: 네... OO아 너는 정말 귀하고 소중한 존재야. 다른 사람이 아닌 너에게 집중하고 잘 돌봐주면 다른 사람들도 너를 절대 함부로 대하지 못할 거야 이제 너는 다른 사람과 있어도 편안함을 느낄 수 있는 사람이야 이제 너를 불안하게 했던 아이도 상황도 없어 더 이상 사람 때문에 불안해하지 말고 지금처럼 친구들과 같이 어울리고 행복했으면 좋겠어. 내가 그렇게 할 수 있도록 옆에서

지켜봐주고 돌봐줄게. 늦어서 미안하고 지금까지 잘 견뎌줘서 고마워

이미지 재구성 I 를 통해 G참여자는 과거 대인외상경험에 대한 이미지를 떠올리며 기억속의 사건과 이미 연합되어 있는 감정을 다시 생생하게 재경험하게 되었다. 이러한 연합된 과거의 높은 불안 감정을 지속적으로 낮춰주고 난 뒤 소크라테스 기법을 통해 인지재구조화하며 타인과 관련된 부적응적인 사고 및 신념을 효과적으로 수정시켰다. 따라서, “반 아이들 모두가 너를 싫어해서 왕따 시킨 건 아닐 거야. 너가 모든 사람들을 다 싫어하거나 다 좋아할 수 없듯이 어떻게 모든 사람들이 너를 싫어할 수 있겠어 말도 안 돼 나도 어렸을 때 왕따 당한 적 있었는데 지금 돌이켜 생각해보면 주동자가 있었고 아직 모두 어리고 미숙하기 때문에 분위기에 휩쓸려서 동참한 아이들도 있었다는 생각이 들어.” 등의 사고확장 및 유연한 사고로 전환되어 과거의 대인외상사건과 관련된 타인에 대한 과잉일반화 사고에서 벗어났다.

2) 폭식(자기 지각, 대인 지각) 관련 인지 내용의 변화 분석

이미지 재구성 인지행동치료 프로그램의 참여자들은 대인외상경험과 관련된 부적응적인 사고 및 비합리적인 핵심신념이 두드러졌고, 이를 적응적으로 처리하지 못하여 폭식을 하거나 혹은 폭식 이후에 다시금 이에 대한 왜곡된 사고를 하며 또다시 폭식을 하는 악순환이 반복되었다. 따라서, 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램을 통해 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성들의 폭식 전·후로 자신, 타인과 관련된 부적응적인 사고 및 신념을 합리적으로 평가하고 수정하는 과정을 연습하면서 자신이 처한 상황을 객관적으로 바라보고, 상황을 재인식 할 수 있게 되며 적응적인 사고로 수정하게 되었다. 프로그램 내에서 폭식과 관련된 왜곡된 사고는 자기 지각, 대인 지각으로 분류하였다. 공통적인 오류를 보인 인지적 오류(Cognitive Error)의 패턴은 범주화하여 기술하였고, 범주화한 내용은 <표 VI-43>에 제시하였다.

<표 VI-43> 실험집단의 폭식 관련 인지적 오류 범주 분류

범주명		범주기술		구체적 예시
폭식	자기지각	자기비난	근거가 전혀 없음에도 사건에 대해 자신과 연관시켜 과도하게 비난하는 것	‘폭식은 제가 얼마나 어리석고 형편없는 실패자인지 보여주는 것 같아요’
		흑백논리	자신이나 다른 사람에 대한 판단이 양극단적이며 상반된 두 개의 범주 중 하나로만 생각하는 것	‘다른 사람들은 식단조절에 운동에 다 절제하면서 열심히 사는데 나는 계속 먹기만 하고, 내 인생은 완전히 망했어.’
	대인지각	독심술	타인의 마음을 마치 자신이 다 아는 것처럼 믿는 것	‘친구가 웃으면서 걱정하는 말투로 그만 먹으라고 했지만 속으로는 나를 비웃으면서 깔보겠지.’

(1) 자기 지각 관련 인지 내용의 변화

① 자기비난

대인외상경험과 마찬가지로 폭식장애경향자들은 외상경험으로 인해 자기 지각에 대한 인지적 왜곡이 있으며 부정적인 자기개념은 자신과 관련 없거나 혹은 관련이 적은 사건에 대해 자신과 연결시켜 과도하게 비난한다. 실험집단의 참여자들은 폭식과 자신을 연결 지어 비난하는 사고들을 보였으며 내용은 <표 VI-44>에 제시하였다.

<표 VI-44> 폭식과 관련된 자기비난 사고의 변화 내용

참여자	부적응적 사고	⇨	적응적 사고
B	폭식은 제가 얼마나 어리석고 형편없는 실패자인지 보여주는 것 같아요.		폭식은 그냥 나 지금 스트레스 엄청 받았어! 이렇게 말해주는 신호 같은 거지 제가 실패자라는 증거를 보여주는 건 아니에요.

C	저처럼 조절 못하고 폭식하는 게 정상은 아니잖아요? 무능한 사람이니까 할 수 있는 게 별로 없어서 계속 폭식하는 것 같아요.	관점을 나는 무능력한 사람이라 먹는 것도 조절하지 못한다는 생각에서 너무 그렇게는 아니네? 내가 먹는 걸 조절했던 적도 있긴 있었네. 어떻게 그랬는지 평소와 뭐가 달랐는지 방법을 찾아봐야겠다는 생각이 들고, 내가 그렇게 무능한 사람만은 아니구나... 맞아 나 기본적인 것들은 그래도 조절해서 해낸 것들도 있었지 라는 생각이 들었어요.
---	---	--

가. B참여자의 사례

B참여자의 경우, 낮은 자존감과 지나친 자기비난으로 폭식하는 자신에 대해 ‘실패자’라고 말하며 폭식하는 행위에 대해 자신이 얼마나 어리석고 형편없는 사람인지를 나타내는 증거라고 하였다. 따라서, 연구자는 B참여자가 생각하는 ‘폭식은 내가 얼마나 어리석고 형편없는 실패자인지 보여주는 것’이라는 자기비난적 사고에 대한 인지적 재구성의 과정이 필요할 것으로 판단되어 이중기준 점검 기법 및 소크라테스식 기법을 통해 다음과 같이 개입을 진행하였다. B참여자는 폭식으로 자기 자신을 평가하는 기준이 다른 사람을 평가할 때의 기준과 달라서 이러한 이중 잣대를 인식할 수 있도록 하여 자기비난 사고를 수정시켰다.

B참여자: 폭식은 제가 얼마나 어리석고 형편없는 실패자인지 보여주는 것 같아요.

연구자: 그렇다면 폭식하는 사람은 모두 형편없는 실패자일까요?

B참여자: 네? 아니요. 폭식하는 저만요. 다른 분들은 아니에요.

연구자: 그럼 여기계신 다른 분이 B님과 똑같이 말한다면 어떨 것 같으세요?

B참여자: 한편으로는 많이 이해가 가면서도 왜 저렇게까지 생각하지? 이럴 것 같아요.
폭식이 실패자라는 걸 보여주는 건 아닌데...

연구자: 맞아요. 폭식 자체가 그 사람의 어리석음, 형편없음, 실패자라는 걸 보여주는 근거가 되기는 어렵잖아요. 그런데 B님은 폭식하는 자신은 실패자라고 생각하면서 다른 사람이 그렇게 생각한다고 하니까 대답이 좀 달랐어요. 뭔가 자신

에게만 엄격하고, 평가하는 잣대가 달라지는 것 같아요. 똑같진 않네요. 어때요? B님이 생각하시지요.

B참여자: 그런 것 같네요. 생각해보니까 저는 평소에도 저랑 다른 사람을 평가하는 기준이 좀 다른 것 같아요. 처음에 폭식하는 사람은 모두 실패자나고 물어보셨을 때 당황했어요. 좀 놀랐어요.

연구자: 아마 그런 기분들을 느낀 이유가 있을 거예요. 어떤 이유였을까요?

B참여자: 그... 내가 다른 사람들을 일부러 나쁘게 몰아가는 것 같다? 다시 생각해보면 제가 일부러 저한테만 나쁜 말로 상처 주는 것 같은데요?

연구자: 그렇다면 나와 다른 사람을 똑같은 잣대로 평가한다면 폭식하는 건 어떤 걸 의미하는 것 같으세요? 그니까 어떤 행동인 것 같으세요? 행동자체로

B참여자: 폭식은 그냥 스트레스를 많이 받아서 먹는 걸로 푸는 행동인 것 같아요.

연구자: 그럼 폭식은 내가 형편없는 실패자라는 증거를 보여주는 게 아니라 그냥 단지 스트레스를 많이 받아서 많이 먹는 행동이네요?

B참여자: 네 맞아요. 폭식은 그냥 나 지금 스트레스 엄청 받았어! 이렇게 말해주는 신호 같은 거지 제가 실패자라는 증거를 보여주는 건 아니에요.

이중기준 점검 기법 및 소크라테스식 기법을 통해 B참여자는 “폭식은 그냥 스트레스를 많이 받아서 먹는 걸로 푸는 행동인 것 같아요.”, “폭식은 그냥 나 지금 스트레스 엄청 받았어! 이렇게 말해주는 신호 같은 거지 제가 실패자라는 증거를 보여주는 건 아니에요.” 등의 사고로 전환시켜 자기비난 사고에서 벗어났다.

나. C참여자의 사례

C참여자의 경우에도, 낮은 자존감과 지나친 자기비난으로 폭식하는 자신에 대해 ‘무능력자’라고 칭하며 폭식을 벗어나기 위한 능력이 없기 때문에 계속적으로 폭식을 한다고 하였다. 따라서, 연구자는 C참여자가 생각하는 ‘폭식은 내가 무능하기 때문에 하는 것’이라는 사고에 대한 인지적 재구성의 과정이 필요할 것으로 판단되어 관점취하기 및 소크라테스식 기법을 통해 다음과 같이 개입을 진행하였다. C참여자에게는 동일한 문제를 경험하고 있는 친구에게 해줄 수 있는 조언을 생각하게 하여 스스로 자신의 상황을 다른 조망에서 볼 수 있도록 인식하여, 사고를 수정하도록 도왔다.

C참여자: 저처럼 조절 못하고 폭식하는 게 정상은 아니잖아요? 무능한 사람이니까 할 수 있는 게 별로 없어서 계속 폭식하는 것 같아요.

연구자: C님이 말씀하신 무능한 사람은 어떤 사람이에요?

C참여자: 예를 들어, 음식을 먹을 때 조절하지 못해서 폭식하는 사람이에요. 얼마나 조절력이 없으면 먹는 것조차 조절을 못하는지... 한심하기도 하네요.

연구자: 저희 파배기 풀기에서 다른 사람 관점취하기에서 배웠었잖아요. 그때 말씀하셨던 같이 국수 먹던 그 친구 분을 떠올려볼까요? 그 친구 분은 폭식한 것에 대해서 어떻게 생각할 것 같아요?

C참여자: 글썄요. 그 친구라면... 근데 이 친구가 원래 폭식하는 친구가 아니라서 별로 심각하게 생각 안 할 것 같아요.

연구자: 심각하게 생각 안 하면 어떻게 다르게 생각할 것 같으세요? 폭식하면 무능한 사람이라고 생각할 것 같으세요?

C참여자: 아니요. 그 친구라면... 내가 좀 힘든 일이 있었나? 좀 스트레스 받았나? 폭식하면 폭식한 거지 무능한 사람까지 생각하는 건 완전 오바 아니야?

연구자: 그럼 만약 그 친구 분에게 나는 폭식을 했고, 음식 조절을 못해서 조절하지 못하는 내가 너무 무능력해 보인다. 나는 무능하다. 라고 얘기한다면 그 친구가 뭐라고 말해줄 것 같으세요?

C참여자: 아마 이렇게 말해줄 것 같아요. 실제로 어느 부분은 친구가 저에게 비슷하게 말해준 적도 있어요. 너는 음식 조절만 못해서 그렇지 그 외에는 조절하는 게 정말 많아. 우리 사이가 이렇게 계속 잘 지낼 수 있는 것도 너가 잘 조절하는 부분들이 있어서 그런 걸 거야. 그리고 조절을 잘 못해서 정말 무능력했다면 너는 학교 졸업도 못했고, 취업도 못했어.

연구자: 그럼 혹시 실제로 음식 외에 조절을 해본 것들이 있다면 한 번 찾아볼까요? 학교 졸업이나 취업도 살면서 조절을 잘 해야지 해낼 수 있잖아요.

C참여자: 프로그램에 시간 맞춰서 참여하는 것도 맞을까요?

연구자: 그렇죠. 저도 그 생각했는데 혹시 이 얘기가 안 나온다면 말씀드리려고 했어요. 프로그램 하는 시간도 저녁이나 주말이라서 평일에는 일 다녀와서 얼마나 힘들고 쉬고 싶은데 그걸 조절해서 참고 참여하는 거겠어요. 주말 참여는 말할 것도 없네요. 그리고 폭식을 조절하기 위해서 프로그램에 신청해서 지금까지 잘 참여하시면서 노력하는 것만 봐도 조절하지 못하는 무능한 사람은 절대

아니에요. 저희는 아직 초반이라서 그렇지 점점 배우면서 해볼 수 있는 것들이 늘어날 거고, 잘 참여하면서 노력해주시면 폭식도 점점 줄어들 거예요.

C참여자: 감사합니다. 생각해보니까 제가 음식만 조절 못해서 그렇지 그렇게 아무거나 다 조절하지 못하는 사람은 아닌 것 같아요.

연구자: 맞아요. 그리고 섭식일지 보시면 실제로 먹는 걸 조절했던 적도 있어요. 그때는 어떻게 잘 조절할 수 있었는지 이유를 생각해 보세요. 관점취하기랑 연결해서 처음에는 음식 먹는 것을 조절하지 못해서 무능력했다면 지금은 어떤 생각이 드세요?

C참여자: 네. 관점을 나는 무능력한 사람이라 먹는 것도 조절하지 못한다는 생각에서 너무 그렇게는 아니네? 내가 먹는 걸 조절했던 적도 있긴 있었네. 어떻게 그랬는지 평소와 뭐가 달랐는지 방법을 찾아봐야겠다는 생각이 들고, 내가 그렇게 무능한 사람만은 아니구나... 맞아 나 기본적인 것들은 그래도 조절해서 해낸 것들도 있었지 라는 생각이 들었어요. 그리고 연구자님이 폭식에 대한 새로운 방법도 알려주신다니까 더 배워서 해보고 싶어요.

관점취하기 및 소크라테스식 기법을 통해 C참여자는 “생각해보니까 제가 음식만 조절 못해서 그렇지 그렇게 아무거나 다 조절하지 못하는 사람은 아닌 것 같아요.”, “관점을 나는 무능력한 사람이라 먹는 것도 조절하지 못한다는 생각에서 너무 그렇게는 아니네? 내가 먹는 걸 조절했던 적도 있긴 있었네. 어떻게 그랬는지 평소와 뭐가 달랐는지 방법을 찾아봐야겠다는 생각이 들고, 내가 그렇게 무능한 사람만은 아니구나... 맞아 나 기본적인 것들은 그래도 조절해서 해낸 것들도 있었지 라는 생각이 들었어요. 그리고 연구자님이 폭식에 대한 새로운 방법도 알려주신다니까 더 배워서 해보고 싶어요.” 등의 사고로 전환시켜 자기비난 사고에서 벗어났다.

② 흑백논리

자신에 대한 판단이 두 개의 범주 중 하나로 분류되는 것으로 이러한 판단이 양극단적이며 상반된 두 개의 범주 중 부정적인 범주에 자신을 국한시켜 생각하는 것이다. 실험집단의 참여자들은 폭식과 자신을 연결 지어 부정적인 범주로 판단하는 사고들을 보였으며 이러한 내용은 <표 VI-45>에 제시하였다.

<표 VI-45> 폭식과 관련된 흑백논리 사고의 변화 내용

참여자	부적응적 사고	⇒	적응적 사고
E	다른 사람들은 식단조절에 운동에 다 절제하면서 열심히 사는데 나는 계속 먹기만 하고, 내 인생은 완전히 망했어		그래프에 놓고, 점수에 대한 조건들을 하나씩 따져보니까 인생이 완전히 망한 것도 아니라는 생각이 들고, 그래도 내가 중간은 하는구나 라는 생각에 조금의 안도감이 든다고 해야 하나? 그렇기도 하고 좀 웃긴 건 먹는 걸 절제하지 못했다고 해서 인생이 망했다고 생각한 것 자체가 맞지도 않은 것 같아서 제가 왜 그렇게 생각했는지 모르겠어요.
F	폭식도 못 멈추는 나는 무능한 사람이야		폭식을 멈추지 못하는 건 무능한 사람이라기보다는 그냥 절제에 어려움이 있는 사람? 도움이 필요한 사람이에요. 아무튼 무능하진 않은 것 같아요. 왜냐하면 무능하면 뭔가 능력이 없는 거라서 배워도 어떻게 해보지 못하는 사람인데 아까 연구자님께서 저는 그래도 해봤다고 알려주셔서 아무것도 못하는 무능한 사람은 아닌 것 같아요.

가. E참여자의 사례

E참여자의 경우, 평소 감정 억압을 중요하게 생각하는 만큼 절제를 중요시하는 편인데 폭식에서 만큼은 절제하지 못하는 자신을 타인과 비교하며 다른 사람들은 먹는 것을 절제하면서 운동까지 열심히 하는 반면, 자신은 음식도 절제하지 못하고 계속 먹기 때문에 ‘다른 사람들은 식단조절에 운동에 다 절제하면서 열심히 사는데 나는 계속 먹기만 하고, 내 인생은 완전히 망했어’라고 생각하는 비합리적인 생각들을 가지고 있었다. 따라서, 연구자는 E참여자의 흑백논리 사고에 대한 인지적 재구성의 과정이 필요할 것으로 판단되어 연속선상에 놓기 기법 및 소크라테스식 기법을 통해 다음과 같

이 개입을 진행하였다. E참여자는 폭식으로 자신의 인생을 부정적인 범주로 판단하는 기존의 기준을 확장시켜 양극단으로 사고가 치우치고 있음을 인식할 수 있도록 하고, 수정시켰다.

E참여자: 과제에 적힌 걸 다시 말씀드리면, 다른 사람들은 식단조절에 운동에 다 절제 하면서 열심히 사는데 저는 계속 먹기만 하고, 제 인생은 완전히 망한 것 같아요.

연구자: 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 그럼 저희가 폭식을 절제하지 못한 E님의 인생이 완전히 망했는지 한 번 살펴볼게요. E님은 폭식을 절제하지 못해서 인생이 완전히 망한 것 같다고 하셨는데 0~100점 중에 몇 점 정도로 망한 것 같으세요?

E참여자: 100점 정도요.

연구자: 그렇군요. 정말 완전히 망했다고 생각하시네요. 그럼 저희가 정확하게 확인하기 위해서 E님의 인생이 망한 정도를 스스로에게 점수를 부여할 건데 먼저 제 설명부터 잘 들어주세요. 0~100의 점수가 있어요. 100점은 인생이 완전 망해서 직장도 없고, 도와줄 사람도 없고 돈도 하나도 없는 상태이고 절제도 하나도 하지 못해요. 그래서 매일 폭식해요. 0점은 너무 완벽하게 먹는 것에 대한 절제를 잘한 나머지 성공해서 백만장자에 친구도 정말 많고 원하는 건 뭐든지 가질 수 있는 상태예요. 그럼 여기서 E님은 중간인 50점은 어떤 사람인 것 같으세요?

E참여자: 50점은 말 그대로 중간이니까 일단 직장이 있고, 친구도 있고, 절제도 중간 정도로 할 수 있어서 어떤 때는 할 수 있고, 어떤 때는 할 수 없는 정도일 것 같아요.

연구자: 그럼 같이 보시는 것과 같이 0~100점 척도에서 다시 점수를 부여한다면 E님은 몇 점 정도에 해당하시는 것 같으세요?

E참여자: 저는 70점?

연구자: E님이 처음에는 망한 정도가 100점이었다가 70점으로 떨어졌네요. 70점은 어느 정도의 인생이라고 할 수 있나요? 구체적으로 얘기해볼게요.

(중략)

연구자: 자 그럼 저희가 정한 70점의 인생을 봤을 때 E님은 다 해당되는 거죠?

E참여자: 아니요. 이것보다는 제가 더 나은 것 같은데요. 점수를 50점 정도로 바뀌도 되나요?

연구자: 네. 그럼 50점으로 봤을 때 저희가 아까 정한 내용을 다 보시면 50점 정도에 해당되시는 거죠?

E참여자: 네. 중간정도인 것 같은데요. 어쨌든 직업도 있고, 친구도 있고, 제가 매번 음식을 절제하지 못하는 건 아니에요.

연구자: 그럼 폭식으로 인해서 E님의 인생이 완전히 망한 건 아니네요. 완전히 망하려면 절제뿐만 아니라 직업, 친구, 돈 같은 것들도 같이 생각해봐야하니까요. 그리고 절제에도 여러 종류가 있을 것 같은데 처음에 E님이 얘기하신 ‘폭식을 절제하지 못했다는 것은 인생이 망했다는 것이다.’의 연결성을 한 번 생각해보시겠어요?

E참여자: 그래프에 놓고, 점수에 대한 조건들을 하나씩 따져보니까 인생이 완전히 망한 것도 아니라는 생각이 들고, 그래도 내가 중간은 하는구나 라는 생각에 조금의 안도감이 든다고 해야 하나? 그렇기도 하고 좀 웃긴 건 먹는 걸 절제하지 못했다고 해서 인생이 망했다고 생각한 것 자체가 맞지도 않은 것 같아서 제가 왜 그렇게 생각했는지 모르겠어요.

연속선상에 놓기 기법 및 소크라테스식 기법을 통해 E참여자는 “그래프에 놓고, 점수에 대한 조건들을 하나씩 따져보니까 인생이 완전히 망한 것도 아니라는 생각이 들고, 그래도 내가 중간은 하는구나 라는 생각에 조금의 안도감이 든다고 해야 하나? 그렇기도 하고 좀 웃긴 건 먹는 걸 절제하지 못했다고 해서 인생이 망했다고 생각한 것 자체가 맞지도 않은 것 같아서 제가 왜 그렇게 생각했는지 모르겠어요.” 등의 사고로 전환시켜 흑백논리 사고에서 벗어났다.

나. F참여자의 사례

F참여자의 경우, 사고가 경직되어 있으며 폭식을 기준으로 폭식을 하는 것과 하지 않는 두 개의 범주를 놓고, 폭식을 하는 혹은 멈추지 못하는 자신은 무능한 사람으로 판단하였다. 따라서, 연구자는 F참여자가 생각하는 ‘폭식도 못 멈추는 나는 무능한 사람이야’라는 사고에 대한 인지적 재구성의 과정이 필요할 것으로 판단되어 기준점 점

검하기 및 소크라테스식 기법을 통해 다음과 같이 개입을 진행하였다. F참여자가 기준으로 설정한 폭식의 기준점이 적응적인 기준점인지를 재인식하게 하여 현실적인 기준점으로 설정할 수 있도록 도왔다.

연구자: F님 과제 중에 폭식도 못 멈추는 나는 무능한 사람이야 라는 생각이 점수가 가장 크게 부여되어 있어서 같이 살펴볼게요. 어떻게 보면 폭식을 기준으로 생각하시는 것 같은데 맞으실까요?

F참여자: 네. 제가 폭식하는 사람이라서 폭식에 중점을 두다보니까 폭식을 멈추고 못 멈추는 게 중요한 기준인 것 같아요.

연구자: 그렇다면 폭식을 못 멈추는 사람은 무능한 사람이고, 폭식을 멈추는 사람은 능력있는 유능한 사람인가요?

F참여자: 네. 멈출 수 있는 방법을 아는 자체가 유능한 것 같고, 방법도 모르고 어떻게 하지 못해서 계속 폭식하는 저를 보면 되게 무능해보여요.

연구자: 그럼 과제 다시 살펴보면 F님이 폭식을 멈췄던 날도 있고, 폭식을 했던 날도 각각 있는데 폭식을 멈췄던 날은 유능했던 날이고, 폭식을 했던 날은 무능해서 폭식을 하셨던 게 되는데 맞을까요?

F참여자: 아니요. 제가 폭식을 멈췄던 날은 프로그램에서 알려준 방법대로 해서 멈췄고, 하루? 이틀? 밖에 되지 않아요.

연구자: 좀 전에 F님은 멈출 수 있는 방법을 아는 자체가 유능하다고 하신 것 같은데 그럼 프로그램에서 배운 방법을 배워서 폭식을 멈췄다면 단 하나라도 방법을 아는 것 자체가 유능하게 되는 것 아닌가요?

F참여자: 그렇긴 하겠죠? 그렇다고 제가 유능한 건 아닌데...

연구자: 저희 기준점을 다시 살펴볼게요. 폭식을 멈추면 능력이 있고, 폭식을 멈추지 못하면 무능하다. 그럼 다른 기준점으로 봤을 때 프로그램에서 배운 폭식을 멈추는 방법들을 배워서 실제로 일상생활에서 적용해본 사람과 해보지 않은 사람으로 나눈다고 했을 때 적용해본 사람은 능력 있는 사람, 적용해보지 않은 사람은 무능한 사람으로 나뉘볼게요. F님은 어떤 사람에 해당되실까요?

F참여자: 저는 해보긴 해봤는데... 제가 능력 있는 사람? 제가 능력이 있다니 이상한데요...

연구자: 과제에도 나와 있으니까 F님은 능력 있는 사람이 되시는 거예요. 이상하다고 말씀하셨는데 어느 부분이 이상하신 것 같으세요?

F참여자: 기준이 좀 이상한 것 같아요. 적용해보지 않은 사람은 무능한 게 아니라 그냥 불성실하거나 노력하지 않는 정도의 사람이지 않을까요. 무능하다고 보는 건 좀 아닌 것 같아요.

연구자: 그럼 폭식을 멈추는 건 능력이 있고, 폭식을 못 멈추는 건 무능하다는 기준은 어떻게 보이세요?

F참여자: 이것도 좀 아닌 것 같아요... 기준이 좀 이상하긴 하네요.

연구자: 그럼 다르게 본다면 폭식을 멈추지 못하는 건 무능한 게 아니라 어떤 사람인 것 같으세요? 기준점이 바뀐 이유도 말씀해주시면 좋을 것 같아요.

F참여자: 음... 폭식을 멈추지 못하는 건 무능한 사람이라기보다는 그냥 절제에 어려움이 있는 사람? 도움이 필요한 사람이에요. 아무튼 무능하진 않은 것 같아요. 왜냐하면 무능하면 뭔가 능력이 없는 거라서 배워도 어떻게 해보지 못하는 사람인데 아까 연구자님께서 저는 그래도 해봤다고 알려주셔서 아무것도 못하는 무능한 사람은 아닌 것 같아요.

기준점 점검하기 및 소크라테스식 기법을 통해 F참여자는 “폭식을 멈추지 못하는 건 무능한 사람이라기보다는 그냥 절제에 어려움이 있는 사람? 도움이 필요한 사람이에요. 아무튼 무능하진 않은 것 같아요. 왜냐하면 무능하면 뭔가 능력이 없는 거라서 배워도 어떻게 해보지 못하는 사람인데 아까 연구자님께서 저는 그래도 해봤다고 알려주셔서 아무것도 못하는 무능한 사람은 아닌 것 같아요.”의 사고로 전환시켜 흑백논리 사고에서 벗어났다.

(2) 대인 지각 관련 인지 내용의 변화

① 독심술

대인외상경험과 마찬가지로 폭식장애경향자들은 외상경험으로 인해 대인 지각과 관련하여 오류가 있다. 타인의 생각을 객관적으로 사고하지 못하고, 마치 자신이 다 알고 있다고 생각하며 그러한 타인의 생각이 사실이라고 믿기 때문에 부적응적으로 왜곡하여 생각한다. 따라서, 타인의 표정과 행동을 있는 그대로 받아들이기 보다는 자신을 조롱하거나 비난한다고 판단하여 타인을 신뢰하는 것이 어렵고, 의미 있는 대인

관계를 맺는 것에 어려움이 있다. 실험집단의 참여자들은 폭식과 관련하여 타인의 사고를 자신만의 사고로 해석하는 독심술 사고를 보였으며 내용은 <표 VI-46>에 제시하였다.

<표 VI-46> 폭식과 관련된 독심술 사고의 변화 내용

참여자	부적응적 사고	⇒	적응적 사고
B	친구가 웃으면서 걱정하는 말투로 그만 먹으라고 했지만 속으로는 나를 비웃으면서 깔보겠지		혹시 제가 저를 평소에 많이 먹는 걸로 안 좋게 생각해서 그런 걸까요? 도둑이 제 발 저린 것처럼? 그런 것 같기도 하고... 제 생각인데 친구 생각이라고 착각한 것 같기도 하고... 그 친구는 그 친구만의 생각이 있었을 것 같은데... 무조건 안 좋게만 판단한 것 같아요.
G	선생님이 복스럽게 잘 먹는다고 말했던 건 내가 돼지같이 많이 먹는다는 말을 대놓고 못하니까 돌려 말한 거겠지. 역시 다른 사람들은 앞뒤가 너무 달라서 믿을 수가 없어		선생님이 제게 나쁜 의도로 그럴 이유가 전혀 없고... 그냥 잘 먹는 모습을 보고 있는 그대로 표현하신 것 같기도 한데... 갑자기 제가 선생님의 의도를 나쁘게만 오해한 것 같다는 생각이 들어요.

가. B참여자의 사례

B참여자의 경우, 낮은 자존감과 자기비난적 사고가 대인지각에서도 연결되어 나타났다. 따라서, 타인이 폭식하는 자신의 모습을 보고 걱정하거나 도와주려고 하는 의도를 왜곡하여 자신을 깔본다고 생각하였다. 따라서, 연구자는 B참여자가 생각하는 ‘친구가 웃으면서 걱정하는 말투로 그만 먹으라고 했지만 속으로는 나를 비웃으면서 깔보겠지’라는 독심술 사고에 대한 인지적 재구성의 과정이 필요할 것으로 판단되어 제 3자의 관점에서 보기 및 소크라테스식 기법을 통해 다음과 같이 개입을 진행하였다. B참여자는 자신의 폭식하는 모습에 대해 다른 사람의 생각을 유추하여 확신하는 좁은

시야에서 벗어나 전체적인 시야를 통해 사고를 확장할 수 있도록 하여, 왜곡된 사고를 수정시켰다.

연구자: B님은 친구와 같이 식사할 때 폭식을 하게 되었고, 친구가 B님을 걱정해주는 모습을 보고 화가 많이 나셨던 것 같네요.

B참여자: 네. 제가 뭘 먹을 때 조절을 잘 못하기 때문에 집에서 혼자서만 먹는 편인데, 아 특히 그날은 과제 때문에 너무 스트레스 받는 일이 있어서 정말 혼자 밥 먹으려고 한 날이었어요. 그런데 친구가 꼭 만나서 할 말이 있다고 해서 어쩔 수 없이 외식을 했어요. 처음에는 계속 조금만 먹어야지 하면서 자제하다가 역시나 제가 배부르다고 말하면서도 계속 급하게 먹는 모습을 보고 친구가 웃으면서 걱정하는 말투로 배부르면 그만 먹으라고 두 번 정도 말했어요. 그런데 저는 그 친구의 태도가 저를 걱정해서 그만 먹으라는 것처럼 들리지 않고, 저를 바라보면서 웃으면서 얘기하는 게 놀리는 것처럼 보이고, 그 친구가 속으로는 저를 비웃으면서 역시 너는 배부르는데 계속 먹는구나 자제도 안 하고 너 그럴 줄 알았다고 생각하면서 저를 깔보는 것 같다는 생각이 들었어요.

연구자: 상황하고 생각을 잘 정리해서 말씀해 주셨네요. 그렇다면 B님의 생각으로 인해서 굉장히 화가 나시거나 다양한 기분이 들었을 것 같은데 특별히 외식을 같이 한 친구 분과 평소 사이가 안 좋거나 최근 다투었거나 아니면 그날 어떤 갈등이 될 만한 소지가 있었나요?

B참여자: 아니요. 그날은 좋은 소식을 전해서 축하하는 분위기였고 그랬어요.

연구자: 그렇다면 특별히 친구분이 B님을 안 좋게 생각할 이유는 없겠네요.

B참여자: 네. 그렇진 않아요.

연구자: 혹시 외식한 친구분과 다 같이 아는 지인이 있으신가요?

B참여자: 네. 그날도 원래 한 명 더 왔어야 했는데 갑작스러운 만남이라 선약이 있어서 못 온 친구가 있어요.

연구자: 그럼 그 참석하지 못한 친구분이 참석했다고 치고 같은 상황에서 외식한 친구분이 참석 못한 친구분에게 웃으면서 걱정하는 말투로 그만 먹으라고 했어요. 이 말을 듣고 참석 못한 친구분은 어떻게 생각할 것 같으세요?

B참여자: 글썄요. 그 친구가 아니라서 잘은 모르겠지만 아마도 그 친구라면 왜 그만 먹으라고 했는지 물어보거나 같이 웃으면서 더 먹을 거라고 장난쳤을 것 같은데요? 저처럼 심각하게 생각해서 화가 나거나 창피해하진 않을 것 같아요.

연구자: 가정이었지만 같은 상황에서 그만 먹으라는 말을 들었을 때 B님과 참석하지 못한 친구분의 생각이나 태도가 좀 다른 것 같아요. 왜 그런지 한 번 생각해 보시겠어요?

B참여자: 제가 저를 평소에 많이 먹는 걸로 안 좋게 생각해서 그런 걸까요? 도둑이 제 발 저린 것처럼? 그런 것 같기도 하고... 제 생각인데 친구 생각이라고 착각한 것 같기도 하고... 그 친구는 그 친구만의 생각이 있었을 것 같은데... 무조건 안 좋게만 판단한 것 같아요.

제3자의 관점에서 보기 기법 및 소크라테스식 기법을 통해 B참여자는 “그 친구가 아니라서 잘은 모르겠지만 아마도 그 친구라면 왜 그만 먹으라고 했는지 물어보거나 같이 웃으면서 더 먹을 거라고 장난쳤을 것 같은데요? 저처럼 심각하게 생각해서 화가 나진 않을 것 같아요.”, “혹시 제가 저를 평소에 많이 먹는 걸로 안 좋게 생각해서 그런 걸까요? 도둑이 제 발 저린 것처럼? 그런 것 같기도 하고... 제 생각인데 친구 생각이라고 착각한 것 같기도 하고... 그 친구는 그 친구만의 생각이 있었을 것 같은데... 무조건 안 좋게만 판단한 것 같아요.” 등의 사고로 전환시켜 독심술 사고에서 벗어났다.

나. G참여자의 사례

G참여자의 경우에는, 바쁜 스케줄을 소화하느라 그만큼 다양한 사람들을 만나왔는데 계속적으로 다른 사람의 표정과 의도를 왜곡하여 독심술 사고로 판단하는 경우가 잦았다. 이에 따라 강한 부정 감정을 느끼면서도 앞에서는 전혀 내색하지 않고, 혼자 있을 때 이를 곱씹으며 폭식하는 패턴이 반복되었다. 따라서, 연구자는 G참여자가 생각하는 ‘선생님이 복스럽게 잘 먹는다고 말했던 건 내가 돼지같이 많이 먹는다는 말을 대놓고 못하니까 돌려 말한 거겠지. 역시 다른 사람들은 앞뒤가 너무 달라서 믿을 수가 없어’라는 독심술 사고에 대한 인지적 재구성의 과정이 필요할 것으로 판단되어 증거 검토, 이익과 손실 평가 및 소크라테스식 기법을 통해 다음과 같이 개입을 진행하였다. G참여자는 자신의 독심술 사고가 어떠한 이익과 손실을 가져다주는지를 평가하는 작업을 통해 자신에게 도움이 되지 않는 사고임을 알고, 수정하였다.

연구자: 그럼 G님이 적은 사고로 이익과 손실을 평가해보도록 할게요. 지금 이 생각이 어떠한 이익이 있나요?

G참여자: 이익은 당연히 없죠. 오히려 화를 나게 할 뿐이에요.

연구자: 그건 손해가 된다는 건데 그러면 이익이 없다면 손실을 한 번 얘기해보면 좋겠어요.

G참여자: 일단 화가 나요. 화가 나서 꼭 참았다가 집에 가서 다시 생각하면서 또 폭식을 하겠죠. 후회도 할 것 같아요. 왜 같이 먹었지? 이렇게 될 게 뻔한데 한심하다. 왜 자꾸 반복하는 거야 또 화나고 이게 가장 큰 손해가 될 것 같아요. 화나서 폭식하게 만드는 게 그리고 나면 기분을 우울하게 만들어요. 완전 안 좋게.

연구자: 그럼 이익은 없는 거고, 오히려 폭식만 부추기는 손해를 입히는 생각이네요. 혹시 같이 식사한 선생님과 평소 사이가 어떠셨어요? 평소에도 앞에 말씀하신 상황처럼 G님의 기분을 상하게 하는 말들을 한 적이 있었나요?

G참여자: 아니요. 친한 사이는 아니라서 저도 어찌다보니 처음으로 같이 밥 먹은 거거든요. 평소에 그냥 안 친하다보니까 인사치레로 뭐 가벼운 칭찬이나 이런 정도?

연구자: 그럼 특별히 G님과 사이가 안 좋다거나 G님의 기분을 일부러 상하게 말할 이유는 없는 사이겠네요?

G참여자: 네 맞아요.

연구자: 좋아요. 그럼 다시 아까 상황으로 돌아가서 질문을 드린다면 복스럽게 잘 먹는다는 말이 돼지같이 많이 먹는다 뜻 말고 다른 뜻은 없을까요?

G참여자: 글썄요. 그때 그 선생님 표정이 눈이 커져서 놀란 듯이 얘기한 것 같은데요? 이제 그 선생님하고 같이 마주하는 건 좀 불편해졌어요.

연구자: 지금도 그 장면이 떠오르셔서 그런지 불편함을 느끼신 것 같은데 그렇다면 반대로 말 그대로 정말 잘 먹어서 복스럽다고 했을 경우도 있잖아요. 한 번 증거점검 차 사진을 같이 살펴볼까요? 복스럽다의 뜻은 모난 데가 없이 복이 있어 보이는 데가 있다는 뜻이래요. 그리고 검색해봤을 때 통상적으로는 복스럽게 먹는다가 좋은 뜻으로 쓰이고 있네요. 공유 화면 보이시죠? 평소의 관계를 연관 지어 생각한다면 그 분이 G님에게 나쁜 의도로 말하진 않았을 것 같은데 G님의 생각은 어떠세요?

G참여자: 정말 그러네요... 제가 혼자 이상하게 생각한 걸까요? 말하다보니까 그 선생님

이 제게 나쁜 의도로 그럴 이유가 전혀 없고... 그냥 잘 먹는 모습을 보고 있는 그대로 표현하신 것 같기도 한데... 갑자기 제가 선생님의 의도를 나쁘게만 오해한 것 같다는 생각이 들어요.

증거 검토, 이익과 손실 평가 및 소크라테스식 기법을 통해 G참여자는 점차적으로 혼자만의 좁은 사고에서 점차적으로 사고를 확장시키며 “그 선생님이 제게 나쁜 의도로 그럴 이유가 전혀 없고... 그냥 잘 먹는 모습을 보고 있는 그대로 표현하신 것 같기도 한데... 갑자기 제가 선생님의 의도를 나쁘게만 오해한 것 같다는 생각이 들어요.” 등의 사고로 전환시켜 독심술 사고에서 벗어났다.

VII. 논의 및 결론

본 연구는 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 폭식 증상 감소를 위한 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램을 개발하고, 실시한 후 그 효과를 규명하는데 목적이 있다. 연구 프로그램의 효과 검증을 위하여 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램과 전통적인 인지행동치료 프로그램을 각각 실시하여 비교하였다. 연구 대상은 아동·청소년기 대인외상경험과 폭식장애경향이 있는 20, 30대 성인 여성 21명을 선발하여 이미지 재구성 인지행동치료 집단(실험집단), 전통적인 인지행동치료 집단(비교집단) 및 통제집단에 각각 7명씩 임의로 배정하였다. 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 총 10회기로 구성되었으며 주 2회, 회기 당 120분씩(10회기 중 이미지 재구성 개별 3회기는 개인 당 약 50분 내외 소요) 실시하였다. 비교집단은 총 10회기로 구성되었으며 주 2회, 회기 당 120분씩 실시하였다. 프로그램의 효과를 알아보기 위해 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 섭식(부정적 정서로 유발된 섭식 동기·행동), 인지(역기능적 신념, 부정적 자동적 사고, 자아존중감), 정서(정서조절곤란, 우울, 상태-특성 불안, 상태-특성 분노) 및 행동(스트레스 대처방식)의 사전, 사후, 추후 검사 점수의 양적 변화를 측정하였다. 또한, 프로그램 진행 과정에서 나타난 실험집단 참여자들의 사고 및 신념의 변화를 보다 심층적으로 살펴보고자 내용분석을 실시하였다. 본 연구의 결과를 토대로 한 논의는 다음과 같다.

1. 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 특성

1) 폭식 증상

프로그램 실시 후 섭식 변인인 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동에서 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 유의한 점수 변화가 나타난 반면, 전통적인 인지행동치료 프로그램은 유의한 점수 변화가 나타나지 않았다. 이러한 결과는 이미지 재구성

인지행동치료 프로그램이 아동·청소년기 폭식장애경향 성인 여성의 폭식 증상 감소에 효과적임을 의미하며, 이는 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램의 인지적 재구성과 이미지 재구성의 단계적인 결합에 의한 치료적 개입의 효과로 추정할 수 있다.

구체적으로 하위요인별로 논의하면, 실험집단은 프로그램 실시 후 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동과 하위요인인 섭식동기, 섭식행동 모두 유의하게 점수가 감소하였고, 이 효과는 3개월 후에도 유지되었다. 이러한 결과는 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램이 참여자로 하여금 폭식을 유발한 부정 감정 이전의 외상 사고 및 부정 감정 이후의 폭식 사고가 모두 잘 다루어져 부정 감정이 느껴질 때 즉각적으로 폭식을 하고 싶다고 생각하는 사고와 실제로 폭식을 하는 행동적 측면의 감소 모두에 효과적이었음을 의미한다. 기존의 폭식장애를 위한 대표적인 치료인 인지행동치료는 폭식에만 초점을 두고 폭식과 관련된 비합리적 사고 및 신념을 수정하기 위해 언어적 접근의 인지적 재구성을 하여 폭식 증상 감소에 치료적 효용성을 입증하였다(권호인, 권정혜, 2003; Fairburn, et al., 2015). 그러나 장기적인 치료 기간, 참여자의 대안사고 찾기의 어려움 및 이를 믿는 정도, 인지적 유연성의 부족, 정서조절 문제, 대인관계 문제 등과 함께 폭식이 재발하는 문제점이 지속적으로 제기되었다(Brown & Keel, 2012; Cooper, et al., 2003; Lundgren, et al., 2004; Monica, et al., 2010; Wonderlich, et al., 2003). 따라서, 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램에서는 폭식장애의 기원이 아동·청소년기 대인외상경험에 있다는 점에 착안하여 초기 외상과 이로 인한 폭식 증상을 효과적으로 다루기 위하여 기존의 폭식 증상에 대한 인지행동치료에 이미지 재구성을 치료적 구성요인에 추가하였다. 이에 따라 인지적 재구성과 이미지 재구성이 3단계에 걸쳐 치료적 개입을 하며 참여자의 초기 대인외상경험, 대인관계문제, 폭식 사고를 모두 수정하였다. 이러한 단계적 과정은 첫째, 소크라테스 기법을 통해 언어적 접근의 인지적 재구성을 하였고, 이로 인해 합리적인 사고를 찾는 연습과 사고의 적응적인 확장을 도왔다. 둘째, 이미지 재구성 I 으로 대인외상경험을 노출하고, 심상 안에서 소크라테스 기법을 사용하여 왜곡된 신념 및 침습적인 심상의 내용을 교정하였다. 셋째, 이미지 재구성 II로 폭식을 일으켰던 가장 최근의 대인관계적 문제 상황 및 폭식 상황을 미래에 발생하였다고 가정하여 진행한 심상 시뮬레이션 훈련과정으로 참여자 스스로 소크라테스 기법을 통해 기존의 수정된 합리적인 사고와 신념을 보다 강화시키고, 수정하였다. 이처럼 인지적 재구성과 이미지 재구성이 서로의 시너지 역할을 하며 현

재의 폭식 증상의 근원인 초기 대인외상경험을 잘 다루어주었기에 부정 정서로 인한 폭식 증상 및 폭식 증상의 재발에 효과적이었던 것으로 보인다.

반면, 비교집단은 프로그램 실시 후 부정적 정서로 유발된 섭식동기·행동과 하위 요인인 섭식동기에서 유의한 점수 변화가 없었으며, 하위요인인 섭식행동에서만 유의하게 점수가 감소하였다. 그러나 하위요인인 섭식행동의 감소는 유의하진 않으나 추후 검사에서 다시 점수가 증가하는 추세를 보였다. 이러한 결과는 전통적인 인지행동치료 프로그램이 폭식을 유발한 부정 감정 이전의 사고와 관련된 근본적인 원인인 초기 대인외상경험과 결부된 왜곡된 신념 및 인지 과정을 변화시키는 데 한계가 있었음을 의미한다. 이는 참여자들의 외상 사건과 관련된 신념의 경우 집단 프로그램에서 단기간 내에 언어적인 인지적 재구성만으로 개입하는 것에 시간적 한계와 어려움이 따랐던 것으로 추측된다. 따라서, 후속 연구에서는 집단 회기를 추가하여 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램과 같이 개인 회기를 마련하여 외상으로 인한 사고를 다루는 인지적 재구성과 이에 도움이 되는 노출 훈련을 함께 시행하는 것에 대해 고려해볼 필요가 있다.

2) 폭식 증상을 유발하는 인지 내용 및 과정

(1) 인지 내용

프로그램 실시 후 인지 변인 중 인지 내용인 역기능적 신념, 부정적 자동적 사고에서 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 모두 유의한 점수 변화가 나타난 반면, 전통적인 인지행동치료 프로그램은 역기능적 신념에서는 변화가 없었으나 부정적 자동적 사고에서는 유의한 점수 변화가 나타났다.

구체적으로 살펴보면, 실험집단은 프로그램 실시 후 역기능적 신념과 역기능적 신념의 하위요인인 사회적 자기에 대한 부정적인 신념, 타인의 인정에 대한 과도한 욕망, 타인 및 대인 관계에 대한 부정적인 신념 모두 유의하게 점수가 감소하였고, 이 효과는 3개월 후에도 유지되었다. 이러한 결과는 프로그램 실시 후 나타난 인지 내용의 변화로 이미지 재구성 인지행동치료의 이미지 재구성이 외상경험자의 외상 사건 기저에 깔린 자신, 타인에 대한 역기능적 인지도식을 적응적으로 변화시켰다는 선행연

구의 결과와 일치하며(Arntz, 2011; Wild & Clark, 2011), 동시에 언어적 접근의 인지적 재구성과 심상적 접근의 이미지 재구성을 같이 실시하였을 때 외상경험자의 사고와 역기능적 핵심신념이 효과적으로 수정되었다는 선행연구를 뒷받침하는 결과이다(Lee & Kwon, 2013; Wild, et al., 2008). 프로그램 초기에 참여자들은 초기 대인외상경험과 폭식 증상에 공통적으로 나타나는 부정적인 자기개념, 타인 및 대인관계에서의 역기능적인 신념이 매우 높았다. 즉, 타인의 의도를 왜곡하거나 자신의 무능함 및 무가치함을 비난하며, 자기 위안 또는 자기 격려를 하지 못하는 양상이 드러나고 이에 따라 개개인마다의 사고가 매우 경직되어 있어 스스로 대안 사고를 찾는 데 어려움이 따랐다. 따라서, 실험집단에서는 참여자들에게 가장 도움이 될 수 있는 관점취하기와 소크라테스 기법을 충분히 활용할 수 있도록 문제해결사, 법정 역할극 등의 활동으로 자신과 다른 참여자들의 신념을 지지하거나 반박함으로써 여러 관점에서 자신의 왜곡된 사고를 바라보는 인지가 확장되어 이를 수정하거나 대안사고를 찾는 소양을 기를 수 있도록 하였다. 또한, 이러한 소크라테스 기법이 연습된 후에 시행한 이미지 재구성 I의 경우에도 심상을 통해 초기 대인외상을 노출하여 성인인 자신이 피해자였던 자신의 어린 아이 심상을 위로하고 돌보며 당시에 형성된 아이 수준의 핵심신념을 효과적으로 수정시키는 데 도움이 되었다. 즉, 피해를 당하는 아이의 사고 수준이 아닌 개선된 성인의 인지기능 수준으로 상황을 주도하며 재구성하고, 성인이 상처받은 어린 아이를 진심으로 위로하고 달래며 기존의 ‘피해 심상’이 ‘대처/주도 심상’으로, ‘자기비난적 태도’가 ‘자기-진정/자기-위로 심상’으로 대체되어 외상 사건을 재경험함으로써 인지 수정이 효과적으로 이루어지게 된 것으로 보인다. 실제 내용분석에서도 ‘이런 일을 겪은 건 전부 다 내 탓이야’, ‘완강하게 거부했다면 이런 일을 겪지 않았을 텐데 대처를 잘하지 못한 내 탓이야’와 같이 자신의 무능함으로 내면화시키는 부적응적인 자기비난적 사고에서 벗어나 상황을 보다 객관적으로 바라보며 ‘네 탓이 아니야. 어떻게 아무것도 모르고 채팅한 어린 너의 탓만이 되겠어. 나쁜 짓 하려고 의도하고 채팅하는 걸 비난해야지 그걸 욕해야지’, ‘네 탓이 아니야 괜찮아. 넌 아무것도 모르는 어린 아이일 뿐이었어. 뭐라고 비난만 하지 말고 자책도 하지 말고 차라리 위로해 주고 받아들여줘’, ‘이 아이의 탓이 아니에요. 그 아저씨가 나쁘고 잘못된 거지 그러니까 제 잘못이 아니에요’, ‘네 탓이 아니야 넌 잘못된 거 하나도 없어 저 사람이 나쁜 사람이야. 어른이 어린 아이한테 잘못된 행동을 했어. 나쁜 사람이야’의 적응적인 사고의 변화가 나타났다. 이처럼 이미지 재구성 I의 외상

사건의 심상은 문제에 대해 단순히 언어적으로 표현하는 것보다 더 정서적 반응을 이끌어 내며(Holmes, et al., 2007), 심상 안에서 각 단계에 따라 ‘성인자아’와 ‘아동자아’의 관점을 취하며 핵심신념을 수정하는 동시에 정서적인 상호작용을 한 측면이 참여자의 부정적인 자기개념과 타인에 대한 부정적인 신념을 수정시켜 인지적 변화를 도모하는 것으로 예측된다. 또한, 이미지 재구성Ⅱ를 통해 미래 긍정적인 심상을 떠올리며 앞서 배웠던 다양한 전략들을 활용하여 대인관계적 스트레스 상황과 폭식 상황을 스스로 해결하는 과정은 앞의 인지적 재구성과 이미지 재구성을 통해 변화된 개인의 합리적인 신념을 더욱 공고히 하였다. 이처럼, 언어적 접근의 인지적 재구성과 심상적 접근의 이미지 재구성의 결합된 인지적 개입이 더욱 효과적으로 참여자의 인지를 수정하는 것으로 예측되어 이들의 결합된 치료적 개입이 중요할 것으로 보인다.

반면, 비교집단은 프로그램 실시 후 인지 변인 중 인지 내용인 역기능적 신념과 하위요인인 사회적 자기에 대한 부정적인 신념, 타인의 인정에 대한 과도한 요망, 타인 및 대인 관계에 대한 부정적인 신념의 점수 모두 유의한 점수 변화가 없었다. 이러한 결과를 분석하기 위해서는 핵심신념과 자동적 사고를 구별하여 설명할 필요가 있다. 먼저, 자동적 사고는 일시적이고 상황에 따라 변화하는 상태 의존적인(State-Dependent) 인지인 반면, 역기능적 핵심신념은 비교적 안정되어 있어 상황에 상관없이 일관성이 있으며 성격의 인지적 구조의 내용을 반영하는 신념체계로서 특질과 비슷한(Trait-Like) 인지이다(조용래, 원호택, 1999). 즉, 역기능적 핵심신념은 자동적 사고를 발생시키는 보다 근원적인 기저 수준의 인지로써, 자동적 사고에 비해 쉽게 바뀌지 않는 특성이 있다. 따라서, 앞서 살펴본 폭식 증상에서 유의한 변화가 없었던 이유와 같이 초기 외상과 관련된 참여자의 기원이 오래된 역기능적 신념은 인지왜곡이 심하고, 그만큼 사고의 유연성 또한 매우 경직되어 있거나 저하되어 있기 때문에 단기간의 정해진 회기 내에서 언어적 접근의 인지적 재구성의 개입만으로 이를 변화시키는 것에는 한계가 따랐을 것으로 여겨진다.

한편, 프로그램 실시 후 부정적 자동적 사고와 하위요인인 부정적인 자기상과 부정적인 기대, 현실에 대한 불만과 변화 욕구, 무기력과 의욕상실에서 실험집단과 비교집단 모두 유의하게 점수가 감소하였고, 이 효과는 3개월 후에도 유지되었다. 이는 두 집단의 공통적인 구성요인인 인지적 재구성이 외상경험자와 폭식장애경향자의 부적응적인 자동적 사고를 적응적으로 변화시켰다는 선행연구의 결과와 일치한다(Agras, et

al., 2000; Ehler, et al., 2005; Fairburn, et al., 2015). 두 집단에서는 부적응적인 자동적 사고를 수정하기 위해 참여자들의 공통적인 인지 오류인 흑백논리, 선택적 추론, 자기비난 등을 직업과 연결시켜 7가지 직업적 파배기 오류를 통해 이해하기 쉽게 설명하여 개인마다 자신의 섭식DTR일지로 주된 자동적 사고를 감찰하고, 이후에 인지적 재구성의 방안인 파배기를 푸는 8가지 대안 방법인 이익과 손실, 증거 점검, 타임머신 기법, 소크라테스 기법 등과 같은 활동을 진행하였다. 이러한 자신의 왜곡된 자동적 사고에 이름을 붙이고, 자동적 사고의 유형에 따라 다양한 대안 방법을 연습하는 활동들을 통해 참여자들이 인지적 전략을 사용할 수 있도록 도운 것으로 예상된다.

(2) 인지 과정

프로그램 실시 후 인지 변인인 인지 과정의 자아존중감에서 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 유의한 점수 변화가 나타나고, 이 효과가 3개월 후에도 유지된 반면, 전통적인 인지행동치료 프로그램은 유의한 점수 변화가 나타나지 않았다. 이러한 결과는 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램이 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 대인외상경험과 결부된 자아존중감의 증가에 효과적임을 의미하며, 이미지 재구성이 자아존중감의 향상에 유의한 영향을 미친다는 선행연구의 결과와 일맥상통한다(Arntz & Weertman, 1999). Brewin(2006)의 인출경쟁 이론(Retrieval Competition Theory)에 따르면, 특정 순간에 여러 기억과 자기 표상들이 인출경쟁을 하게 되므로, 효과적인 치료개입을 위해서는 동일한 인출 단서가 제시되었을 때 기존의 부정적인 인출결과의 패턴이 반복되지 않도록 긍정적인 대안적 표상을 만들어낼 필요가 있다고 하였다. 즉, 이미지 재구성을 통해 부정적으로 편향된 초기 기억을 교정하여 개인이 원하는 긍정적인 방향으로 수정하는 것은 초기 기억 및 이와 연관된 부정적인 자기심상이 긍정적인 자기심상으로 대체되어 인출경쟁 시 긍정적인 이미지가 우위를 점하게 된다. 따라서, 부정적인 자기 평가와 관련된 침습적인 외상 기억을 이미지 재구성을 통해 직접적으로 다룸으로써 자신에 대한 부정적 평가가 보다 적응적으로 변화된 부분이 자아존중감 향상에 긍정적인 변화를 가져온 것으로 보인다. 또한, 이미지 재구성Ⅱ로 대인관계적 스트레스 상황 및 폭식 상황을 미래의 긍정적인 자기심상을 적용하여 스스로 문제 상황을 해결해 나가는 시뮬레이션의 성공경험 또한

자아존중감을 증진시키는 하나의 방법이 되었을 수 있다. 따라서, 이러한 초기 대인의 상경험 및 이와 관련된 부정적인 자기 이미지를 심상으로 수정하여 새로운 적응적인 이미지로 형성하는 것은 기존의 인지 처리 과정의 오류를 수정하게 되어 개인의 자아존중감의 증진에 영향을 미쳤을 가능성이 크다.

반면, 전통적인 인지행동치료 프로그램은 인지 변인인 인지과정의 자아존중감에서 유의한 점수 변화가 없었다. 이러한 결과는 전통적인 인지행동치료 프로그램의 주된 치료구성요인인 언어적 접근의 인지적 재구성이 부적응적 사고의 감소를 통해 자아존중감과 연결된 부정적인 자기 지각에 대한 자동적 사고 수준의 변화에는 영향을 미치나, 외상 사건과 결부된 부정적인 이미지인 인지 과정을 다뤄주는 직접적인 개입이 병행되지 않으면 인지처리 과정의 오류가 변화될 수 없음을 의미한다. 이는 자아존중감 향상을 위해서는 낮은 자아존중감을 형성시킨 초기의 원인 수준에서의 직접적인 개입이 필요하기 때문에(Harter, 1990), 언어적인 개입의 인지적 재구성만으로는 이를 다룰 수 없었던 것으로 보인다.

3) 폭식 증상을 유발하는 정서조절의 어려움 및 부정 정서

(1) 정서조절곤란

프로그램 실시 후 정서 변인인 정서조절곤란에서 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램과 전통적인 인지행동치료 프로그램 모두 유의한 점수 변화가 나타났다. 이러한 결과는 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램과 전통적인 인지행동치료 프로그램 모두 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 정서조절곤란의 감소에 유의한 영향을 끼친다는 것을 의미한다.

구체적으로 하위 요인별로 논의하면, 실험집단은 프로그램 실시 후 정서 변인인 정서조절곤란과 하위요인인 충동통제곤란, 정서 비수용성, 정서조절 전략 접근제한, 목표지향행동 수행 어려움은 유의하게 점수가 감소한 반면, 하위요인인 정서주의/자각 부족과 정서적 명료성 부족은 유의한 점수 변화를 보이지 않았다. 그러나 3개월 이후 추후검사에서 하위요인인 충동통제곤란, 정서 비수용성, 정서조절 전략 접근제한, 목표지향행동 수행 어려움은 효과가 유지되었고, 사후 검사에서 유의하지 않았던 하위요인인

정서주의/자각 부족과 정서적 명료성 부족의 점수가 유의하게 감소하여 모든 하위요인에서 효과가 나타났다. 이러한 결과는 이미지 재구성이 어린 시절의 대인외상 사건에 대해 자신이 아닌 다른 원인에 재귀인 하게 하여 수정된 사고를 통해 정서적 처리(Emotional Processing)의 변화가 효율적으로 일어나게 한다는 선행연구를 뒷받침하는 결과이다(Holmes, et al., 2007; Laeng & Sulutvedt, 2014; Pearson, et al., 2015). 초기 대인외상경험자의 경우 당시에 정서가 억제되어 있거나 정서를 표현할 때 안전감을 경험하지 못하여 위협감을 느끼거나, 정서적인 지지를 받으려는 노력으로 정서가 적응적으로 처리되지 못하였기 때문에(Arntz, 2011), 성인이 된 이후에도 감정처리 및 조절에 있어 불편감과 어려움을 경험할 수 있다. 이러한 정서적 불편감은 이미지 재구성을 통해 외상 당시 억제되었던 욕구와 감정을 표현하는 정서적 경험을 재처리하게 함으로써(Arntz, 2012), 치유될 수 있도록 하였다. 실제로, 부록의 회기 소감에도 나와 있듯이 이미지 재구성 I 회기에서 전체 참여자 모두 각자의 초기 대인외상경험을 떠올리며 두려움, 슬픔, 분노, 불안 등과 같이 억압되어 있던 부정 정서를 표출하며 많은 눈물을 쏟아내었고, 이후에 재구성 작업을 통해 활가분함, 충만함, 따뜻함, 후련함 등과 같은 긍정 기분을 보고하였다. 이처럼 초기 대인외상경험과 관련된 정서적 경험의 재처리 과정은 참여자들로 하여금 과거의 역기능적인 정서적 관점을 변화시켜 이후에 정서를 처리하는데 안정감을 도모하게 되고, 이는 감정 인식 및 표현에 있어 긍정적인 영향을 미치게 되므로 이러한 부분이 정서조절의 적응적인 처리에 도움이 된 것으로 보인다. 또한, 언어적인 인지적 재구성과 이미지 재구성 I, II를 통해 폭식의 근원인 초기 대인외상경험과 이후의 대인관계문제 및 폭식 상황에 대한 인지적 개입으로 외상, 대인관계, 폭식과 관련된 부적응적인 사고들이 보다 합리적인 사고로 인지가 전환된 부분도 정서조절에 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 사료된다.

한편, 프로그램 실시 후 실험집단에서 정서조절곤란의 하위요인인 정서주의/자각 부족과 정서적 명료성 부족의 점수가 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났으나, 3개월 후 추후검사 결과에서 두 하위요인 모두 유의하게 감소한 것으로 나타났다. 이러한 결과는 유의하진 않으나 프로그램 종결 직후의 점수 감소 추이와 종결 3개월 후의 유의한 점수 감소의 결과로 미루어보았을 때 정서에 주의를 기울이고, 자신이 느끼는 정서가 무엇인지 명료하게 인식하는 정도의 개선은 10회기의 비교적 짧은 회기로 유의한 변화를 이끄는 것에 한계가 있었을 것으로 여겨진다. 본 프로그램의 경우 이미지

재구성을 통해 외상과 관련된 기원이 오래된 정서부터 현재의 대인관계문제 및 폭식에 영향을 미치는 정서까지 포괄적으로 다뤄주었기 때문에 이를 소화하여 상황마다 자신의 정서를 정확하게 자각하여 명료화시키는 데 시간이 필요하였을 것으로 예상된다.

전통적인 인지행동치료 프로그램에서는 정서 변인인 정서조절곤란과 하위요인인 충동통제곤란, 정서 비수용성, 정서적 명료성 부족, 정서조절 전략 접근제한은 유의하게 점수가 감소하였고, 이 효과는 3개월 후에도 유지되었다. 반면, 하위요인인 정서주의/자각 부족과 목표지향행동 수행 어려움은 유의한 점수 변화를 보이지 않았다. 정서조절곤란은 폭식을 초래하는 원인으로 폭식과 같은 섭식문제를 가지고 있는 대상자에게 특징적으로 나타나는 변인이다(Brewerton, 2007; Burns, et al., 2012; Kong & Bernstein, 2009). 일반적으로 폭식자의 경우 충동성이 강하여(Keel & Mitchell, 1997), 스트레스 수준이 높아졌을 경우 자신의 정서를 인식하지 못하고 정서조절곤란을 경험하게 되며 이때, 회피적인 스트레스 대처방식으로 폭식을 사용한다(Grau, et al., 2002). 이에 전통적인 인지행동치료 프로그램에서는 자기감찰, 인지적 재구성, 이완훈련, 문제해결기술을 포함하는 스트레스 대처훈련을 실시하였다. 먼저, 참여자들에게 자기감찰을 통해 부정 정서를 느끼는 구체적인 대인관계적 스트레스 상황을 탐색하게 하여 이와 관련된 사고, 정서, 신체반응의 유기적 연결성을 인식하게 하고, 폭식까지 이어지는 개인의 회피패턴을 인지시켜 인지적 재구성을 통해 관련 사고를 수정하였다. 또한, 이러한 자기감찰 및 인지적 재구성과 함께 행동적 기법인 이완훈련 및 스트레스대처 훈련으로 부정 정서를 느끼는 상황에서 사고와 감정에 압도되는 것을 막고, 자신을 빠르게 진정시키는 동시에 문제해결 중심의 대처방식을 사용할 수 있도록 도왔다.

한편, 프로그램 실시 후 비교집단에서 정서조절곤란의 하위요인인 정서주의/자각 부족과 목표지향행동 수행 어려움의 점수가 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다. 그러나 프로그램 사전-사후에 두 하위요인 모두 점수가 감소한 점을 살펴보았을 때, 정서에 주의를 기울여 자신의 정서를 자각하는 정서주의/자각 부족과 부정 정서를 경험하고 있을지라도 자신이 설정한 목표를 위해 노력하는 목표지향행동 수행 어려움은 초기 외상경험과 연결하여 생각해 볼 수 있다. 전통적인 인지행동치료 프로그램의 경우 외상 기억을 다룰 때 언어적인 접근의 인지적 재구성에 중점을 두었기 때문에 외상경험 당시의 핵심 정서를 직접적으로 다뤄주지 못하였다. 따라서, 외상경험이 갑

작스럽게 떠오르거나 이와 관련된 상황에서 자신의 부정 정서에 주의를 기울여 자각하거나 자신이 설정한 목표를 위해 정서를 조절하는 것에 어려움이 따랐을 것으로 예상해 볼 수 있다.

(2) 우울

프로그램 실시 후 정서 변인인 우울에서 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램과 전통적인 인지행동치료 프로그램 모두 유의한 점수 변화가 나타났다. 특히, 집단 간 차이를 보이며 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램이 전통적인 인지행동치료 프로그램에 비해 우울을 변화시키는 데 있어 더욱 유의한 변화를 보이는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 기존의 전통적인 인지행동치료에 이미지 재구성을 구성요인으로 추가시키는 방안이 우울 증상을 감소시키는 데 더욱 효과적임을 의미한다.

구체적으로 살펴보면, 프로그램 실시 후 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 정서 변인인 우울에서 유의한 점수 변화가 있었으며, 전통적인 인지행동치료 프로그램보다 더 효과적인 것으로 나타났다. 또한, 이 효과는 3개월 후에도 유지되었다. 이러한 결과는 이미지 재구성 인지행동치료의 핵심적 치료 구성요인인 이미지 재구성이 전통적인 인지행동치료의 언어화 기술보다 정서에 더 큰 영향을 미쳐 정서를 이끌어 내고, 변화시키는데 더욱 효과적임을 밝혀낸 선행연구들과 일치하는 결과이며(Holmes, et al., 2007; Holmes & Mathews, 2005; Holmes & Mathews, 2010), 우울증 환자를 대상으로 이미지 재구성의 치료적 효과를 확인한 선행연구(Brewin, et al., 2009; Wheatley & Hackmann, 2011)를 뒷받침하는 결과이다. 인지행동치료의 창시자인 Beck(1979)은 정신적 활동은 단어와 문장으로 된 언어적 인지의 형식과 이미지를 가진 시각적 인지 형식, 두 가지로 나뉜다고 하였다. 또한, 정서적 고통감은 언어적 인지와 함께 시각적 인지와 직접적으로 연결되어 있기에 고통스러운 시각적 인지를 수정하는 것이 유의미한 인지적, 정서적 변화를 가져올 수 있다고 하였다(Beck, et al., 1985). 이와 같이 선행연구들에 의하면, 우울 증상의 발생 및 유지에는 특정 자전적 기억에 대한 침습적 심상과 부정적인 자기개념의 시각적 인지 형식 모두를 변화시키는 것이 중요하다고 하였는데(Brewin, et al., 1999), 이 두 개의 요소를 심상에 기반한 이미지 재구성이 효과적으로 다뤄주며 우울을 감소시킨 것으로 보인다. 따라서, 이러한 이미지 재구성의 치료적 기제

가 본 프로그램 참여자들의 우울 감소에도 비슷하게 작동한 것으로 예측된다. 이처럼 이미지 재구성은 초기 대인외상경험의 침습적 심상과 부정적인 재기개념 모두를 효율적으로 다뤄주므로 외상과 연관된 우울을 감소시키는 데 있어 없어서는 안 될 중요한 치료적 구성요소임을 확인하였다.

한편, 전통적인 인지행동치료 프로그램도 정서 변인인 우울에서 유의한 점수 변화가 나타났고, 이 효과는 3개월 후에도 유지되었다. 이러한 결과는 언어적 접근의 인지적 재구성이 자동적 사고를 적응적으로 수정시켜 폭식자의 우울을 감소시켰다는 선행연구(Fischer, et al., 2014)와 일맥상통하며, 인지행동치료의 인지적 접근이 외상경험자의 우울을 감소시키는 데 효과적임을 보고한 선행연구(Kataoka, et al., 2003; Stein, et al., 2003)를 뒷받침하는 결과이다. 전통적인 인지행동치료 프로그램에서는 언어적 접근의 인지적 재구성을 통한 인지적 접근과 함께 이완훈련, 스트레스 대처훈련의 행동적 개입을 같이 실시하였다. 따라서, 이러한 인지행동치료의 통합적 접근으로 이루어진 성과가 우울 감소에 효과적이었던 것으로 예측된다.

(3) 상태-특성 불안

프로그램 실시 후 정서 변인인 상태-특성 불안에서 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 유의한 점수 변화가 나타난 반면, 전통적인 인지행동치료 프로그램은 유의한 점수 변화가 나타나지 않았다. 이러한 결과는 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램이 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 상태-특성 불안의 감소에 효과적임을 의미한다.

구체적으로 살펴보면, 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 정서 변인인 상태-특성 불안에서 유의한 점수 변화가 나타났고, 이 효과는 3개월 후에도 유지되었다. 이는 인지행동치료의 노출훈련이 외상 환자의 불안을 감소시키는데 효과적임을 주장한 선행연구의 결과와 맥을 같이한다(Ehlers, et al., 2005). 이미지 재구성은 노출의 기능 또한 가능하게 하며 대상자로 하여금 과거 대인외상 사건을 회피하지 않고, 직면시킨다. 이때, 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램의 경우 기존의 인지행동치료의 노출 기법의 한계점이 보완된 이미지 재구성을 통해 심상 안에서 노출과 자기위로를 단계적으로 시행하며 안정적으로 불안을 감소시킨다는 장점이 있다. 이처럼 이미지 재구성

을 통해 시행된 불안에 대한 안전한 노출경험이 적응적인 사고 및 신념체계를 더욱 공고히 만들기 때문에 불안이 안정적으로 감소한 것으로 보인다. 또한, 섭식문제 대상자는 아니지만 이미지 재구성으로 사회불안자들의 불안 및 회피 수준을 감소시킨 선행연구의 결과(최윤영, 2018; 최윤영, 권정혜, 2021; Lee & Kwon, 2013)와 맥락을 같이 한다. 선행연구에서는 참여자에게 사회불안을 일으킨 초기의 외상 사건을 이미지 재구성을 실시하여 자동적으로 떠오르는 부정적인 자아상의 인출 패턴을 방해하는 반면에 긍정적인 자아상의 접근성을 강화하고 증가시켰다. 따라서, 선행연구에서 이미지 재구성으로 긍정적 자아상을 형성 및 대체시켜 불안을 감소시킨 것처럼 본 연구에서도 이미지 재구성을 통해 자신의 자아상이 긍정적으로 변화하여 자동적으로 인출되는 부분이 불안을 감소시키는 요인으로 작용했을 가능성이 높다. 또한, 앞서 설명한 선행연구에서는 이미지 재구성으로 불안을 일으킨 초기 사건을 다뤄준 뒤 미래 심상을 통해 자신이 원하는 바를 구체적으로 시뮬레이션 함으로써 사회불안 증상이 효과적으로 개선되었다고 하였다. 이와 같이 이미지 재구성을 통해 사회불안을 감소시킨 것처럼 본 연구에서도 이미지 재구성Ⅱ를 통해 긍정적인 미래 심상을 다뤄준 부분이 참여자들의 불안을 낮추는 데 효과적으로 작용했을 것으로 예상된다.

반면, 전통적인 인지행동치료 프로그램은 정서 변인인 상태-특성 불안에서 유의한 점수 변화가 없었다. 이는 참여자들의 불안의 기원이 초기 대인외상경험과 같이 트라우마적 신념과 결부된 불안이기 때문에 기원이 오래된 핵심신념의 경우 스키마가 단단해졌을 뿐만 아니라 이로 인한 불안의 강도 또한 매우 높았을 것으로 예상된다. 따라서, 상대적으로 기존의 일반화된 불안이나 사회불안보다 강도가 더 센 불안이었기 때문에 비교적 단회기의 프로그램으로는 변화되기 어려우며 본 연구와 같이 정해진 10회기 내에서 언어적인 접근의 치료적 방식만으로는 불안의 감소 효과가 유의하게 나타나지 않았을 것으로 예측된다. 한편, 인지행동치료의 선행연구들에 의하면, 인지적 접근과 행동적 접근의 노출훈련을 병행하였을 때 불안 감소가 매우 효과적이라고 보고하였다(김은정, 원호택, 2000; Emmelkamp, et al., 1985; Gillian, et al., 1984). 실제로 외상을 다루는 인지행동치료의 경우 인지적 개입인 인지적 재구성과 함께 행동적 개입인 노출을 같이 시도하였을 때 더욱 불안이 감소하는 효과가 나타났다(Deville & Spence, 1999; Foa, et al., 2005; Paunovic & Öst, 2001). 따라서, 아동·청소년기 대인외상과 같이 대상자의 불안의 강도가 높은 경우에는 인지적 재구성과 함께 노출훈련

을 병행하는 것이 매우 중요함을 시사한다.

(4) 상태-특성 분노

프로그램 실시 후 정서 변인인 상태-특성 분노에서 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램과 전통적인 인지행동치료 프로그램 모두 유의한 점수 변화가 나타났다. 이러한 결과는 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램과 전통적인 인지행동치료 프로그램 모두 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 상태-특성 분노의 감소에 유의한 영향을 끼친다는 것을 의미한다.

구체적으로 살펴보면, 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 정서 변인인 상태-특성 분노에서 유의한 점수 변화가 나타났고, 이 효과는 3개월 후에도 유지되었다. 이러한 결과는 이미지 재구성을 통해 대인외상경험으로 형성된 초기의 분노에 대한 표출을 도왔기 때문인 것으로 예측된다. 아동·청소년기 대인외상경험자의 경우 대인외상사건에서 가해자를 탓하기보다는 자신을 비난하며 탓하는 경향이 강하며, 당시의 분노를 바깥으로 표출하기 보다는 억압한다(Pearlman & Saakvitne, 1998; Van der Kolk, 2001). 따라서, 이미지 재구성을 통해 심상으로 인지를 재구성하며 자기비난적 사고를 수정하고, 가해자에게 충분한 분노를 표출하거나 응징을 가하도록 하여 정서적 고통감을 줄어들도록 하였다(Prasko, et al., 2012). 이러한 가해자에 대한 직접적인 분노 표출이 분노의 감소에 긍정적인 영향을 끼친 것으로 보인다.

한편, 전통적인 인지행동치료 프로그램도 정서 변인인 상태-특성 분노에서 유의한 점수 변화가 나타났고, 이 효과는 3개월 후에도 유지되었다. 이러한 결과는 전통적인 인지행동치료 프로그램에서 스트레스 대처에 대한 프로그램 구성 시 상대적으로 쉽게 느끼고 더 잘 드러낼 수 있는 외재화된 감정인 분노에 중점을 두었기 때문인 것으로 예상된다. 스트레스는 분노의 주요 원인으로 평가되며, 개인이 스트레스에 어떻게 대처하는가에 따라 스트레스로 인한 분노 발생 여부는 달라질 수 있다(Bodenmann, et al., 2010). 따라서, 전통적인 인지행동치료 프로그램에서는 분노에 초점을 맞춘 스트레스 대처훈련을 통해 참여자로 하여금 스트레스 상황에 효율적으로 대처할 수 있는 전략들을 보유했다는 인식과 적절한 대처전략을 실제로 사용하도록 함으로써 이러한 훈련이 잘 되었기 때문에 분노를 조절하는데 도움을 준 것으로 예상된다(Kassinove &

Eckhardt, 1995).

4) 폭식 증상 감소를 위한 스트레스 대처방식

프로그램 실시 후 행동 변인인 스트레스 대처방식의 문제중심적 대처, 사회적지지 추구, 정서완화적 대처에서 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 모두 유의한 변화가 나타난 반면, 전통적인 인지행동치료 프로그램은 정서완화적 대치를 제외한 문제중심적 대처, 사회적지지 추구에서 유의한 점수 변화가 나타났다. 이러한 결과는 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램과 전통적인 인지행동치료 프로그램 모두 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 적극적으로 문제 자체에 초점을 맞춰 해결하려는 문제중심적 대처와 문제를 해결하는 데 있어서 타인에게 도움을 요청하는 사회적지지 추구의 증가에 효과적임을 의미하며, 소극적으로 상황을 회피하는 정서완화적 대처방식의 감소에 있어서는 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램만이 효과가 있음을 시사한다.

구체적으로 살펴보면, 프로그램 실시 후 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 행동 변인인 스트레스 대처방식의 문제중심적 대처, 사회적지지 추구는 유의한 증가를, 정서완화적 대처는 유의한 감소가 나타났고, 이 효과는 3개월 후에도 유지되었다. 폭식과 같은 이상 섭식자들은 스트레스가 발생하였을 때 문제해결 중심의 대처보다 회피적이고 정서 중심적인 대처 방식으로 폭식을 한다(Bittinger & Smith, 2003; Grilo, et al., 1994; Janzen, et al., 1992). 따라서, 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램에서는 참여자가 문제 상황을 정서적으로 회피하지 않고, 적극적으로 대처하여 폭식 증상을 감소할 수 있도록 이미지 재구성을 활용하여 단계적으로 훈련을 실시하였다. 즉, 초·중반에는 언어적인 소크라테스 기법과 이미지 재구성 I 으로 인지적 개입을 하며 참여자의 사고의 변화에 초점을 맞추고, 후반에는 행동적 개입으로 스트레스 대처훈련을 하며 문제해결기술을 교육 및 실행하는 것에 중점을 두었다. 이후에는 이미지 재구성 II로 폭식을 일으킨 대인관계적 문제 상황과 폭식 상황을 선정하여 미래에 비슷한 사건이 발생한다고 가정하여 스스로 해결하도록 훈련하였다. 이미지 재구성 II의 경우 미래에 대한 긍정적인 결말을 심상을 통해 시뮬레이션하며 상상한 장면이 실제 경험과 같은 정서적 정보를 제공할 수 있는 과정이 되기에(Moulton & Kosslyn, 2009) 참

여자로 하여금 문제중심적으로 대처하는 것에 대한 자신감을 불러일으킨 것으로 보인다. 실제로 부록에 명시된 이미지 재구성Ⅱ 훈련 직후의 참여자들의 회기 소감에 의하면 “떠올리면서 제가 잘 해결해나가는 모습을 보면서 진심으로 즐거웠고, 실제로 그런 일이 생긴다거나 생겼을 때 제가 해볼 수 있는 방법들이 많으니까 제 마음을 든든하게 해주는 것도 있었어요.”, “나중에 비슷한 상황에서 막히면 혼자서 해결해볼 수 있을 것 같아요. 자신감이 생기네요.”, “상상하면서 정말 즐거웠고, 그동안 배웠던 걸 복습하면서 상황을 해결하고, 폭식도 하지 않는 저를 보면서 자신감을 얻었어요.”, “일단 너무 후련하고, 아직도 막 웃음이 나요. 충분히 변할 수 있다는 생각. 나도 할 수 있다는 생각들이 너무 도움이 되는 것 같아요”, “자꾸 해보고 싶다는 생각이 들어요. 저한테 잘했다고 얘기해주고 싶어요.” 등 성공 경험에 대한 긍정적인 기분을 느끼며 앞으로의 문제해결에 대한 자신감을 보였다. 따라서, 이러한 심상을 통한 현실적인 방식이 대상으로 하여금 프로그램의 다양한 인지적, 행동적 구성요소를 구체화하도록 하며 기존의 문제를 회피하는 정서적인 폭식 패턴에서 벗어나 향상된 문제해결 대처전략을 사용하게 되며 문제중심적 대처는 증가한 반면, 정서완화적 대처는 감소하였을 것으로 예상된다. 사회적지지 추구의 경우에는 화상 집단 프로그램의 특성상 전체 집단 토론뿐만 아니라 소수로 이루어진 소그룹 활동이 집단원들 간의 깊이 있는 공감을 불러일으킨 것으로 여겨진다. 또한, 집단원간 서로의 문제 상황을 해결해주기 위한 진심어린 조언 및 구체적인 피드백을 통해 도움을 주고받는 대인관계에서의 긍정적인 지지 경험이 사회적 지지추구를 증가시킨 것으로 보인다.

한편, 전통적인 인지행동치료 프로그램은 스트레스 대처방식의 문제중심적 대처, 사회적지지 추구에서 유의한 점수 변화가 나타났고, 이 효과는 3개월 후에도 유지되었으나, 정서완화적 대처는 유의한 점수 변화가 없었다. 이러한 결과는 참여자들이 스트레스 대처훈련으로 스트레스 상황에 적극적으로 대처하고자 하는 동기와 참여자들과 같이 문제해결기술 및 좋은 소식-나쁜 소식-좋은 소식 등의 대처기술을 함께 연습하고 도우며 당면한 대인관계적 문제와 폭식 상황을 적극적으로 해결하려는 문제중심적 대처력과 사회적지지 추구가 증가한 것으로 보인다. 그러나 정서완화적 대처의 경우에는 앞서 살펴보았듯이 섭식 변인인 부정적 정서로 유발된 섭식동기·섭식행동에서 섭식동기적 측면은 유의한 변화가 없었던 것, 인지 변인인 역기능적 신념과 자아존중감을 효율적으로 변화시키지 못한 부분으로 미루어보아, 참여자가 일상생활에서 자동적

사고 수준에서는 스트레스에 대처하기 위해 적극적으로 문제를 해결하며 스트레스를 경감시키는 것에 일부 도움이 되었으나 초기 대인외상의 핵심신념과 관련된 특정 상황 혹은 불수의적으로 외상 경험의 이미지가 떠오른 상황에서는 여전히 회피적인 정서중심 대처방식이 남아있을 것으로 예상해볼 수 있다. 따라서, 스트레스의 근본적인 원인을 해결하기 위해서는 외상경험과 관련된 사고와 신념 및 사고의 과정인 부정적인 이미지의 변화와 함께 접근하는 것이 효과적임을 시사하는 것으로 볼 수 있다.

5) 폭식 증상 변화의 지속성

프로그램 종결 3개월 후 실시한 추후검사에서 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램만이 섭식(부정적 정서로 유발된 섭식 동기·행동), 인지(역기능적 신념, 부정적 자동적 사고, 자아존중감), 정서(정서조절곤란, 우울, 상태-특성 불안, 상태-특성 분노) 및 행동 변인(스트레스 대처방식)의 효과가 유지되고 있는 것으로 나타났다. 또한, 전체 변인의 사전-사후-추후검사의 점수도 지속적인 감소 추세를 보였다. 이는 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램에 참여한 초기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성이 프로그램 종결 후에도 대안적인 사고를 하고 있으며 심리적 건강을 확보하여 폭식 증상의 감소가 유지되고 있음을 알 수 있다. 즉, 초기 대인외상경험과 폭식장애경향성 모두에 초점을 맞춘 프로그램 구성 요소의 단계적인 접근과 체계성이 참여자의 인지, 정서, 행동에 영향을 미치고, 다시 이러한 세 가지 측면들이 서로에게 상호작용 함으로써 궁극적으로 폭식 증상의 감소를 유지하는 것에 효과적이었을 것으로 예측된다.

구체적으로, 핵심적 치료 구성 요소인 이미지 재구성을 통한 사고 및 핵심신념의 인지 수정이 참여자로 하여금 효과적인 정서조절을 가능하게 해주었으며(Taylor, et al., 1998), 이러한 향상된 정서조절능력이 프로그램 종결 후에도 참여자의 폭식 증상 감소에 지속적인 영향을 준 것으로 보인다. 이는 이미지 재구성을 통해 변화된 핵심신념이 추후까지 유지되어 부정 정서를 감소시켰다는 선행연구들을 뒷받침하는 결과이다(안정광, 2017; 윤혜영, 권정혜, 2020; Wild, et al., 2008). 이미지 재구성 인지행동치료의 참여자들이 인지적 특성인 역기능적 신념과 부정적 자동적 사고, 자아존중감의 변화를 유지하고 있다는 것은 프로그램이 종결된 후에도 끊임없이 사고 및 신념의 변

화를 일상생활에 적용하고 있음을 추측해볼 수 있다. 이는 부적응적인 사고가 참여자로 하여금 자신의 삶에 어떠한 영향을 미치는지 스스로 점검하며 수정하는 활동이 참여자의 사고변화에 관여하였을 뿐만 아니라 그 효과를 유지시키고 있는 것으로 보인다. 같은 맥락에서, 연구자가 제안만 하였을 뿐 과제물로 제시하지는 않았으나 이미지 재구성 I을 처음 시행한 뒤 대부분의 참여자들이 자신의 부정 정서를 바꾸기 위해 스스로 이미지 재구성을 반복적으로 연습하였는데 참여자들의 보고에 의하면, 혼자 이미지 재구성을 하였을 때도 큰 위로와 위안을 얻게 되며 처음에 했던 부적응적인 사고를 다시금 생각해볼 수 있는 계기가 되어 정서조절에 도움이 되었다고 하였다. 또한, 이미지 재구성 II의 경우에도 문제 상황을 긍정적인 결말로 해결하는 시뮬레이션 훈련이 개인의 적응적인 인지를 강화하고, 이는 긍정적인 정서를 느끼도록 하므로 행동대처전략에 있어 정서에 압도되지 않고 보다 현실적인 계획 세우기가 용이하였을 것으로 추정된다. 따라서, 정서조절 및 대처방안을 찾는 것에 도움이 되어 이러한 방향성이 개인의 자신감을 증진시키고, 이는 훈련된 것들을 실제 행동으로 이행하는 확률을 높였을 것이다(Libby, et al., 2007). 이러한 이미지 재구성 I, II를 통한 훈련이 참여자로 하여금 스스로 치료자가 될 수 있게 하였으므로 현재의 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖추도록 하여 장기적인 치료적 효과를 유지시켰을 것으로 예측된다. 따라서, 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성들의 폭식 감소 및 장기적인 치료적 효과성을 위해서는 인지, 정서, 행동적 개입 모두에 이미지 재구성을 활용하는 방안이 중요할 것으로 보인다.

2. 사고 및 신념의 변화 내용분석

이미지 재구성 인지행동치료 프로그램 과정에서 나타난 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 아동·청소년기 대인외상경험 및 폭식 관련 사고와 신념의 변화 내용을 분석한 결과, 초기 대인외상경험 및 폭식과 관련된 자기 지각 및 대인 지각과 관련된 사고와 신념의 변화를 살펴볼 수 있었다. 초기 대인외상경험과 관련된 자기 지각에서는 자기비난과 흑백논리 사고가 나타났으며 대인 지각에서는 과잉일반화 사고가 나타났다. 먼저, 자기 지각 중 자기 비난 사고는 대인외상 사건을 자신의 탓으로

돌리거나 외상 사건이 발생하였을 때 대처를 잘하지 못한 자신을 비난하는 것으로 참여자들은 ‘이런 일을 겪은 건 전부 다 내 탓이야, ‘완강하게 거부했다면 이런 일을 겪지 않았을 텐데 대처를 잘하지 못한 내 탓이야’와 같은 부적응적인 사고 및 신념을 보였다. 따라서, 본 프로그램에서는 이미지 재구성 I의 3단계 작업을 통해 초기 대인의 상경험에 대한 심상적 노출(Imaginal Exposure)로 인한 관련 사고 및 정서의 활성화, 기존의 피해(Victimization) 심상을 대처/주도(Cope/Mastery) 심상으로 대체, 기존의 결핍되었던 자기 양육/자기 위로 능력을 향상시키며 왜곡된 자동적 사고 및 신념을 효과적으로 다뤄주었다. 또한, 흑백논리 사고는 자신에 대한 판단이 양극단으로 나뉜 것으로 외상경험자들은 회색지대 없이 자신을 부정적인 방향으로 판단하여 자신을 무가치한 사람으로 인식하였다. 이에 따라 참여자들은 ‘나는 별로고 가치 없는 사람이야’, ‘나는 사랑받을 만하지 않아. 가치 없는 사람이야.’라고 자신을 부정적으로 판단하였다. 따라서, 본 프로그램에서는 언어적인 인지적 재구성, 이미지 재구성, 관점취하기, 증거찾기 등의 기법을 활용하여 사고 및 신념을 수정하여 적응적인 사고방식으로 변화하는 데 도움을 주었다. 대인 지각과 관련된 사고를 살펴보면, 참여자들은 외상 사건 속 가해자에 대한 부정적인 사고를 일반화하여 외상 사건과 전혀 관련이 없는 타인의 의도를 왜곡하며 높은 관계적인 스트레스를 받아 폭식까지 이어지는 악순환적 패턴을 보였다. 따라서, 본 프로그램에서는 이미지 재구성으로 초기 대인의상경험을 재경험하게 하여 어린 시절에 타인과의 부정적인 관계를 다른 사람에 대한 원형적 표상으로 보는 관점을 변화시켰다. 즉, 당시의 상황이 예외적이고, 보편적이지 않은 상황임을 인식시키며 외상 기억 속의 가해자와 다른 사람들은 다름을 일깨워주었다. 이에 따라, 참여자들이 타인에게 가졌던 부적응적인 사고를 적응적인 사고로 전환하게 되어 이후의 인생에서 건강한 대인관계를 형성할 수 있는 발판을 마련해 주었다.

다음으로, 폭식과 관련된 사고에서는 크게 자기 지각, 대인 지각이 있었다. 먼저 자기 지각은 자기비난과 흑백논리 사고가 두드러졌는데 이 두 개의 사고는 대인의상경험과 가장 연결되는 인지 오류로 폭식을 하는 자신을 형편없는 실패자라고 자기비난하거나 폭식을 하지 않으면 성공한 인생, 폭식을 하면 망한 인생이라는 두 개의 범주 중 하나로 분류하는 흑백논리가 있었다. 다음으로, 대인 지각에는 독심술이 있었으며 이는 폭식과 관련하여 타인의 생각과 의도를 자신의 방식으로 추론하여 객관적으로 사고하지 못하는 것이다. 따라서, 본 프로그램에서는 이러한 부적응적 사고들을 수정

하기 위해 증거 점검, 인지적 연속성 기법, 이중기준 점검 기법, 관점 취하기, 소크라테스 기법 등으로 인지적 재구성 작업을 실시하여 합리적인 사고로 변화를 이끌었다.

3. 종합논의

이상의 논의들을 종합해 볼 때 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 위한 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 폭식 증상의 감소에 효과적이었다. 본 프로그램에서는 폭식장애의 기원을 초기 대인외상경험으로 보고 초기 대인외상경험과 폭식 모두에 초점을 맞춰 이와 관련된 사고 및 신념과 관련된 부정적인 이미지인 인지 과정을 인지적 재구성과 이미지 재구성을 결합하여 개입함으로써 상호 보완적으로 인지 내용 및 과정을 수정시켰다. 특히, 심상에 기반한 이미지 재구성의 경우 I, II로 나뉘어 초기 대인외상경험과 관련된 부정적인 사고 및 이미지를 효과적으로 수정시키는 것뿐만 아니라 합리적으로 변화된 적응적인 인지를 미래심상을 통해 강화하였다. 인지행동치료는 인지적 개입이 효과적으로 작용하여 인지 변화가 있을 때 이에 수반된 정서 및 행동의 변화 또한 이루어질 수 있다는 선행연구(Spence, et al., 2000)의 전제에 따라 본 프로그램에서도 대상자의 인지가 적응적으로 변화 및 강화됨에 따라 정서조절곤란 수준이 개선되고, 부정 정서인 우울, 상태-특성 불안, 상태-특성 분노가 감소되었다. 또한, 정서조절과 부정 정서를 위한 이완훈련, 문제 상황을 정서적으로 회피하는 폭식패턴을 적극적으로 문제해결하여 대처할 수 있도록 연습한 스트레스 대처훈련, 섭식DTR일지를 작성하며 폭식에 대한 자기관리를 한 부분들도 대상자의 인지, 정서, 행동적 측면에 영향을 미치며 결국 폭식 증상 감소에 긍정적인 영향을 준 것으로 나타났다. 정리하면, 본 프로그램에서 가장 중점을 둔 이미지 재구성은 외상경험으로 형성된 인지 내용 및 과정을 변화시키고, 이를 강화함으로써 폭식 발생의 근원적 이유를 효과적으로 다루어주었기에 이러한 부분이 일반화가 되어 폭식 증상의 감소에 도움이 되고, 지속적인 폭식 감소의 안정성에도 긍정적인 영향을 준 것으로 보인다.

4. 연구의 의의 및 제언

본 연구의 의의는 다음과 같다.

첫째, 본 연구에서는 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성을 대상으로 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램을 구성, 개발하였다는 데 그 의의가 있다. 특히 폭식에만 초점을 맞춘 선행연구들과는 차별적으로 초기 대인외상경험과 폭식 증상 모두를 다루주며 20, 30대 성인 여성을 대상으로 프로그램을 실시하여 그 효과성을 검증하였으며, 프로그램 종결 3개월 이후에도 프로그램의 효과가 유지되고 있음을 입증하였다는 데 그 의의가 있다. 나아가 본 프로그램에서 개발한 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램이 전통적인 인지행동치료 프로그램에 비해 폭식 증상, 인지적 특성, 정서적 특성, 행동적 특성을 변화시키는 데 더욱 효과적이었음이 밝혀졌다.

둘째, 본 연구에서 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 초기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향자의 폭식 증상뿐만 아니라, 관련된 변인들까지도 변화시켰다. 현재 대부분의 폭식 치료방법들은 대개 폭식 증상 자체를 감소시키는 데만 목적을 두고 있다. 그러나 폭식장애는 폭식 증상뿐만 아니라 정서조절곤란, 우울, 불안, 분노 및 낮은 자아존중감과 같은 다양한 심리적 문제도 함께 나타나므로, 폭식 자체만을 감소시키는 것은 대상자의 심리적 건강과 프로그램의 장기적인 효과성 측면에서 다소 부족할 것이다. 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램은 폭식과 관계가 깊은 다양한 변인들에 대해 효과를 보였으며, 이는 곧 이미지 재구성 인지행동치료 프로그램이 폭식장애경향 대상자들의 심리적 건강을 되찾는 데 충분히 효과적인 프로그램이 될 수 있음을 시사한다.

셋째, 본 연구에서는 기존의 전통적인 인지행동치료가 통상적으로 언어적인 인지적 재구성만으로 인지적 개입을 하는 것과 차별적으로 언어적 접근의 인지적 재구성과 심상적 접근의 이미지 재구성을 체계적으로 결합하여 치료효과 검증을 실시하였으며, 특히 이미지 재구성을 I, II로 나누어 각각의 시점에 따라 과거 대인외상경험과 관련된 인지를 수정한 뒤 미래심상을 통해 수정된 합리적인 인지를 강화시키는 기법을 통해 아동·청소년기 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성의 인지를 보다 효과적으로 다루었다는 것에 의의가 있다.

넷째, 본 연구는 임상적인 문제를 보이지 않는 폭식장애경향자를 대상으로 하여 폭

식장애에 대한 예방적인 차원의 접근이 가능하다는 것에 의의가 있다. 폭식은 일반인에게도 만연하게 나타나지만 이러한 식습관이 반복되면 폭식장애로 발전하게 될 가능성이 높다(Ackard, et al., 2003). 이러한 가능성을 고려할 때, 임상적인 문제를 보이지 않는 폭식장애경향자를 대상으로 프로그램을 진행하였다는 데 의의가 있다.

본 연구의 제한점 및 후속연구를 위한 제언은 다음과 같다.

첫째, 본 연구는 연구에 참여한 대상자 수가 실험, 비교, 통제 집단별로 7명씩 총 21명이므로 프로그램 대상자의 수가 적기 때문에 본 연구를 통해 얻어진 결과를 대인외상경험이 있는 폭식장애경향 성인 여성에게 일반화하는 데 한계가 있다. 따라서 후속연구에서는 집단별로 보다 많은 대상자 수를 포함시켜 본 연구에서 구성된 프로그램을 반복적으로 시행하여 효과를 재검증할 필요가 있다.

둘째, 본 연구에서는 폭식장애경향이 있으며 동시에 초기 대인외상경험이 있는 대상으로 참가자를 한정하였으며, 대인외상경험의 유형에 따라 대상자를 구분하지 않았다. 그러나 대인외상의 경우 학대(신체적, 성적, 정서적, 방임), 성폭행, 배신 충격(사기, 외도 등), 대인관계 적응문제(따돌림, 괴롭힘 등) 등 다양한 유형으로 구분되어지고, 이에 따라 폭식장애경향도 달라질 수 있으므로 추후에는 대상자 선별에서 대인외상 유형을 보다 체계적으로 분류하여 유형별 프로그램을 계획, 실시할 필요성이 있다.

셋째, 본 연구에서는 실험집단과 비교집단의 프로그램 진행자가 본 연구자로 동일하였으므로 프로그램 진행에 상호 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 이러한 부분이 외적타당도와 일반화에 영향을 미쳤을 가능성을 배제할 수 없다. 따라서, 후속 연구에서는 연구보조자의 객관적인 평가 등을 통해 외적 타당도를 저해하는 요인을 최소화할 필요성이 있다.

참 고 문 헌

- 건강보험심사평가원 (2018). 「생활 속 질병통계 100선」.
- 고나래 (2008). 아동, 청소년기 복합외상경험이 정서조절과 대인관계문제에 미치는 영향. 이화여자대학교 대학원 석사학위 청구논문.
- 고아름 (2012). 수용-전념 치료가 죽음관련 외상경험이있는 청소년들의 심리적 고통, 부정적 정서수준 및외상 후 성장에 미치는 영향. 덕성여자대학교 대학원 석사학위 청구논문.
- 고유나 (2016). 아동기 정서적 외상경험이 대학생의 우울 및 불안수준에 미치는 영향-자아탄력성의 조절효과를 중심으로. 청소년복지연구, 18(1), 105-132.
- 고은영 (1997). 분노표현방식과 분노표현의 적절성이 우울에 미치는 영향. 가톨릭대학교 대학원 석사학위 청구논문.
- 공성숙 (2001). 폭식행동자의 인지행동치료 경험에 관한 연구. 정신간호학회지, 10(2), 148-163.
- 권석만 (2013). 현대이상심리학. 서울: 학지사.
- 권석만, 윤호균 (1994). 한국판 자동적 사고척도의 개발과 활용. 학생연구, 29(1), 10-25.
- 권정혜 (2020). 인지행동치료 원리와 기법. 서울: 학지사.
- 권호인, 권정혜 (2003). 폭식 행동을 보이는 여대생의 인지행동 집단치료 효과. 인지행동치료, 3(1), 27-42.
- 권희주 (2014). 고통감내력, 분노반추와 역기능적 분노의 관계: 청소년과 성인집단 비교. 서울여자대학교 석사학위논문.
- 김고은 (2013). 대학생의 자아탄력성과 외상 후 성장의관계: 삶의 의미와 적극적 스트레스 대처의 매개효과. 경상대학교 석사학위논문.
- 김교현, 왕소정 (2000). 학부모와 교사가 지각하는 집단따돌림 현상의 원인과 대책및 배척받는 아동의 심리적 특성. 충남대학교 학생생활연구소, 27, 85-107.
- 김미리혜 (2008). 폭식행동의 이해. 한국심리학회지: 일반, 27(3), 605-619.
- 김보미, 유성은 (2012). 대인관계 외상 경험자들의 사회적 유대감, 정서 조절과 자살생각의 관계. 한국심리학회지, 31(3), 731-748.

- 김연 (2013). **아동기 애착 및 피학대 경험과 대학생의 경계선 성격성향의 관계에서 스트레스대처양식의 매개효과**. 경기대학교 박사학위논문.
- 김은정, 김진숙 (2008). 아동기 정서적 외상경험과 우울수준간의 관계에서 정서조절곤란의 매개효과. **상담학연구**, 9(4), 1505-1520.
- 김은정, 김진숙 (2010). 아동기 외상과 초기 성인기 우울수준과의 관계: 초기부적응도식과 정서표현양가성 및 회피대처방식의 매개효과. **한국심리학회지: 상담 및 심리치료**, 22(3), 605-630.
- 김은정, 원호택 (2000). 안전행동의 감소가 사회공포증 집단의 불안과 부정적 사고에 미치는 영향. **한국심리학회지**, 19(3), 409-425.
- 김정숙 (1994). **스트레스 대처 훈련이 여고생의 불안감소 및 자아실현 경향성에 미치는 효과**. 미간행 석사학위논문, 이화여자대학교 석사학위논문.
- 김정옥 (2000). **섭식장애**. 서울: 학지사.
- 김정택 (1978). **특성불안과 사회성과의 관계: Spielberger 의 STAI 를 중심으로**. 고려대학교 석사학위논문.
- 김정희 (1987). **지각된 스트레스 요인 및 대처양식의 우울에 대한 작용**. 서울대학교 대학원 박사학위논문.
- 김준기 (1997). 폭식증의 인지행동치료. **대한정신약물학회지**, 8(1), 23-41.
- 김중술, 이한주, 한수정 (2003). **사례로 읽는 임상심리학**. 서울: 서울대학교출판문화원.
- 김지숙, 류상희 (2003). 초등학생의 스트레스 요인과 대처양식. **한국실과교육학회지**, 16(1), 105-117.
- 김평화, 윤혜미 (2014). 아동학대가 아동의 우울 및 공격성에 미치는 영향에 대한 수치심의 매개효과. **아동과 권리**, 18(4), 601-620.
- 김현정, 함경애, 이동훈 (2014). 실직자의 가족탄력성과 외상 후 성장의 관계에서 적극적인 대처방식의 매개효과 검증. **한국심리학회지: 상담 및 심리치료**, 26(3), 787-806.
- 김혜인, 신민섭, 김은정 (2012). 정서적 학대 경험과 성인기 심리적 부적응간의 관계: 정서 인식의 어려움과 정서 표현 억제의 매개효과. **정서·행동장애연구**, 28(4), 353-380.
- 김혜은, 박경 (2003). 여성의 우울과 스트레스 대처방식이 폭식행동에 미치는 영향. **한**

- 국심리학회지: 건강, 8(3), 511-524.
- 김희경 (2012). 북한이탈주민의 외상 유형에 따른 복합 PTSD 와 PTSD 증상의 차이. **한국심리학회지: 일반**, 31(4), 1003-1022.
- 노은여 (1997). **결혼생활 만족도와 자아존중감의변동이 기혼 남녀의 우울증상에 미치는 영향**. 고려대학교 석사학위 논문.
- 라영선, 현명호, 차성이, 윤선영 (2009). 정서적 학대와 복합 PTSD 경향성의 관계: 용서의 조절효과를 중심으로. **한국심리학회 학술대회 자료집**, 2009(1), 180-181.
- 박경희 (2006). **외상경험글쓰기의 치료적 효과와 기제: 가정폭력피해 여성을 중심으로**. 서울대학교 박사학위논문.
- 박시현, 김명식 (2014). 지각된 아동· 청소년기 외상경험이 대학생의 대인불안과 우울에 미치는 영향: 내면화된 수침심을 매개변인으로. **영유아아동정신건강연구**, 7(1), 69-86.
- 박애실 (2016). 외상 후 인지가 외상 후 성장에 미치는 영향: 침습적 반추와 의도적 반추의 이중매개효과와 적응적 인지적 정서조절전략의 조절된 매개효과 검증. **상담학연구**, 17(5), 181-200.
- 박은미 (1999). **아동기 학대 및 지각된 부모의 양육태도가 성인기 대인 관계에 미치는 영향에 관한 연구**. 연세대학교 박사학위논문.
- 박정호 (2019). 아동학대에 관한 불교 상담적 접근. **불교상담학연구**, 97-119.
- 박정희 (2012). **자아존중감이 정서조절을 매개로 폭식에 미치는 영향**. 영남대학교 석사학위논문.
- 박주영 (1995). **A · B 성격유형 · 자아정체감 · 스트레스 대처간의 관계연구**. 숙명여자대학교 석사학위논문.
- 박찬섭 (2000). **청소년의 자아개념 및 완벽주의와 섭식장애와의 관계**. 원광대학교 대학원 박사학위 논문.
- 배하영, 이민규 (2004). 부정적 정서로 유발된 섭식동기척도의 개발. **한국심리학회지: 건강**, 9(1), 187-199.
- 백지예 (2020). **대인관계 외상을 경험한 대학생의 심리적 고통감과 관계중독의 관계: 스트레스 대처양식의 병렬매개효과**. 동덕여자대학교 석사학위논문.
- 백지은, 박경애 (2016). **청소년 폭식행동에 대한 인지행동치료 최근 연구동향 및 과제**.

- 인지행동치료, 16(4), 489-515.
- 백희진 (2010). 외상경험 아동의 우울 및 불안완화의 미술치료 사례연구. 영남대학교 석사학위논문.
- 서호준, 채정호 (2006). 외상 후 스트레스 장애에 대한 인지행동치료의 최근 동향. **인지행동치료**, 6(2), 117-129.
- 소원현 (2000). 부정적인 정서가 폭식행동에 미치는 영향. 고려대학교 대학원 석사학위 청구논문.
- 소원현 (2009). 부적 정서가 신경성 폭식자의 과식행동에 미치는 영향. **한국심리학회지: 건강**, 14(2), 419-432.
- 손은정 (2013). 여대생의 사회적으로 부과된 완벽주의와 폭식행동 간의 관계에서 대인관계 불일치, 지각된 사회적지지, 우울의 매개효과. **한국심리학회지: 상담 및 심리치료**, 25(2), 309-330.
- 송승훈, 이홍석, 박준호, 김교현 (2009). 한국판 외상후 성장 척도의 타당도 및 신뢰도 연구. **한국심리학회지: 건강**, 14(1), 193-214.
- 송현, 이영순 (2011). 심리적 강인성과 정서지능이 외상 후 성장에 미치는 영향: 적극적 대처의 매개효과를 중심으로. **상담학연구**, 12(4), 1231-1246.
- 심현진, 권해수 (2013). 대학생의 아동기 대인간 외상경험과 사회불안의 관계에서 내면화된 수치심의 매개효과. **상담학연구**, 14(6), 3709-3722.
- 안정광 (2017). 사회불안장애에 대한 강화된 인지행동 치료의 효과 검증 및 치료 기제 연구. 고려대학교 대학원 박사학위논문.
- 안현의 (2007). 복합외상 (complex trauma) 의 개념과 경험적 근거. **한국심리학회지: 일반**, 26(1), 105-119.
- 안현의, 박철옥, 주혜선 (2012). 외상관련 정서의 확장: 수치심, 죄책감, 분노를 중심으로. **상담학연구**, 13(2), 839-854.
- 안현의, 장진이, 조하나 (2009). 자기체계의 손상으로 본 복합외상증후군. **한국심리학회지: 일반**, 28(2), 283-301.
- 안현의, 한민희, 주혜선 (2013). 외상 후 스트레스 장애의 인지-기억 체계. **한국심리학회지: 상담 및 심리치료**, 25(1), 111-133.
- 양유진, 정경미 (2008). 어머니의 양육태도가 청소년 우울에 미치는 영향: 회피적 정서

- 조절과 정서인식의 명확성을 매개요인으로. **한국심리학회지**, 27(3), 669-688.
- 양윤경 (2018). **여대생을 위한 REBT 기반 폭식행동 관리 프로그램의 개발 및 효과**. 고려대학교 박사학위논문.
- 오경자, 정현강 (2008). 이상 섭식 행동에 영향을 주는 완벽주의 성향과 정서조절 양식에 대한 연구. **한국심리학회지: 건강**, 13(1), 41-55.
- 오유라 (2017). **감각놀이연계 요리활동이 만 2 세 영아의 사회정서행동과 식습관 및 편식행동에 미치는 영향**. 중앙대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 오자영 (2006). **섭식행동에 있어서 정서 수용 및 정서 억제의 효과**. 고려대학교 대학원 석사학위논문.
- 오지원 (2000). **자존감과 고독감 및 스트레스가 대학생의 폭식습관에 미치는 영향**. 가톨릭대학교 석사학위논문.
- 원호택 (1991). 스트레스와 대처방안. **정신건강연구**, 10, 37-50.
- 유진, 김광자 (2002). 무용: 여자 무용수들의 섭식행동과 섭식장애 분석. **한국체육학회지**, 41(5), 501-510.
- 윤경희, 배정규, 임영진 (2014). 대학생 편집성향집단과 우울성향집단의 역기능적사고, 분노사고, 분노표현. **한국심리학회지: 건강**, 19(3), 769-790.
- 윤명숙, 김서현 (2012). 대학생 외상경험이 자살생각에 미치는 영향과 관계만족도의 매개효과분석. **정신건강과 사회복지**, 40(2), 5-31.
- 윤희영, 권정혜 (2010). 사회불안장애의 이미지 재구성 훈련: 이론적 배경과 증례 보고. **인지행동치료**, 10(2), 1-25.
- 윤화영 (1996). **여대생의 폭식행동, 우울 및 귀인양식간의 관계**. 가톨릭대학교 석사학위논문.
- 이근배 (2008). **분노기분에서 반추사고와 반추초점의 효과**. 경북대학교 대학원박사학위논문.
- 이미라 (2005). **점진적 근육이완 훈련이 당뇨병 노인의 스트레스 반응, 자가간호 및 당화혈색소에 미치는 효과**. 서울대학교 박사학위논문.
- 이미현 (2009). **부정적 정서와 폭식행동의 관계: 정서조절곤란의 매개효과를 중심으로**. 성신여자대학교 석사학위논문.
- 이미현, 채규만 (2012). **부정적 정서와 폭식행동의 관계-정서조절곤란의 매개효과를 중**

- 심으로. **인지행동치료**, 12(2), 129-144.
- 이삼연 (2000). 애착이론과 임상사회사업. **정신건강과 사회복지**, 9, 97-125.
- 이수연, 이동훈 (2017). 대학생의 가족 및 타인에 의한 대인외상경험과 심리적 증상의 관계에서 가족기능의 매개효과. **한국심리학회지: 상담 및 심리치료**, 29(2), 451-479.
- 이수진, 장혜인 (2017). 부적응적 완벽주의, 부정정서, 부정적 긴급성이 여자 대학생의 신경성 폭식증 증상에 미치는 영향. **한국심리학회지**, 36(2), 192-205.
- 이슬기 (2015). **외상 후 인지와 외상 후 성장의 관계에서 스트레스 대처방식의 조절 효과: 대인관계적 외상을 중심으로**. 대전대학교 석사학위논문.
- 이아람, 김남재 (2012). 복합외상경험과 경계선 성격특성의 관계에서 자기개념의 중재 효과와 매개효과. **한국심리학회지: 여성**, 17(2), 227-243.
- 이영호, 송종용 (1991). BDI, SDS, MMPI-D 척도의 신뢰도 및 타당도에 대한 연구. **한국심리학회지**, 10(1), 98-113.
- 이유경 (2006). **여대생의 아동기 외상경험이 심리적 증상과 대인관계문제에 미치는 영향**. 이화여자대학교 석사학위논문.
- 이유미 (2013). **특성불안과 내면화된 수치심의 관계에서 자기자비심의 조절효과**. 이화여자대학교 석사학위논문.
- 이정민 (2019). **복합 PTSD 위험군의 외상 기억 처리과정에서 지시적 심상화의 자가 치료 효과**. 서울대학교 박사학위논문.
- 이정애 (1997). **폭식행동 집단의 인지적 특성**. 고려대학교 석사학위논문.
- 이정운, 최정훈 (1996). 사회불안증에 대한 인지행동치료와 노출치료의 효과연구. **한국심리학회 학술대회 자료집**, 1996(1), 583-598.
- 이진희, 황순택, 김준기, 배재현 (1999). **폭식행동집단의 성격특질**. 충북대학교 석사학위 논문.
- 이태영, 심혜숙 (2011). 아동기 외상경험이 초기 성인기 대인관계문제에 미치는 영향에서 내면화된 수치심의 매개효과. **상담학연구**, 12(6), 2273-2291.
- 이현승 (2019). **대인관계 인지왜곡과 외로움이 문제성 인터넷 사용에 미치는 영향: 스트레스 대처전략의 조절된 매개효과**. 계명대학교 석사학위논문.
- 이형주, 최해림 (2010). 상담자의 공감, 상태-특성불안, 완벽주의 부정적 결과가 심리적

- 소진에 미치는 영향. **인간이해**, 31(1), 29-45.
- 임선영, 최혜라, 권석만 (2007). 사후반추사고가 사회적 자기효능감 및 예기불안에 미치는 영향. **한국심리학회지**, 26(1), 39-56.
- 임지수, 박경 (2018). 분노표현양식이 폭식행동에 미치는 영향: 부정정서 조급성의 매개효과. **한국심리학회지**, 37(4), 491-502.
- 임혜은 (2021). **청소년의 아동학대경험이 경험회피, 사회불안 및 분노억제를 통해 전위된 공격행동에 미치는 영향**. 이화여자대학교 박사학위논문.
- 장혜경, 손정남 (2014). 여대생의 외모스트레스, 자아탄력성, 대인관계 및 우울이 섭식 태도에 미치는 영향. **기본간호학회지**, 21(3), 235-242.
- 정새봄 (2012). **군장병의 외상경험과 불안, 우울, 군적응**. 경북대학교 석사학위 논문.
- 정진영, 이훈진, 박세란 (2019). 정서적 취약성과 스트레스, 신체불만족이 정서적 섭식과 신경성 폭식경향에 미치는 영향: 여자 대학생을 중심으로. **한국심리학회지: 임상심리 연구와 실제**, 5(1), 39-63.
- 정호준, 안정광, 권정혜 (2017). 집단따돌림이 가해염려 사회불안에 미치는 영향: 자기표상, 분노표현, 추론편향의 매개효과. **인지행동치료**, 17(3), 315-339.
- 정희진 (2015). **여대생의 사회불안, 분노억제와 우울 및 폭식행동의 관계**. 이화여자대학교 석사학위논문.
- 조용래 (2000). 발표불안에 대한 인지적 평가: 자동적 사고 질문지의 개발 및 타당화. **한국심리학회지**, 19(4), 831-851.
- 조용래 (2001). 불안장애에 대한 노출치료: 비판적 분석, 작용기제 및 개선방안. **한국심리학회지: 일반**, 20(1), 229-257.
- 조용래 (2007). 정서조절곤란의 평가: 한국판 척도의 심리측정적 속성. **한국심리학회지: 임상**, 26(4), 1015-1038.
- 조용래, 원호택 (1999). 사회공포증에 대한 인지적 평가 3: 역기능적 신념검사의 개발 및 타당화. **한국심리학회지**, 18(1), 141-162.
- 조은정, 이기학 (2004). 아동기의 정서적 학대 경험의 대인관계 문제해결능력에 미치는 영향. **상담학연구**, 5(3), 583-595.
- 조재희 (2017). **편집성향과 역기능적 분노표현의 관계: 내면화된 수치심과 탈중심화의 간접(매개)효과**. 경상대학교 석사학위논문.

- 조한익, 최종환 (2013). 아동기 정서적 외상이 초기 성인기 역기능적 분노표현에 미치는 영향에서 부정적 용서신념의 매개효과. **청소년학연구**, 20(9), 125-148.
- 조현주, 현명호 (2011). 자기비판과 우울관계에서 지각된 스트레스와 자기자비 효과. **한국심리학회지: 건강**, 16(1), 49-62.
- 조혜나 (2016). **아동기 외상과 폭식행동의 관계: FFFS, 정서조절곤란, 해리의 매개효과를 중심으로**. 대구가톨릭대학교 박사학위논문.
- 채정호 (2004). 외상 후 스트레스 장애의 진단과 병태 생리. **대한정신약물학회지**, 15, 14-21.
- 최나운, 이영호 (2018). 아동기 외상이 초기 성인기 대인관계 문제에 미치는 영향: 초기부적응도식과 자기개념 및 정서조절곤란의 매개효과. **청소년학연구**, 25(2), 137-166.
- 최성일, 김중술, 신민섭, 조맹제 (2001). 분노표현방식과 우울 및 신체화 증상과의 관계. **신경정신의학**, 40(3).
- 최승미 (2008). **외상 후 성장 관련 변인의 탐색**. 고려대학교 박사학위논문.
- 최승혜 (2018). **여자 대학생의 대인관계 스트레스와 폭식 행동의 관계에서 회복탄력성의 조절효과**. 전북대학교 석사학위논문.
- 최윤경 (2010). 외상후 스트레스 장애에서 지속노출치료의 효과에 대한 예비 연구. **인지행동치료**, 10(1), 97-116.
- 최윤영 (2018). **사회불안장애에 대한 강화된 이미지 재구성 치료효과 및 치료기제 검증: 자기심상과 미래심상을 중심으로**. 고려대학교 박사학위논문.
- 최윤영, 권정혜 (2021). 사회불안장애에 대한 이미지 재구성 치료와 강화된 이미지 재구성 치료의 효과 비교. **인지행동치료**, 21(2), 255-291.
- 최은영, 안현의 (2011). 여대생의 아동 청소년기 대인간 외상 경험과 자기역량 손상의 관계에서 내면화된 수치심의 매개효과. **한국심리학회지: 여성**, 16(3), 285-302.
- 최지영, 오경자 (2015). 누적 아동기 외상이 성폭력 피해 아동의 정서조절과 외상후 스트레스장애 증상에 미치는 영향. **한국심리학회지**, 34(1), 61-75.
- 하예지, 서미경 (2014). 데이트 폭력 인식과 폭력경험에 관한 연구. **사회과학연구**, 30(4), 79-103.
- 한기백 (2021). 여자 대학생이 지각한 아동기 모의 양육 태도와 신경증적 폭식 행동의

- 관계: 자기 존중감, 부적응적 완벽주의, 불안 성인 애착, 우울의 매개 효과. **한국아동심리치료학회지**, 16(3), 19-40.
- 한덕웅, 이창호, 전겸구 (1996). Spielberger 의 상태-특성 불안검사 Y 형의 개발. **한국심리학회지: 건강**, 1(1), 1-14.
- 한덕웅, 이창호, 탁진국 (1993). Spielberger 상태-특성 불안 검사의 표준화. **한국심리학회 학술대회 자료집**, 1993(1), 505-512.
- 한덕웅, 전겸구, 이창호 (1997). 한국판 STAXI 척도 개발: 분노와 혈압. **한국심리학회지: 건강**, 2(1), 60-78.
- 한수경, 정남운 (2014). 대인간 외상경험이 대인관계문제에 미치는 영향에서 자기체계 손상의 매개효과. **인간이해**, 35(1), 149-168.
- 한유정 (2004). **여대생의 아동기 학대경험과 스트레스 대처방식의 관계**. 숙명여자대학교 석사학위논문.
- 한진화 (2003). **신경성 폭식증의 인지행동집단치료 효과**. 덕성여자대학교 석사학위논문.
- 함진선, 이장한 (2012). 특질 불안 경향자의 위협자극에 대한 주의편향 연구: 안구운동 추적장비를 이용하여. **한국심리학회지**, 31(1), 355-371.
- 허정윤, 유영달 (2012). 아동기 정서적 외상경험이 대학생의 정신건강과 삶의 만족도에 미치는 영향: 자아존중감을 매개변인으로. **가족과 문화**, 24(1), 178-212.
- 홍세희, 조용래 (2006). 역기능적 신념검사 단축판의 구성: Rasch 평정척도모형의 적용. **한국심리학회지**, 25(3), 865-880.
- 황은수, 성영혜 (2006). 아동의 학대경험이 우울과 불안에 영향을 미치는 자기인식정서의 매개효과. **놀이치료연구-한국놀이치료학회**, 9(2), 73-89.
- Abraham, S. F., & Beumont, P. J. V. (1982). How patients describe bulimia or binge eating. *Psychological medicine*, 12(3), 625-635.
- Ackard, D. M., Neumark-Sztainer, D., Story, M., & Perry, C. (2003). Overeating among adolescents: prevalence and associations with weight-related characteristics and psychological health. *Pediatrics*, 111(1), 67-74.
- Afifi, T. O., Asmundson, G. J. G., Taylor S., & Jang, K. L. (2010). The role of genes and environment on trauma exposure and posttraumatic stress

- disorder symptoms: A review of twin studies. *Clinical Psychology Review*, 30(1), 101-112.
- Agabi, C. E., & Wilson, J. P. (2005). Trauma, PTSD, and resilience. *Trauma, Violence, and Abuse*, 6(3), 195-216.
- Agras, W. S., Crow, S. J., Halmi, K. A., Mitchell, J. E., Wilson, G. T., & Kraemer, H. C. (2000). Outcome predictors for the cognitive behavior treatment of bulimia nervosa: Data from a multisite study. *American Journal of Psychiatry*, 157(8), 1302-1308.
- Agras, W. S., & Telch, C. F. (1998). The effects of caloric deprivation and negative affect on binge eating obese binge-eating disordered women. *Behavior Therapy*, 29(3), 491-503.
- Agras, W. S., Telch, C. F., Arnow, B., Eldredge, K., & Marnell, M. (1997). One-year follow-up of cognitive-behavioral therapy for obese individuals with binge eating disorder. *Journal of consulting and Clinical Psychology*, 65(2), 343.
- Agras, W. S., Walsh, B. T., Fairburn, C. G., Wilson, G. T., & Kraemer, H. C. (2000). A multicenter comparison of cognitive-behavioral therapy and interpersonal psychotherapy for bulimia nervosa. *Archives of General Psychiatry*, 57(5), 459-466.
- Allen, J. G. (1995). The spectrum of accuracy in memories of childhood trauma. *Harvard review of psychiatry*, 3(2), 84-95.
- Allen, J. G. (2008). *Coping with trauma: Hope through understanding*. American Psychiatric Pub.
- Amianto, F., Ottone, L., Daga, G. A., & Fassino, S. (2015). Binge-eating disorder diagnosis and treatment: a recap in front of DSM-5. *BMC psychiatry*, 15(1), 1-22.
- Arnow, B., Kenardy, J., & Agras, W. S. (1992). Binge eating among the obese: A descriptive study. *Journal of behavioral medicine*, 15(2), 155-170.
- Arnow, B., Kenardy, J., & Agras, W. S. (1995). The Emotional Eating Scale: The

- development of a measure to assess coping with negative affect by eating. *International Journal of Eating Disorders*, 18(1), 79–90.
- Arntz, A. (2011). Imagery rescripting for personality disorders. *Cognitive and Behavioral Practice*, 18(4), 466–481.
- Arntz, A. (2012). Imagery rescripting as a therapeutic technique: Review of clinical trials, basic studies, and research agenda. *Journal of Experimental Psychopathology*, 3(2), 189–208.
- Arntz, A., Thoma, T. C., & McKay, D. (2014). Imagery rescripting for posttraumatic stress disorder. *Working with emotion in cognitive-behavioral therapy: Techniques for clinical practice*, 203–215.
- Arntz, A., Tiesema, M., & Kindt, M. (2007). Treatment of PTSD: A comparison of imaginal exposure with and without imagery rescripting. *Journal of behavior therapy and experimental psychiatry*, 38(4), 345–370.
- Arntz, A., & Weertman, A. (1999). Treatment of childhood memories: Theory and practice. *Behaviour research and therapy*, 37(8), 715–740.
- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)*. Washington DC: APA.
- Beck, A. T. (1963). Thinking and depression: I. Idiosyncratic content and cognitive distortions. *Archives of general psychiatry*, 9(4), 324–333.
- Beck, A. T. (1964). Thinking and depression: Theory and therapy. *Archives of General Psychiatry*, 10, 561–571.
- Beck, A. T. (1967). *Depression: Clinical, experimental, and theoretical aspects*. University of Pennsylvania Press.
- Beck, A. T. (1979). *Cognitive therapy and the emotional disorders*. Penguin.
- Beck, A. T. (1985). Cognitive therapy, behavior therapy, psychoanalysis, and pharmacotherapy. In *Cognition and psychotherapy* (pp. 325–347). Springer, Boston, MA.
- Beck, A. T., & Clark, D. A. (1997). An information processing model of anxiety: Automatic and strategic processes. *Behaviour research and therapy*, 35(1),

49-58.

- Beck, A. T., Emery, G., & Greenberg, R. L. (1985). *Anxiety disorders and phobias: A cognitive perspective*. Greenburg: New York, NY, USA.
- Beck, A. T., Emery, G., & Greenberg, R. L. (2005). *Anxiety disorders and phobias: A cognitive perspective*. basic Books.
- Beck, A. T., Freeman, A., & Davis, D. (1990). *Associates. Cognitive therapy of personality disorders*. New York: Guilford.
- Beck, A. T., Steer, R. A., & Carbin, M. G. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. *Clinical psychology review*, 8(1), 77-100.
- Beck, J. S., & Beck, A. T. (1995). *Cognitive therapy: Basics and beyond*. New York: Guilford press.
- Bodell, L. P., Brown, T. A., & Keel, P. K. (2012). The impact of bulimic syndromes, mood and anxiety disorders and their comorbidity on psychosocial impairment: what drives impairment in comorbidity?. *European Eating Disorders Review*, 20(1), 74-79.
- Bittinger, J. N., & Smith, J. E. (2003). Mediating and moderating effects of stress perception and situation type on coping responses in women with disordered eating. *Eating Behaviors*, 4(1), 89-106.
- Bodenmann, G., Meuwly, N., Bradbury, T. N., Gmelch, S., & Ledermann, T. (2010). Stress, anger, and verbal aggression in intimate relationships: Moderating effects of individual and dyadic coping. *Journal of Social and Personal Relationships*, 27(3), 408-424.
- Bolton, D., & Hill, J. (1996). *Mind, meaning, and mental disorder: The nature of causal explanation in psychology and psychiatry*. Oxford University Press.
- Bosch, A., Miltenberger, R. G., Gross, A., Knudson, P., & Breitwieser, C. B. (2008). Evaluation of extinction as a functional treatment for binge eating. *Behavior modification*, 32(4), 556-576.
- Brewerton, T. D. (2007). *Eating disorders, trauma, and comorbidity: Focus on*

- PTSD. *Eating disorders*, 15(4), 285-304.
- Brewin, C. R. (2006). Understanding cognitive behaviour therapy: A retrieval competition account. *Behaviour research and therapy*, 44(6), 765-784.
- Brewin, C. R., Dalgleish, T., & Joseph, S. (1996). A dual representation theory of posttraumatic stress disorder. *Psychological review*, 103(4), 670-686.
- Brewin, C. R., Gregory, J. D., Lipton, M., & Burgess, N. (2010). Intrusive images in psychological disorders: characteristics, neural mechanisms, and treatment implications. *Psychological review*, 117(1), 210-232.
- Brewin, C. R., Reynolds, M., & Tata, P. (1999). Autobiographical memory processes and the course of depression. *Journal of abnormal psychology*, 108(3), 511-517.
- Brewin, C. R., Wheatley, J., Patel, T., Fearon, P., Hackmann, A., Wells, A., Fisher, P., & Myers, S. (2009). Imagery rescripting as a brief stand-alone treatment for depressed patients with intrusive memories. *Behaviour research and therapy*, 47(7), 569-576.
- Briere, J. (1996). Trauma symptom checklist for children. *Odessa, FL: Psychological Assessment Resources*, 00253-8.
- Briere, J., & Runtz, M. (1988). Multivariate correlates of childhood psychological and physical maltreatment among university women. *Child abuse & neglect*, 12(3), 331-341.
- Brown, T. A., & Keel, P. K. (2012). Current and emerging directions in the treatment of eating disorders. *Substance abuse: research and treatment*, 6(4), 33-61.
- Browne, C., & Winkelman, C. (2007). The effect of childhood trauma on later psychological adjustment. *Journal of Interpersonal Violence*, 22(6), 684-697.
- Browne, D. (2002). Coping alone: Examining the prospects of adolescent victims of child abuse placed in foster care. *Journal of Youth and Adolescence*, 31(1), 57-66.
- Brunner, R. L., Maloney, M. J., Daniels, S., Mays, W., & Farrell, M. (1989). A controlled study of type A behavior and psychophysiologic responses to stress in anorexia nervosa. *Psychiatry research*, 30(2), 223-230.
- Brytek-Matera, A. (2008). Mood and emotional symptoms in eating disordered

- patients. *Archives of Psychiatry and Psychotherapy*, 2008(iss. 2), 65-71.
- Bulik, C. M., Sullivan, P. F., Carter, F. A., McIntosh, V. V., & Joyce, P. R. (1998). The role of exposure with response prevention in the cognitive-behavioural therapy for bulimia nervosa. *Psychological Medicine*, 28(3), 611-623.
- Bulik, C. M., Sullivan, P. F., & Kendler, K. S. (2002). Medical and psychiatric morbidity in obese women with and without binge eating. *International Journal of Eating Disorders*, 32(1), 72-78.
- Burns, E. E., Fischer, S., Jackson, J. L., & Harding, H. G. (2012). Deficits in emotion regulation mediate the relationship between childhood abuse and later eating disorder symptoms. *Child abuse & neglect*, 36(1), 32-39.
- Butler, G., Fennell, M., & Hackmann, A. (2010). *Cognitive-behavioral therapy for anxiety disorders: Mastering clinical challenges*. Guilford Press.
- Button, E. J., Chadalavada, B., & Palmer, R. L. (2010). Mortality and predictors of death in a cohort of patients presenting to an eating disorders service. *International Journal of Eating Disorders*, 43(5), 387-392.
- Button, E. J., Sonuga-Barke, E. J. S., Davies, J., & Thompson, M. (1996). A prospective study of self esteem in the prediction of eating problems in adolescent schoolgirls: Questionnaire findings. *British Journal of Clinical Psychology*, 35(2), 193-203.
- Campbell, J. D., Chew, B., & Scratchley, L. S. (1991). Cognitive and emotional reactions to daily events: The effects of self esteem and self complexity. *Journal of personality*, 59(3), 473-505.
- Carroll, J. S. (1978). The effect of imagining an event on expectations for the event: An interpretation in terms of the availability heuristic. *Journal of experimental social psychology*, 14(1), 88-96.
- Chua, J. L., Touyz, S., & Hill, A. J. (2004). Negative mood-induced overeating in obese binge eaters: an experimental study. *International Journal of Obesity*, 28(4), 606-610.
- Cicchetti, D., & Toth, S. L. (1992). The role of developmental theory in prevention

- and intervention. *Development and Psychopathology*, 4(4), 489-493.
- Clancy, C. P., Graybeal, A., Tompson, W. P., Badgett, K. S., Feldman, M. E., Calhoun, P. S., . . . Beckham, J. C. (2006). Lifetime trauma exposure in veterans with military-related posttraumatic Stress disorder: Association with current symptomatology. *Journal of Clinical Psychiatry*, 67(9), 1346-1353.
- Cloitre, M., Miranda, R., Stovall-McClough, K. C., & Han, H. (2005). Beyond PTSD: Emotion regulation and interpersonal problems as predictors of functional impairment in survivors of childhood abuse. *Behavior therapy*, 36(2), 119-124.
- Cockell, S. J., Zaitsoff, S. L., & Geller, J. (2004). Maintaining change following eating disorder treatment. *Professional Psychology: Research and Practice*, 35(5), 527-534.
- Cole, P. M., Michel, M. K., & Teti, L. O. D. (1994). The development of emotion regulation and dysregulation: A clinical perspective. *Monographs of the society for research in child development*, 59(2-3), 73-102.
- Cole, P. M., & Putnam, F. W. (1992). Effect of incest on self and social functioning: A developmental psychopathology perspective. *Journal of consulting and clinical psychology*, 60(2), 174-184.
- Confalonieri, L., Sassaroli, S., Alighieri, S., Cattaneo, S., Pozzato, M., Sacco, M., & Ruggiero, G. M. (2013). Intuitive Heuristics Linking Perfectionism, Control, and Beliefs Regarding Body Shape in Eating Disorders. *Psychological Studies*, 58(3), 265-275.
- Conrad, A., & Roth, W. T. (2007). Muscle relaxation therapy for anxiety disorders: it works but how?. *Journal of anxiety disorders*, 21(3), 243-264.
- Conway, M. A. (2001). Phenomenological records and the self-memory system. *Time and memory: Issues in philosophy and psychology*, 235-255.
- Conway, M., Meares, K., & Standart, S. (2004). Images and goals. *Memory*, 12(4), 525-531.

- Conway, M. A., & Pleydell-Pearce, C. W. (2000). The construction of autobiographical memories in the self-memory system. *Psychological review*, 107(2), 261-288.
- Cooper, M. J. (2005). Cognitive theory in anorexia nervosa and bulimia nervosa: Progress, development and future directions. *Clinical psychology review*, 25(4), 511-531.
- Cooper, M. J. (2011). Working with imagery to modify core beliefs in people with eating disorders: A clinical protocol. *Cognitive and Behavioral Practice*, 18(4), 454-465.
- Cooper, M. J., & Fairburn, C. G. (1993). Demographic and clinical correlates of selective information processing in patients with bulimia nervosa. *International Journal of Eating Disorders*, 13(1), 109-116.
- Cooper, M. J., Todd, G., & Turner, H. (2007). The effects of using imagery to modify core emotional beliefs in bulimia nervosa: An experimental pilot study. *Journal of Cognitive Psychotherapy*, 21(2), 117-122.
- Cooper, Z., Fairburn, C. G., & Hawker, D. M. (2003). *Cognitive-behavioral treatment of obesity: A clinician's guide*. New York: Guilford Press.
- Coopersmith, S. (1967). *The antecedents of self-esteem*. San Francisco : Freeman.
- Craighead, W. L., Martinez, A. M., & Klump, L. K. (2013). *Bulimia nervosa and binge eating disorder*. In E. E. Craighead, J. D. Miklowitz, & W. L. Craighead (Eds.), *Psychopathology (2th ed.)* (pp. 445-481). NJ: John Wiley & Sons, Inc.
- Croll, J., Neumark-Sztainer, D., Story, M., & Ireland, M. (2002). Prevalence and risk and protective factors related to disordered eating behaviors among adolescents: relationship to gender and ethnicity. *Journal of Adolescent Health*, 31, 166-175.
- Courtois, C. A., & Ford, J. D. (Eds.). (2009). *Treating complex traumatic stress disorders: An evidence-based guide*. Guilford Press.
- Dadds, M. R., Bovbjerg, D. H., Redd, W. H., & Cutmore, T. R. (1997). Imagery in

- human classical conditioning. *Psychological bulletin*, 122(1), 89-103.
- D'Andrea, W., Ford, J., Stolbach, B., Spinazzola, J., & van der Kolk, B. A. (2012). Understanding interpersonal trauma in children: Why we need a developmentally appropriate trauma diagnosis. *American Journal of Orthopsychiatry*, 82(2), 187-200.
- Danner, U. N., Sternheim, L., & Evers, C. (2014). The importance of distinguishing between the different eating disorders (sub)types when assessing emotion regulation strategies. *Psychiatry Research*, 215(3), 727-732.
- Darcy, A. M., & Dooley, B. (2007). A clinical profile of participants in an online support group. *European Eating Disorders Review: The Professional Journal of the Eating Disorders Association*, 15(3), 185-195.
- D'Argembeau, A., & Van der Linden, M. (2006). Individual differences in the phenomenology of mental time travel: The effect of vivid visual imagery and emotion regulation strategies. *Consciousness and cognition*, 15(2), 342-350.
- Davilly, G. J., & Spence, S. H. (1999). The relative efficacy and treatment distress of EMDR and a cognitive-behavior trauma treatment protocol in the amelioration of posttraumatic stress disorder. *Journal of anxiety disorders*, 13(1-2), 131-157.
- Didie, E. R., & Fitzgibbon, M. (2005). Binge eating and psychological distress: Is the degree of obesity a factor?. *Eating Behaviors*, 6(1), 35-41.
- Dingemans, A. E., Bruna, M. J., & Van Furth, E. F. (2002). Binge eating disorder: a review. *International journal of obesity*, 26(3), 299-307.
- Domar, A. D. (2004). Impact of psychological factors on dropout rates in insured infertility patients. *Fertility and sterility*, 81(2), 271-273.
- Dorairaj, K., Thompson, K., Wilksch, S., Wade, T., Paxton, S., Austin, S. B., & Byrne, S. (2013). Risk factors for eating disorders: investigating the relationships between global self-esteem, body-specific self-esteem and dietary restraint. *Journal of Eating Disorders*, 1(1), 1-1.

- Drapeau, M., & Perry, J. C. (2004). Childhood trauma and adult interpersonal functioning: A study using the Core Conflictual Relationship Theme Method (CCRT). *Child abuse & neglect*, 28(10), 1049-1066.
- Dugué, R., Renner, F., Austermann, M., Tuschen Caffier, B., & Jacob, G. A. (2019). Imagery rescripting in individuals with binge eating behavior: An experimental proof of concept study. *International Journal of Eating Disorders*, 52(2), 183-188.
- Ehlers, A., & Clark, D. M. (2000). A Cognitive model of posttraumatic stress disorder. *Behaviour Research and Therapy*, 38(4), 319-345.
- Ehlers, A., Clark, D. M., Hackmann, A., McManus, F., & Fennell, M. (2005). Cognitive therapy for post-traumatic stress disorder: development and evaluation. *Behaviour research and therapy*, 43(4), 413-431.
- Ehlers, A., & Steil, R. (1995). Maintenance of intrusive memories in posttraumatic stress disorder: A cognitive approach. *Behavioural and cognitive psychotherapy*, 23(3), 217-249.
- Ehring, T., & Quack, D. (2010). Emotion regulation difficulties in trauma survivors: The role of trauma type and PTSD symptom severity. *Behavior therapy*, 41(4), 587-598.
- Eisen, A. R., & Silverman, W. K. (1993). Should I relax or change my thoughts? A preliminary examination of cognitive therapy, relaxation training, and their combination with overanxious children. *Journal of Cognitive Psychotherapy*, 7(4), 265-279.
- Elmore, D. K., & de Castro, J. M. (1990). Self rated moods and hunger in relation to spontaneous eating behavior in bulimics, recovered bulimics, and normals. *International Journal of Eating Disorders*, 9(2), 179-190.
- Emmelkamp, P. M., Mersch, P. P., & Vissia, E. (1985). The external validity of analogue outcome research: Evaluation of cognitive and behavioral interventions. *Behaviour research and therapy*, 23(1), 83-86.
- Evers, C., Stok, M. F., & de Ridder, D. T. (2010). Feeding your feelings: Emotion

- regulation strategies and emotional eating. *Personality and social psychology bulletin*, 36(6), 792-804.
- Fairburn, C. (1981). A cognitive behavioural approach to the treatment of bulimia. *Psychological medicine*, 11(4), 707-711.
- Fairburn, C. G. (1995). *Overcoming binge eating*. Guilford Press.
- Fairburn, C. G. (1988). The current status of the psychological treatments for bulimia nervosa. *Journal of Psychosomatic Research*, 32(6), 635-645.
- Fairburn, C. G., Bailey-Straebl, S., Basden, S., Doll, H. A., Jones, R., Murphy, R., O'Connor, M. E., & Cooper, Z. (2015). A transdiagnostic comparison of enhanced cognitive behaviour therapy (CBT-E) and interpersonal psychotherapy in the treatment of eating disorders. *Behaviour research and therapy*, 70, 64-71.
- Fairburn, C. G., & Cooper, P. J. (1989). *Cognitive behavior therapy for psychiatric problems: A practical guide* (pp. 277-314). Oxford University Press.
- Fairburn, C. G., Cooper, Z., Doll, H. A., & Welch, S. L. (1999). Risk factors for anorexia nervosa: three integrated case-control comparisons. *Archives of general psychiatry*, 56(5), 468-476.
- Fairburn, C. G., Cooper, Z., & Shafran, R. (2003). Cognitive behaviour therapy for eating disorders: A “transdiagnostic” theory and treatment. *Behaviour research and therapy*, 41(5), 509-528.
- Fairburn, C. G., & Harrison, P. J. (2003). Risk factors for anorexia nervosa. *The Lancet*, 361(9372), 1914.
- Fairburn, C. G., Jones, R., Peveler, R. C., Carr, S. J., Solomon, R. A., O'Connor, M. E., Burton, J., & Hope, R. A. (1991). Three psychological treatments for bulimia nervosa: A comparative trial. *Archives of General Psychiatry*, 48(5), 463-469.
- Fairburn, C. G., Jones, R., Peveler, R. C., Hope, R. A., & O'Connor, M. (1993). Psychotherapy and bulimia nervosa: Longer-term effects of interpersonal psychotherapy, behavior therapy, and cognitive behavior therapy. *Archives*

- of General Psychiatry*, 50(6), 419-428.
- Fairburn, C. G., Kirk, J., O'Connor, M., Anastasiades, P., & Cooper, P. J. (1987). Prognostic factors in bulimia nervosa. *British Journal of Clinical Psychology*, 26(3), 223-224.
- Fairburn, C. G., Kirk, J., O'Connor, M., & Cooper, P. J. (1986). A comparison of two psychological treatments for bulimia nervosa. *Behaviour research and therapy*, 24(6), 629-643.
- Fairburn, C. G., Peveler, R. C., Jones, R., Hope, R. A., & Doll, H. A. (1993). Predictors of 12-month outcome in bulimia nervosa and the influence of attitudes to shape and weight. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 61(4), 696-698.
- Fairburn, C. G., Wilson, G. T., & Schleimer, K. (1993). *Binge eating: Nature, assessment, and treatment* (pp. 317-360). New York: Guilford Press.
- Fassino, S., Leombruni, P., Pierò, A., Abbate-Daga, G., & Rovera, G. G. (2003). Mood, eating attitudes, and anger in obese women with and without binge eating disorder. *Journal of psychosomatic research*, 54(6), 559-566.
- Feindler, E. L., & Ecton, R. B. (1986). *Adolescent anger control: Cognitive-behavioral techniques*. New York: Pergamon Press.
- Feinson, M. C., & Hornik-Lurie, T. (2016). Binge eating & childhood emotional abuse: The mediating role of anger. *Appetite*, 105, 487-493.
- Fischer, S., Meyer, A. H., Dremmel, D., Schlup, B., & Munsch, S. (2014). Short-term cognitive-behavioral therapy for binge eating disorder: long-term efficacy and predictors of long-term treatment success. *Behaviour research and therapy*, 58, 36-42.
- Fleming, J., Mullen, P. E., Sibthorpe, B., & Bammer, G. (1999). The long-term impact of childhood sexual abuse in Australian women. *Child abuse & neglect*, 23(2), 145-159.
- Foa, E. B., Hembree, E. A., Cahill, S. P., Rauch, S. A., Riggs, D. S., Feeny, N. C., & Yadin, E. (2005). Randomized trial of prolonged exposure for

- posttraumatic stress disorder with and without cognitive restructuring: outcome at academic and community clinics. *Journal of consulting and clinical psychology*, 73(5), 953-964.
- Foa, E. B., Riggs, D. S., Dancu, C. V., & Rothbaum, B. O. (1993). Reliability and validity of a brief instrument for assessing post traumatic stress disorder. *Journal of traumatic stress*, 6(4), 459-473.
- Foa, E. B., & Rothbaum, B. O. (1998). *Cognitive-Behavior Therapy for PTSD*. New York: Guilford.
- Foa, E. B., Steketee, G., & Rothbaum, B. O. (1989). Behavioral/cognitive conceptualizations of post-traumatic stress disorder. *Behavior therapy*, 20(2), 155-176.
- Fowler, J. C., Allen, J. G., Oldham, J. M., & Frueh, B. C. (2013). Exposure to interpersonal trauma, attachment insecurity, and depression severity. *Journal of affective disorders*, 149(1-3), 313-318.
- Freeman, L. M. Y., & Gil, K. M. (2004). Daily stress, coping, and dietary restraint in binge eating. *International Journal of Eating Disorders*, 36(2), 204-212.
- Fryer, S., Waller, G., & Kroese, B. S. (1997). Stress, coping, and disturbed eating attitudes in teenage girls. *International Journal of Eating Disorders*, 22(4), 427-436.
- Gan, W. Y., Mohamad, N., & Law, L. S. (2018). Factors associated with binge eating behavior among Malaysian adolescents. *Nutrients*, 10(1), 66-67.
- Ganley, R. M. (1989). Emotion and eating in obesity: A review of the literature. *International Journal of eating disorders*, 8(3), 343-361.
- Garner, D. M. (1991). *Eating Disorder Inventory-2; Professional Manual. Psychological assessment resources*.
- Garner, D. M., & Garfinkel, P. E. (Eds.). (1997). *Handbook of treatment for eating disorders*. Guilford Press.
- Gerke, C. K., Mazzeo, S. E., & Kliewer, W. (2006). The role of depression and dissociation in the relationship between childhood trauma and bulimic

- symptoms among ethnically diverse female undergraduates. *Child abuse & neglect*, 30(10), 1161-1172.
- Gianini, L. M., White, M. A., & Masheb, R. M. (2013). Eating pathology, emotion regulation, and emotional overeating in obese adults with binge eating disorder. *Eating behaviors*, 14(3), 309-313.
- Gilbert, P. (1998). *What is shame? Some core issues and controversies*. In P. Gilbert & B. Andrews (Eds.), *Shame: Interpersonal behavior, psychopathology, and culture* (pp. 3 -38). Oxford University Press.
- Gilbert, P. (2003). Evolution, social roles, and the differences in shame and guilt. *Social Research: An International Quarterly*, 70(4), 1205-1230.
- Gilbert, P., & Procter, S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self criticism: Overview and pilot study of a group therapy approach. *Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory & Practice*, 13(6), 353-379.
- Gillian, B., Anne, C., Mary, M., Peter, A., & Michael, G. (1984). Exposure and anxiety management in the treatment of social phobia. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 52(4), 642 - 650.
- Gillies, J., & Neimeyer, R. A. (2006). Loss, grief, and the search for significance: Toward a model of meaning reconstruction in bereavement. *Journal of constructivist Psychology*, 19(1), 31-65.
- Goldschmidt, A. B., Wall, M. M., Zhang, J., Loth, K. A., & Neumark-Sztainer, D. (2016). Overeating and binge eating in emerging adulthood: 10-year stability and risk factors. *Developmental psychology*, 52(3), 475-483.
- Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. *Journal of psychopathology and behavioral assessment*, 26(1), 41-54.
- Gratz, K. L., Paulson, A., Jakupcak, M., & Tull, M. T. (2009). Exploring the relationship between childhood maltreatment and intimate partner abuse:

- Gender differences in the mediating role of emotion dysregulation. *Violence and Victims*, 24(1), 68-82.
- Grau, G. E., Fusté, A., Miró, A., Saldaña, C., & Bados, A. (2002). Coping style and disturbed eating attitudes in adolescent girls. *International Journal of Eating Disorders*, 32(1), 116-120.
- Greeno, C. G., & Wing, R. R. (1994). Stress-induced eating. *Psychological bulletin*, 115(3), 444-464.
- Gregory, W. L., Cialdini, R. B., & Carpenter, K. M. (1982). Self-relevant scenarios as mediators of likelihood estimates and compliance: Does imagining make it so?. *Journal of personality and social psychology*, 43(1), 89-99.
- Grilo, C. M., & Masheb, R. M. (2001). Childhood psychological, physical, and sexual maltreatment in outpatients with binge eating disorder: Frequency and associations with gender, obesity, and eating related psychopathology. *Obesity Research*, 9(5), 320-325.
- Grilo, C. M., Shiffman, S., & Carter Campbell, J. T. (1994). Binge eating antecedents in normal weight nonpurging females: Is there consistency?. *International Journal of Eating Disorders*, 16(3), 239-249.
- Grilo, C. M., White, A. M., & Masheb, M. R. (2009). DSM-IV psychiatric disorder comorbidity and its correlates in binge eating disorder. *International Journal of Eating Disorders*, 42(3), 228-234.
- Grisset, N. I., & Norvell, N. K. (1992). Perceived social support, social skills, and quality of relationships in bulimic women. *Journal of consulting and clinical psychology*, 60(2), 293-299.
- Groleau, P., Steiger, H., Bruce, K., Israel, M., Sycz, L., Ouellette, A. S., & Badawi, G. (2012). Childhood emotional abuse and eating symptoms in bulimic disorders: An examination of possible mediating variables. *International Journal of Eating Disorders*, 45(3), 326-332.
- Hackmann, A., Clark, D. M., & McManus, F. (2000). Recurrent images and early memories in social phobia. *Behaviour research and therapy*, 38(6), 601-610.

- Hackmann, A., Ehlers, A., Speckens, A., & Clark, D. M. (2004). Characteristics and content of intrusive memories in PTSD and their changes with treatment. *Journal of Traumatic Stress: Official Publication of the International Society for Traumatic Stress Studies*, 17(3), 231-240.
- Hagenaars, M. A., & Arntz, A. (2012). Reduced intrusion development after post-trauma imagery rescripting; an experimental study. *Journal of behavior therapy and experimental psychiatry*, 43(2), 808-814.
- Hansel, S. L., & Wittrock, D. A. (1997). Appraisal and coping strategies in stressful situations: A comparison of individuals who binge eat and controls. *International Journal of Eating Disorders*, 21(1), 89-93.
- Harford, T. C., Yi, H. Y., & Grant, B. F. (2014). Associations between childhood abuse and interpersonal aggression and suicide attempt among US adults in a national study. *Child Abuse & Neglect*, 38(8), 1389-1398.
- Harter, S. (1990). Developmental differences in the nature of self-representations: Implications for the understanding, assessment, and treatment of maladaptive behavior. *Cognitive therapy and research*, 14(2), 113-142.
- Haskett, M. E., & Kistner, J. A. (1991). Social interactions and peer perceptions of young physically abused children. *Child development*, 62(5), 979-990.
- Hatsukami, D., Owen, P., Pyle, R., & Mitchell, J. (1982). Similarities and differences on the MMPI between women with bulimia and women with alcohol or drug abuse problems. *Addictive behaviors*, 7(4), 435-439.
- Hawkins, R. C., & Clement, P. F. (1984). Binge eating: Measurement problems and a conceptual model. *The binge purge syndrome: Diagnosis, treatment, and research*, 229-251.
- Heatherton, T. F., & Baumeister, R. F. (1991). Binge eating as escape from self-awareness. *Psychological Bulletin*, 110(1), 86-108.
- Herbozo, S., Schaefer, L. M., & Thompson, J. K. (2015). A comparison of eating disorder psychopathology, appearance satisfaction, and self-esteem in overweight and obese women with and without binge eating. *Eating*

behaviors, 17, 86-89.

- Herman, J. L. (1992). Complex PTSD: A syndrome in survivors of prolonged and repeated trauma. *Journal of traumatic stress*, 5(3), 377-391.
- Herman, C. P., Polivy, J., Lank, C. N., & Heatherton, T. F. (1987). Anxiety, hunger, and eating behavior. *Journal of abnormal psychology*, 96(3), 264-269.
- Hilbert, A., & Tuschen Caffier, B. (2007). Maintenance of binge eating through negative mood: A naturalistic comparison of binge eating disorder and bulimia nervosa. *International journal of eating disorders*, 40(6), 521-530.
- Hirst, R. B., Beard, C. L., Colby, K. A., Quittner, Z., Mills, B. M., & Lavender, J. M. (2017). Anorexia nervosa and bulimia nervosa: a meta-analysis of executive functioning. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 83, 678-690.
- Hofmann, W., Gschwendner, T., Friese, M., Wiers, R. W., & Schmitt, M. (2008). Working memory capacity and self-regulatory behavior: toward an individual differences perspective on behavior determination by automatic versus controlled processes. *Journal of personality and social psychology*, 95(4), 962-977.
- Hollon, S. D., & Kendall, P. C. (1980). Cognitive self-statements in depression: Development of an automatic thoughts questionnaire. *Cognitive therapy and research*, 4(4), 383-395.
- Holmes, E. A., Arntz, A., & Smucker, M. R. (2007). Imagery rescripting in cognitive behaviour therapy: Images, treatment techniques and outcomes. *Journal of behavior therapy and experimental psychiatry*, 38(4), 297-305.
- Holmes, E. A., & Mathews, A. (2005). Mental imagery and emotion: A special relationship?. *Emotion*, 5(4), 489-497.
- Holmes, E. A., & Mathews, A. (2010). Mental imagery in emotion and emotional disorders. *Clinical psychology review*, 30(3), 349-362.
- Holmes, E. A., Mathews, A., Mackintosh, B., & Dalgleish, T. (2008). The causal effect of mental imagery on emotion assessed using picture-word cues. *Emotion*, 8(3), 395-409.

- Holmes, T. H., & Rahe, R. H. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. *Journal of Psychosomatic Research*, 11(2), 213 - 218.
- Hope, D. A., Burns, J. A., Hayes, S. A., Herbert, J. D., & Warner, M. D. (2010). Automatic thoughts and cognitive restructuring in cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder. *Cognitive Therapy and Research*, 34(1), 1-12.
- Hopfinger, L., Berking, M., Bockting, C. L., & Ebert, D. D. (2016). Emotion regulation mediates the effect of childhood trauma on depression. *Journal of affective disorders*, 198, 189-197.
- Hudson, J. I., Coit, C. E., Lalonde, J. K., & Pope Jr, H. G. (2012). By how much will the proposed new DSM 5 criteria increase the prevalence of binge eating disorder?. *International Journal of Eating Disorders*, 45(1), 139-141.
- Hudson, J. I., Hiripi, E., Harrison, G., & Kessler, R. (2005). *The epidemiology of eating disorders: Results from the National Comorbidity Survey Replication*. In 11th Annual Meeting of the Eating Disorders Research Society, Toronto, Ontario, Canada.
- Hudson, J. I., Hiripi, E., Pope Jr, H. G., & Kessler, R. C. (2007). The prevalence and correlates of eating disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Biological psychiatry*, 61(3), 348-358.
- Humphreys, K. L., LeMoult, J., Wear, J. G., Piersiak, H. A., Lee, A., & Gotlib, I. H. (2020). Child maltreatment and depression: A meta-analysis of studies using the Childhood Trauma Questionnaire. *Child abuse & neglect*, 102, 104361.
- Jacobson, E. (1987). Progressive relaxation. *The American Journal of Psychology*, 100(3/4), 522-537.
- Jacobson, R., & Robins, C. J. (1989). Social dependency and social support in bulimic and nonbulimic women. *International Journal of Eating Disorders*, 8(6), 665-670.
- Janoff-Bulman, R. (1989). Assumptive worlds and the stress of traumatic events: Applications of the schema construct. *Social cognition*, 7(2), 113-136.

- Janoff-Bulman, R. (1992). *Toward a new psychology of trauma*. NY: FreePress.
- Janoff-Bulman, R. (2006). Schema-change perspectives on posttraumatic growth. I LG: Calhoun & R. Tedeschi (red). *Handbook of posttraumatic growth: Research and Practice*.
- Jansen, A. (2001). Towards effective treatment of eating disorders: nothing is as practical as a good theory. *Behaviour research and therapy*, 39(9), 1007-1022.
- Janzen, B. L., Kelly, I. W., & Saklofske, D. H. (1992). Bulimic symptomatology and coping in a nonclinical sample. *Perceptual and Motor Skills*, 75(2), 395-399.
- Kadriu, F., Claes, L., Witteman, C., & Krans, J. (2021). Imagery rescripting of autobiographical memories versus intrusive images in individuals with disordered eating. *Cognitive Therapy and Research*, 1-12.
- Kaplan, H. I., & Kaplan, H. S. (1957). The psychosomatic concept of obesity. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 125, 181 - 201.
- Kassinove, H., & Eckhardt, C. I. (1995). An anger model and a look to the future. In H. Kassinove (Ed.), *Anger disorders: Definition, diagnosis, and treatment* (pp. 197 - 204). Taylor & Francis.
- Kataoka, S. H., Stein, B. D., Jaycox, L. H., Wong, M., Escudero, P., Tu, W., Elliott, M. N., & Fink, A. (2003). A school-based mental health program for traumatized Latino immigrant children. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 42(3), 311-318.
- Keel, P. K., & Mitchell, J. E. (1997). Outcome in bulimia nervosa. *The American Journal of Psychiatry*, 154(3), 313 - 321.
- Kendall, P. C. (1991). Guiding theory for therapy with children and adolescents. *Child and adolescent therapy: Cognitive-behavioral procedures*, 2.
- Kessler, R. C., Berglund, P. A., Chiu, W. T., Deitz, A. C., Hudson, J. I., Shahly, V., Gaxiol, S. A., Alonso, J., Matthias, C. A., Benjet, C., Bruffaerts, R., de Girolamo, G., de Graaf, R., Haro, J. M., Kovess-Masfety, V., O'Neill, S., Posada-Villa, J., Sasu, C., Scott, K., Viana, M. C., & Xavier, M. (2013).

- The prevalence and correlates of binge eating disorder in the World Health Organization World Mental Health Surveys. *Biological psychiatry*, 73(9), 904-914.
- Kim, J., & Cicchetti, D. (2006). Longitudinal trajectories of self system processes and depressive symptoms among maltreated and nonmaltreated children. *Child development*, 77(3), 624-639.
- Kim, G. S., & Song, Y. H. (1993). Relaxation therapy for pain control. *Korean Acad Craniomandibular Disorders*, 5(1), 1-5.
- Kleim, B., Ehlers, A., & Glucksman, E. (2012). Investigating cognitive pathways to psychopathology: Predicting depression and posttraumatic stress disorder from early responses after assault. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 4(5), 527-537.
- Kong, S., & Bernstein, K. (2009). Childhood trauma as a predictor of eating psychopathology and its mediating variables in patients with eating disorders. *Journal of Clinical Nursing*, 18(13), 1897-1907.
- Kotler, L. A., Boudreau, G. S., & Devlin, M. J. (2003). Emerging psychotherapies for eating disorders. *Journal of Psychiatric Practice*®, 9(6), 431-441.
- Krug, I., Bulik, C. M., Vall-Llovera, O. N., Granero, R., Agüera, Z., Villarejo, C., Jiménez-Múrcia, S., & Fernández-Aranda, F. (2008). Anger expression in eating disorders: Clinical, psychopathological and personality correlates. *Psychiatry Research*, 161(2), 195-205.
- Lacey, H. J., Coker, S., & Birtchnell, S. A. (1986). Bulimia: Factors associated with its etiology and maintenance. *International Journal of Eating Disorders*, 5(3), 475-487.
- Laeng, B., & Sulutvedt, U. (2014). The eye pupil adjusts to imaginary light. *Psychological science*, 25(1), 188-197.
- Laessle, R. G., Wittchen, H. U., Fichter, M. M., & Pirke, K. M. (1989). The significance of subgroups of bulimia and anorexia nervosa: Lifetime frequency of psychiatric disorders. *International Journal of Eating*

- Disorders*, 8(5), 569-574.
- Lamoureux, B. E., Palmieri, P. A., Jackson, A. P., & Hobfoll, S. E. (2012). Child sexual abuse and adulthood-interpersonal outcomes: Examining pathways for intervention. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 4(6), 605.
- Lavender, J. M., & Anderson, D. A. (2010). Contribution of emotion regulation difficulties to disordered eating and body dissatisfaction in college men. *International Journal Of Eating Disorders*, 43(4), 352-357.
- Lazarus, R. S. (1981). Psychological stress and coping in psychosomatic illness. *Society, stress and disease*, 4, 162-168.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer publishing company.
- Lazarus, R. S., Kanner, A. D., & Folkman, S. (1980). Emotions: A cognitive - phenomenological analysis. In *Theories of emotion* (pp. 189-217). Academic Press.
- Leahy, R. L., & Holland, S. J. (2000). *The clinician's toolbox. Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders*. Guilford Press.
- LeDoux, J. E. (2000). Emotion circuits in the brain. *Annual review of neuroscience*, 23(1), 155-184.
- Lee, S. W., & Kwon, J. H. (2013). The efficacy of imagery rescripting (IR) for social phobia: A randomized controlled trial. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 44(4), 351-360.
- Leehr, E. J., Krohmer, K., Schag, K., Dresler, T., Zipfel, S., & Giel, K. E. (2015). Emotion regulation model in binge eating disorder and obesity—a systematic review. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 49, 125-13.
- Lee-Winn, A. E., Reinblatt, S. P., Mojtabai, R., & Mendelson, T. (2016). Gender and racial/ethnic differences in binge eating symptoms in a nationally representative sample of adolescents in the United States. *Eating behaviors*, 22, 27-33.

- Libby, L. K., Shaeffer, E. M., Eibach, R. P., & Slemmer, J. A. (2007). Picture yourself at the polls: Visual perspective in mental imagery affects self-perception and behavior. *Psychological Science, 18*(3), 199–203.
- Lieb, K., Zanarini, M. C., Schmahl, C., Linehan, M. M., & Bohus, M. (2004). Borderline personality disorder. *The Lancet, 364*(9432), 453–461.
- Lindeman, M., Stark, K., & Keski-Vaara, P. (2001). Continuum and linearity hypotheses on the relationship between psychopathology and eating disorder symptomatology. *Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 6*(4), 181–187.
- Lingswiler, V. M., Crowther, J. H., & Stephens, M. A. (1989). Affective and cognitive antecedents to eating episodes in bulimia and binge eating. *International Journal of Eating Disorders, 8*(5), 533–539.
- Lundgren, J. D., Danoff-Burg, S., Anderson, D. A. (2004). Cognitive behavioral therapy for bulimia nervosa: an empirical analysis of clinical significance. *International Journal of Eating Disorders, 35*, 262–274.
- Luxenberg, T., Spinazzola, J., & Van der Kolk, B. A. (2001). Complex trauma and disorders of extreme stress (DESNOS) diagnosis, part one: Assessment. *Directions in psychiatry, 21*(25), 373–392.
- Maciejewski, P. K., & Mazure, C. M. (2006). Fear of criticism and rejection mediates an association between childhood emotional abuse and adult onset of major depression. *Cognitive therapy and research, 30*(1), 105–122.
- MacLeod, A. K., Tata, P., Kentish, J., Carroll, F., & Hunter, E. (1997). Anxiety, depression, and explanation based pessimism for future positive and negative events. *Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory and Practice, 4*(1), 15–24.
- Mandelli, L., Petrelli, C., & Serretti, A. (2015). The role of specific early trauma in adult depression: A meta-analysis of published literature. Childhood trauma and adult depression. *European psychiatry, 30*(6), 665–680.
- Mannarino, A. P., & Cohen, J. A. (1996). Abuse-related attributions and perceptions, general attributions, and locus of control in sexually abused

- girls. *Journal of Interpersonal Violence*, 11(2), 162-180.
- Marcus, M. D., Wing, R. R., & Hopkins, J. (1988). Obese binge eaters: Affect, cognitions, and response to behavioral weight control. *Journal of consulting and clinical psychology*, 56(3), 433-439.
- Masuda, A., Price, M., & Latzman, R. D. (2012). Mindfulness moderates the relationship between disordered eating cognitions and disordered eating behaviors in a non-clinical college sample. *Journal of psychopathology and behavioral assessment*, 34(1), 107-115.
- Matheson, K., Skomorovsky, A., Fiocco, A., & Anisman, H. (2007). The limits of 'adaptive' coping: Well-being and mood reactions to stressors among women in abusive dating relationships. *Stress*, 10(1), 75-91.
- Mathews, A., Ridgeway, V., & Holmes, E. A. (2013). Feels like the real thing: Imagery is both more realistic and emotional than verbal thought. *Cognition & emotion*, 27(2), 217-229.
- Mayhew, R., & Edelman, R. J. (1989). Self-esteem, irrational beliefs and coping strategies in relation to eating problems in a non-clinical population. *Personality and Individual Differences*, 10(5), 581-584.
- McLaughlin, K. A., & Nolen-Hoeksema, S. (2012). Interpersonal stress generation as a mechanism linking rumination to internalizing symptoms in early adolescents. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 41(5), 584-597.
- Meng, X., & D'Arcy, C. (2015). Comorbidity between lifetime eating problems and mood and anxiety disorders: Results from the Canadian community health survey of mental health and well being. *European Eating Disorders Review*, 23(2), 156-162.
- Meyer, C., Leung, N., Waller, G., Perkins, S., Paice, N., & Mitchell, J. (2005). Anger and bulimic psychopathology: Gender differences in a nonclinical group. *International Journal of Eating Disorders*, 37(1), 69-71.
- Meyer, C., Waller, G., & Waters, A. (1998). Emotional states and bulimic

- psychopathology. *Neurobiology in the treatment of eating disorders*, 271–289.
- Michael, T., Ehlers, A., Halligan, S. L., & Clark, D. M. (2005). Unwanted memories of assault: what intrusion characteristics are associated with PTSD?. *Behaviour research and therapy*, 43(5), 613–628.
- Michopoulos, V., Powers, A., Moore, C., Villarreal, S., Ressler, K. J., & Bradley, B. (2015). The mediating role of emotion dysregulation and depression on the relationship between childhood trauma exposure and emotional eating. *Appetite*, 91, 129–136.
- Monica, D., Paulo, M., Appolinário, J. C., Freitas, S. R. D., Coutinho, G., Santos, C., & Coutinho, W. (2010). Assessment of executive functions in obese individuals with binge eating disorder. *Brazilian Journal of Psychiatry*, 32(4), 381–388.
- Monteleone, A. M., Tzischinsky, O., Cascino, G., Alon, S., Pellegrino, F., Ruzzi, V., & Latzer, Y. (2021). The connection between childhood maltreatment and eating disorder psychopathology: a network analysis study in people with bulimia nervosa and with binge eating disorder. *Eating and Weight Disorders–Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity*, 28(1), 1–9.
- Morina, N., Deeprose, C., Pusowski, C., Schmid, M., & Holmes, E. A. (2011). Prospective mental imagery in patients with major depressive disorder or anxiety disorders. *Journal of anxiety disorders*, 25(8), 1032–1037.
- Moscovitch, D. A. (2009). What is the core fear in social phobia? A new model to facilitate individualized case conceptualization and treatment. *Cognitive and Behavioral Practice*, 16(2), 123–134.
- Moulton, S. T., & Kosslyn, S. M. (2009). Imagining predictions: mental imagery as mental emulation. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 364(1521), 1273–1280.
- Musa, C., Lépine, J. P., Clark, D. M., Mansell, W., & Ehlers, A. (2003). Selective attention in social phobia and the moderating effect of a concurrent depressive disorder. *Behaviour research and therapy*, 41(9), 1043–1054.

- Negele, A., Kaufhold, J., Kallenbach, L., & Leuzinger-Bohleber, M. (2015). Childhood trauma and its relation to chronic depression in adulthood. *Depression Research and Treatment*, 2015, Article 650804.
- Novaco, R. W. (1994). *Anger as a risk factor for violence among the mentally disordered*. In J. Monahan & H. J. Steadman (Eds.), *Violence and mental disorder: Developments in risk assessment* (pp. 21 -59). The University of Chicago Press.
- Nunnally, J. C. (1978). An overview of psychological measurement. *Clinical diagnosis of mental disorders*, 97-146.
- Olstad, R., Sexton, H., & Sogaard, A. J. (2001). The Finnmark Study. A prospective population study of the social support buffer hypothesis, specific stressors and mental distress. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 36(12), 582-589.
- Paradis, A., & Boucher, S. (2010). Child maltreatment history and interpersonal problems in adult couple relationships. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 19(2), 138-158.
- Pasold, T. L., McCracken, A., & Ward-Begnoche, W. L. (2014). Binge eating in obese adolescents: Emotional and behavioral characteristics and impact on health-related quality of life. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 19(2), 299-312.
- Paunovic, N., & Öst, L. G. (2001). Cognitive-behavior therapy vs exposure therapy in the treatment of PTSD in refugees. *Behaviour research and therapy*, 39(10), 1183-1197.
- Payne, R. A., & Donaghy, M. (2010). *Relaxation techniques E-book: a practical handbook for the health care professional*. Elsevier Health Sciences.
- Pearlman, L. A., & Saakvitne, K. W. (1998). *Treating traumatized therapists. Secondary traumatic stress disorder: Trauma and its wake*. New York: Brunner/Mazel.
- Pearson, J., Naselaris, T., Holmes, E. A., & Kosslyn, S. M. (2015). Mental imagery:

- functional mechanisms and clinical applications. *Trends in cognitive sciences*, 19(10), 590-602.
- Pelcovitz, D., Van der Kolk, B., Roth, S., Mandel, F., Kaplan, S., & Resick, P. (1997). Development of a criteria set and a structured interview for disorders of extreme stress (SIDES). *Journal of traumatic Stress*, 10(1), 3-16.
- Peñas Lledó, E., Fernández, J. D. D., & Waller, G. (2004). Association of anger with bulimic and other impulsive behaviours among non clinical women and men. *European Eating Disorders Review: The Professional Journal of the Eating Disorders Association*, 12(6), 392-397.
- Pham, L. B., & Taylor, S. E. (1999). From thought to action: Effects of process-versus outcome-based mental simulations on performance. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 25(2), 250-260.
- Pictet, A., Coughtrey, A. E., Mathews, A., & Holmes, E. A. (2011). Fishing for happiness: The effects of generating positive imagery on mood and behaviour. *Behaviour research and therapy*, 49(12), 885-891.
- Polivy, J., & Herman, C. P. (1993). Etiology of binge eating: Psychological mechanisms. In C. G. Fairburn & G. T. Wilson (Eds.), *Binge eating: Nature, assessment, and treatment* (pp. 173 - 205). New York: Guilford Press.
- Polivy, J., & Herman, C. P. (2002). Causes of eating disorders. *Annual review of psychology*, 53(1), 187-213.
- Polivy, J., Zeitlin, S. B., Herman, C. P., & Beal, A. L. (1994). Food restriction and binge eating: a study of former prisoners of war. *Journal of abnormal psychology*, 103(2), 409-411.
- Prasko, J., Grambal, A., Kamaradova, D., & Jelenova, D. (2012). Imagery rescripting of traumatic or distressing stories from childhood. *Act Nerv Super Rediviva*, 54(3), 113-120.
- Pull, C. B. (2004). Binge eating disorder. *Current Opinion in Psychiatry*, 17(1),

43-48.

- Pyle, R. L., Mitchell, J. E., & Eckert, E. D. (1981). Bulimia: A report of 34 cases. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 42(2), 60 - 64.
- Racine, S. E., & Wildes, J. E. (2015). Emotion dysregulation and anorexia nervosa: An exploration of the role of childhood abuse. *International Journal of Eating Disorders*, 48(1), 55-58.
- Raune, D., MacLeod, A., & Holmes, E. A. (2005). The simulation heuristic and visual imagery in pessimism for future negative events in anxiety. *Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory & Practice*, 12(4), 313-325.
- Rebert, W. M., Stanton, A. L., & Schwarz, R. M. (1991). Influence of personality attributes and daily moods on bulimic eating patterns. *Addictive behaviors*, 16(6), 497-505.
- Rehm, L. P., & Rokke, P. (1988). *Self-management therapies*. In K. S. Dobson (Ed.), *Handbook of cognitive-behavioral therapies* (pp. 136 - 166). New York: Guilford Press.
- Reynolds, M., & Brewin, C. R. (1998). Intrusive cognitions, coping strategies and emotional responses in depression, post-traumatic stress disorder and a non-clinical population. *Behaviour Research and Therapy*, 36(2), 135-147.
- Rezaei, M., & Ghazanfari, F. (2016). The role of childhood trauma, early maladaptive schemas, emotional schemas and experiential avoidance on depression: A structural equation modeling. *Psychiatry research*, 246, 407-414.
- Ricca, V., Castellini, G., Fioravanti, G., Sauro, C. L., Rotella, F., Ravaldi, C., Lazzeretti, L., & Faravelli, C. (2012). Emotional eating in anorexia nervosa and bulimia nervosa. *Comprehensive psychiatry*, 53(3), 245-251.
- Richardson, G. E. (2002). The metatheory of resilience and resiliency. *Journal of clinical psychology*, 58(3), 307-321.
- Romito, P., & Grassi, M. (2007). Does violence affect one gender more than the

- other? The mental health impact of violence among male and female university students. *Social Science & Medicine*, 65(6), 1222-1234.
- Rosenberg, M. (1965). *Society and Adolescent Self-Image*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Rosenberg, M. (1979). The nature of self-esteem. *Conceiving the self*, 1-51.
- Rubin, D. C., Berntsen, D., & Bohni, M. K. (2008). A memory-based model of posttraumatic stress disorder: evaluating basic assumptions underlying the PTSD diagnosis. *Psychological review*, 115(4), 985-1011.
- Rubin, D. C., Feldman, M. E., & Beckham, J. C. (2004). Reliving, emotions, and fragmentation in the autobiographical memories of veterans diagnosed with PTSD. *Applied Cognitive Psychology: The Official Journal of the Society for Applied Research in Memory and Cognition*, 18(1), 17-35.
- Russell, G. (1979). Bulimia nervosa: an ominous variant of anorexia nervosa. *Psychological medicine*, 9(3), 429-448.
- Salo, J., Punamäki, R. L., & Qouta, S. (2004). Associations between self and other representations and posttraumatic adjustment among political prisoners. *Anxiety, Stress & Coping*, 17(4), 421-440.
- Sanftner, J. L., & Crowther, J. H. (1998). Variability in self esteem, moods, shame, and guilt in women who binge. *International Journal of Eating Disorders*, 23(4), 391-397.
- Schacter, D. L., Addis, D. R., & Buckner, R. L. (2007). Remembering the past to imagine the future: the prospective brain. *Nature reviews neuroscience*, 8(9), 657-661.
- Schmeichel, B. J., Volokhov, R. N., & Demaree, H. A. (2008). Working memory capacity and the self-regulation of emotional expression and experience. *Journal of personality and social psychology*, 95(6), 1526-1540.
- Schor, E. L. (2003). Family pediatrics: report of the Task Force on the Family. *Pediatrics*, 111(6 Pt 2), 1541-1571.
- Shafran, R., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2002). Clinical perfectionism: A cognitive

- behavioural analysis. *Behaviour research and therapy*, 40(7), 773-791.
- Shatford, L. A., & Evans, D. R. (1986). Bulimia as a manifestation of the stress process: A LISREL causal modeling analysis. *International Journal of Eating Disorders*, 5(3), 451-473.
- Shorey, R. C., Cornelius, T. L., & Idema, C. (2011). Trait anger as a mediator of difficulties with emotion regulation and female-perpetrated psychological aggression. *Violence and victims*, 26(3), 271-282.
- Shorey, R. C., Sherman, A. E., Kivisto, A. J., Elkins, S. R., Rhatigan, D. L., & Moore, T. M. (2011). Gender differences in depression and anxiety among victims of intimate partner violence: The moderating effect of shame proneness. *Journal of interpersonal violence*, 26(9), 1834-1850.
- Short, M. M., Mushquash, A. R., & Sherry, S. B. (2013). Perseveration moderates the relationship between perfectionism and binge eating: A multi-method daily diary study. *Eating behaviors*, 14(3), 394-396.
- Skinner, H. H., Haines, J., Austin, S. B., & Field, A. E. (2012). A prospective study of overeating, binge eating, and depressive symptoms among adolescent and young adult women. *Journal of Adolescent Health*, 50(5), 478-483.
- Smink, F. R., Van Hoeken, D., & Hoek, H. W. (2012). Epidemiology of eating disorders: incidence, prevalence and mortality rates. *Current psychiatry reports*, 14(4), 406-414.
- Smith, J. C. (1999). *ABC relaxation theory: An evidence-based approach*. Springer Publishing Company.
- Smith, M. C., & Thelen, M. H. (1984). Development and validation of a test for bulimia. *Journal of consulting and clinical psychology*, 52(5), 863-872.
- Smith, T. E., Burkey, N. A., Nawn, J., & Reif, M. C. (1991). A comparison of demographic, behavioral, and ego function data in borderline and eating disorder patients. *Psychiatric quarterly*, 62(1), 19-33.
- Smucker, M. R. (2005). Imagery rescripting and reprocessing therapy. In *Encyclopedia of cognitive behavior therapy* (pp. 226-229). Boston: Springer,

MA.

- Smucker, M. R., & Dancu, C. V. (1999). *Cognitive-behavioral treatment for adult survivors of childhood trauma: Imagery rescripting and reprocessing*. Jason Aronson.
- Smucker, M. R., & Niederee, J. (1995). Treating incest-related PTSD and pathogenic schemas through imaginal exposure and rescripting. *Cognitive and Behavioral Practice*, 2(1), 63-92.
- Snoek, H. M., Van Strien, T., Janssens, J. M., & Engels, R. C. (2007). Emotional, external, restrained eating and overweight in Dutch adolescents. *Scandinavian journal of psychology*, 48(1), 23-32.
- Soukup, V. M., Beiler, M. E., & Terrell, F. (1990). Stress, coping style, and problem solving ability among eating disordered inpatients. *Journal of Clinical Psychology*, 46(5), 592-599.
- Speckens, A. E., Ehlers, A., Hackmann, A., Ruths, F. A., & Clark, D. M. (2007). Intrusive memories and rumination in patients with post-traumatic stress disorder: A phenomenological comparison. *Memory*, 15(3), 249-257.
- Spence, S. H., Donovan, C., & Brechman-Toussaint, M. (2000). The treatment of childhood social phobia: The effectiveness of a social skills training-based, cognitive-behavioural intervention, with and without parental involvement. *The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 41(6), 713-726.
- Spielberger, C. D. (1972). Anxiety as an emotional state. *Anxiety-Current trends and theory*, 3-20.
- Spielberger, C. D. (1988). Manual for the state-trait anger expression scale (STAXI). *Odessa, FL: Psychological Assessment Resources*.
- Spielberger, C. D. (1996). Manual for the state-trait anger expression scale. *Port Huron, MI: Sigma assessments system*.
- Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. (1970). Stai. *Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (Self Evaluation Questionnaire)*. Palo Alto

- California: Consulting Psychologist*, 22, 1-24.
- Stein, B. D., Jaycox, L. H., Kataoka, S. H., Wong, M., Tu, W., Elliott, M. N., & Fink, A. (2003). A mental health intervention for schoolchildren exposed to violence: a randomized controlled trial. *The Journal of the American Medical Association*, 290(5), 603-611.
- Stein, R. I., Kenardy, J., Wiseman, C. V., Douchis, J. Z., Arnow, B. A., & Wilfley, D. E. (2007). What's driving the binge in binge eating disorder?: A prospective examination of precursors and consequences. *International Journal of Eating Disorders*, 40(3), 195-203.
- Steiger, H., Gauvin, L., Jabalpurwala, S., Séguin, J. R., & Stotland, S. (1999). Hypersensitivity to social interactions in bulimic syndromes: relationship to binge eating. *Journal of consulting and clinical psychology*, 67(5), 765-775.
- Steiger, H., Leung, F., & Thibaudeau, J. (1993). Prognostic value of pretreatment social adaptation in bulimia nervosa. *International Journal of Eating Disorders*, 14(3), 269-276.
- Steil, R., & Ehlers, A. (2000). Dysfunctional meaning of posttraumatic intrusions in chronic PTSD. *Behaviour research and therapy*, 38(6), 537-558.
- Stice, E. (2001). A prospective test of the dual-pathway model of bulimic pathology: mediating effects of dieting and negative affect. *Journal of abnormal psychology*, 110(1), 124-135.
- Stice, E., Killen, J. D., Hayward, C., & Taylor, C. B. (1998). Age of onset for binge eating and purging during late adolescence: A 4- year survival analysis. *Journal of Abnormal Psychology*, 107(4), 671-675.
- Stice, E., Presnell, K., & Spangler, D. (2002). Risk factors for binge eating onset in adolescent girls: a 2-year prospective investigation. *Health Psychology*, 21(2), 131-138.
- Stopa, L. (Ed.). (2009). *Imagery and the threatened self: Perspectives on mental imagery and the self in cognitive therapy*. Routledge.
- Stovall-McClough, K. C., & Cloitre, M. (2006). Unresolved attachment, PTSD, and

- dissociation in women with childhood abuse histories. *Journal of consulting and clinical psychology*, 74(2), 219.
- Striegel-Moore, R. H., Silberstein, L. R., & Rodin, J. (1993). The social self in bulimia nervosa: Public self-consciousness, social anxiety, and perceived fraudulence. *Journal of abnormal psychology*, 102(2), 297-303.
- Strien, T. V., Frijters, J. E. R., Bergers G. P. A., & Defares P. B. (1986). The dutch eating behavior questionnaire(DEBQ) for assessment of restrained, emotional, and external eating behavior. *International Journal of Eating Disorder*, 5(2), 295-315.
- Stunkard, A. J. (1959). Eating patterns and obesity. *Psychiatric quarterly*, 33(2), 284-295.
- Tanofsky-Kraff, M., Shomaker, L. B., Olsen, C., Roza, C. A., Wolkoff, L. E., Columbo, K. M., Raciti, G., Zocca, J. M., Wilfley, D. E., Yanovski, S. Z., & Yanovski, J. A. (2011). A prospective study of pediatric loss of control eating and psychological outcomes. *Journal of abnormal psychology*, 120(1), 108-118.
- Taylor, S. E., Pham, L. B., Rivkin, I. D., & Armor, D. A. (1998). Harnessing the imagination: Mental simulation, self-regulation, and coping. *American psychologist*, 53(4), 429-439.
- Tchanturia, K., Anderluh, M. B., Morris, R. G., Rabe-Hesketh, S., Collier, D. A., Sanchez, P., & Treasure, J. L. (2004). Cognitive flexibility in anorexia nervosa and bulimia nervosa. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 10(4), 513-520.
- Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (1996). The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. *Journal of traumatic stress*, 9(3), 455-471.
- Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). " Posttraumatic growth: conceptual foundations and empirical evidence". *Psychological inquiry*, 15(1), 1-18.
- Telch, C. F., & Agras, W. S. (1994). Obesity, binge eating and psychopathology:

- are they related?. *International Journal of Eating Disorders*, 15(1), 53-61.
- Telch, C. F., Agras, W. S., & Linehan, M. M. (2001). Dialectical behavior therapy for binge eating disorder. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 69(6), 1061-1065.
- Thelen, M. H., Farmer, J., Wonderlich, S., & Smith, M. (1991). A revision of the Bulimia Test: The BULIT-R. *Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 3(1), 119-124.
- Thompson, D. A., Berg, K. M., & Shatford, L. A. (1987). The heterogeneity of bulimic symptomatology: Cognitive and behavioral dimensions. *International Journal of Eating Disorders*, 6(2), 215-234.
- Tomori, M., & Rus-Makovec, M. (2000). Eating behavior, depression, and self-esteem in high school students. *Journal of adolescent health*, 26(5), 361-367.
- Troop, N. A., Holbrey, A., Trowler, R., & Treasure, J. L. (1994). Ways of coping in women with eating disorders. *Journal of Nervous and Mental Disease*.
- Tull, M. T., Barrett, H. M., McMillan, E. S., & Roemer, L. (2007). A preliminary investigation of the relationship between emotion regulation difficulties and posttraumatic stress symptoms. *Behavior therapy*, 38(3), 303-313.
- Twamley, E. W., & Davis, M. C. (1999). The sociocultural model of eating disturbance in young women: The effects of personal attributes and family environment. *Journal of social and clinical psychology*, 18(4), 467-489.
- Van der Kolk, B. A. (2001). The psychobiology and psychopharmacology of PTSD. *Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental*, 16(S1), S49-S64.
- Van der Kolk, B. A., & Van der Hart, O. (1989). Pierre Janet and the breakdown of adaptation in psychological trauma. *American Journal of Psychiatry*, 146(12), 1530-1540.
- Ventegodt, S., Thegler, S., Andreasen, T., Struve, F., Enevoldsen, L., Bassaine, L., Torp, M., & Merrick, J. (2007). Self-reported low self-esteem. Intervention and follow-up in a clinical setting. *The Scientific World Journal*, 7,

299-305.

- Vocks, S., Tuschen Caffier, B., Pietrowsky, R., Rustenbach, S. J., Kersting, A., & Herpertz, S. (2010). Meta analysis of the effectiveness of psychological and pharmacological treatments for binge eating disorder. *International Journal of Eating Disorders*, 43(3), 205-217.
- Waller, G. (2002). The psychology of binge eating. *Eating disorders and obesity: A comprehensive handbook*, 2, 98-102.
- Waller, G., Babbs, M., Milligan, R., Meyer, C., Ohanian, V., & Leung, N. (2003). Anger and core beliefs in the eating disorders. *International journal of eating disorders*, 34(1), 118-124.
- Walsh, B. T., Wilson, G. T., Loeb, K. L., Devlin, M. J., Pike, K. M., Roose, S. P., Fleiss, J., & Waternaux, C. (1997). Medication and psychotherapy in the treatment of bulimia nervosa. *American Journal of Psychiatry*, 154(4), 523-531.
- Wheatley, J., & Hackmann, A. (2011). Using imagery rescripting to treat major depression: Theory and practice. *Cognitive and Behavioral Practice*, 18(4), 444-453.
- Webber, E. M. (1994). Psychological characteristics of bingeing and nonbinging obese women. *The journal of psychology*, 128(3), 339-351.
- Wegner, D. M., Schneider, D. J., Carter, S. R., & White, T. L. (1987). Paradoxical effects of thought suppression. *Journal of Personality and Social Psychology*, 53(1), 5-13.
- Whiteside, U., Chen, E., Neighbors, C., Hunter, D., Lo, T., & Larimer, M. (2007). Difficulties regulating emotions: Do binge eaters have fewer strategies to modulate and tolerate negative affect?. *Eating Behaviors*, 8(2), 162-169.
- Wild, J., & Clark, D. M. (2011). Imagery rescripting of early traumatic memories in social phobia. *Cognitive and behavioral practice*, 18(4), 433-443.
- Wild, J., Hackmann, A., & Clark, D. M. (2008). Rescripting early memories linked to negative images in social phobia: A pilot study. *Behavior Therapy*, 39(1),

47-56.

- Williams, K. L., & Galliher, R. V. (2006). Predicting depression and self-esteem from social connectedness, support, and competence. *Journal of Social and Clinical Psychology, 25*(8), 855-874.
- Williamson, D. A., Kelley, M. L., Davis, C. J., Ruggiero, L., & Blouin, D. C. (1985). Psychopathology of eating disorders: A controlled comparison of bulimic, obese, and normal subjects. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53*(2), 161-166.
- Wilson, G. T., & Fairburn, C. G. (2002). *Treatments for eating disorders*. In P. E. Nathan & J. M. Gorman (Eds.), *A guide to treatments that work* (pp. 559-592). Oxford University Press.
- Wilson, G. T., Fairburn, C. C., Agras, W. S., Walsh, B. T., & Kraemer, H. (2002). Cognitive-behavioral therapy for bulimia nervosa: Time course and mechanisms of change. *Journal of consulting and clinical psychology, 70*(2), 267-274.
- Wind, T. W., & Silvern, L. (1992). Type and extent of child abuse as predictors of adult functioning. *Journal of Family violence, 7*(4), 261-281.
- Wingo, A. P., Wrenn, G., Pelletier, T., Gutman, A. R., Bradley, B., & Ressler, K. J. (2010). Moderating effects of resilience on depression in individuals with a history of childhood abuse or trauma exposure. *Journal of affective disorders, 126*(3), 411-414.
- Wolf, E. M., & Crowther, J. H. (1992). An evaluation of behavioral and cognitive behavioral group interventions for the treatment of bulimia nervosa in women. *International Journal of Eating Disorders, 11*(1), 3-15.
- Wolff, G. E., Crosby, R. D., Roberts, J. A., & Wittrock, D. A. (2000). Differences in daily stress, mood, coping, and eating behavior in binge eating and nonbinge eating college women. *Addictive behaviors, 25*(2), 205-216.
- Wonderlich, S. A. (2002). Personality and eating disorders. Fairburn CG, Brownell KD, ed. *Eating Disorders and Obesity: A Comprehensive Handbook*. New

York: Guilford Press, 204-210.

- Wonderlich, S. A., De Zwaan, M., Mitchell, J. E., Peterson, C., & Crow, S. (2003). Psychological and dietary treatments of binge eating disorder: conceptual implications. *International Journal of Eating Disorders*, 34(S1), S58-S73.
- Wortman, C. B., & Silver, R. C. (1989). The myths of coping with loss. *Journal of consulting and clinical psychology*, 57(3), 349-357.
- Wright, J. H., Basco, M. R., & Thase, M. E. (2009). *Learning Cognitive-Behavior Therapy*(김정민 역). 서울: 학지사.
- Yager, J., Rorty, M., & Rossotto, E. (1995). Coping styles differ between recovered and nonrecovered women with bulimia nervosa, but not between recovered women and non-eating-disordered control subjects. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 183(2), 86 - 94.
- Yanovski, S. Z., Nelson, J. E., Dubbert, B. K., & Spitzer, R. L. (1993). *Association of binge eating disorder and psychiatric comorbidity in obese subjects*. The American journal of psychiatry.
- Zack, M., Poulos, C. X., Fragopoulos, F., & MacLeod, C. M. (2003). Effects of negative and positive mood phrases on priming of alcohol words in young drinkers with high and low anxiety sensitivity. *Experimental and clinical psychopharmacology*, 11(2), 176-185.
- Zahn-Waxler, C., Klimes - Dougan, B., & Slattery, M. J. (2000). Internalizing problems of childhood and adolescence: Prospects, pitfalls, and progress in understanding the development of anxiety and depression. *Development and psychopathology*, 12(3), 443-466.

부 록

- <부록 1> 대인외상경험 체크리스트
- <부록 2> 신경성 폭식증 검사 개정판 (BULIT-R)
- <부록 3> 부정적 정서로 유발된 섭식 동기·행동 척도 (NEIEMEBS)
- <부록 4> 역기능적 신념 척도 (SDBT)
- <부록 5> 부정적 자동적 사고 척도 (ATQ-N)
- <부록 6> 자아존중감 척도 (RSS)
- <부록 7> 정서조절곤란 척도 (DERS)
- <부록 8> 우울 척도 (BDI)
- <부록 9> 상태-특성 불안 척도 (STAI)
- <부록 10> 상태-특성 분노 척도 (STAXI)
- <부록 11> 스트레스 대처방식 척도 (SCSC)
- <부록 12> 실험집단의 이미지 재구성 I, II 회기로 인한 주관적 변화 정도
및 소감

<부록 1> 대인외상경험 체크리스트

※ 다음 체크리스트는 살아오면서 경험할 수 있는 다양한 사건들을 나열한 것입니다. **19세 이전에 직접 경험했던 매우 힘들고 충격적인 경험에 모두** 표시해 주시기 바랍니다. 목록에 해당되지 않는 경험은 기타에 직접 기입하시기 바랍니다.

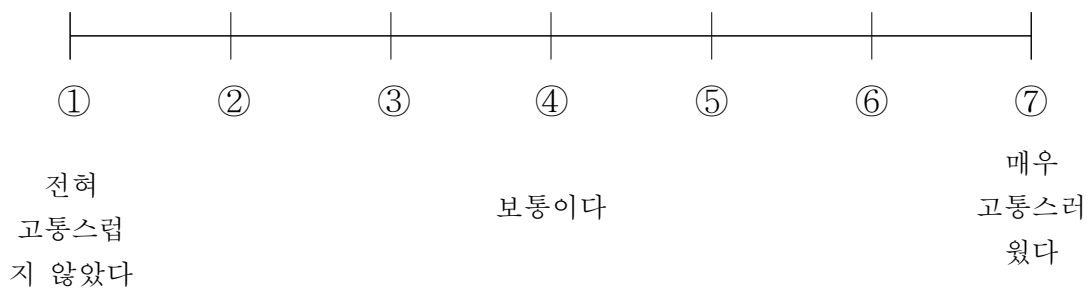
문 항	내 용	해당여 부	문 항	내 용	해당여부
1	적응의 어려움 (학교, 사회에서의 소외 혹은 따돌림)		2	부모님의 이혼 및 별 거	
3	구타, 폭행, 강도 등의 범죄 피해 (학교폭력 등)		4	성추행 및 성폭력	
5	배신, 충격 (거짓말, 속임 등)		6	가정의 경제적 어려움 (가정불화)	
7	사랑하는 사람의 질병 (가족, 가까운 사람, 친구 등)		8	어린 시절의 학대 경 험 (신체, 언어, 성적, 정서, 방임)	
9	사랑하는 사람의 사망 (가족, 가까운 사람, 친구 등)		10	대인관계 파탄 (이별, 실연, 절교 등)	
11	없 음				
12	기 타				

1) 앞에서 ‘해당여부’에 표시한 사건들 중에 **가장 고통스러웠던 사건을 하나**만 선택하여 **괄호** 안에 번호를 적어 주십시오. () 그리고 어떤 경험이었는지 아래에 간략하게 작성하시기 바랍니다.

앞으로 응답하게 될 문항은 방금 1)번에 표기한 ‘가장 고통스러웠던 경험’ 하나에 관한 것입니다. 기입한 경험을 잘 기억해 주시고, 그에 따라 아래 각 문항에 답해주시기 바랍니다.

2) 그 사건이 발생했을 당시의 나이를 적어주세요. () 세

3. 그 사건이 발생했을 당시 얼마나 고통스러웠습니까? 아래 번호 위에 표시하시기 바랍니다.



<부록 2> 신경성 폭식증 검사 개정판 (BULIT-R)

※ 다음 질문들은 당신의 평소 식습관에 관한 내용으로 구성되어 있습니다. 요즘(오늘을 포함한 최근 한 달 동안) 본인을 가장 잘 나타낸다고 생각되는 것에 표시해 주시기 바랍니다.

1. 나는 내 식사패턴에 만족한다. (1) 그렇다. (2) 대체로 그렇다. (3) 약간 그렇지 않다. (4) 그렇지 않다. (5) 전혀 그렇지 않다. 2. 당신은 스스로 '폭식한다'고 할 수 있습니까? (1) 절대적으로 그렇다. (2) 그렇다. (3) 아마 그럴 것이다. (4) 그렇게 볼 수도 있다. (5) 아마도 그렇지 않을 것이다. 3. 식사량을 스스로 조절할 수 있습니까? (1) 거의 항상 그렇다. (2) 꽤 그렇다. (3) 가끔 그렇다. (4) 거의 그렇지 않다. (5) 전혀 그렇지 않다. 4. 나는 내 체형과 치수(size)에 대해 만족한다. (1) 항상 그렇다. (2) 가끔 그렇다. (3) 이따금씩 그럴 때도 있다. (4) 거의 그렇지 않다. (5) 전혀 그렇지 않다.	5. 내 식사 행동을 통제할 수 없다고 느낄 때, 케도를 회복하기 위해 단기의 다이어트나 설사약이나 변비약을 복용하거나 손가락을 입에 넣어 구토를 하기도 하고 과도한 운동을 한다. (1) 항상 그렇다. (2) 대체로 그렇다. (3) 자주 그렇다. (4) 가끔 그렇다. (5) 전혀 그렇지 않다 / 나는 식사행동을 통제할 수 없게 된 적이 없다. 6. 나는 체중조절을 위해 변비약이나 설사약을 복용한다. (1) 하루에 1회 이상 (2) 일주일에 3회 내지 6회 (3) 일주일에 1회 내지 2회 (4) 한 달에 2회 내지 3회 (5) 한 달에 1회 혹은 사용하지 않음 7. 나는 내 체형이나 신체치수에 대해 늘 고민에 사로잡혀 있다. (1) 항상 그렇다. (2) 대체로 그렇다. (3) 자주 그렇다. (4) 가끔 그렇다. (5) 거의 혹은 전혀 그렇지 않다.
--	--

8. 너무 많은 음식을 급하게 먹을 때가 있다.	는 않는다. / 운동을 하지 않는다.
(1) 일주일에 3회 이상	12. 당신 또래의 여성들과 비교해 얼마나 체중과 체형에 집착하는 것 같습니까?
(2) 일주일에 2회	(1) 평균보다 훨씬 더 많이
(3) 일주일에 1회	(2) 평균보다 더 많이
(4) 한 달에 2회 내지 3회	(3) 평균 이상
(5) 한 달에 1회 혹은 전혀 없음	(4) 평균 이하
9. 얼마나 오랫동안 폭식을 해왔습니까? (폭식: 한동안 다이어트나 절식을 하다가 갑자기 자기 자신을 통제할 수 없을 만큼 마구 먹어대는 행동)	(5) 평균보다 더 적게
(1) 전혀 하지 않는다.	13. 먹기 시작하면 멈출 수 없을 거라는 두려움 때문에 어떤 것도 먹기가 겁난다.
(2) 3개월 이하	(1) 항상 그렇다.
(3) 3개월에서 1년 사이	(2) 대체로 그렇다.
(4) 1년에서 3년 사이	(3) 자주 그렇다.
(5) 3년 그 이상	(4) 가끔 그렇다.
10. 나를 아는 사람들이 내가 한 번에 얼마나 많이 먹는지를 알면 놀랄 것이다.	(5) 거의 혹은 전혀 그렇지 않다.
(1) 확실히 그럴 것이다.	14. 똥똥해질 거라는 생각에 시달린다.
(2) 거의 그럴 것이다.	(1) 항상 그렇다.
(3) 아마도 그럴 것이다.	(2) 대체로 그렇다.
(4) 그럴 수도 있다.	(3) 자주 그렇다.
(5) 그렇지 않다.	(4) 가끔 그렇다.
11. 칼로리를 소모시키기 위해 운동을 한다.	(5) 거의 혹은 전혀 그렇지 않다.
(1) 하루 2시간 이상	15. 먹고 난 후 의도적으로 구토를 하는 일이 얼마나 자주 있습니까?
(2) 하루 2시간 정도	(1) 일주일에 2회 내지 그 이상
(3) 하루 2시간 이하 1시간 이상	(2) 일주일에 1회
(4) 하루 1시간 혹은 그 이하	(3) 한 달에 2회 내지 3회
(5) 칼로리를 소모시키기 위해 운동하지	(4) 한 달에 1회
	(5) 한 달에 1회보다 더 적게 혹은 하지
	않음

16. 배고프지 않을 때에도 음식을 많이 먹는다. (1) 매우 자주 그렇다. (2) 자주 그렇다. (3) 그럴 때도 있다. (4) 가끔 그렇다. (5) 거의 혹은 전혀 그렇지 않다.	(5) 지난 1년 동안 5번 이상
17. 내 식사행동은 보통 사람들과 다르다. (1) 항상 그렇다. (2) 대체로 항상 그런 편이다. (3) 자주 그렇다. (4) 가끔 그렇다. (5) 거의 혹은 전혀 그렇지 않다.	20. 칼로리를 소모하기 위해서 과도하게 오랜 시간동안 운동을 한다. (1) 평균 이하 (2) 평균보다 좀 적게 (3) 평균보다 좀 많이 (4) 평균보다 많이 (5) 평균보다 훨씬 많이
18. 폭식을 한 직후 살이 찌지 않기 위해서 과도한 운동을 하거나 단기의 다이어트, 단식, 이뇨제, 설사약이나 변비약을 먹는 등의 방법을 쓴다. (1) 전혀 하지 않는다/ 폭식을 하지 않는다. (2) 거의 하지 않는다. (3) 할 때도 있다. (4) 자주 한다. (5) 거의 항상 한다.	21. 폭식을 할 때 탄수화물이 많이 들어 있는 음식(달콤하고 전분이 많은 음식)을 먹는 경향이 있다. (1) 항상 그렇다. (2) 대체로 항상 그런 편이다. (3) 자주 그렇다. (4) 가끔 그렇다. (5) 거의 혹은 전혀 폭식을 하지 않는다.
19. 단식을 하거나 단기의 다이어트를 해서 체중을 줄이려고 노력한 적이 있다. (1) 지난 1년 동안 그런 적이 없다. (2) 지난 1년 동안 1번 (3) 지난 1년 동안 2~3번 (4) 지난 1년 동안 4~5번	22. 대개의 사람들과 비교하여 나의 식사행동을 통제하는 능력은? (1) 다른 사람들보다 훨씬 낮다. (2) 비슷하다. (3) 다른 사람들 보다 못하다. (4) 훨씬 못하다. (5) 통제할만한 능력이 전혀 없다.
	23. 나는 스스로 ‘충동적으로 먹는 사람’이라고 할 수 있다. (1) 확실히 그렇다. (2) 그렇다. (3) 그런 편이다. (4) 그렇게 볼 수도 있을 것이다.

(5) 그렇지 않다.

24. 나는 너무 많이 먹은 후에 내 모습을 보는 것이 싫다.

- (1) 거의 혹은 전혀 그렇지 않다.
- (2) 가끔 그렇다.
- (3) 자주 그렇다.
- (4) 거의 항상 그렇다.
- (5) 항상 그렇다.

25. 살찌지 않으려고 노력을 할 때, 과도한 운동이나 단기의 다이어트, 단식, 손가락을 넣어 구토를 유도하거나, 이노제나 설사약, 변비약을 복용하는 것에 내가 의존하고 있다는 느낌을 받는다.

- (1) 전혀 그렇지 않다.
- (2) 거의 그렇지 않다.
- (3) 가끔 그렇다.
- (4) 자주 그렇다.
- (5) 거의 항상 그렇다.

26. 구토를 하는 것이 다른 사람들에게 보다 당신에게는 수월한 방법이라고 생각하십니까?

- (1) 그렇다. 전혀 어렵지 않다.
- (2) 그렇다. 쉬운 방법이다.
- (3) 비교적 쉬운 방법이다.
- (4) 그저 그렇다.
- (5) 쉽지 않다.

27. 체중 조절을 위해 이노제를 복용한다.

- (1) 한 달에 1회 이하 혹은 전혀 사용하지 않음
- (2) 거의 하지 않는 편(한 달에 2~3회)
- (3) 가끔 복용(일주일에 1~2회)
- (4) 자주 복용(일주일에 3~6회)
- (5) 매우 자주 복용(하루에 1회 그 이상)

28. 음식이 내 삶을 통제하고 있다고 느껴진다.

- (1) 항상 그렇다.
- (2) 대체로 항상 그런 편이다.
- (3) 자주 그렇다.
- (4) 가끔 그렇다.
- (5) 거의 혹은 전혀 그렇지 않다.

29. 하루나 그 이상의 기간을 먹지 않거나 아주 적게 먹는 것으로 체중을 조절하려고 한다.

- (1) 전혀 그렇지 않다.
- (2) 거의 그렇지 않은 편이다.
- (3) 가끔 그렇다.
- (4) 자주 그렇다.
- (5) 매우 자주 그렇다.

30. 많은 양의 음식을 먹을 때, 보통 어느 정도의 속도로 먹습니까?

- (1) 보통 사람들보다 훨씬 빨리 먹는 편이다.

(2) 보통 사람들보다 꽤 빨리 먹는 편이다.	(3) 못하다.
(3) 보통 사람들보다 빨리 먹는 편이다.	(4) 아주 못하다.
(4) 보통 사람들과 비슷한 속도로 먹는다.	(5) 형편없다.
(5) 보통 사람들보다 조금 느린 편이다.	
31. 체중 조절을 위해 설사약을 복용한다.	34. 최근 3개월 동안 얼마나 자주 폭식을 했습니까?
(1) 전혀 사용하지 않는다.	(1) 한 달에 1회 혹은 하지 않음
(2) 거의 사용하지 않는다.	(2) 한 달에 2~3회
(3) 가끔 사용한다.	(3) 일주일에 1회
(4) 자주 사용한다.	(4) 일주일에 2회
(5) 매우 자주 사용한다.	(5) 일주일에 2회 이상
32. 폭식을 한 직후 내 느낌은? (폭식: 한동안 다이어트나 절식을 하다가 갑자기 자기 자신을 통제할 수 없을 만큼 마구 먹어대는 행동)	35. 나를 아는 사람들은 내가 많은 음식을 먹은 후에 얼마나 똥똥해 지는지를 보면 놀랄 것이다.
(1) 너무 똥똥하고 부풀어서 참을 수 없을 정도이다.	(1) 분명히 그렇다.
(2) 극도로 똥똥해진다는 느낌이다.	(2) 그렇다.
(3) 똥똥하다는 느낌이다.	(3) 그럴 것이다.
(4) 약간 똥똥해진다는 느낌이다.	(4) 그럴 수도 있다.
(5) 내 몸이 어떻게든 괜찮다고 느낀다. / 폭식을 하지 않는다.	(5) 그럴 리도 없고, 나는 많은 음식을 먹지 않는다.
33. 다른 여성들과 비교해서 얼마나 먹을 것인지 조절할 수 있는 나의 능력은?	36. 체중조절을 위해 이노제를 복용한다.
(1) 비슷하거나 더 낫다.	(1) 일주일에 3회 이상
(2) 못한 편이다.	(2) 일주일에 1~2회
	(3) 한 달에 2~3회
	(4) 한 달에 1회
	(5) 전혀 복용하지 않는다.

<부록 3> 부정적 정서로 유발된 섭식 동기·행동 척도 (NEIEMEBS)

※ 다음은 자신의 섭식 생각과 행동에 대한 내용입니다. 각 문항들을 잘 읽고, 자신과 일치하는 정도에 따라 V표 해주십시오. 한 문항도 빠지 말고 반드시 한 문장만을 선택하시되, 너무 오래 생각하지 마시고 솔직하게 응답해 주십시오.

번호	문 항	전 혀 그 렇 지 않 다			보 통 이 다			매 우 그 렇 다
1	아무 할 일이 없을 때 음식이 먹고 싶어진다.	0	1	2	3	4	5	6
2	아무 할 일이 없을 때 실제로 음식을 먹는다.	0	1	2	3	4	5	6
3	우울하거나 낙심하면 음식이 먹고 싶어진다.	0	1	2	3	4	5	6
4	우울하거나 낙심하면 실제로 음식을 먹는다.	0	1	2	3	4	5	6
5	외로울 때 음식이 먹고 싶어진다.	0	1	2	3	4	5	6
6	외로울 때 실제로 음식을 먹는다.	0	1	2	3	4	5	6
7	누군가에게 무시를 당하면 음식이 먹고 싶어진다.	0	1	2	3	4	5	6
8	누군가에게 무시를 당하면 실제로 음식을 먹는다.	0	1	2	3	4	5	6
9	기분이 언짢으면 음식이 먹고 싶어진다.	0	1	2	3	4	5	6
10	기분이 언짢으면 실제로 음식을 먹는다.	0	1	2	3	4	5	6
11	불쾌한 일이 생기면 음식이 먹고 싶어진다.	0	1	2	3	4	5	6
12	불쾌한 일이 생기면 실제로 음식을 먹는다.	0	1	2	3	4	5	6
13	불안, 걱정 혹은 긴장되면 음식이 먹고 싶어진다.	0	1	2	3	4	5	6

14	불안, 걱정 혹은 긴장되면 실제로 음식을 먹는다.	0	1	2	3	4	5	6
15	뜻대로 일이 안되거나 잘못될 때 음식이 먹고 싶어진다.	0	1	2	3	4	5	6
16	뜻대로 일이 안되거나 잘못될 때 실제로 음식을 먹는다.	0	1	2	3	4	5	6
17	놀랐을 때 음식이 먹고 싶어진다.	0	1	2	3	4	5	6
18	놀랐을 때 실제로 음식을 먹는다.	0	1	2	3	4	5	6
19	실망한 일이 생기면 음식이 먹고 싶어진다.	0	1	2	3	4	5	6
20	실망한 일이 생기면 실제로 음식을 먹는다.	0	1	2	3	4	5	6
21	기분이 상할 때 음식이 먹고 싶어진다.	0	1	2	3	4	5	6
22	기분이 상할 때 실제로 음식을 먹는다.	0	1	2	3	4	5	6
23	지루하거나 안절부절 못할 때 음식이 먹고 싶어진다.	0	1	2	3	4	5	6
24	지루하거나 안절부절 못할 때 실제로 음식을 먹는다.	0	1	2	3	4	5	6

<부록 4> 역기능적 신념 척도 (SDBT)

※ 다음은 사람들이 가지고 있는 여러 가지 신념과 태도들에 관한 것입니다. 각 문항들을 잘 읽고, 자신의 ‘평소 신념(태도)과 일치하는 정도’를 따라 V표 해주십시오. 한 문항도 빠지 말고 반드시 한 문장만을 선택하시되, 너무 오래 생각하지 마시고 솔직하게 응답해 주십시오.

번호	문 항	전혀 일치 하지 않는 다	웬만 큼 일치 하지 않는 다	약간 일치 하지 않는 다	약 간 일 치 한 다	웬만 큼 일치 한다	전 적 으로 일치 한다
1	모든 사람들로부터 인정을 받아야만 괜찮은 사람이다.	1	2	3	4	5	6
2	나는 말재주도 없고 대인관계 능력이 부족하고 서툴러서 다른 사람을 거북하게 한다.	1	2	3	4	5	6
3	사람들은 나를 평범하고, 재미없으며, 상대하기 거북한 사람으로 여길 것이다.	1	2	3	4	5	6
4	다른 사람에게 인기가 있으려면, 그들 앞에서 매끄럽고 유능하게 처신해야 한다.	1	2	3	4	5	6
5	나를 아는 대부분의 사람이 나를 칭찬해주지 않으면 나는 행복할 수 없다.	1	2	3	4	5	6
6	사람들로부터 인정을 받으려면 항상 일을 잘해야만 한다.	1	2	3	4	5	6
7	아무도 내게 관심이 없다.	1	2	3	4	5	6
8	주변 사람들이 날 좋아하게 만들려면 말을 유창하게 그리고 재미있게 해야한다.	1	2	3	4	5	6
9	내 의견에 동의하지 않는 사람들은, 그들이 나를 좋아하지 않는다는 것을 뜻한다.	1	2	3	4	5	6
10	내 기분이나 행동은 나에 대한 다른 사람의 태도나 평가에 의해 좌우되는 것 같다.	1	2	3	4	5	6
11	사람들은 근본적으로 이기적이고 이해타산적이다.	1	2	3	4	5	6
12	나는 남들에게 좋은 인상을 주지 못할 것이다.	1	2	3	4	5	6
13	사람들이란 알고 보면 다 남의 말하기를 좋아하고	1	2	3	4	5	6

	상대방에게 진정한 관심이 없으며 거부적인 속성을 가지고 있다.						
14	상대방을 항상 즐겁게 해주어야 한다.	1	2	3	4	5	6
15	사람들이 나를 알게 되면 내가 정말 열등하다는 것을 알아차리고 말 것이다.	1	2	3	4	5	6
16	나는 어딘가 부족한 사람이다.	1	2	3	4	5	6
17	중요한 사람들로부터 인정을 못 받는 것은 몹시 끔찍한 일이다.	1	2	3	4	5	6
18	지금 내 모습 그대로를 보고는 사람들이 날 형편없는 사람으로 볼 것이다.	1	2	3	4	5	6
19	나의 실제 모습이 알려지면 사람들은 나를 전보다 업신여길 것이다.	1	2	3	4	5	6
20	나는 다른 사람들과 잘 맞지 않는다.	1	2	3	4	5	6
21	절반의 실패는 전부 실패한 거나 다름없다.	1	2	3	4	5	6
22	다른 사람들은 나를 사교성이 부족하고 바보 같은 사람이라고 생각할 것이다.	1	2	3	4	5	6
23	성공이 확실하게 보장되지 않는 한 어떤 일이든 시작하지 않는 게 상책이다.	1	2	3	4	5	6
24	다른 사람들에게 좋은 인상을 주어야 인정받을 것이다.	1	2	3	4	5	6
25	인간은 본질적으로 착취적일 수밖에 없다. 따라서 인간관계는 결국 착취적일 수밖에 없다.	1	2	3	4	5	6
26	긴장감이 느껴지는 대인관계를 일찍 그만두지 않는다면, 나중에는 끔찍한 결과를 경험하게 될 것이다.	1	2	3	4	5	6
27	사람들은 상대방이 허점을 보이면 그것이 어떤 허점이든 그 사람을 멀리할 것이다.	1	2	3	4	5	6
28	다른 사람에게 도움을 요청하는 것은 나약함의 표시이다.	1	2	3	4	5	6
29	나로 인해 다른 사람의 기분이 상하게 되어서는 안 된다.	1	2	3	4	5	6
30	내가 관심을 가진 사람들이 날 좋아하지 않는다면,	1	2	3	4	5	6

	이는 끔찍한 일이다.						
31	사람들은 내 실력이 별로라고 생각할 것이다.	1	2	3	4	5	6
32	사람들은 잘 변해서 믿을 수가 없다.	1	2	3	4	5	6
33	다른 사람이 나를 싫어한다면, 나는 견딜 수가 없다.	1	2	3	4	5	6
34	내 자신의 모습, 특히 결점이나 허점을 남들에게 있는 그대로 보여서는 안 된다.	1	2	3	4	5	6
35	나를 분명하게 좋아하지 않는 사람을 만나는 것은 시간낭비이다.	1	2	3	4	5	6
36	남들이 날 봤을 때 나를 그저 그런 사람으로 생각할 것이다.	1	2	3	4	5	6

<부록 5> 부정적 자동적 사고 척도 (ATQ-N)

※ 다음은 가끔씩 우리의 머릿속에 떠오르는 여러 가지 생각들을 열거한 내용입니다. 각 문항들을 잘 읽고, 지난 한 주 동안 얼마나 자주 이러한 생각들이 떠올랐는지를 그 빈도에 따라 적당한 곳에 V표 해주십시오. 한 문항도 빠지 말고 반드시 한 문장만을 선택하시되, 너무 오래 생각하지 마시고 솔직하게 응답해 주십시오.

번 호	문 항	전혀 한적 없다	가끔 한다	종종 한다	자주 한다	매우 자주 한다
1	세상이 나를 힘들게 하는 것처럼 느껴진다.	0	1	2	3	4
2	나는 쓸모없는 사람이다.	0	1	2	3	4
3	도대체 왜 나는 성공할 수 없는 것일까?	0	1	2	3	4
4	아무도 나를 이해해주지 않는다.	0	1	2	3	4
5	나는 종종 사람들을 실망시켜 왔다.	0	1	2	3	4
6	나는 내가 해 온 일을 계속 할 수 없을 것 같다.	0	1	2	3	4
7	나는 더 나은 사람이 되고 싶다.	0	1	2	3	4
8	나는 너무 나약하다.	0	1	2	3	4
9	내 인생은 내가 원하는 대로 흘러가고 있지 않다.	0	1	2	3	4
10	나는 내 자신에 대해 매우 실망하고 있다.	0	1	2	3	4
11	어떤 것에서도 더 이상 즐거움을 느낄 수가 없다.	0	1	2	3	4
12	나는 이제 더 이상 인내할 수 없다.	0	1	2	3	4
13	나는 새로운 일에 착수할 수 없다.	0	1	2	3	4
14	도대체 나에게 무엇이 잘못되어 있는가?	0	1	2	3	4



15	나는 다른 곳에서 살았으면 좋겠다.	0	1	2	3	4
16	왜 나에겐 모든 것이 뒤죽박죽일까?	0	1	2	3	4
17	나는 내 자신을 싫어한다.	0	1	2	3	4
18	나는 가치 없는 인간이다.	0	1	2	3	4
19	나는 어디론가 사라져 버리고 싶다.	0	1	2	3	4
20	도대체 나에겐 무엇이 문제란 말인가?	0	1	2	3	4
21	나는 인생의 패배자다.	0	1	2	3	4
22	내 인생은 엉망진창이다.	0	1	2	3	4
23	나는 실패자다.	0	1	2	3	4
24	나는 결코 성공하지 못할 것이다.	0	1	2	3	4
25	나는 무기력하다.	0	1	2	3	4
26	나는 무언가 변화되어야 한다.	0	1	2	3	4
27	나에겐 틀림없이 무언가 잘못되어 있다.	0	1	2	3	4
28	나는 미래에 대한 희망이 없다.	0	1	2	3	4
29	가치 있게 느껴지는 것이 없다.	0	1	2	3	4
30	나는 어떤 일도 끝까지 해낼 수 없다.	0	1	2	3	4

<부록 6> 자아존중감 척도 (RSS)

※ 다음은 자신이 생각하는 자신에 관한 느낌에 관한 문항입니다. 각 문항을 잘 읽고 자신과 가깝다고 생각되는 정도를 따라 V표 해주십시오. 한 문항도 빠지 말고 반드시 한 문장만을 선택하시되, 너무 오래 생각하지 마시고 솔직하게 응답해 주십시오.

번 호	문 항	전혀 그렇 지 않다	대체로 그렇지 않다	보통 이다	대체 로 그렇 다	매우 그렇 다
1	나는 나 자신을 긍정적으로 생각한다.	1	2	3	4	5
2	나도 다른 사람만큼 일을 잘 해낼 수 있다.	1	2	3	4	5
3	나는 대체적으로 나 자신에게 만족한다.	1	2	3	4	5
4	나는 좋은 점을 많이 가지고 있다고 느낀다.	1	2	3	4	5
5	나도 남들만큼 가치가 있는 사람이라고 느낀다.	1	2	3	4	5
6	나는 자랑거리를 많이 가지고 있지 않다.	1	2	3	4	5
7	나의 삶은 크게 쓸모 있는 것은 아니다.	1	2	3	4	5
8	나에게 나 자신을 존중하는 마음이 좀 더 있었으면 한다.	1	2	3	4	5
9	때때로 나는 전혀 좋은 사람이 아니라고 느껴진다.	1	2	3	4	5
10	나는 대체로 나를 실패자라고 느낀다.	1	2	3	4	5

<부록 7> 정서조절곤란 척도 (DERS)

※ 다음의 문항들은 정서를 처리하는 방식과 관련된 문항입니다. 각 문항들을 잘 읽고, 자신의 모습과 일치하는 정도를 따라 V 표 해주십시오.

번호	문 항	전혀 그렇 지 않다	대체 로그 렇지 않다	보통 이다	대체 로 그렇 다	매우 그렇 다
1	나는 내 감정에 대해 분명하게 알고 있다.	1	2	3	4	5
2	나는 내가 어떻게 느끼는지에 주의를 기울인다.	1	2	3	4	5
3	나는 감정에 압도되고 감정을 통제하기 힘들다고 여긴다.	1	2	3	4	5
4	나는 내가 어떤 감정을 느끼고 있는지를 잘 모른다.	1	2	3	4	5
5	나는 내 감정을 이해하기 어렵다.	1	2	3	4	5
6	나는 내 감정에 주의를 기울인다.	1	2	3	4	5
7	나는 내가 어떻게 느끼고 있는지를 정확하게 안다.	1	2	3	4	5
8	나는 내가 느끼고 있는 것에 관심이 있다.	1	2	3	4	5
9	나는 내가 느끼는 감정(방식)에 대해 혼란스럽다.	1	2	3	4	5
10	나는 화가 나거나 기분이 나쁠 때, 내 감정을 알아차린다.	1	2	3	4	5
11	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 그렇게 느끼는 나 자신에게 화가 난다.	1	2	3	4	5
12	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 그렇게 느끼는 것에 대해 당황하게 된다.	1	2	3	4	5
13	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 일을 끝마치기가 어렵다.	1	2	3	4	5
14	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 자제하지 못한다.	1	2	3	4	5
15	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 오랫동안 내가 그	1	2	3	4	5



	런 상태로 있을 것이라고 믿는다.					
16	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 결국에는 내가 아주 우울해질 것이라고 믿는다.	1	2	3	4	5
17	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 다른 일에 집중하기 어렵다.	1	2	3	4	5
18	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 자제하지 못한다고 느낀다.	1	2	3	4	5
19	나는 화가 나거나 기분이 나쁘더라도, 여전히 일은 끝마칠 수 있다.	1	2	3	4	5
20	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 그렇게 느끼는 것에 대해 부끄럽게 느낀다.	1	2	3	4	5
21	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 궁극적으로 기분이 더 좋아지는 방법을 내가 찾아낼 수 있다고 믿는다.	1	2	3	4	5
22	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 내가 나약한 사람처럼 느껴진다.	1	2	3	4	5
23	나는 화가 나거나 기분이 나쁘더라도, 내 행동을 통제할 수 있는 것처럼 느껴진다.	1	2	3	4	5
24	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 그렇게 느끼는 것에 대해 죄책감을 느낀다.	1	2	3	4	5
25	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 집중하기 어렵다.	1	2	3	4	5
26	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 내 행동을 통제하기가 어렵다.	1	2	3	4	5
27	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 내 기분을 더 좋아지게 하기 위하여 내가 할 수 있는 일이 아무것도 없다고 믿는다.	1	2	3	4	5
28	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 그렇게 느끼는 나 자신에게 짜증이 난다.	1	2	3	4	5
29	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 나 자신에 대해 기분이 매우 나빠지기 시작한다.	1	2	3	4	5
30	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 그 상태에 빠져 허우적거리는 것이 내가 할 수 있는 모든 것이라고 믿는다.	1	2	3	4	5
31	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 내 행동에 대한 통제력을 잃어버린다.	1	2	3	4	5
32	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 다른 어떤 일에	1	2	3	4	5

	대해서도 생각하기가 어렵다.					
33	나는 화가 나거나 기분이 나쁘더라도, 내가 진정으로 느끼고 있는 것이 무엇인지 신중하게 이해한다.	1	2	3	4	5
34	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 다시 기분이 좋아지기까지 오랜 시간이 걸린다.	1	2	3	4	5
35	나는 화가 나거나 기분이 나쁘면, 내 감정들에 의해 압도당하는 것처럼 느껴진다.	1	2	3	4	5

<부록 8> 우울 척도 (BDI)

※ 다음은 일상생활에서 자신이 경험할 수 있는 내용들로 구성되어 있습니다. 각 문항들을 자세히 읽어보시고, 그 중 최근(오늘을 포함하여 지난 2주일 동안) 자신을 가장 잘 나타낸다고 생각되는 하나의 문장을 선택하여 ()안에 V표 해주십시오. 한 문항도 빠지 말고 반드시 한 문장만을 선택하시되, 너무 오래 생각하지 마시고 솔직하게 응답해 주십시오.

1. ① () 나는 슬프지 않다.
 ① () 나는 슬프다.
 ② () 나는 항상 슬퍼서 그것을 떨쳐 버릴 수 없다.
 ③ () 나는 너무나 슬프고 불행해서 도저히 견딜 수 없다.

2. ① () 나는 앞날에 대해서 별로 낙심하지 않는다.
 ① () 나는 앞날에 대해서 비관적인 느낌이 든다.
 ② () 나는 앞날에 대해서 기대할 것이 아무것도 없다고 느낀다.
 ③ () 나의 앞날은 아주 절망적이고 나아질 가능성이 없다고 느낀다.

3. ① () 나는 실패자라고 느끼지 않는다.
 ① () 나는 보통 사람들보다 더 많이 실패할 것 같다.
 ② () 내가 살아온 과거를 되돌아보면, 생각나는 것은 실패뿐이다.
 ③ () 나는 인간으로서 완전히 실패자인 것 같다.

4. ① () 나는 전과 같이 일상생활에 만족하고 있다.
 ① () 나의 일상생활은 전처럼 즐겁지 않다.
 ② () 나는 더 이상 어떤 것에서도 참된 만족을 얻지 못한다.
 ③ () 나는 모든 것이 다 불만스럽고 지겹다.

5. ① () 나는 특별히 죄책감을 느끼지 않는다.
 ① () 나는 죄책감을 느낄 때가 많다.
 ② () 나는 거의 언제나 죄책감을 느낀다.
 ③ () 나는 항상 죄책감을 느낀다.

6. ① () 나는 벌을 받고 있다고 느끼지 않는다.
 ① () 나는 아마 벌을 받을 것 같다.
 ② () 나는 벌을 받아야 한다고 생각한다.
 ③ () 나는 항상 벌을 받고 있다고 느낀다.

7. ① () 나는 나 자신에게 실망하지 않는다.

- ① () 나는 나 자신에게 실망하고 있다.
 ② () 나는 나 자신이 혐오스럽다.
 ③ () 나는 나 자신을 증오했다.
8. ① () 내가 다른 사람보다 못한 것 같지는 않다.
 ① () 나는 나의 약점이나 실수에 대해서 나 자신을 탓한다.
 ② () 내가 한 일이 잘못되었을 때는 언제나 나를 탓한다.
 ③ () 일어나는 모든 나쁜 일들은 다 내 탓이다.
9. ① () 나는 자살 같은 것은 생각하지 않는다.
 ① () 나는 자살 할 생각은 하고 있으나 실제로 하지는 않을 것이다.
 ② () 나는 자살하고 싶다.
 ③ () 나는 기회만 있으면 자살하겠다.
10. ① () 나는 평소보다 더 울지는 않는다.
 ① () 나는 전보다 많이 운다.
 ② () 나는 요즘 항상 운다.
 ③ () 나는 전에는 울고 싶을 때 울 수 있었지만, 요즘은 울 기력조차 없다.
11. ① () 나는 요즘 평소보다 더 짜증을 내는 편은 아니다.
 ① () 나는 전보다 더 쉽게 짜증이 나고 귀찮아진다.
 ② () 나는 요즘 항상 짜증스럽다.
 ③ () 전에는 짜증스럽던 일에 요즘은 너무 지쳐서 짜증조차 나지 않는다.
12. ① () 나는 다른 사람들에 대한 관심을 잃지 않고 있다.
 ① () 나는 전보다 다른 사람들에 대한 관심이 줄었다.
 ② () 나는 다른 사람들에 대한 관심이 거의 없어졌다.
 ③ () 나는 다른 사람들에 대한 관심이 완전히 없어졌다.
13. ① () 나는 평소처럼 결정을 잘 내린다.
 ① () 나는 결정을 미루는 때가 전보다 더 많다.
 ② () 나는 전에 비해 결정을 내리는 데에 더 큰 어려움을 느낀다.
 ③ () 나는 더 이상 아무 결정도 내릴 수가 없다.
14. ① () 나는 전보다 내 모습이 더 나빠졌다고 느끼지 않는다.
 ① () 나는 나이 들어 보이거나 매력 없어 보일까봐 걱정한다.
 ② () 나는 내 모습이 매력 없게 변해버린 것 같은 느낌이 든다.
 ③ () 나는 내가 추하게 보인다고 믿는다.
15. ① () 나는 전처럼 일을 할 수 있다.

- ① () 어떤 일을 시작하려면 전보다 훨씬 더 많은 노력이 든다.
 ② () 나는 무엇인가를 하려면 매우 힘들다.
 ③ () 나는 전혀 아무 일도 할 수가 없다.
16. ① () 나는 평소처럼 잘 잔다.
 ① () 나는 전만큼 잘 자지 못한다.
 ② () 나는 평소보다 한두 시간 빨리 깨고 다시 잠들기 어렵다.
 ③ () 나는 평소보다 몇 시간이나 일찍 깨고, 한번 깨면 다시 잠들지 못한다.
17. ① () 나는 평소보다 더 피곤하지는 않다.
 ① () 나는 전보다 쉽게 피곤해진다.
 ② () 나는 무엇을 해도 언제나 피곤해진다.
 ③ () 나는 너무나 피곤해서 아무 일도 할 수가 없다.
18. ① () 내 식욕은 평소와 다름없다.
 ① () 나는 요즘 전보다 식욕이 좋지 않다.
 ② () 나는 요즘 식욕이 많이 떨어졌다.
 ③ () 요즘에는 식욕이 전혀 없다.
19. ① () 요즘 체중이 별로 줄지 않았다.
 ① () 전보다 몸무게가 2kg 가량 줄었다.
 ② () 전보다 몸무게가 5kg 가량 줄었다.
 ③ () 전보다 몸무게가 7kg 가량 줄었다.
- 19-1. 나는 현재 음식 조절로 체중을 줄이고 있는 중이다. (① 예 ② 아니오)
20. ① () 나는 건강에 대해 전보다 더 염려하고 있지는 않다.
 ① () 나는 여러 가지 통증, 소화불량, 변비 등 신체적인 문제로 걱정하고 있다.
 ② () 나는 건강이 염려되어 다른 일을 생각하기 힘들다.
 ③ () 나는 건강이 너무 염려되어 다른 일은 아무것도 생각할 수 없다.
21. ① () 나는 요즘 성에 대한 관심에 별다른 변화가 있는 것 같지는 않다.
 ① () 나는 전보다 성에 대한 관심이 줄었다.
 ② () 나는 전보다 성에 대한 관심이 상당히 줄었다.
 ③ () 나는 성에 대한 관심을 완전히 잃어버렸다.

<부록 9> 상태-특성 불안 척도 (STAI)

※ 다음은 사람들이 자신을 표현하는데 사용되는 것들입니다. 각 문항을 잘 읽고, 자신이 지금 이 순간에 느끼고 있는 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 정도에 V표 해주십시오. 한 문항도 빠지 말고 반드시 한 문장만을 선택하시되, 너무 오래 생각하지 마시고 솔직하게 응답해 주십시오.

번호	문항	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇다	매우 그렇다
1	나는 마음이 차분하다.	1	2	3	4
2	나는 마음이 든든하다.	1	2	3	4
3	나는 긴장되어 있다.	1	2	3	4
4	나는 후회스럽고 서운하다.	1	2	3	4
5	나는 마음이 편하다.	1	2	3	4
6	나는 당황해서 어찌할 바를 모르겠다.	1	2	3	4
7	나는 앞으로 불행이 있을까 걱정하고 있다.	1	2	3	4
8	나는 마음이 놓인다.	1	2	3	4
9	나는 불안하다.	1	2	3	4
10	나는 편안하게 느낀다.	1	2	3	4
11	나는 자신감이 있다.	1	2	3	4
12	나는 짜증이 난다.	1	2	3	4
13	나는 마음이 조마조마하다.	1	2	3	4
14	나는 극도로 긴장되어 있다.	1	2	3	4



15	내 마음은 긴장이 풀려 푸근하다.	1	2	3	4
16	나는 만족스럽다.	1	2	3	4
17	나는 걱정하고 있다.	1	2	3	4
18	나는 흥분되어 어쩔 줄 모른다.	1	2	3	4
19	나는 즐겁다.	1	2	3	4
20	나는 기분이 좋다.	1	2	3	4
21	나는 언제나 기분이 좋다.	1	2	3	4
22	나는 쉽게 피로해진다.	1	2	3	4
23	나는 울고 싶은 심정이다.	1	2	3	4
24	나도 다른 사람들처럼 행복했으면 한다.	1	2	3	4
25	나는 마음을 빨리 정하지 못해서 실패를 한다.	1	2	3	4
26	나는 마음이 놓인다.	1	2	3	4
27	나는 차분하고 침착하다.	1	2	3	4
28	나는 너무 많은 여러 문제가 밀어닥쳐서 극복할 수 없을 것 같다.	1	2	3	4
29	나는 하찮은 일에 너무 걱정을 한다.	1	2	3	4
30	나는 행복하다.	1	2	3	4
31	나는 무슨 일이건 힘들게 생각한다.	1	2	3	4
32	나는 자신감이 부족하다.	1	2	3	4

33	나는 마음이 든든하다.	1	2	3	4
34	나는 위기나 어려움을 피하려고 애쓴다.	1	2	3	4
35	나는 울적하다.	1	2	3	4
36	나는 만족스럽다.	1	2	3	4
37	사소한 생각이 나를 괴롭힌다.	1	2	3	4
38	나는 실망을 지나치게 예민하게 받아들이기 때문에 머리 속에서 지워버릴 수가 없다.	1	2	3	4
39	나는 착실한 사람이다.	1	2	3	4
40	나는 요즈음의 걱정이나 관심거리를 생각하면 긴장되 거나 어찌할 바를 모른다.	1	2	3	4

<부록 10> 상태-특성 분노 척도 (STAXI)

※ 다음은 사람들이 자신을 표현하는데 사용되는 것들입니다. 각 문항을 잘 읽고, 자신이 지금 이 순간에 느끼고 있는 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 정도에 V표 해주십시오. 한 문항도 빠지 말고 반드시 한 문장만을 선택하시되, 너무 오래 생각하지 마시고 솔직하게 응답해 주십시오.

[평소에 느끼는 일반적인 기분과 심정을 기준으로 답해주십시오.]					
번 호	문 항	전혀 그렇지 않다	조금 그렇다	보통 그렇다	매우 그렇다
1	나는 성미가 급하다.	1	2	3	4
2	나는 불같은 성질을 지녔다.	1	2	3	4
3	나는 격해지기 쉬운 사람이다.	1	2	3	4
4	나는 다른 사람이 잘못해서 내 일이 늦어지게 되면 화가난다.	1	2	3	4
5	나는 일을 잘하고도 다른 사람으로부터 인정받지 못하면 분통이 터진다.	1	2	3	4
6	나는 쉽게 화를 낸다.	1	2	3	4
7	나는 화가 나면 욕을 한다.	1	2	3	4
8	나는 다른 사람 앞에서 비판을 받게 되면 격분한다.	1	2	3	4
9	나는 내 일이 막히면, 누군가를 때려주고 싶다.	1	2	3	4
10	나는 일을 잘했는데도 나쁜 평가를 받게 되면 격분한다.	1	2	3	4
[요즘 느끼는 기분과 심정을 기준으로 답해 주십시오.]					
11	나는 격분하고 있다.	1	2	3	4
12	나는 짜증을 느끼고 있다.	1	2	3	4
13	나는 분노하고 있다.	1	2	3	4

14	나는 누군가에게 소리 지르고 싶다.	1	2	3	4
15	나는 물건을 부수고 싶다.	1	2	3	4
16	나는 미칠 듯이 화가 나 있다.	1	2	3	4
17	나는 책상을 주먹으로 내리치고 싶다.	1	2	3	4
18	나는 누군가를 때려주고 싶다.	1	2	3	4
19	나는 속이 부글부글 끓고 있다.	1	2	3	4
20	나는 욕을 퍼붓고 싶다.	1	2	3	4
[평소에 화가 나거나 분노를 느꼈을 때 어떻게 하시는지를 기분으로 답해주시요.]					
21	나는 화를 참는다.	1	2	3	4
22	나는 화난 감정을 표현한다.	1	2	3	4
23	나는 말을 하지 않는다.	1	2	3	4
24	나는 사람들에게 인내심을 가지고 대한다.	1	2	3	4
25	나는 똥해지거나 토라진다.	1	2	3	4
26	나는 사람들을 피한다.	1	2	3	4
27	나는 소리를 지른다.	1	2	3	4
28	나는 냉정을 유지한다.	1	2	3	4
29	나는 문을 꽂아 버리는 식의 행동을 한다.	1	2	3	4
30	나는 상대의 시선을 피한다.	1	2	3	4

31	나는 나의 행동을 자제한다.	1	2	3	4
32	나는 사람들과 말다툼을 한다.	1	2	3	4
33	나는 아무에게도 말하지 않으나 안으로는 앙심을 품는 경향이 있다.	1	2	3	4
[평소에 화가 나거나 분노를 느꼈을 때 어떻게 하시는지 기분으로 답해주십시오.]					
34	나는 목소리를 높인다.	1	2	3	4
35	나는 화가 나더라도 침착하게 자제할 수 있다.	1	2	3	4
36	나는 속으로는 다른 사람들을 비판한다.	1	2	3	4
37	나는 나 자신이 인정하고 싶은 것보다 더 화가 나있다.	1	2	3	4
38	나는 대부분의 사람보다 빨리 진정하는 편이다.	1	2	3	4
39	나는 욕을 한다.	1	2	3	4
40	나는 참고 이해하려 노력한다.	1	2	3	4
41	나는 다른 사람들이 알고 있는 것보다 더 분통이 나있다.	1	2	3	4
42	나는 자제심을 잃고 화를 낸다.	1	2	3	4
43	나는 화난 표정을 짓는다.	1	2	3	4
44	나는 화난 감정을 자제한다.	1	2	3	4

<부록 11> 스트레스 대처방식 척도 (SCSC)

※ 최근에 나 자신을 매우 불안하게 한 일이나 심한 스트레스를 유발한 일을 떠올려보시기 바랍니다. 떠올린 일을 생각하며 내가 그 일에 어떻게 대처하였는지를 생각해보고 해당되는 곳에 V표 해주십시오. 한 문항도 빠지 말고 반드시 한 문장만을 선택하시되, 너무 오래 생각하지 마시고 솔직하게 응답해 주십시오.

번 호	문 항	전혀 그렇 지 않다	그렇 지 않다	약간 그렇 다	꽤 그렇 다	매우 그렇 다
1	활동계획을 세우고 그것에 따른다.	0	1	2	3	4
2	무엇을 해야 할지를 알기 때문에 일이 잘 되도록 더 열심히 노력한다.	0	1	2	3	4
3	일이 어떻게 되었으면 좋겠다는 공상이나 소망을 한다.	0	1	2	3	4
4	자신이 처한 지금의 상황보다 더 좋은 경우를 상상하거나 공상한다.	0	1	2	3	4
5	문제를 구체화시킬 수 있는 사람과 이야기한다.	0	1	2	3	4
6	존경하는 친척이나 친구에게 조언을 구한다.	0	1	2	3	4
7	모든 것을 잊어버리려고 노력한다.	0	1	2	3	4
8	그 일을 무시해버리거나 그것을 너무 심각하게 받아들이지 않는다.	0	1	2	3	4
9	그 일에서 무엇인가 창조적인 일을 할 수 있는 단서를 얻는다.	0	1	2	3	4
10	일이 잘 되어 나갈 수 있도록 무엇인가를 변화시킨다.	0	1	2	3	4
11	운이 나쁠 때도 있으므로 운으로 돌린다.	0	1	2	3	4
12	아무 일이 안 일어난 것처럼 행동한다.	0	1	2	3	4
13	그 일이 사라지거나 끝나버리기를 바란다.	0	1	2	3	4



14	일어난 일이나 나의 느낌을 바꿀 수 있기를 바란다.	0	1	2	3	4
15	자신이 느끼고 있는 바를 누구에게 말한다.	0	1	2	3	4
16	그 일에 대해 좀 더 알아보려고 누군가와 이야기한다.	0	1	2	3	4
17	그 문제를 더 잘 이해하기 위해서 그것을 자세히 분석해 본다.	0	1	2	3	4
18	다음 단계에는 어떻게 할 것인지에 대해서 전념한다.	0	1	2	3	4
19	그 일을 잊기 위해서 다른 일을 하거나 다른 활동을 한다.	0	1	2	3	4
20	다른 사람에게 분풀이를 한다.	0	1	2	3	4
21	그 일이 지금보다 더 나쁠 수도 있었음을 스스로 일깨운다.	0	1	2	3	4
22	그 일이 잘 되게 해 달라고 기도한다.	0	1	2	3	4
23	전문적인 도움을 청한다.	0	1	2	3	4
24	다른 사람들의 동정과 이해를 받아들인다.	0	1	2	3	4

**<부록 12 > 실험집단의 이미지 재구성 I, II 회기로 인한
주관적 변화 정도 및 소감**

1. A(20대/여성)

	1회차 이미지 재구성 I 사전	1회차 이미지 재구성 I 사후	2회차 이미지 재구성 I 사전	2회차 이미지 재구성 I 사후	3회차 이미지 재구성 II 사전	3회차 이미지 재구성 II 사후
1. 대인외상경험 의 생생함 (0~100)	90점 → 60점		50점 → 40점			
2. 대인외상경험의 고통감 (0~100)	100점 → 50점		40점 → 20점		1. 새로운 대안적 핵심신념을 믿는 정도	
3. 핵심신념을 믿는 정도 (0~100)	100점 → 5점		50점 → 10점		60점 → 80점	

1회차(5회기)		내가 나를 구해줄 수 있다는 게 신기하기도 했고, 그렇게 생각하고 나니까 무서운 게 별로 없어지는 것 같아서 좋았어요. 왜냐하면 눈을 감고 그때를 떠올리는 게 눈을 감자마자 무서웠는데 나를 도와주고 위로해주는 것까지 하고, 다 끝나고 나서 눈을 뜨니까 무서웠던 기분이 괜찮아졌고, 오히려 흥분해졌어요.
2회차(7회기)	이미지 재구성 I: 과거 대인외 상경험	그냥 이때까지는 그때의 경험을 떠올리면 그일 자체가 저한테 있어서 약점인 것 같았어요. 그리고 왜 그랬을까... 내가 처음부터 시작하지를 말걸... 이런 저에 대한 자책과 후회가 제일 많았고, 약간 그 사람에 대한 분노도 있긴 있었는데 그것보다는 저에 대한 자책이 정말 비교도 할 수 없을 만큼 더 컸어요. 그런데 개인회기 하면서 웬지 내 자신에 대한 자책감이 줄었고, 그만큼 그 사람에 대한 분노가 커야 될 것 같지만 또 그렇지도 않네요. 그 사람에 대한 생각 자체가 별로 없어지는 것 같고 그리고 알게 모르게 그 경험이 제 삶의 구멍처럼, 약점처럼 느껴져서 그런지 마음이 항상 허한 게 있었는데 이제는 좀 충만한 느낌이 들어요. 그래서 신기한 것 같아요. 진짜로 사실은 그냥 눈을 감고 상상만으로도 제가 저를 도와준 게 신기하고, 그게 가능하다는 걸 배운 것 같아요.
3회차(9회기)	이미지 재구성 II:	떠올리면서 제가 잘 해결해나가는 모습을 보면서 진심으로 즐거웠고, 식단 일지 포함해서 집단에서 배운 모든 것들이 저에게 정말 큰 도움이 되었다는 걸 다시 한 번 깨닫게 되는 계기가 되었어요. 그리

	미래심상(‘최고로 가능한 자기’)	고 아까 연구자님께서 문제해결에 대한 힌트를 주셨을 때 그런게 좀 진짜 실생활에서도 도움이 되고 실제로 그런 일이 생긴다거나 생겼을 때 제가 해볼 수 있는 방법들이 많으니까 제 마음을 든든하게 해주는 것도 있었어요.
--	--------------------	--

1회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사전)	1회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사후)
1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 나는 무능하고, 무력하고, 도움이 필요하고, 의지할 곳이 필요한 상태이다. 2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 어리다. 2) 무서움 3) 도움을 청할 사람이 있었으면 좋겠다.	1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 그때의 나는 외로웠고, 함께할 누군가가 필요했다. 2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 안타깝다. 2) 안쓰럽다. 3) 이제는 그때의 나를 비난하지 말고 위로해주고 싶다.
2회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사전)	2회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사후)
1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 자책하거나 비난할 필요 없이 그냥 나는 외로웠을 뿐이다. 외로웠다. 2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 슬픔 2) 안쓰럽다. 3) 덜 생생하다.	1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 이제는 그때를 떠올리면 그냥 내가 나를 도와주고, 위로할 수 있다. 2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 용기 2) 든든함 3) 이제는 괜찮다는 안도감
3회차 이미지 재구성 II: 미래심상(사전)	3회차 이미지 재구성 II: 미래심상(사후)
1. 현재 자신에 대한 이미지 1) 항상 바쁘다. 2) 뭔가를 잘 잊어버린다. 3) 부지런하다.	1. 현재 자신에 대한 이미지 1) 뭐든 열심히 노력한다. 2) 깊게 생각한다. 3) 주변 사람들을 중요하게 생각한다.

2. B(20대/여성)

	1회차 이미지 재구성 I 사전	1회차 이미지 재구성 I 사후	2회차 이미지 재구성 I 사전	2회차 이미지 재구성 I 사후	3회차 이미지 재구성 II 사전	3회차 이미지 재구성 II 사후
1. 대인외상경험의 생생함	100점 → 80점		90점 → 50점			

(0~100)			
2. 대인외상경험의 고통감 (0~100)	70점 → 10점	40점 → 30점	2. 새로운 대안적 핵심신념을 믿는 정도
3. 핵심신념을 믿는 정도 (0~100)	100점 → 80점	60점 → 20점	81점 → 90점

1회차(5회기)	이미지 재구성 I: 과거 대인외 상경험	항상 전문적인 심리 상담 전문가에게 상담을 받으면 어떨까라는 생각을 했었는데 이번 기회에 이 작업을 통해서 따뜻함을 느꼈어요. 살면서 저의 부족한 부분을 지적하고, 구박하기만 한 것 같은데 제가 저를 위로하고, 위로받는 날이 다 오네요...
2회차(7회기)		지난 번 작업보다 마음이 더 편안해졌고, 좀 더 진심으로? 체계적으로? 저를 도우면서 더 위로를 받았어요. 떠올리기 싫은 기억이라 한참 피해 다녔고, 전혀 피해지지 않고 가끔씩 저도 모르게 떠오르던 지우고 싶던 기억이었는데... 저번에는 떠올리기 싫어서 힘들었는데 오늘은 그만큼 힘들지는 않았어요. 위로받고 싶었나 봐요. 한동안은 혼자 이걸 떠올려보면서 다양한 방법으로 어떻게 위로해주면 도와주면 좋을지도 생각했었어요. 그러면 마음이 편안해져요.
3회차(9회기)	이미지 재구성 II: 미래심 상('최 고로 가능한 자기')	제가 평소에 좇불 끄기로 도움을 많이 받아서 사실 되게 많이 해봤거든요. 그런데 오늘도 문제가 생기니까 바로 좇불 끄기부터 시작하는 게 신기했어요. 습관이 무섭네요. 그리고 전에 프로그램에서 대치카드 그럴 때 어떤 순서로 하고, 어떤 안 좋은 생각을 합리적인 생각으로 바꿔서 쓰고 이거를 큰 생각 없이 만든 줄 알았는데 오늘 바로바로 대치카드가 떠올랐어요. 사실 책상에 놔두고 있어서 자주 보거든요. 그림이나 문구가 매뉴얼처럼 그냥 그 순서대로만 해도 되네요. 물론 잠깐 생각이 안 나서 막혔던 적도 있지만 그때 감사하게도 연구자님이 방향성? 힌트 주셔서 나중에 비슷한 상황에서 막히면 혼자서 해결해볼 수 있을 것 같아요. 자신감이 생기네요.

1회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사전)		1회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사후)	
1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 남들과 잘 어울리지 못하는 성격이다.		1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 독립적인 성격이다.	
2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 외톨이 2) 피해 3) 혼자 책만 많이 읽음		2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 왕따 2) 외로움 3) 독립적	
2회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사전)		2회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사후)	
1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있		1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고	

는 생각 및 의미: 충격적이고, 사랑을 받지 못했다. 2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 세상은 아무도 내 편이 없는 외톨이 2) 비참함 3) 믿을 사람이 없다.	있는 생각 및 의미: 나는 불쌍했구나 2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 쓸쓸함, 외로움 2) 위로받고 싶은 아이 3) 내가 나를 사랑하지 못함.
3회차 이미지 재구성 II: 미래심상(사전)	3회차 이미지 재구성 II: 미래심상(사후)
1. 현재 자신에 대한 이미지 1) 고집 2) 독립적 3) 변화	1. 현재 자신에 대한 이미지 1) 변화의 방법 2) 나를 위한 노력 3) 관계

3. C(20대/여성)

	1회차 이미지 재구성 I 사전	1회차 이미지 재구성 I 사후	2회차 이미지 재구성 I 사전	2회차 이미지 재구성 I 사후	3회차 이미지 재구성 II 사전	3회차 이미지 재구성 II 사후
1. 대인외상경험의 생생함 (0~100)	100점 → 100점		90점 → 70점		3. 새로운 대안적 핵심신념을 믿는 정도	
2. 대인외상경험의 고통감 (0~100)	100점 → 80점		55점 → 35점			
3. 핵심신념을 믿는 정도 (0~100)	100점 → 85점		60점 → 25점		60점 → 75점	

1회차(5회기)	이미지 재구성 I:	어린 시절의 저는 혼자 그 상황을 감당하면서 주위에 도와줄 사람이 한 명도 없었는데 이번에는 도와줄 사람이 있었으니까... 나라도 있었으니까 덜 무서웠어요. 끝나고 나니까 홀가분한 기분이에요.
2회차(7회기)	과거 대인외 상경험	그 상황에서 만약 누군가가 있었다면 한명이라도... 정말 좋았을 것 같다는 생각도 들고... 지금까지 뿌리치거나 제대로 거절하지 못한 제 탓이라고만 생각했는데 그 사람이 나쁘고 잘못된 거지 제 잘못이 아니니까 앞으로 그런 생각은 안 했으면 좋겠다는 생각이 들어요. 그리고 이번 회기를 하면서 조금 더 마음치료가 된 것 같아요. 지난 회기에서는 기억을 떠올리기만 해도 정말 힘들었는데 지금은 흐릿하게? 기억이 처음처럼 잘 나지는 않아요. 그래서 덜 힘든 것

		같아요. 맨 처음 할 때는 내가 과연 할 수 있을까?라는 생각도 들고 걱정이 많이 되었는데 그냥 연구자님 목소리를 듣고 하다보니까 공감도 많이 되고, 소통하고 위로받고 하다보니까 우울했던 감정도 덜어지고 더 홀가분해요.
3회차(9회기)	이미지 재구성 II: 미래심상(‘최고로 가능한 자기’)	상상하면서 정말 즐거웠고, 그동안 배웠던 걸 복습하면서 상황을 해결하고, 폭식도 하지 않는 저를 보면서 자신감을 얻었어요. 배운 대로 혼자서도 잘 할 수 있을 것 같아요. 옛날에는 다른 사람이나 관계적인 스트레스 받으면 많이 먹으면서 폭식하는 것밖에 제 스트레스를 풀 수 있는 방법이 없다고 생각했어요.

1회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사전)		1회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사후)	
1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 다른 사람에 대한 두려움		1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 도망가거나 제대로 거절하지 못한 것에 대한 후회	
2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 분노 2) 나에 대한 죽음, 자살 3) 공포		2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 우울 2) 후회 3) 슬픔	
2회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사전)		2회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사후)	
1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 내성적, 소심함		1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 어린 나를 그럴 수밖에 없었구나. 최선이구나. 누군가 나를 도와줄 수도 있구나	
2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 무서움 2) 분노 3) 외로움		2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 언니(어렸을 적 자신을 도와주던 성인인 자신)의 위로로 인한 안정감 2) 가족에 대한 이해 3) 희망적	
3회차 이미지 재구성 II: 미래심상(사전)		3회차 이미지 재구성 II: 미래심상(사후)	
1. 현재 자신에 대한 이미지 1) 자신감 2) 내성적 3) 건담		1. 현재 자신에 대한 이미지 1) 다양함 2) 희망적 3) 극복	

4. D(20대/여성)

	1회차 이미지 재구성 I 사전	1회차 이미지 재구성 I 사후	2회차 이미지 재구성 I 사전	2회차 이미지 재구성 I 사후	3회차 이미지 재구성 II 사전	3회차 이미지 재구성 II 사후
1. 대인외상경험의 생생함 (0~100)	40점 → 80점		30점 → 20점			
2. 대인외상경험의 고통감 (0~100)	60점 → 20점		10점 → 0점			
3. 핵심신념을 믿는 정도 (0~100)	100점 → 20점		20점 → 3점		4. 새로운 대안적 핵심신념을 믿는 정도 85점 → 95점	

1회차(5회기)	이미지 재구성 I: 과거 대인외 상경험	저는 그 힘들었던 일이 잊고 있어서 기억이 되게 짧다고 생각해서 많이 힘들었다는 것도 몰랐고, 그 일 이후에 그렇게 심하게 힘들다고 생각하지는 않았는데 이미지 재구성을 하면서 힘든 감정이 갑자기 확 들어서 당황스럽기도 하고, 그때의 그 경험이 지금도 영향을 많이 미칠 수 있다는 생각이 계속 들었어요. 사실 이미지 재구성하기 전에도 저를 괴롭히던 그 친구와 관련된 힘든 기억이 떠올라서 힘들었다가 그래도 시간이 많이 지나서 속으로 조금 용서했다고 생각했었는데 작업이 끝나고 나서 보니까 지금 이제야 조금 용서가 되는 것 같아요. 신기하네요.
2회차(7회기)		개인회기 할 때 처음 사전면담이나 5회기 때는 저도 모르게 눈물이 나고 그래서 힘들었는데 지금은 그때마다 많이 해소가 돼서 그런지 그 기억을 좀 더 떠올려보려고 해도 잘 기억이 안 나고, 그때 느꼈던 부정적인 감정도 많이 없어진 것 같아요. 신기하게 웃으면서 얘기가 나오네요. 너무 신기해요.
3회차(9회기)	이미지 재구성 II: 미래심 상('최 고로 가능한 자기')	일단 너무 후련하고, 아직도 막 웃음이 나요. 기분이 즐겁고 좋아가지고 좀 더 생각해보면 그때그때 상황마다 힘들었던 거를 좀 얘기하지 못하고, 참았던 것들을 얘기하니까 그냥 얘기하는 것만으로도 좀 후련하고, 시간이 길든 짧은 그냥 그거를 제가 스스로 상대방에게 눈치 보지 않고 말할 수 있었다는 게 좋고, 실제로도 그렇게 노력하고 있어서 조금씩 제 의견을 표현하고 있어요. 저 지금 폭식도 안 하고 있어요. 충분히 변할 수 있다는 생각. 나도 할 수 있다는 생각들이 너무 도움이 되는 것 같아요.

1회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사전)	1회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사후)
1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 대인관계를 맺는 방식이	1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 지금 나의 대인관계에

잘못되었다. 2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 무력함 2) 배신감 3) 분노	대해서 생각해봐야겠다. 2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 순진함 2) 다정함 3) 바보 같은
2회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사전)	2회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사후)
1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 다른 사람한테 내 생각과 감정을 충분히 전달하지 못한다. 2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 무기력 2) 답답함 3) 후회	1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 나에게 좋은 영향을 미치는 사람들을 더 잘 챙겨야한다. 2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 후회 2) 친구 3) 경험
3회차 이미지 재구성 II: 미래심상(사전)	3회차 이미지 재구성 II: 미래심상(사후)
1. 현재 자신에 대한 이미지 1) 밝음 2) 변해가는 중 3) 노력	1. 현재 자신에 대한 이미지 1) 편안함과 즐거움 2) 후련함 3) 상상했던 방법들을 실제로 실천하고 싶다는 생각과 의지

5. E(20대/여성)

	1회차 이미지 재구성 I 사전	1회차 이미지 재구성 I 사후	2회차 이미지 재구성 I 사전	2회차 이미지 재구성 I 사후	3회차 이미지 재구성 II 사전	3회차 이미지 재구성 II 사후
1. 대인외상경험의 생생함 (0~100)	100점 → 100점		100점 → 80점			
2. 대인외상경험의 고통감 (0~100)	100점 → 20점		50점 → 30점			
3. 핵심신념을 믿는 정도 (0~100)	100점 → 50점		60점 → 10점		5. 새로운 대안적 핵심신념을 믿는 정도 100점 → 100점	

1회차(5회기)		이거를 회상을 안 해야겠다는 생각이 많아서 묻어두고 있었는데 이미지 재구성을 하니까 하늘나라 간 동생이 무서운 게 아니라 나도 슬픈데 엄마, 아빠도 슬퍼하니까 참고 있고, 부모님이랑 떨어진 상황에서 전 또 너무 어린 막내 동생을 챙기면서 개를 안 무섭게 해주려고 제 감정은 숨기고 더 강한척했던 기억이 새롭게 생각나는 것 같아요...
2회차(7회기)	이미지 재구성 I: 과거 대인외상경험	지난 개인 회기는 되게 힘들었다고 해야 하나 아이 일 때, 어른 일 때처럼 다른 관점에서 보니까 어느 정도 인지가 된다고 해야 하나 뭔가 가늠이 되고 어떤 기분이겠다. 진짜 힘들었구나. 이런 것들이 그때의 기분을 정확하게 알게 되는 것들이 저를 편안하게 만들어줬어요. 그리고 오늘 시작하기 전에 다시 한다고 해도 슬플 것 같다고 생각했는데 오늘 막상 하고 나니까 부담감이나 책임감이 덜해진 느낌이 들어요. 지난 회기 이후에 혼자만의 생각에 갇혀서 틀을 만들고, 그 틀로 모든 관계를 정의하지 말자는 생각을 종종했어요. 저를 힘들게 하는 상황들을 다시 보면 내가 그려낸 나만의 시선에서 생각한 것이니까 나만의 고정적인 틀을 벗어나서 다양한 관점에서 생각하고, 이해해야겠다고 생각했어요. 그 이유는 다양한 관점에서 보면 좀 덜 슬프고, 덜 화나지 않을까요. 기분이 변화될 수도 있구요.
3회차(9회기)	이미지 재구성 II: 미래심상(‘최고로 가능한 자기’)	관계에서 스트레스를 받으면 그니까 진짜 열 받았을 때 상대방에게 표현하지 않고, 혼자 속으로 화내면서 좀 글로 쓰거나 머리로만 생각하는 편인데 말로 표현하니까 통쾌하네요. 직접 표현하는 게 훨씬 더 후련하고, 중요하다는 생각이 들어요. 할 말 다 하면 후련하네요. 옛날에는 혼자 화나는 거 삭히면서 아니면 어떤 기분인지도 모르고 화가 났는지 슬픈지도 모르고 바로 폭식을 했었는데 폭식 말고 제가 저를 위해 해볼 수 있는 방법들이 다양하게 많아졌어요.

1회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사전)	1회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사후)
1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 잊히지 않는, 잠시적인 불안감, 충격적인	1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 나도 어리고 슬픈데 나 말고 부모님과 동생을 챙기고 있는 내 자신이 안쓰럽다.
2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 자책 2) 충격적인 3) 책임감	2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 불쌍함 2) 슬픔 3) 무섭다
2회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사전)	2회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사후)
1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 나의 슬픔을 말해줌	1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 성숙해지고 있다.

2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 책임감 2) 무서움 3) 슬픔	2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 책임감 2) 슬픔 3) 상실감
3회차 이미지 재구성Ⅱ: 미래심상(사전)	3회차 이미지 재구성Ⅱ: 미래심상(사후)
1. 현재 자신에 대한 이미지 1) 무뚝뚝 2) 꼼꼼함 3) 책임감	1. 현재 자신에 대한 이미지 1) 생각이 많다(~하면 어떻게 될까?, 변수) 2) 결정 3) 호불호가 확실하다.

6. F(30대/여성)

	1회차 이미지 재구성 I 사전	1회차 이미지 재구성 I 사후	2회차 이미지 재구성 I 사전	2회차 이미지 재구성 I 사후	3회차 이미지 재구성 II 사전	3회차 이미지 재구성 II 사후
1. 대인외상경험의 생생함 (0~100)	50점 → 80점		80점 → 70점			
2. 대인외상경험의 고통감 (0~100)	90점 → 70점		40점 → 10점			
3. 핵심신념을 믿는 정도 (0~100)	80점 → 30점		50점 → 0점		90점 → 95점	

1회차(5회기)	이미지 재구성 I: 과거 대인외 상경험	처음 1단계는 과거의 힘들었던 기억을 떠올려야 하고, 그 생각의 이미지에 집중하니까 갑자기 머릿속이 너무 어지러웠어요. 무섭고... 너무 어린 시절의 짧은 단편적인 기억이지만 그냥 아... 나한테 정말 많은 영향을 주고 있는 부분이었구나... 몰랐네... 이렇게만 생각 하고 있었어요. 그런데 2, 3단계를 전체적으로 경험하고 나니까 뭔가 진짜 그때로 돌아가서 다녀온 것 같은 기분이 들었어요. 사실 그때의 기억이 가끔씩 들 때면 너무 무섭고 불쾌하고 그냥 빨리 지워버리려고 하고 그냥 없애버리려고만 했는데 지금 이걸 하니까 약간 뭔가 해소된 느낌이랄까 그런 느낌이 들어요.
2회차(7회기)		책이나 영상이나 상담이나 보면 ‘내가 나 자신을 사랑해줘야 한다.’는 그런 약간 뻘한 이야기들을 굉장히 많이 하잖아요. 그런 이야기들을 들었을 때 진짜 한숨만 나고 머리로는 알겠는데 좋은지 알겠

		는데... 그냥 그게 어떻게 하는 건지 도대체 뭔지 몰랐던 것 같아요. 그 자체가 그냥 공부를 열심히 하면 돼. 그런데 공부를 어떻게 해야 잘 할 수 있는지 방법을 모르는 것처럼 그냥 나 자신을 도대체 어떻게 사랑해주란 말이지? 와 닿지도 않고, 너무 몰랐어요. 그런데 이 회기를 하면서 한 번에 이해가 되었어요. 아... 내가 진짜 그때 어릴 때 힘들었구나... 사실 제가 한여름인데도 겨울 이불을 덮고 자는 거 되게 좋아하거든요. 그런데 이거 하면서 아... 내가 잘 때 그렇게 포근함과 따뜻함을 느끼고 싶어서 위로받고 싶어서 사랑받고 싶어서 그런 거구나... 하는 이해가 되었고 나는 그냥 아주 어렸을 때 그때부터 많이 불안했던 거구나... 그냥 이런 게 느껴지는 거예요. 이런 것들이 하나둘씩 이해가 되니까 이런 이해만으로도 내가 진짜 나를 정말 생각해주고, 사랑해주는 방법일 텐데 그 방법을 정말 몰랐구나... 이 프로그램을 통해 알게 되어서 참 다행이라는 생각이 들고, 감사하다고 말씀드리고 싶어요.
3회차(9회기)	이미지 재구성 II: 미래심상(‘최고로 가능한 자기’)	정말 뭐라 표현을 못하겠어요. 근데 너무 너무 좋은 경험이었고, 근데 좋은 경험이라고 말하기에는 너무 표현이 약해요. 소중했다. 너무 진짜 너무 새로웠고, 진짜 너무 좋았어요. 이 벽찬 감정을 어떤 단어로 이걸 표현해야 할지 모르겠어요. 저의 이 느껴지는 감정을 단어로 표현하기에 감정 단어가 너무 작아요. 앞의 개인 회기들과 오늘 조금 다른 개인 회기를 또 하면서 그니까 앞의 회기들이 저에게 마음의 여운이 막 남아가지고 되게 좋았거든요. 그래서 이번 개인 회기까지 연결돼서 마무리가 정말 잘 된 것 같아요. 그래서 오늘 그 핵심 대안을 생각해낼 수 있었던 것 같아요. 긍정적으로? 적응적으로? 생각 바꾸는 것도 그렇고 앞에 개인 회기들이 있었기 때문에 만약 그게 없었다면 사실 잘 모르겠어요. 어쨌을지 오늘 제가 어떻게 상황을 해결하고, 어떻게 생각을 바꿀 수 있었을까... 잘 모르겠어요. 정말 감사합니다. 지금 나 해 볼 수 있겠다. 내가 나를 더 돌봐야겠다. 지금 이런 생각들이 계속 떠올라요.

1회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사전)	1회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사후)
1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 불안하다. 사랑받지 못한다. 2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 “그때를 떠올리면 저에 대한 모습은 모르겠어요. 주변 사람들만 기억나요” 1) 엄마의 뒷모습 2) 엄마 3) 오빠	1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 타인을 깊게 사귀지 못하는 것은 불안함이 가장 크다. 불안함은 큰 테두리이고, 그 안에서 생각해보면 이런 어렸을 때의 경험 때문에 사람을 잘 믿지 못하는 것 같다. 언젠가는 다 떠난다. 2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 무서움 2) 불안함 3) 초조함

2회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사전)	2회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사후)
1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 나는 비난만 받기에는 약한 존재이다.	1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 그 경험을 지금과 연관시켜 힘들지 말자. 나도 있고, 생각해보면 모두가 다 나를 떠나진 않았다.
2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 어린 2) 가여운 3) 작은	2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 불안, 슬픔, 분노 2) 팬츠를 떠나지 않을 한사람 나 3) 위로와 따뜻함
3회차 이미지 재구성 II: 미래심상(사전)	3회차 이미지 재구성 II: 미래심상(사후)
1. 현재 자신에 대한 이미지 1) OOO(자신의 이름을 말함) 2) 올바른 3) 기본	1. 현재 자신에 대한 이미지 1) 부지런하다. 2) 건고함 3) 잔 다르크

(7) G(30대/여성)

	1회차 이미지 재구성 I 사전	1회차 이미지 재구성 I 사후	2회차 이미지 재구성 I 사전	2회차 이미지 재구성 I 사후	3회차 이미지 재구성 II 사전	3회차 이미지 재구성 II 사후
1. 대인외상경험의 생생함 (0~100)	80점 → 90점		10점 → 7점		7. 새로운 대안적 핵심신념을 믿는 정도	
2. 대인외상경험의 고통감 (0~100)	95점 → 85점		50점 → 10점			
3. 핵심신념을 믿는 정도 (0~100)	90점 → 40점		45점 → 15점		70점 → 85점	

1회차(5회기)	이미지 재구성 I: 과거 대인외 상경험	제가 불안해하고 있다는 걸 몰랐는데 발견하게 돼서 정말 좋았습니다. 상상한대로 그 아이에게 해주는 방법과 그렇게 상상하고 연구자님의 질문과 안내를 들으면서 정말 그렇게 해줄 수 있으면 어린 아이였던 제가 안심하겠다는 생각이 들었어요. 앞으로 제가 어떤 식으로 지내게 되고, 어떤 좋은 습관을 만들면 좋을지를 생각하고 실천하면서 이런 것들에 에너지를 좀 써봐야겠다는 방향성이 생겼어요. 오늘 아이를 만나는 시간은 정말 귀하고, 중요한 경험이라고 생각해
----------	--------------------------------------	---

		요. 그래서 진짜 치료에 도움이 되는 것 같은... 따뜻한 느낌을 느꼈어요. 이 과정 전체에서요.
2회차(7회기)		저번에 개인회기가 정말 많은 도움이 되었다고 개인회기 끝나고도 말씀드리고 집단 모였을 때 6회기 시작하면서도 말씀드렸잖아요. 오늘 또 말씀드려요. 그때 내가 언제든 필요하면 달려올 거고, 안아줄 거고, 옆에 있어 줄 거고 그 경험이 너무 강렬해서 인상에 남아서 매일매일 그 장면을 저도 모르게 아니면 의도적으로 떠올렸어요. 그러면서 약간 제 내면의 그 어린 상처받은 아이를 보호하고, 늘 도움을 주고 싶다... 이런 무의식적인 생각을 좀 했는데 안정감이나 편안함을 찾는 데 좀 도움이 되었어요. 그런데 오늘은 지난 번 내면 아이 만날 때와는 또 달랐어요. 저번에는 장면을 떠올리는 것만으로도 그 고통에 제가 휩쓸리거나 압도될 것 같은 느낌을 받았고, 그 아이를 바라보는 제 마음도 굉장히 아팠고, 지금 생각하면 고통 지수가 100점 만점이라면 95점 정도였는데 너무 힘들었어요. 그래도 연구자님이 저와 그 아이를 만날 수 있게 해주시고, 계속 물어주셨잖아요. 뭘 해주고 싶나요. 기분은 어떠신가요?처럼 이렇게 제가 그 아이와 소통하게 도와주셨잖아요. 소통한 결과가 남아서 제가 그 경험을 계속 일상 속에서 되새기면서 지내다보니까 물론 오늘 다시 그 아이를 만날 때 아이가 겪는 고통은 또다시 많이 고통스럽겠지만 그래도 그거를 한 발짝 떨어져서 볼 수 있게 되었다고 할까요? 압도되는 게 아니라 약간 그런 느낌이었어요. 객관성을 유지하면서 감정에 압도되지 않고, 똑바로 볼 수 있게 되었어요. 그래서 제가 감정에 휩쓸리지 않았나 봐요. 제 중심을 잡으면서 어떻게 도와줄까, 저 아이가 원하는 건 뭘까? 이런 것들이요. 제가 처음 했던 이미지 재구성에서 너무 많은 도움을 받아서 이렇게 된 것 같아요. 정말 감사합니다.
3회차(9회기)	이미지 재구성 II: 미래심상(‘최고로 가능한 자기’)	저는 이런 과정을 자주 자주 겪고 싶다고 생각해요. 그 이유는 왜 살다보면 그런 다른 사람과의 관계적인 자극은 어디서든 받을 수 있잖아요. 엄마한테서 받은 친구한테서 받은 그게 폭식으로 이어지는데 근데 그 상황마다 제가 뭘 선택해서 어떤 결과를 내지는 다 다를 수 있으니까요. 오늘 계속 자동화된 제 안의 제가 계속 어떻게 해야 돼. 그래 잘했어. 그렇게 해보자. 이번에는 그거 해보자. 이렇게 혼잣말?처럼 하는 이런 저의 목소리에 되게 많이 그냥 끌려갔던 것 같거든요. 그래서 제가 원하는 걸 생각해보고, 하고 싶은 걸 생각해 보면서 좀 힘을 기르고 표현을 한다든가 아니면 좀 긍정적인 뭔가 생각이나 방법을 찾는다는가 내가 옛날처럼 바로 폭식하는 게 아니라 대처하는 방법을 바꾸는 이런 경험들 있잖아요? 자꾸 해보고 싶다는 생각이 들어요. 저한테 잘했다고 얘기해주고 싶어요.
1회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사전)		1회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사후)
1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고		1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고

있는 생각 및 의미: 적극적으로 내 감정이나 의사표현을 하지 못했구나. 나 스스로도 나를 소외시킨 채 엄청 오랜 시간을 보냈구나 2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 너무 잔인했다. 2) 감당하기 힘들었다. 3) 마음이 아프다.	있는 생각 및 의미: 무의식적으로 많은 것들이 그때의 영향을 받았구나 2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 엄청 불안하고, 긴장 했었구나 가엾어라 2) 자주 만나고 싶다. 자주보자 3) 알게 돼서 다행이다. 내가 이제 지켜줄게
2회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사전)	2회차 이미지 재구성 I: 대인외상(사후)
1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 나는 이런 상황을 정말 싫어하고, 피로워하는데 감정 표현을 하지 못했다. 2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 경직, 불안하다. 2) 답답하다. 3) 숨어버림	1. 외상경험이 나 자신에 대하여 말해주고 있는 생각 및 의미: 나 자신에 대한 정보, 내가 필요로 하는 것과 부족한 것, 그런 모든 것들을 알게 되었다. 2. 대인외상 당시의 자신에 대한 이미지 1) 내가 핵심 2) 관계에서의 편안함 3) 중심
3회차 이미지 재구성 II: 미래심상(사전)	3회차 이미지 재구성 II: 미래심상(사후)
1. 현재 자신에 대한 이미지 1) 애씀 2) 민감함 3) 알아차림	1. 현재 자신에 대한 이미지 1) 진실 2) 중요한 것 3) 힘 기르기

**Development and Effectiveness of Imagery Rescripting Cognitive Behavioral
Therapy Program for Women with Binge Eating Tendencies, Who Have Had a
Traumatic Experience in Interpersonal Relationships
during Their Childhood and Adolescence**

Hong Chaeyoung

Department of Child Development and Education

Graduate School, Myongji University

Directed by Professor Kim Jungmin

The aim of this study is to develop and implement a cognitive behavioral therapy program incorporating imagery rescripting for female adults with binge eating tendencies who had interpersonal traumatic experience in their childhood and adolescence, and then to compare its effects with a traditional cognitive behavioral therapy program. The components of a cognitive behavioral therapy program incorporating imagery rescripting are self-management, cognitive restructuring, imagery rescripting, relaxation training and stress-coping training, while the components of the traditional cognitive behavioral therapy program are self-management, self-monitoring, cognitive restructuring, relaxation training, and stress-coping training. The research participants of this study were selected in two steps. In the first screening, women in their 20s and 30s meeting the dual criteria of 5 points or higher in the interpersonal traumatic experience checklist and 88 points or higher in the BULIT-R were selected. In the second screening, a total of 21 female adults were selected after conducting an interview and imagery interview with the female adults selected in the first screening. These research participants

were randomly assigned to three groups in equal number of people: an experimental group implementing the cognitive behavioral therapy incorporating imagery rescripting; a comparison group implementing a traditional cognitive behavioral therapy; and a static group placed under a controlled condition without any treatment. For the experimental group, the cognitive behavioral therapy program incorporating imagery rescripting was implemented twice a week for a total of 10 sessions, each lasting 120 minutes (3 sessions out of 10 sessions take about 50 minutes per person). For the comparison group, a traditional cognitive behavioral therapy program was implemented twice a week for a total of 10 sessions, each lasting 120 minutes.

The effectiveness of the developed program was verified through pre-, post-, and 3-month follow-up tests and content analysis. Variables related to interpersonal traumatic experience and binge eating tendencies were classified into four domains —eating, cognitive (content, process), emotional, and behavioral domains—and were measured using scales for negative emotion-induced eating motive and eating behaviors, dysfunctional beliefs(SDBT), negative automatic thinking(ATQ-N), self-esteem(RSS), emotional dysregulation(DERS), depression (BDI), state-trait anxiety(STAI), state-trait anger(STAXI-K), and stress coping style(SCSC). For analysis of the collected data, SPSS 21.0 statistical program was used.

The main results of this study are as follows. First, after program implementation, the experimental group that implemented the cognitive behavioral therapy incorporating imagery rescripting showed significantly decreased scores in the eating variable of negative emotion-induced eating motive/behaviors and its subfactor of eating motive and eating behavior. On the other hand, the comparison group that implemented a traditional cognitive behavioral therapy showed significantly decreased scores only in the subfactor of eating behavior. Second, after program implementation, the experimental group showed significantly decreased

scores in cognitive contents such as dysfunctional beliefs and negative automatic thinking among the cognitive variables. On the other hand, the comparison group showed significantly decreased scores on in negative automatic thinking. In the cognitive process of self-esteem, among other cognitive variables, scores significantly increased only for the experimental group. Third, after program implementation, the experimental group and the comparison group both showed significantly decreased scores in emotional variables such as emotional dysregulation, depression, and state-trait anger. In particular, significant difference between groups was observed in depression, indicating that the implemented therapy was more effective for the experimental group than the comparison group. On the other hand, in the state-trait anxiety, among other emotional variables, scores significantly increased only for the experimental group. Fourth, after program implementation, the experimental group and the comparison group both showed significantly increased scores in problem-focused coping and seeking social support among three stress coping styles of behavioral variables, while only the experimental group showed significantly increased scores in emotion-alleviating coping. Fifth, in the follow-up test conducted 3 months after program completion, significant difference was observed between the experimental group and the comparison group in all variables. The results of the pre-, post-, and follow-up tests indicated that maintaining significant effects or making continuous changes in all the variables take place only for the experimental group.

This study is significant in that it constructed and developed a cognitive behavioral therapy program incorporating imagery rescripting for the reduction of binge eating symptoms targeting female adults with binge eating tendencies who had interpersonal traumatic experience in their childhood and adolescence. Unlike previous studies that focused only on binge eating to reduce binge eating symptoms, this study covered both interpersonal traumatic experiences and binge

eating with imagery rescripting to demonstrate the reduction of binge eating symptoms as well as effective changes and maintenance of such changes in related variables for the target group. The results demonstrated in this study suggest that cognitive behavioral therapy program incorporating imagery rescripting can be a promising treatment for people with binge eating tendencies in restoring their psychological health.

Keywords: Interpersonal traumatic experience, binge eating tendencies, imagery rescripting cognitive behavioral therapy program, Socratic method, cognitive restructuring, imagery rescripting, female adult